

이 과제는 2023년 고용노동부의
학술연구용역사업의 일환으로 연구되었음
발간등록번호 : 11-1492000-001018-01

산재보험 행정처분에 대한 권리구제 절차 연구

2023. 10.

연구기관: (사)한국고용노사관계학회



연구진

책임연구원 : 전 윤 구 (경기대 법학과, 교수)
공동연구원 : 권 혁 (부산대 법학전문대학원, 교수)
공동연구원 : 김 희 성 (강원대 법학전문대학원, 교수)
공동연구원 : 성 대 규 (강원대 법학전문대학원, 교수)
공동연구원 : 김 근 주 (한국노동연구원, 연구위원)
공동연구원 : 박 수 경 (강원대 비교법학연구소, 연구교수)
공동연구원 : 이 재 현 (노무법인 남명, 노무사, 법학박사)

제 출 문

고용노동부 장관 귀하

본 보고서를 고용노동부의 수탁연구 『산재보험 행정처분에 대한 권리구제 절차 연구』의 최종보고서로 제출합니다.

2023. 10.

한국고용노사관계학회

회장 권 순 원

목 차

제1장 서론	1
I. 산업재해의 발생과 노동법적 대응의 필요성	1
1. 근로계약관계에 잠재된 위험, 산업재해	1
2. 근로자의 자기책임, 사용자 책임, 사회보험	1
II. 산업재해의 노동사회법적 의미	2
1. 근로자의 노동력 손실	2
2. 기업 경영상의 문제유발	3
3. 국가경제적 손실	3
III. 업무상 재해 판단 시스템 관련 규율의 기본 원리	4
1. 당위성: 노사 신뢰의 최소침해 원칙	4
2. 방법론: 충분보상원칙과 신속보상원칙의 조화	4
 제2장 행정심판 제도와 산재 권리구제 절차 현황	 5
제1절 행정심판 제도	5
I. 행정심판 개관	5
1. 행정심판의 의의	5
2. 행정심판의 법적 근거와 성격	10
3. 행정심판의 구체적인 기능	11
II. 행정심판제도의 문제점과 개선 논의	13
1. 현행 행정심판제도에 관한 주요 쟁점	13
2. 행정심판제도 개선 논의	15
III. 소결 - 의의 및 시사점	15
 제2절 산재보험 행정처분 권리구제 절차	 17

I. 산재 행정처분 권리구제 절차	17
1. 산재 권리구제 제도의 의의	17
2. 근로복지공단의 결정	17
3. 산재 심사	27
4. 산재 재심사	41
5. 감사원 및 중앙행정심판위원회 구제 절차	46
6. 유사 제도 - 고용보험심사위원회 등의 운영 현황 및 특성	53
7. 산업재해 심사·재심사 제도에 관한 헌법재판소 결정	59
II. 산재 원처분 및 권리구제 통계	63
1. 원처분	63
2. 심사청구	70
3. 재심사청구	77
III. 산재 권리구제에 관한 실태	79
1. 대리인 조사	79
2. 근로복지공단 간담회	85
IV. 의의 및 시사점	86
 제3절 업무상 질병에 대한 판정	88
I. 업무상 질병 판정을 위한 실무 절차	88
1. 업무상 질병판정위원회 심의대상	88
2. 업무상 질병판정위원회 심의대상에서 제외되는 질병	89
3. 심의 절차	91
II. 업무상 질병 판정위원회의 운영 현황	100
1. 업무상질병 판정위원회의 심의회의 개최 현황	100
2. 업무상 질병 판정위원회의 심의결정 소요기간	100
III. 소결 : 업무상 질병 사건의 신속한 판정을 위한 방안 검토	102

제3장 외국의 입법례	104
제1절 독일	104
I. 독일 산업재해보험제도 일반	104
1. 역사적 발전 과정과 특징	104
2. 산업재해보험제도의 체계적 이해	113
II. 직업병(업무상 질병)의 처리	121
1. 개관	121
2. 직업병의 인정 절차	122
3. 직업병의 처리 절차	126
4. 이의신청과 조정	127
5. 현황	129
III. 시사점	133
1. 독일 재해보험 운영의 기본원칙과 시사점	133
2. 독일 「산재의사의 신고의무」와 시사점	136
 제2절 영국	 138
I. 산재보험제도 일반	138
1. 특징	138
2. 체계	139
II. 업무상 질병의 처리	140
1. 개관	140
2. 업무상 질병 인정 절차	143
3. 업무상 질병 처리 절차	145
4. 이의신청과 조정	148
5. 현황	149
III. 시사점	153
1. 기금의 운용	153

2. 지급 요건	153
3. 재심사 제도	154
제3절 일본	155
I. 산재보험제도 일반	155
1. 특징	155
2. 체계	155
II. 업무상 질병의 처리	156
1. 개관	156
2. 업무상 질병의 인정 절차	157
3. 업무상 질병 처리 절차	164
4. 이의신청과 조정: 산재보험 심사청구 제기 방법(산재보험 불복신청)	169
5. 현황 및 사례	174
III. 시사점	181
제4장 결 론 - 산재 절차 개선 입법정책적 개선방안 -	184
I. 산재보험 판정절차의 문제점과 개선 방향	184
1. 절차적 문제점	184
2. 절차개선의 방향	185
II. 역할 분담을 통한 판정처리 절차의 효율성 제고	188
1. 피보험자격 확인을 전담하는 (가칭)산재보험심사관제 도입	188
2. 피재근로자 상병명에 대한 주치의 소견서 작성 개선	190
3. 종합병원급 의사의 업무상 질병 의심사례 신고의무 및 점진적 확대	192
4. 상병명 판단에 관한 소위원회 역할의 명확화	194
III. 산재 원처분 결정의 신속성 확보 - 소속기관장의 표준심의기간 설정과 기간준수인센티브의 제도화	197
IV. 업무부하의 경감과 가용자원의 효율적 활용	199

1. 업무상 질병 판단에 관한 패스트랙제도 적용범위 확대	199
2. 근골격계 질환에 대한 패스트 트랙의 신속한 운용	200
3. 업무상 질병판정위원회 절차 제외대상 확대	201
V. 업무상 재해판정에 대한 불복절차의 일원화	203
VI. 소결 : 업무상 재해 판정에 대한 신뢰확보 및 수용성 제고	206
 참고문헌	 207

표 목차

[표 2-1] 행정심판위원회 설치현황	8
[표 2-2] 특별행정심판기관	9
[표 2-3] 근골격계 질병 상병·직종·근무기간·유효기간 기준	25
[표 2-4] 산업재해보상보험업무및심사에 관한 법률 개정 연혁	29
[표 2-5] 업무상 재해 신청 및 승인현황	63
[표 2-6] 업무상 질병 신청 및 승인현황	64
[표 2-7] 업무상재해 처리 소요일수 현황	66
[표 2-8] 업무상질병 처리 소요일수 현황	67
[표 2-9] 판정위원회 심의결정 소요기간 현황	68
[표 2-10] 업무상질병 전문(역학)조사 현황	69
[표 2-11] 산재 심사 취소율 연도별 추이	71
[표 2-12] 산재 급여별 취소율 현황	72
[표 2-13] 산재 심사 연도별 현황	75
[표 2-14] 산재 재심사 연도별 현황	77
[표 2-15] 업무상질병 판정위원회의 심의회의 개최 현황	100
[표 2-16] 판정위원회 심의결정 소요기간 현황	101
(단위: 일)	101
[표 3-1] 독일 산업재해보험제도의 역사적 발전 과정의 특징	112
[표 3-2] 독일의 이원적 산업안전보건체계	113
[표 3-3] 산재보험 병원 시설	120
[표 3-4] 독일 직업병 목록 등재 질병의 수(2023년 9월 14일 현재)	121
[표 3-5] ‘산재보험조합별’ 직업병 의심 신고 건수	130
[표 3-6] ‘산재보험조합별’ 직업병 인정 건수	131
[표 3-7] 연도별 직업병 의심 신고 건수, 인정 건수, 연금수급자 수	132
[표 3-8] 영국 산업재해장해급여의 장해 수준별 주당 급여(2023-2024)	142

[표 3-9] 영국 업무상 질병의 주요 질병 명칭	143
[표 3-10] 영국 업무상 질병상 패스트 트랙 주요 질병 명칭	148
[표 3-11] 영국의 산업재해장해급여 청구 건수	150
[표 3-12] 업무상 질병의 유형별 청구 건수	151
[표 3-13] 업무상 질병 승인 건수	152
[표 3-14] 법개정에 따른 변경 사항	165
[표 3-15] 업무상 질병의 신규지급 결정 건수 (단위: 건)	175
[표 3-16] 노동보험심사회 사건 처리 상황	176
[표 3-17] 이 중 산재보험 처리 건수	176
[표 3-18] 사건 종류별 청구 건수	177
[표 3-19] 사건 종류별 처리 건수	177

그림 목차

[그림 2-1] 심사·재심사 청구 절차도	41
[그림 2-2] 산재 재심사 사건처리 절차	46
[그림 2-3] 감사원 및 중앙행정심판 취소율 비교	52
[그림 2-4] 업무상 재해 신청 및 승인현황	64
[그림 2-5] 업무상 질병 승인율	65
[그림 2-6] 업무상재해 처리 소요일수 현황	66
[그림 2-7] 업무상질병 처리 소요일수 현황	67
[그림 2-8] 판정위원회 심의결정 소요기간 현황	68
[그림 2-9] 업무상질병 전문(역학)조사 소요일수	70
[그림 2-10] 산재 심사 취소율 연도별 추이	71
[그림 2-11] 산재 급여별 취소율 현황	74

[그림 2-12] 산재 심사 연도별 접수 및 취소 건수	76
[그림 2-13] 산재 심사 연도별 취소율	76
[그림 2-14] 산재 재심사 연도별 접수 및 취소 건수	78
[그림 2-15] 산재 재심사 연도별 취소율	79
[그림 2-16] 업무상 질병의 발생형태에 따른 분류체계	88
[그림 2-17] 근골격계 다빈도 상병 업무상 질병 조사 및 판정절차 도식도	95
[그림 3-1] 독일 산재 관련 근로자 수 변화 추이(1886년 이후)	109
[그림 3-2] 독일 산재 관련 근로자 수 감소 추이(1956년 이후)	110
[그림 3-3] 직업병 인정 절차	128
[그림 3-4] 업무상 질병에 대한 산업재해장해급여청구서 예시	145
[그림 3-5] 뇌·심장질환의 산재인정 절차 (예)	163
[그림 3-6] 노동보험(산재보험+고용보험) 심사제도 구조	168
[그림 3-7] 노동보험심사회 심사 절차	173
[그림 3-8] 노동보험심사회에서의 심리 절차	174

제1장 서론

I. 산업재해의 발생과 노동법적 대응의 필요성

1. 근로계약관계에 잠재된 위험, 산업재해

산업화 이후 산업현장의 근로자는 항상 재해 발생 위험에 노출되어 있다. 게다가 날이 갈수록 그 재해의 정도는 심각해지고 있다.¹⁾ 산업현장에서의 위험작업이 늘어나고 있어, 일단 재해가 발생할 경우 초래되는 손해도 막대하다. 산업재해의 발생 위험이 단순히 개인적 불행이 아니라 노동법적 관점에서 재평가하게 된 것은 역사적으로 제법 오래된 일이기도 하지만, 다른 한편 계약법적 관점에서 볼 때도 당연한 결과라고 할 수 있다. 그 이유는 다음과 같다.

본래 근로계약관계는 산업현장에서 직접 타인의 노동력 그 자체의 제공을 계약의 목적으로 한다. 요컨대 근로계약관계는 근로자의 노동력을 매개로 하여, 일정한 산업화를 직접 구현하는 것이므로, 이행과정에서 여러 가지 재해가 발생하게 되는 것은 불가피한 것이라 할 수 있다. 이러한 점에서 산업재해의 발생은 근로계약관계가 개념상 내포하게 되는 내재적 상시위험인 셈이다. 더욱이 오늘날 산업구조가 매우 세분화·복잡화되어 근로자의 업무 수행에는 보다 섬세한 주의가 필요하게 되었다. 이는 그만큼 근로자에게 발생할 수 있는 재해 위험이 높아졌다는 것을 의미하는 것이다. 더 나아가 오늘날 근로자의 업무란 것이 작업장 내에서의 근로시간에 국한된 것만 아니다. 오히려 근로자는 '상시적으로' 과중한 업무부담을 감수하여야 하는 상황에 놓여 있다. 이러한 현실은 근로자를 더욱 긴장하게 만들며, 불행하게도 산업재해는 더욱 빈번하게 발생하고 있다.

2. 근로자의 자기책임, 사용자 책임, 사회보험

산업재해가 근로계약관계에 본질적으로 내재한 위험이라는 점에 착안한다면, 산업재해에 대한 대응책 역시도 근로계약관계의 테두리 내에서 모색되어야 하고, 따라서 그에 관한 법 제도는 노동법 영역에서 담당하게 되는 것은 당연한 논리적 귀결

1) 전광석, 「한국사회보장법론」, 2007, 346면.

로 보인다. 노동법 영역에서의 법제적 대응이란, 노사 공동체적 가치 관념을 전제로 하여, 그 보상은 신속하면서도 충분하게 이루어지도록 하는 제도의 모색을 말한다. 근로자 개인만의 불행으로 보는 순수 자기 책임적 접근을 벗어난 것이 산업재해보상제도의 시작이자 본질이다. 즉, 노동력의 지배자인 사용자의 책임부담을 긍정할 수 있도록 한 것이다. 여기에서 더 나아가 오늘날에는 산업재해 보상제도의 초점을 사회보험제도로 두기에 이르렀다. 요컨대 개별적인 사용자의 책임제로부터 사회보험제도로 과감하게 이전되었고, 이를 통해 그 보상의 범위도 확대되어 가고 있다.²⁾ 하지만 그렇다고 하여 재해보상제도가 소위 책임 이론으로부터 완전히 탈피할 수는 없다.³⁾

이 때문에 개별적인 책임 귀속을 본질로 하는 산업재해 해당 여부가 매우 중요한 의미를 갖게 된다.⁴⁾ 즉, 실제로 산업재해가 발생하면, 산업재해로서 보상의 대상이 되어야 하는가를 판단하는 것이 관련 분쟁의 주요 쟁점이다. 최근 산업현장에서 보면, 근로자들의 자유로운 휴게시간 활용이나 스포츠 활동이 늘어나고, 회사 측도 이러한 일련의 행사를 복지적 차원에서 지원하는 일이 늘어나면서, 점차 근로자의 사적 영역과 회사의 업무영역이 구별하기 어려워지는 일이 빈번하게 발생하고 있는데, 이러한 사실은 산업재해 판단을 매우 어렵게 하고 있다.

II. 산업재해의 노동사회법적 의미

근로관계의 지속과정에서 발생하는 산업재해는 노동사회법상 매우 중요한 의미를 가진다. 그 재해가 매우 심각한 문제를 유발하기 때문이다.

1. 근로자의 노동력 손실

가장 먼저 언급되어야 할 손해로는 근로자의 노동력 상실 부분이다. 근로자에게 있어 노동력은 그 자신은 물론이고 그 가족의 생계 기반이 되는 것이며, 자신의 인격을 실현하는 전제 요건이다. 그런데 산업재해는 결과적으로 이러한 노동력에 상당한 훼손을 가져온다.⁵⁾ 이러한 결과는 근로자 자신의 물론 그 가족의 생계 기반이

2) 김형배, 「노동법」, 2010, 488면.

3) 김형배, 「노동법」, 2010, 488면.

4) 김형배, 「노동법」, 2010, 488면.

5) 같은 취지로 전광석, 「한국사회보장법론」, 2007, 346면.

박탈되거나, 경제적 활동 의욕을 상실케 한다. 이로써 사회에는 생계형 범죄가 발생하는 등 여러 가지 사회문제가 발생하게 되어, 사회안전망이 무너지는 사례는 전 세계 여러 나라의 예에서 이미 입증된 바가 있다. 사실 생계의 유지만이 직업을 가져야 하는 이유가 되는 것은 아니다. 인간은 일을 통해 자아실현을 할 수 있다. 근로자의 노동력 상실이나 감소가 현대 기본권 사상에서 중요한 이유는 바로 여기에 있다. 인간다운 삶을 유지하기 위한 일자리에의 참여가 봉쇄되면, 이는 매우 심각한 인격 훼손이 아닐 수 없기 때문이다. 산업재해에 대한 실질적인 - 예방이든, 보상이든 - 대응이 필요한 이유가 바로 여기에 있다.

2. 기업 경영상의 문제유발

산업재해가 초래하는 문제는 이렇게 근로자의 노동력 손실을 가져오는 것만으로 그치는 것은 아니다. 산업재해의 발생은 사실 한 개인의 노동능력 상실이나 하락을 의미하는 데 그치지 않는다. 사용자로서도 이러한 산업재해의 발생 위험은 큰 부담이 아닐 수 없다. 근로자의 근로손실은 기업업무의 수행에 차질을 초래하고, 따라서 기업 경영상 매우 치명적인 손실을 초래할 수밖에 없기 때문이다.

3. 국가경제적 손실

산업재해가 초래하는 불이익은 개인적인 것에 그치지 않아서, 국가경제적 손실도 엄청나게 큰 것으로 나타난다. 소위 노동법 제도의 체계적 정비가 완비되어 있다는 독일의 경우에도 산업재해는 매우 어려운 문제로 평가되고 있다. 최근 독일의 경우 산업재해가 감소 추세라는 발표가 나오고는 있지만, 여전히 산업재해에 따른 국가적 경제 손실은 막대하다고 한다. 이러한 관점에서 독일 연방 노동사회부가 산업재해로 인해 발생하는 경제적 손실을 추정한 바가 있다. 독일 정부의 발표에 따르면 산업재해로 인해 발생하는 경제적 손실을 2005년 기준으로 하여 근로자 1인당 근로손실일수가 연평균 12.2일이며, 이를 전체 산업으로 확대하여 환산할 경우 근로손실일수가 약 4억 2천만 일이라고 한다. 각 산업별로 살펴보면, 건설(근로자 1인당 연간 13.6일), 생산(13.5일), 서비스(13.3일), 무역·영업·교통(11.4일), 농수산 및 임업(9.8일) 등의 순으로 손실의 발생 정도가 큰 것으로 분석되었다.⁶⁾ 산업재해로 인한 근로손실과 더불어 업무상 사고와 직업병의 직접적인 처리 및 예방을 위해 법정 의무가입보험을 통해 지출된 실제적인 비용은 2005년 약 125억 유로에 이른 것으로

6) 이정원, “독일의 산업재해 발생현황”, 국제노동브리프, 2006, 한국노동연구원.

보고되고 있다.⁷⁾ 특히 산업재해에 따른 근로자의 상해 정도가 심대하여 근로자가 사실상 근로 능력을 잃게 되면 해당 근로자는 소위 사회연금수급자가 되는데, 이러한 연금 재원의 마련도 독일로서는 매우 부담스러운 부분이 아닐 수 없다.

III. 업무상 재해 판단 시스템 관련 규율의 기본 원리

1. 당위성: 노사 신뢰의 최소침해 원칙

사실 산업재해가 초래하는 직접적 손해와 문제점 이외에도 노사 간 신뢰 훼손이나 불필요한 소송 등 분쟁 해결 과정에서 보이지 않는 여러 가지 손실이 발생할 수 있다. 어쩌면 이러한 보이지 않는 손실이 더 큰 문제인지도 모른다. 왜냐하면 근로자와의 신뢰를 유지하는 것이야말로 근로계약관계의 당사자인 노사 간에 가장 중요한 존립 전제 요건이기 때문이다. 이러한 점을 염두에 둔다면 산업재해에 관한 한, 독일 사회법상 명시된 바와 같이 예방과 보상 그리고 재활을 실천적으로 구현하는 것이 매우 필요한 일임은 재차 강조할 필요도 없어 보인다.

2. 방법론: 충분보상원칙과 신속보상원칙의 조화

산업재해 관련 제도가 기능하는 영역을 보다 명확히 하고, 그 영역에 속하는 재해인지 여부에 관한 판단 문제도 간명하게 하는 것이 중요하다.

노사 간 신속하고 충분한 산재 보호제도의 구현은 이러한 전제 요건이 충족되어야만 가능하기 때문이다. 산업재해가 발생하였는데, 그 본질에 대한 판단이 늦어지거나, 판단과정에서 오해가 발생한다면 이는 그 보상의 효율성을 상실하는 것에 그치지 않고 노사 간 불신을 초래할 수 있기 때문이다. 이에 관한 선진제국의 입법 현황과 판단방식에 관한 실무적 노하우를 적극적으로 배우고, 이를 바탕으로 현행 법 제도를 개선하는 일은 노사선진화를 위한 매우 시급하고도 절실한 노동법적 과제라고 볼 수 있다.

7) 이정원, “독일의 산업재해 발생현황”, 국제노동브리프, 2006, 한국노동연구원.

제2장 행정심판 제도와 산재 권리구제 절차 현황

제1절 행정심판 제도

I. 행정심판 개관

1. 행정심판의 의의

(1) 행정심판의 개념

행정심판은 일반적으로 행정기관이 행하는 행정법상의 분쟁 해결 절차를 말한다. 즉, 행정청의 위법·부당한 행정처분이나 기타 공권력의 행사·불행사로 인하여 권리나 이익을 침해당한 자가 행정기관에 대하여 그 시정을 구하는 절차를 말한다.⁸⁾ 행정심판은 행정청의 처분과 부작위에 대한 간이·신속·저렴한 불복절차로서, 오늘날 행정소송과 함께 행정쟁송 제도의 양대 축을 이룬다.⁹⁾ 일반적으로 행정심판의 개념은 실질적 의미와 형식적 의미로 구분하여 설명되는데, 실질적 의미의 행정심판이란 특정한 실정법 제도와 관계없이 이론적인 관점¹⁰⁾에서 파악하는 행정심판의 개념이다. 이에 비하여 형식적 의미의 행정심판은 특정한 실정법 제도에 의한 행정심판을 가리키는 것으로서 현행 「행정심판법」에 따른 행정심판¹¹⁾을 의미한다.¹²⁾

행정청은 행정심판이 제기되는 사안을 참고하여 법령을 정비하고 동종의 과오를 방지할 수 있는 대책을 세울 수 있다. 행정기관이 가지고 있는 전문성, 자신의 행정작용을 누구보다도 잘 알고 있는 데서 오는 판단의 신속성, 반복적인 과오를 시정할 수 있는 기회로서의 특징을 갖고 있다.¹³⁾

8) 류지태·박종수, 「행정법신론」, 박영사, 2021, 615면.

9) 최영규, “행정심판의 기능과 심판기관의 구성 -행정심판의 사법화에 대한 이의-”, 「행정법연구」(제42호), 2015, 50면; 김광수, “행정심판제도의 현황과 발전방향”, 「행정법연구」(제43호), 2015, 112면에 의하면, 역사적으로 행정심판은 행정소송보다 더 연원이 깊은데, 유럽에서는 과거에 오늘날의 행정 불복에 관한 심리를 행정기관이 담당했다고 한다.

10) 이에 따르면 행정심판이란, 행정상의 법률관계에 관한 법적 분쟁을 행정기관이 심리·판정하는 쟁송 절차(행정심판·이의신청·심사청구·심판청구 등)를 총칭한다.

11) **행정심판법 제1조(목적)** 이 법은 행정심판 절차를 통하여 행정청의 위법 또는 부당한 처분(處分)이나 부작위(不作爲)로 침해된 국민의 권리 또는 이익을 구제하고, 아울러 행정의 적정한 운영을 꾀함을 목적으로 한다.

12) 정하중·김광수, 「행정법개론」, 법문사, 2022, 614-615면.

13) 김광수, “행정심판제도의 현황과 발전방향”, 「행정법연구」(제43호), 2015, 113-114면 참고.

(2) 행정심판의 지위와 역할

행정심판은 위법한 처분 등으로 인한 **국민의 권리구제 기능**, 행정권 스스로 행정의 적법성과 타당성을 자율적으로 보장하려는 **행정의 자율적 통제**를 주된 기능으로 하고 있다. 또한, **사법재판의 단점¹⁴⁾을 보완**하여 권리구제를 충실히 하고자 하는 의의가 크다.¹⁵⁾ 즉, 행정심판은 실질적 법치주의 실현과 국민의 권리구제를 위해 중요한 기능을 수행한다.¹⁶⁾ 행정심판은 위법성 심사를 하는 법원과 달리 부당성도 심사하는데 이를 행정심판의 독자적 의의라고 평가할 수 있다. 즉, 법원에서 구제받을 수 없는 부당한 처분으로 인한 권리·이익의 침해를 받은 국민은 행정심판에서 구제받을 수 있다.¹⁷⁾

행정심판은 사전에 그 기준과 내용이 공지된 기준의 적합 여부를 심사하여 위반을 통제하므로 **행정의 일관성 유지**에 기여한다. 사실관계의 진위를 살피고 행정청이 판단한 내용의 적법 여부에 대해 법적인 논거를 제시하여 평가하므로 행정청이 결정에 있어 이유를 명확히 제시하도록 유도¹⁸⁾한다. 한편, 심판위원의 구성과 심판절차에 있어서 대심주의¹⁹⁾ 채택 등 **공정성**의 정신을 잘 구현한 제도다. 변호사 선임이 강제되지 않고, 신속한 결정이 이루어지므로 **경제적·효율적인 권익구제제도**로서도 기능하고 있다.²⁰⁾ 국민들은 법원보다 간이·신속·저렴한 권리구제 기회를 가지며, 행정심판을 통하여 당해 사안의 법적 쟁점과 승소 가능성을 확인하여 소송 사건 수를 줄이는 역할도 한다.²¹⁾

(3) 우리나라의 행정심판제도

우리 「헌법」은 행정심판을 제도보장으로 받아들이고 있다. 특히, 심판절차에 대하여 사법절차를 준용하도록 규정하여 조문의 위치·체계상²²⁾ 행정심판이 단순한 행정

14) 행정의 복잡다기화·전문화·기술화가 진행됨에 따라 사법부에 의한 권리구제는 시간과 노력 및 비용이 많이 들고, 사후구제에 그칠 수 있다.

15) 정사연, “행정심판의 절차상 한계와 효율성확보방안”, 「국가법연구」(제8권 제2호), 2012, 3면.

16) 정남철, “행정심판의 확대 및 기능 강화를 위한 개선방안”, 「행정법학」(제14호), 2018, 87면.

17) 이윤정, “행정심판에서 부당성 심사의 실용성과 확대 방안”, 「강원법학」(제68권), 2022, 117면. 다만, 해당 연구는 이러한 형식적인 구분에 주의해야 한다는 입장이다.

18) 행정심판에서 심판이유를 통해 명확한 법적 근거를 제시하는 것은 과거 오랫동안 권위주의적 행정의 징표로 간주되어 왔던 일방적 결정과 강행의 폐해를 시정하고, 결정의 설득력을 높이는 중요한 계기가 되며, 공무원들이 결정을 내릴 때 합당한 근거를 발견하여 민원인에게 제시하도록 유도한다.

19) 대립되는 분쟁 당사자들의 공격·방어를 통하여 심리를 진행하는 제도로, 당사자 쌍방에게 공격·방어 방법을 제출할 수 있는 대등한 기회를 보장한다.

20) 선정원, “행정심판과 고충처리제도의 조직적 통합의 의의와 법정정책 개선과제”, 「법과 정책 연구」(제11집 제4호), 2011, 7면.

21) 김광수, “행정심판제도의 현황과 발전방향”, 「행정법연구」(제43호), 2015, 112면.

22) 행정심판은 「헌법」 제4장 정부가 아닌, 제5장 법원에 위치해 있다.

상 통제절차가 아니라 사법적 구제절차라는 독자적 성격을 분명히 하고 있다.²³⁾

행정심판제도는 1951년도 「소원법」상 소원으로 시작하여, 1985년 「행정심판법」으로 개정되며 오늘과 같은 모습을 갖추게 되었다. 행정심판은 행정심판의 인용률이 저조하거나 권리구제를 지연하는 등의 문제로 인하여 그동안 여러 차례에 걸쳐 변경되었다. 가장 큰 변화는 행정심판의 임의절차화, 국민권익위원회 소속의 조직개편, 행정심판위원회 단일화, 중앙행정심판위원회 개칭 등이다. 제도개선을 통하여 행정심판사건은 크게 증가 및 활성화되었으며, 특히 행정심판의 국민권익구제기능이 강조·개선되었다.²⁴⁾ 국무총리행정심판위원회는 2008년 2월 이후 국민고충처리위원회와 국가청렴위원회 등의 기능을 합쳐 국민권익위원회로 통합되었으며 현재는 행정심판사건에 대하여 직접 재결을 하는 등 절차를 간소화하였고, 2018년에는 국선대리인 선임지원, 조정제도 신설 등을 통해 갈등을 조기에 해결하도록 실효성을 제고하고 있다.²⁵⁾ 「행정심판법」은 “다른 법률에서 특별행정심판이나 이 법에 따른 행정심판절차에 대한 특례를 정한 경우에도 그 법률에서 규정하지 아니한 사항에 관하여는 이 법에서 정하는 바에 따른다”고 규정²⁶⁾하여 행정심판에 관한 일반법으로서의 성격을 분명히 하고 있다.²⁷⁾ 또한, 청구가 인용되면 피청구인인 행정청이 불복할 수 없는 강력한 효력을 발휘한다.²⁸⁾

(4) 행정심판위원회의 설치현황

현행 「행정심판법」상 행정심판위원회는 국민권익위원회에 두는 중앙행정심판위원회, 처분청 소속 행정심판위원회²⁹⁾, 특별행정심판기관³⁰⁾으로 구분된다.

23) 황창근, “행정심판과 재결취소소송의 관계”, 「연세법학」(제35호), 2020, 51면.

24) 김남철, “우리나라 행정심판의 위상과 발전방향”, 「행정법학」(제14호), 2018, 46-47면 참고.

25) 서보국, “행정심판제도의 기능과 책임성 강화에 대한 고찰” 「법학연구」(제28권 제3호), 2020, 105면.

26) 제4조(특별행정심판 등) ① 사안(事案)의 전문성과 특수성을 살리기 위하여 특히 필요한 경우 외에는 이 법에 따른 행정심판을 갈음하는 특별한 행정불복절차(이하 “특별행정심판”이라 한다)나 이 법에 따른 행정심판 절차에 대한 특례를 다른 법률로 정할 수 없다.

② 다른 법률에서 특별행정심판이나 이 법에 따른 행정심판 절차에 대한 특례를 정한 경우에도 그 법률에서 규정하지 아니한 사항에 관하여는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

③ 관계 행정기관의 장이 특별행정심판 또는 이 법에 따른 행정심판 절차에 대한 특례를 신설하거나 변경하는 법령을 제정·개정할 때에는 미리 중앙행정심판위원회와 협의하여야 한다.

27) 류지태·박종수, 「행정법신론」, 박영사, 2021, 616면.

28) 김광수, “행정심판제도의 현황과 발전방향”, 「행정법연구」(제43호), 2015, 113면.

29) 행정심판법 제6조(행정심판위원회의 설치) ① 다음 각 호의 행정청 또는 그 소속 행정청(행정기관의 계층구조와 관계없이 그 감독을 받거나 위탁을 받은 모든 행정청을 말하되, 위탁을 받은 행정청은 그 위탁받은 사무에 관하여는 위탁한 행정청의 소속 행정청으로 본다. 이하 같다)의 처분 또는 부작위에 대한 행정심판의 청구(이하 “심판청구”라 한다)에 대하여는 다음 각 호의 행정청에 두는 행정심판위원회에서 심리·재결한다.<개정 2016. 3. 29.>

1. 감사원, 국가정보원장, 그 밖에대통령령으로 정하는 대통령 소속기관의 장

2. 국회사무총장·법원행정처장·헌법재판소사무처장 및 중앙선거관리위원회사무총장

[표 2-1] 행정심판위원회 설치현황³¹⁾

구분	심리관할(처분청)
17개 시·도 행정심판위원회	시장·군수·구청장의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구사건
17개 시·도 교육청 행정심판위원회	소속 교육장 등의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구사건
6개 고등검찰청 행정심판위원회	소속 지방검찰청검사장, 지청장의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구사건
4개 지방교정청 행정심판위원회	소속 교도소장, 구치소장의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구사건
감사원 행정심판위원회	감사원장의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구사건
국가정보원 행정심판위원회	국가정보원장의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구사건
대통령비서실 행정심판위원회	대통령비서실장의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구사건
국가안보실 행정심판위원회	국가안보실장의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구사건
대통령경호처 행정심판위원회	대통령경호처장의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구사건
방송통신위원회 행정심판위원회	방송통신위원회의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구사건
국가인권위원회 행정심판위원회	국가인권위원회 사무처장의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구사건

3. 국가인권위원회, 그 밖에 지위·성격의 독립성과 특수성 등이 인정되어 대통령령으로 정하는 행정청
- ② 다음 각 호의 행정청의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구에 대하여는 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 따른 국민권익위원회(이하 “국민권익위원회”라 한다)에 두는 중앙행정심판위원회에서 심리·재결한다. <개정 2012. 2. 17.>
- 제1항에 따른 행정청 외의 국가행정기관의 장 또는 그 소속 행정청
 - 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(특별시·광역시·특별자치시·도 또는 특별자치도의 교육감을 포함한다. 이하 “시·도지사”라 한다) 또는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도(이하 “시·도”라 한다)의 의회(의장, 위원회의 위원장, 사무처장 등 의회 소속 모든 행정청을 포함한다)
 - 「지방자치법」에 따른 지방자치단체조합 등 관계 법률에 따라 국가·지방자치단체·공공법인 등이 공동으로 설립한 행정청. 다만, 제3항제3호에 해당하는 행정청은 제외한다.
- ③ 다음 각 호의 행정청의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구에 대하여는 시·도지사 소속으로 두는 행정심판위원회에서 심리·재결한다.
- 시·도 소속 행정청
 - 시·도의 관할구역에 있는 시·군·자치구의 장, 소속 행정청 또는 시·군·자치구의 의회(의장, 위원회의 위원장, 사무국장, 사무과장 등 의회 소속 모든 행정청을 포함한다)
 - 시·도의 관할구역에 있는 둘 이상의 지방자치단체(시·군·자치구를 말한다)·공공법인 등이 공동으로 설립한 행정청
- ④ 제2항제1호에도 불구하고 대통령령으로 정하는 국가행정기관 소속 특별지방행정기관의 장의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구에 대하여는 해당 행정청의 직권 상급행정기관에 두는 행정심판위원회에서 심리·재결한다.
- 30) 제4조(특별행정심판 등) ① 사안(事案)의 전문성과 특수성을 살리기 위하여 특히 필요한 경우 외에는 이 법에 따른 행정심판을 갈음하는 특별한 행정불복절차(이하 “특별행정심판”이라 한다)나 이 법에 따른 행정심판 절차에 대한 특례를 다른 법률로 정할 수 없다.
- 다른 법률에서 특별행정심판이나 이 법에 따른 행정심판 절차에 대한 특례를 정한 경우에도 그 법률에서 규정하지 아니한 사항에 관하여는 이 법에서 정하는 바에 따른다.
 - 관계 행정기관의 장이 특별행정심판 또는 이 법에 따른 행정심판 절차에 대한 특례를 신설하거나 변경하는 법령을 제정·개정할 때에는 미리 중앙행정심판위원회와 협의하여야 한다.
- 31) 국민권익위원회 온라인행정심판 홈페이지, [https://www.simpan.go.kr/nsph/sph150.do#sp\(2023.7.21.확인\)](https://www.simpan.go.kr/nsph/sph150.do#sp(2023.7.21.확인))

국회사무처 행정심판위원회	국회 사무총장의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구사건
법원행정처 행정심판위원회	대법원 및 각급법원의 장, 법원행정처장 등의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구사건
헌법재판소사무처 행정심판위원회	헌법재판소 사무처장의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구사건
중앙선거관리위원회 행정심판위원회	중앙선거관리위원장 등의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구사건
고위공직자범죄수사처 행정심판위원회	고위공직자범죄수사처장 등의 처분 또는 부작위에 대한 심

[표 2-2] 특별행정심판기관³²⁾

구분	설치근거
조세심판원(국무총리)	국세기본법 제67조
관세심사위원회(세관, 관세청)	관세법 제124조
국세심사위원회(세무서, 지방국세청, 국세청)	국세기본법 제66조의2
지방세심의위원회(지방자치단체)	지방세기본법 제141조
중앙해양안전심판원(해양수산부) 지방해양안전심판원(해양수산부)	해양사고의 조사 및 심판에 관한 법률 제3조, 제8조
특허심판원(특허청)	특허법 제132조의2
소청심사위원회(행정자치부)	국가공무원법 제9조
교원소청심사위원회(교육부)	교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제7조
중앙군인사소청심사위원회(국방부) 군인사소청심사위원회(각 군 본부) 향고심사위원회(국방부 등)	군인사법 제51조 군인사법 제51조 군인사법 제60조의2
17개 시·도 지방소청심사위원회	지방공무원법 제13조
17개 시·도 교육청 교육소청심사위원회	지방공무원법 제13조
산업재해보상보험심사위원회(근로복지공단)	산업재해보상보험법 제104조
산업재해보상보험재심사위원회(고용노동부)	산업재해보상보험법 제107조
중앙노동위원회(고용노동부)	노동위원회법 제2조
중앙토지수용위원회(국토교통부) 17개 지방토지수용위원회	공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제49조
고용보험심사위원회(고용노동부)	고용보험법 제99조
중앙선거관리위원회 시·도선거관리위원회	공직선거법 제219조(선거소청)
광업조정위원회(산업통산자원부)	광업법 제92조
건강보험분쟁조정위원회(보건복지부)	국민건강보험법 제89조
국민연금심사위원회(국민연금공단)	국민연금법 제109조
변호사징계위원회(법무부)	변호사법 제92조
어업재해보상보험심사위원회(해양수산부)	어선원 및 어선재해보상보험법 제60조
공무원재해보상연금위원회(국무총리소속, 사무국 인사혁신처)	공무원 재해보상법 제52조
군인연금급여재심위원회(국방부)	군인연금법 제5조

32) 국민권익위원회 온라인행정심판 홈페이지, [https://www.simpan.go.kr/nsph/sph150.do#sp\(2023.7.21.확인\)](https://www.simpan.go.kr/nsph/sph150.do#sp(2023.7.21.확인))

2. 행정심판의 법적 근거와 성격

(1) 법적 근거

행정심판의 헌법적 근거는 「헌법」 제107조 제3항³³⁾이며, 동 규정은 행정심판은 재판의 전심절차여야 하고, 행정심판절차에 사법절차가 준용되어야 한다는 점을 요구하고 있다.³⁴⁾ 헌법상 행정심판 논의에 있어서 헌법상 직접적 근거 규정인 제107조 제3항, 제12조 적법절차 원리³⁵⁾, 제27조 재판청구권³⁶⁾ 상호 간 관계설정의 통일성 및 규범 조화적 해석이 필요하다.³⁷⁾ 행정은 적법절차 내지는 행정절차의 일환으로 행정심판을 제대로 운영할 책무가 있으므로, 행정심판 제도 자체를 기피하거나 불성실하고 부실하게 운영하는 것은 헌법을 위반하는 행위라고 평가할 수 있다.³⁸⁾

(2) 성격

사법절차는 제3자인 법원이 공정하고 중립적인 입장에서 법률관계 분쟁의 해결을 위해 사실인정 및 법의 해석 및 적용을 하는 심리·판단 절차이며 3면 구조다. 이에 비하여 행정절차는 행정작용의 종국적인 실현 전에 상대방의 권리 보호를 위해 소명과 증거제출의 기회를 주거나 전문가 의견을 청취하는 '자기통제적 절차'이므로 2면 구조가 원칙적인 모습이다.³⁹⁾ 다만, 행정심판은 분쟁에 대한 심판작용으로서의 성격을 갖는 동시에 행정작용으로서의 성격을 갖는다. 행정심판은 행정법 관계의 분쟁을 심리·판단한다는 점에서 재판에 준하는 성격을 가지는 한편, 심판기관의 의사 표현으로서 분쟁이 있는 행정법 관계를 규율하고 형성함으로써 행정 목적을 실현하는 행정작용에 해당한다.⁴⁰⁾ 준사법절차의 구성요소로는 크게 ①대심적 심리구

33) 제107조 ③재판의 전심절차로서 행정심판을 할 수 있다. 행정심판의 절차는 법률로 정하되, 사법절차가 준용되어야 한다.

34) 성중탁, “행정심판에서의 재판청구제도 도입에 관한 논의”, 「법학논총」(제29집 제1호), 2022, 91-92면 참고.

35) 제12조 ①모든 국민은 신체의 자유를 가진다. 누구든지 법률에 의하지 아니하고는 체포·구속·압수·수색 또는 심문을 받지 아니하며, 법률과 적법한 절차에 의하지 아니하고는 처벌·보안처분 또는 강제노역을 받지 아니한다.

36) 제27조 ①모든 국민은 헌법과 법률이 정한 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리를 가진다.

37) 최선웅, “행정심판의 헌법상 근거 -헌법 제107조 제3항의 해석을 중심으로-”, 「행정법연구」(제44호), 2016, 45면.

38) 최선웅, “행정심판의 헌법상 근거 -헌법 제107조 제3항의 해석을 중심으로-”, 「행정법연구」(제44호), 2016, 64면.

39) 김용욱, “행정절차구조의 유형화 시론 -준사법절차적 대심구조의 구현을 중심으로-”, 「법조」(제71권 제3호), 2022, 182면.

40) 정하중·김광수, 「행정법개론」, 법문사, 2022, 616면; 김광수, “행정심판제도의 현황과 발전방향”,

조(대심구조), ②처분의 사전통지, ③당사자의 자료접근권, ④당사자 의견진술 및 증거제출권, ⑤심판자의 증거조사권, ⑥변호사의 조력을 받을 권리 등을 들 수 있다. 이 중 대심구조란, 중립적인 판단자 앞에서 양 당사자가 대등한 지위에서 서로에게 공격과 방어를 하는 방식으로 심리를 진행하는 구조다.⁴¹⁾ 제도보장의 관점에서 보면, 헌법 제107조 제3항 후문의 의미는, 법률로써 실질적 의미의 행정심판 모두를 반드시 준사법절차로 형성하라는 의미가 아니라, 실질적 의미의 행정심판의 범주·내용·형태 등을 구체적으로 형성함에 있어서 사법절차가 준용되는 범주의 행정심판을 반드시 두어야 한다는 의미라고 할 것이며, 이는 행정심판에 관한 입법형성권의 한계를 이룬다.⁴²⁾

3. 행정심판의 구체적인 기능

(1) 자율적 행정통제

「행정심판법」 제1조의 ‘행정의 적정한 운영’은 행정통제기능을 의미한다. ‘행정의 자기통제’는 입법·사법에 의한 통제를 제외한 행정 내의 통제를 의미한다.⁴³⁾ 행정심판은 행정권 스스로 국민의 권익을 구제하는 제도로써 의의를 갖는 동시에, 행정의 적법성과 합목적성을 행정권 스스로 확보하려는 자율적 행정통제로서 의의를 갖고 있다.⁴⁴⁾ 즉, 행정심판위원회가 처분청의 감독기관으로서 원처분의 잘못된 내용을 쉬운 절차를 통하여 바로잡을 수 있는데, 이러한 특성으로 인해 행정심판은 그 대상으로 위법한 처분뿐 아니라 합목적성의 문제를 야기하는 부당한 처분도 그 대상에 포함하게 된다.⁴⁵⁾

(2) 국민의 권리구제 수단

행정의 자기통제는 행정의 적법 상태 유지라고 하는 본래의 기능 외에도 궁극적

「행정법연구(제43호)」, 2015, 112면.

41) 김용욱, “행정절차구조의 유형화 시론 -준사법절차적 대심구조의 구현을 중심으로-”, 「법조」(제71권 제3호), 2022, 184면. 이는 판단자의 독립성과 공정성 확보를 위한 3면 구조를 전제하는 것이며 준사법절차 요소의 전제가 된다.

42) 최진수, “행정심판 제도의 구조에 관한 고찰” 「공법연구」(제43집 제2호), 2014, 187면.

43) 황창근, “행정심판과 재결취소소송의 관계”, 「연세법학」(제35호), 2020, 58면.

44) 정하중·김광수, 「행정법개론」, 법문사, 2022, 616-617면. 국민의 권리구제와 행정의 적정성 확보는 궁극적으로 사법부에 의하여 보장될 수 있음에도 행정심판제도를 두는 것은 행정작용에 대한 제1차적 통제는 행정권에 의하여 자율적으로 행하도록 하는 것이 보다 합리적·효율적이라는 사고에서 출발하고 있다.

45) 류지태·박종수, 「행정법신론」, 박영사, 2021, 618면.

으로는 국민의 권익구제에 기여한다.⁴⁶⁾ 행정소송절차는 그 대상인 행정작용의 전문성과 기술성 등으로 법원에 의한 해결에 많은 어려움이 나타난다. 또한, 특수한 행정작용에서는 사법심사의 범위가 제한됨으로써 권리구제의 공백이 발생하거나 소송절차의 장기화로 권리 보호가 늦어지는 현상을 보인다. 행정심판의 사법절차 준용을 통해 소송절차의 전 단계로서 행정심판절차와 사법절차가 서로 유기적인 협조체제를 구축할 수 있게 되며, 당사자의 권리를 행정의 영역에서 구제함으로써 법원에 의한 사법적 권리구제절차 부담을 경감하는 효과도 기대할 수 있다.⁴⁷⁾

(3) 행정의 전문지식 활용과 사법기능 보완

현대산업사회에서 나타나는 새로운 사회적·경제적 문제는 고도의 전문성과 기술적인 성격⁴⁸⁾을 갖는바, 일반법원은 이러한 전문적·기술적 문제의 해결에 적합하지 않은 경우가 많다. 반면, 행정기관은 전문적·기술적 문제의 처리에 적합하게 조직되었을 뿐 아니라, 충분한 경험과 지식을 갖추고 있는 것이 일반적이다. 따라서 행정쟁송의 일차적 단계에서 전문기관인 행정청이 분쟁을 심판하는 것이 합리적이며, 법원의 부담도 현저히 완화해 준다.⁴⁹⁾ 또한, 행정심판 과정에서 쟁점이 명확해지므로 이후 최종심에 임하는 법원의 심리가 용이하게 진행될 수 있다.⁵⁰⁾

(4) 행정능률의 보장과 경제성 확보

행정심판은 충분한 심리를 하지 못하는 면도 있으나, 신속하고 저렴한 비용이라는 장점이 있다.⁵¹⁾ 사법절차에 의한 분쟁 해결은 심리 절차의 공정과 신중으로 개인의 권리구제에 충실할 수 있으나 상당한 시일을 요한다. 행정심판은 사법절차에 앞서서 신속·간편한 행정심판을 거치도록 함으로써 행정법관계의 분쟁을 조속히 해결하도록 하는 것은 행정능률에 적지 않게 이바지한다.⁵²⁾ 따라서 행정심판을 사법절차와 별도의 절차로서 또는 전심절차로서 인정하는 것은 소송경제에 기여한다.⁵³⁾

46) 최선웅, “행정심판의 헌법상 근거 -헌법 제107조 제3항의 해석을 중심으로-”, 『행정법연구』(제44호), 2016, 48면.

47) 류지태·박종수, 『행정법신론』, 박영사, 2021, 618면.

48) 대표적으로 조세나 사회보험 등을 들 수 있다.

49) 정하중·김광수, 『행정법개론』, 법문사, 2022, 617면.

50) 김명길, 『기본행정법』, 탐북스, 2014, 394면.

51) 김명길, 『기본행정법』, 탐북스, 2014, 394면.

52) 정하중·김광수, 『행정법개론』, 법문사, 2022, 616-617면.

53) 정하중·김광수, 『행정법개론』, 법문사, 2022, 617면.

II. 행정심판제도의 문제점과 개선 논의

1. 현행 행정심판제도에 관한 주요 쟁점

(1) 개관

현행 행정심판제도는 개별법상 필수적 전치주의를 채택하고 있는 경우를 제외하고는 임의적 전치주의를 채택하고 있어 행정소송과 행정심판이 동시에 이루어지는 경우 재결에 실질적인 영향을 미칠 수 있는 점, 심판위원의 구성에 따라 유사한 사안에서 상이한 재결이 발생할 수 있는 점, 개별법상 특별행정심판위원회와 일반행정심판위원회가 구분되어 청구인이 행정심판청구에 용이하게 접근하기 어려운 점⁵⁴⁾, 행정의 행위형식은 다양하나 행정심판의 대상은 처분이므로 실질적인 국민의 권익침해에 대한 구제가 용이하지 않을 수 있는 점 등은 행정심판을 통한 권리구제의 한계점으로 지적된다.⁵⁵⁾ 국민 대다수가 국민권익위원회나 행정심판위원회를 잘 모르는 점, 행정심판 제도의 복잡성·난해성도 문제로 지적되고 있다.⁵⁶⁾

(2) 심판기관의 객관적 지위 확보

권리구제를 효과적으로 하기 위해서는 결정 주체의 객관적이고 공정한 제3자적 지위가 보장되어야 한다. 이를 위해 현행 제도는 중앙행정심판위원회를 신설하고 행정심판위원회의 위원 구성에 있어서도 외부위원들의 참여를 확대하도록 함으로써 심리 절차에 있어서 객관성을 도모하고 있으나, 여전히 객관적인 지위확보에 있어서 문제점을 안고 있다.⁵⁷⁾ 즉, 행정기관에 의한 판단이라는 점에서 판단기관의 독립성(제3자성)이 충분히 확보되지 않아 판단의 공정성이 담보되지 않을 수 있다.⁵⁸⁾

(3) 준사법절차 지향

준사법절차화 경향에 대하여 논쟁이 존재한다. 행정심판 절차의 사법화가 행정심

54) 산재보험과 관련해서도 적용·징수 등에 관한 사항은 일반행정심판위원회가 담당하나, 보험급여에 관한 사항은 산재심사 및 재심사를 통해 이루어지고 있어 차이가 있다.

55) 정사언, “행정심판의 절차상 한계와 효율성확보방안”, 「국가법연구」(제8권 제2호), 2012, 2면.

56) 김남철, “우리나라 행정심판의 위상과 발전방향”, 「행정법학」, 2018, 47면.

57) 류지태·박종수, 「행정법신론」, 박영사, 2021, 618면.

58) 김명길, 「기본행정법」, 탐북스, 2014, 394면.

판의 권리구제기능을 충실화하는데 기여했다 하더라도, 행정의 자기통제 기능 등은 약화될 수 있다.⁵⁹⁾ 또한, 행정심판은 본질적으로 사법절차보다는 공익을 실현하고자 하는 행정 작용의 일부라는 점에서, 권리구제기능의 강조가 공익의 손상이나 저해로 연결되는 것은 바람직하지 않다.⁶⁰⁾ 또한, 준사법절차를 지향한다고 하더라도 행정심판의 경제성과 신속성을 훼손해서는 안 된다.⁶¹⁾ 이러한 논거들은 행정심판의 준사법절차화 지향에 관한 반대 근거가 될 수 있다.⁶²⁾

반면, 준사법절차가 더욱 강화되어야 한다는 입장도 존재한다. 행정심판의 실재에 있어서 사법절차에 준하는 내용들이 시간 부족 등 여러 이유로 행해지지 않는 경우가 있으며, 서면심리주의에 따라 위원들의 가부 의사만을 물어 결정되는 경우도 있다. 심리 절차는 법률에 규정된 대로 가능한 대심 구조를 이루어 진행할 필요가 있으며, 당사자 쌍방의 무기 대등 원칙 실현을 위하여 청구인에게 피청구인인 처분청이 갖는 자료의 제출요구권을 인정하는 것도 필요하다.⁶³⁾ 간이·신속성을 확보한다는 면에서 사실인정이 법원의 심리만큼 엄격한 절차에 의할 수 없어 판단의 공정성이 낮아질 수 있다는 우려⁶⁴⁾도 있다.

(4) 집행 부정지 원칙과 사정재결

현행 제도에 의하면 행정심판의 청구가 있어도 문제가 되는 처분의 효력에는 아무런 영향을 주지 않는다.⁶⁵⁾ 집행정지를 인정하지 않는 것은, 행정의 능률적 수행을 도모하고 행정심판의 남용으로 행정작용의 계속성이 중단되는 것을 막기 위한 것이다. 그러나 이는 당사자의 권리 보호 측면은 배려하지 못하는 문제를 안고 있다.⁶⁶⁾

「행정심판법」은 청구인의 주장이 이유가 있더라도 이를 인용하는 것이 현저히 공공복리에 반하는 경우에는 행정심판위원회의 의결에 의하여 심판청구를 기각하는 재결을 할 수 있도록 규정하고 있다.⁶⁷⁾ 이를 사정재결이라고 하는데, 당사자의 권리

59) 최영규, “행정심판의 기능과 심판기관의 구성 -행정심판의 사법화에 대한 이의-”, 「행정법연구」(제42호), 2015, 51면; 68면 참고.

60) 최진수, “행정심판 제도의 구조에 관한 고찰”, 「공법연구」(제43집 제2호), 2014, 202면.

61) 이를 위해서, 행정심판위원의 수를 증원하고 행정심판을 지원하는 등 인력·예산을 확충하고, 사건 접수 후 위원에게 기록이 송부되는 시간을 최대한 단축하며, 기일 전에 직권조사를 보다 충실히 하는 시스템을 통해 기일의 공전을 막는 방법 등이 효과적이라고 한다.

62) 최진수, “행정심판 제도의 구조에 관한 고찰”, 「공법연구」(제43집 제2호), 2014, 201면.

63) 류지태·박종수, 「행정법신론」, 박영사, 2021, 619-620면 참고.

64) 김명길, 「기본행정법」, 탐북스, 2014, 394면.

65) 행정심판법 제30조(집행정지) ① 심판청구는 처분의 효력이나 그 집행 또는 절차의 속행(續行)에 영향을 주지 아니한다.

66) 류지태·박종수, 「행정법신론」, 박영사, 2021, 619면.

67) 제44조(사정재결) ① 위원회는 심판청구가 이유가 있다고 인정하는 경우에도 이를 인용(認容)하는 것이 공공복리에 크게 위배된다고 인정하면 그 심판청구를 기각하는 재결을 할 수 있다. 이 경우 위원회는 재결의 주문(主文)에서 그 처분 또는 부작위가 위법하거나 부당하다는 것을 구체적으로 밝혀야

구제는 공공복리라는 공익을 이유로 후퇴하게 된다. 행정심판제도에서 여전히 행정의 이해관계를 강조하는 재결유형을 두는 것은 지나치게 공익을 강조하는 조치라고도 볼 수 있다.⁶⁸⁾

2. 행정심판제도 개선 논의

(1) 제도의 단순화와 전문성 강화

행정심판제도가 더욱 발전하기 위해서는 행정 불복 제도 간의 명확화와 통합을 통하여 행정심판제도를 단순화함으로써 국민들이 쉽게 이해하고 이용할 수 있는 제도가 되도록 하고, 행정심판의 전문성을 더욱 강화하여 국민의 행정심판에 대한 신뢰를 향상시켜야 한다.⁶⁹⁾

(2) 법원을 통한 권리구제 절차와의 관계 설정

전문직 간 이해 충돌⁷⁰⁾은 행정구제 절차 설정이나 법원 권리구제 관계설정에도 영향을 미칠 수 있다. 행정심판위원회는 변호사들에게 기회가 될 수 있고, 경쟁 체제를 형성하여 국민에게 선택권을 제공한다. 또한, 분쟁 해결 비용의 합리화로 이어질 수 있다. 행정심판기관과의 경쟁이 이루어지는 순간 법원은 인력을 확충하고 전문화하여 오히려 더 많은 사건을 심리하고자 노력할 것으로 전망된다.⁷¹⁾

III. 소결 - 의의 및 시사점

(준사법절차의 지향과 한계) 우리나라의 행정심판제도는 헌법에 명시되어 있으며, 기본적으로 준사법적 절차를 지향하고 있다. 이는 행정심판의 공정성, 합리성, 법적

한다.

② 위원회는 제1항에 따른 재결을 할 때에는 청구인에 대하여 상당한 구제방법을 취하거나 상당한 구제방법을 취할 것을 피청구인에게 명할 수 있다.

③ 제1항과 제2항은 무효등확인심판에는 적용하지 아니한다.

68) 류지태·박종수, 「행정법신론」, 박영사, 2021, 620면.

69) 김남철, “우리나라 행정심판의 위상과 발전방향”, 「행정법학」, 2018, 75-76면 참고.

70) 세무사, 변리사, 공인노무사와 변호사의 직역 간섭 등이 대표적이다. 일반적으로 세무사 등의 직역은 행정처분과 구제에 강점이 있고 변호사는 소송업무를 전담하므로 행정심판과 법원을 통한 권리구제의 기능과 절차를 어떻게 설정하느냐에 영향을 미칠 수 있다.

71) 최지현, “헌법상 재판청구권의 보장을 위한 행정구제 법제의 설계”, 「법조」(제69권 제6호), 2020, 77면.

안정성을 제고하기 위한 것이며, 행정심판제도의 발전에도 기여한 것으로 평가된다. 다만, 행정심판 제도와 소송 절차는 본질적으로 다르기 때문에 행정심판 고유의 목적과 취지 등을 고려하지 않고 형식적·맹목적으로 준사법절차를 지향하는 태도는 경계할 필요가 있다. 결국, 당사자 권리구제 측면의 준사법절차와 행정의 고유목적 달성을 위한 행정제도 사이의 적절한 균형을 유지하는 것이 중요하다. 즉, 준사법절차를 지나치게 강조하여 당사자의 권리구제 기능만을 강조하거나, 반대로 행정의 고유목적만을 강조하여 당사자의 의견청취 및 반영을 간과하는 것 모두 경계할 필요가 있다.

(신속하고 효율적인 분쟁 해결) 행정심판의 기능과 목적 중에는 간이하고 신속한 분쟁 해결도 존재한다는 점을 고려하면, 행정심판 제도 중 판단을 복잡하게 하거나 분쟁을 장기화할 소지가 있는 제도는 개선을 요한다고 평가할 수 있다. 즉, 행정심판은 행정과 관련된 분쟁의 신속하고 효율적인 해결을 지향한다. 따라서 실제적 진실 판단이나 당사자 주장 사실 검증에 너무 많은 시간이 소요될 것으로 예상되는 경우, 이를 효율적으로 관리·판단하는 시스템이 요구되며, 소송 절차와 다른 관점에서 운용될 필요성이 있다.

(특별행정심판의 취지 등 고려) 행정심판은 일반행정심판과 특별행정심판으로 구분되는바, 특별행정심판은 특정 영역의 특수성과 전문성을 고려한 제도라고 평가할 수 있다. 이러한 특별행정심판은 분쟁의 해결과 관련하여 일반행정심판보다 제도 및 절차의 구성과 운영, 판단 방법 등에 있어서 재량의 여지가 더욱 넓게 해석될 수 있다. 예를 들어, 산업재해보상보험과 관련된 행정심판은 산업재해 및 사회보험이라는 기술적·전문적·의학적 분야를 다룬다는 점이 제도 개선에 일정 부분 고려될 필요가 있다.

제2절 산재보험 행정처분 권리구제 절차

I. 산재 행정처분 권리구제 절차

1. 산재 권리구제 제도의 의의

근로자의 업무상 재해를 사업주가 보상하도록 하게 하면, 재해가 일시에 많이 발생하거나 사망사고가 빈발하면 거액의 보상을 할 수 없어 피해근로자나 유족의 생활을 보장할 수 없게 된다. 산재보험은 강제보험방식에 의하여 재원을 마련하고 산업재해가 발생한 경우에 신속하고도 공정하게 보상하여 피해근로자와 그 가족의 보호에 기여한다. 피해근로자에 대한 신속한 보상을 위하여 전국에 요양 시설을 설치·운영하며, 업무상 질병에 대한 요양급여 결정에 걸리는 기간 등을 고려하여 우선적으로 건강보험을 적용하기 위한 요양급여 비용의 대부 및 충당·상환절차⁷²⁾를 마련하고 있다. 또한, 피해근로자에 대한 업무상 재해의 부지급 결정 및 보상지연에 따른 신속한 구제절차로서 심사 및 재심사 제도를 마련하고 있다.⁷³⁾

대법원 1995. 9. 5. 선고 94누12012판결

법은 산업재해보상보험사업(이하 보험사업이라 한다)을 행하여 근로자의 업무상 재해에 대하여 신속하고 공정하게 보상하고 이에 필요한 보험시설을 설치·운영하며 재해예방 기타 근로자의 복지증진을 위한 사업을 행함으로써 재해를 입은 근로자와 그 가족의 생존권을 보장 하는 등 사회보장제도의 확립을 도모할 뿐만 아니라(법 제1조) 불의의 재해로 사업주가 과중한 경제적부담을 지게 되는 위험을 분산·경감시켜(법 제11조 제1항) 안정된 기업활동을 할 수 있도록 하게 하는 한편 보험사업에 소요되는 비용에 충당하기 위하여 국고의 부담 및 지원 이외에 보험가입자인 사업주로부터 보험료를 징수하도록 하고 있으므로(법 제2조의 2, 3, 제19조)... (중략)

2. 근로복지공단의 결정

(1) 개관

72) 산업재해보상보험법 제93조(국민건강보험 요양급여 비용의 본인 일부 부담금의 대부) ① 공단은 제 37조제1항제2호에 따른 업무상 질병에 대하여 요양 신청을 한 경우로서 요양급여의 결정에 걸리는 기간 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 사람에 대하여 「국민건강보험법」 제44조에 따른 요양급여 비용의 본인 일부 부담금에 대한 대부사업을 할 수 있다. <개정 2011. 12. 31., 2020. 5. 26.>

② 공단은 제1항에 따라 대부를 받은 사람에게 지급할 이 법에 따른 요양급여가 있으면 그 요양급여를 대부금의 상환에 충당할 수 있다. <개정 2020. 5. 26.>

73) 이상국, 「산재보험법(I)」, 대명출판사, 2017, 8면.

「산업재해보상보험법(이하, '산재보험법'이라 함)」은 법의 목적을 달성하기 위한 사업을 효율적으로 수행하기 위하여 근로복지공단을 설립하도록 규정하고 있다(제10조). 근로복지공단이 수행하는 사업 중 재해근로자의 보험급여와 직접적인 관련성이 있는 것은 '보험급여의 결정과 지급', '보험급여 결정 등에 관한 심사청구의 심리·결정'이며(제11조 제3호; 제4호), 간접적으로는 '산업재해보상보험 시설의 설치·운영', '보험급여 결정 및 지급을 위한 업무상 질병 관련 연구'도 관련 있다(동조 제5호; 5의4호). 보험급여는 보험급여를 받을 수 있는 수급권자의 청구에 따라 지급하며 급여의 종류는 요양급여, 휴업급여, 장해급여, 간병급여, 유족급여, 상병보상연금, 장례비, 직업재활급여로 구성된다(제36조 제1항 및 내2항). 업무상 재해는 업무상 사고, 업무상 질병, 출퇴근 재해로 구분되며, 각 사유에 대한 별도의 인정기준을 두고 있다(제37조). 시행령은 이를 다시 업무 수행 중의 사고, 시설물 등의 결함 등에 따른 사고, 행사 중의 사고, 특수한 장소에서의 사고, 요양 중의 사고, 제3자의 행위에 따른 사고, 업무상 질병의 인정기준, 출퇴근 중의 사고 등으로 구분하고 있다(시행령 제27조 내지 제35조).

특히, 업무상 질병의 인정에 대해서는 업무상질병판정위원회를 두어 심의하도록 규정하고 있는데(제38조), 심의에서 제외되는 질병을 제외한 질병을 심의⁷⁴⁾하고 있으며(시행규칙 제7조), 공단 분사무소의 장은 판정위원회의 심의가 필요한 질병에 대하여 보험급여의 신청 또는 청구를 받으면 판정위원회에 업무상 질병으로 인정할지에 대한 심의를 의뢰하여야 하고 판정위원회는 20일 이내(부득이한 사유가 있는 경우 10일을 넘지 않는 범위에서 한 차례 기간 연장 가능)에 심의하여 결과를 알려야 한다(시행규칙 제8조).

업무상질병판정위원회운영규정

제4조(업무상 질병 인정 여부 심의의뢰) ① 소속기관장은 법 제36조제1항에 따른 보험급여의 신청 또는 청구를 받은 경우로서 그 신청 또는 청구가 업무상 질병의 인정 여부

74) 제7조(판정위원회의 심의에서 제외되는 질병) 법 제38조제2항에 따른 판정위원회의 심의에서 제외되는 질병은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 질병으로 한다. <개정 2010. 11. 24., 2015. 3. 24., 2021. 2. 1.>

1. 진폐
2. 이황화탄소 중독증
3. 유해·위험요인에 일시적으로 다량 노출되어 나타나는 급성 중독 증상 또는 소견 등의 질병
4. 영 제117조제1항제3호에 따른 진찰을 한 결과 업무와의 관련성이 매우 높다는 소견이 있는 질병
5. 제22조 각 호의 기관에 자문한 결과 업무와의 관련성이 높다고 인정된 질병
6. 그 밖에 업무와 그 질병 사이에 상당인과관계가 있는지를 명백히 알 수 있는 경우로서 공단이 정하는 질병

에 관한 것이면 **7일 이내**에 별지 제1호의 업무상질병판정 심의의뢰서에 따라 그 소속기관의 소재지를 관할하는 판정위원회에 업무상 질병의 인정 여부에 대한 심의를 의뢰하여야 한다. 다만, 심의의뢰 대상의 주된 질병이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 서울남부업무상질병판정위원회에 심의를 의뢰하여야 한다. <개정 2022. 6. 9.>

1. 「의료법 시행규칙」 제41조제1항제2호에 따른 산부인과·안과·이비인후과·피부과·비뇨기과의 진료과목에 해당하는 질병 <개정 2021. 2. 26.>

2. 「의료법 시행규칙」 제41조에 따른 모든 진료과목에 해당하는 질병 중 암

② 소속기관장은 제1항에 따라 업무상 질병의 인정 여부에 대한 심의를 의뢰하는 때에는 「요양업무처리규정」 별지 제1호 서식에 따른 **재해조사서**, 주치의사 및 해당 상병분야의 진료과목에 대한 전문의 자격을 가진 자문의사의 **소견서** 등 관련 서류를 첨부하여야 한다. 다만, 「산업재해보상보험 의학 자문 운영지침」에서 자문 생략 대상으로 정하고 있는 질병은 의학 자문을 생략할 수 있다. <개정 2022. 6. 9.>

③ 제1항에 따른 심의의뢰 기간에는 규칙 제21조제2항제2호부터 제6호까지에 해당하는 기간은 포함하지 아니한다.

④ 소속기관장은 제1항에 따라 판정위원회에 심의를 의뢰한 때에는 그 사실을 신청인 또는 청구인, 보험가입자에게 알려야 한다. 이 경우 신청인 또는 청구인이 「요양업무처리규정」 제7조의2에 따른 대리인을 선임한 경우에는 그 대리인에게 통지하여야 한다. <개정 2019. 8. 12.>

⑤ 소속기관장은 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 신청인 또는 청구인에게 그 변경 또는 추가된 질병에 대하여도 신청 또는 청구할 뜻이 있는지 여부를 물어 **신청 또는 청구할 뜻이 있는 것으로 확인되면** 당초 신청 또는 청구를 받은 질병과 함께 변경 또는 추가된 질병에 대하여도 판정위원회에 심의를 의뢰하여야 한다.

1. 보험급여의 신청 또는 청구를 받은 질병명이 착오임이 명백하여 질병명을 변경할 필요가 있는 경우

2. 신청 또는 청구를 받은 질병 외에 해당 신청 또는 청구와 관련한 다른 질병이 발견되어 그 질병에 대한 판정위원회의 심의가 필요하다고 인정되는 경우 <개정 2022. 6. 9.>

제5조(판정위원회의 심의 제외 질병) 규칙 제7조제6호에서 “업무와 그 질병 사이에 상당인과관계가 있는지를 명백히 알 수 있는 경우로서 공단이 정하는 질병”이란 다음 각 호와 같다. <개정 2021. 2. 26., 2022. 6. 9.>

1. 법 제49조에 따른 추가상병 요양급여를 신청한 질병

2. 「산업재해보상보험법 시행령」(이하 “령”이라 한다) 제34조제3항 별표 3 제7호차목에 따른 소음성 난청 <개정 2015. 12. 29.>

3. 석면폐증 <개정 2015. 12. 29.>

4. 규칙 제22조에 따른 자문을 거친 광업 종사경력자의 만성폐쇄성폐질환, 또는 법 제119조에 따른 진찰 결과 만성폐쇄성폐질환 진단기준에 미달하는 경우 <신설 2017. 4. 7.>
5. 영 제34조제3항 별표 3 제6호바목·사목, 제9호가목·다목, 제12호바목·사목에 해당하는 질병 <신설 2021. 2. 26., 2022. 6. 9.>

제6조(심의사건의 회송) 위원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 사유를 명시하여 소속기관장에게 심의사건을 회송할 수 있다. <개정 2015. 12. 29.>

1. 동일한 사건이 중복하여 심의의뢰된 경우
2. 심의사건에 대해 2회 이상 보완을 요구하였음에도 소속기관장이 보완하지 아니하여 심의가 불가능한 경우. 이 경우 소속기관장은 신청인 또는 청구인이 보완하지 아니하여 회송 받은 심의사건을 「민원 처리에 관한 규정」에 따라 처리하여야 한다. <개정 2019. 8. 12., 2022. 6. 9.>
3. 소속기관장이 심의를 의뢰한 사건이 규칙 제7조에 따른 판정위원회의 심의제외 질병에 해당하는 등 판정위원회의 심의대상이 아닌 경우
4. 신청인 또는 청구인이 심의사건의 신청 또는 청구를 철회하는 경우
5. 「요양업무처리규정」 제9조제4항에 따라 규칙 제22조에 따른 업무상 질병에 관한 자문의 적정 여부에 대하여 공단 본부의 의견이 필요함에도 의견 조치가 생략된 경우 <신설 2022. 6. 9.>
6. 판정위원회 심의안건 검토회의 또는 심의회의 결과 규칙 제22조에 따른 업무상 질병에 관한 자문이 필요한 경우 <신설 2022. 6. 9.>

참고 - 산재보험법 시행규칙

제7조(판정위원회의 심의에서 제외되는 질병) 법 제38조제2항에 따른 판정위원회의 심의에서 제외되는 질병은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 질병으로 한다. <개정 2010. 11. 24., 2015. 3. 24., 2021. 2. 1.>

1. 진폐
2. 이황화탄소 중독증
3. 유해·위험요인에 일시적으로 다량 노출되어 나타나는 급성 중독 증상 또는 소견 등의 질병
4. 영 제117조제1항제3호에 따른 진찰을 한 결과 업무와의 관련성이 매우 높다는 소견이 있는 질병
5. 제22조 각 호의 기관에 자문한 결과 업무와의 관련성이 높다고 인정된 질병
6. 그 밖에 업무와 그 질병 사이에 상당인과관계가 있는지를 명백히 알 수 있는 경우로서 공단이 정하는 질병

제8조(판정위원회의 심의 절차) ① 공단의 분사무소(이하 “소속 기관”이라 한다)의 장은 판정위원회의 심의가 필요한 질병에 대하여 보험급여의 신청 또는 청구를 받으면 판정위원회에 업무상 질병으로 인정할지에 대한 심의를 의뢰하여야 한다.

② 판정위원회는 제1항에 따라 심의를 의뢰받은 날부터 20일 이내에 업무상 질병으로 인정되는지를 심의하여 그 결과를 심의를 의뢰한 소속 기관의 장에게 알려야 한다. 다만, 부득이한 사유로 그 기간 내에 심의를 마칠 수 없으면 10일을 넘지 않는 범위에서 한 차례만 그 기간을 연장할 수 있다.

제21조(요양급여의 결정 등) ① 공단은 법 제41조에 따른 요양급여의 신청을 받으면 그 신청을 받은 날부터 7일 이내에 요양급여를 지급할지를 결정하여 신청인(법 제41조제2항에 따라 산재보험 의료기관이 요양급여의 신청을 대행한 경우에는 산재보험 의료기관을 포함한다) 및 보험가입자에게 알려야 한다.

② 제1항에 따른 처리기간 7일에는 다음 각 호의 기간은 산입하지 않는다. <개정 2022. 7. 5.>

1. 판정위원회의 심의에 걸리는 기간
2. 법 제117조 및 법 제118조에 따른 조사에 걸리는 기간
3. 법 제119조에 따른 진찰에 걸리는 기간
4. 제20조에 따른 요양급여 신청과 관련된 서류의 보완에 걸리는 기간
5. 제20조제2항에 따른 보험가입자에 대한 통지 및 의견 청취에 걸리는 기간
6. 업무상 재해의 인정 여부를 판단하기 위한 역학조사나 그 밖에 필요한 조사에 걸리는 기간

③ 공단은 제1항에 따른 요양급여에 관한 결정을 할 때 필요하면 영 제42조제1항에 따른 자문의사(이하 “자문의사”라 한다)에게 자문하거나 영 제43조에 따른 자문의사회의(이하 “자문의사회의”라 한다)의 심의를 거칠 수 있다.

산재보험 수급권자가 근로복지공단에 보험급여의 지급을 신청 또는 청구하면, 근로복지공단은 법령의 규정에 따라 이를 판단하여 지급 여부를 결정하는데, 이 중 업무상 질병에 관해서는 법으로 제외하는 것을 제외하고는 업무상질병판정위원회를 의무적으로 거쳐야 한다.

한편, ‘업무상질병판정위원회운영규정’ 제4조 제5항은 판정위원회에 상병을 변경 또는 추가할 수 있음을 규정하고 있다. ①보험급여의 신청 또는 청구를 받은 질병명이 착오임이 명백하여 변경 필요가 있거나, ②신청 또는 청구 질병 외에 관련된 질병이 발견되어 판정위원회의 심의가 필요한 경우가 이에 해당한다. 최초 보험급여 청구 단계에서 재해자나 초진 병원에서 재해와 관계된 상병명을 명확하게 특정하지 못하고 있는 경우, 이를 업무상질병판정위원회에서 수정할 수 있는 근거 규정

을 두고 있는 것으로 평가할 수 있다. 한편, 해당 규정은 재해자의 “신청 또는 청구할 뜻”이 확인되는 경우 변경 또는 추가 가능하다고 규정하고 있으나, 상병 확정 등과 관련된 분쟁을 예방하기 위해서 업무상질병판정위원회가 이를 직권으로 처리하거나 요양기관과 협의하여 결정하는 적극적인 형태로 개정할 필요가 있다. 상병명이 명확히 특정되지 않는 경우, 상병명 확정과 관련된 분쟁이 추후 심사, 재심사, 소송에서 이어질 우려가 있기 때문이다. 즉, 업무상 질병과 관련하여 상병명 특정에 관한 사항이 업무상질병판정위원회에서 최종적으로 확정 또는 결정하도록 하는 방안을 고려해볼 필요가 있다.

(2) 자문의사 제도

공단은 업무상의 재해에 따른 보험급여·진료비 또는 약제비 등의 지급 결정이나 그 밖에 보험사업에 필요한 의학적 자문을 하기 위하여 의사·치과의사 또는 한의사(공단의 직원인 의사·치과의사 또는 한의사를 포함한다)를 자문의사로 위촉하거나 임명할 수 있다(산재보험법 시행령 제42조). 자문의사는 산재의료전문위원, 상시 자문의사, 수시자문의사로 구분된다.

한편, 공단은 업무상의 재해에 따른 보험급여·진료비 또는 약제비 등의 지급 결정이나 그 밖에 보험사업과 관련된 의학적 판단이 필요한 사항에 대하여 체계적으로 자문하기 위하여 공단 소속 기관에 ‘자문의사회’를 두는데, 자문의사회는 5명 이상으로 구성하며 다음의 사항을 심의한다(시행령 제43조).

산재보험법 시행령 제43조(자문의사회) ③ 자문의사회는 공단의 자문에 응하여 의학적인 판단이 필요한 사항으로서 다음 각 호에 해당하는 사항을 심의한다. <개정 2021. 6. 8.>

1. 요양 중인 근로자의 치료종결 여부(주치의와 자문의사의 치료종결에 관한 의학적 소견이 서로 다른 경우에만 해당된다)
2. 법 제48조제1항제4호에 따른 산재보험 의료기관 변경 요양 사유의 타당성
3. 제72조에 따른 보험급여의 일시지급 금액의 산정과 관련된 의학적 소견
4. 제118조제4항 단서에 따른 판정 또는 판단과 관련된 의학적 소견
5. 그 밖에 보험급여·진료비 및 약제비에 관한 사항으로서 공단 소속 기관의 장이 자문의사회회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

자문의사회회의는 월 1회 이상 개최함을 원칙으로 하며, 필요한 경우 수시 개최가 가능하다. 근로복지공단은 자문의사회회의 필수 심의 사항에 관하여 다음과 같이 구

체적으로 정하고 있는 것으로 파악된다. 자문의사회는 구조 및 심의 특성상, 향후 논쟁이 될 수 있는 업무상 질병 판정과 관련된 쟁점의 대다수를 해소하는 기능을 담당하고 있는 것으로 보인다. 다만, 회의 개최 빈도가 원활하지 못하거나 심의사건이 많은 경우에는 이러한 역할이 제한될 수 있다고 판단된다.

- 치료종결에 대한 주치의·자문의사 간 의학적 소견 상이한 경우
- 척수신경자극기설치술의 필요성 및 타당성, 적정진료 여부 심사
- 비기질성 정신질환이 추가상병으로 신청된 경우
- 복합부위통증증후군이 추가상병으로 신청된 경우
- 척추수술후통증증후군이 추가상병으로 신청된 경우
- 부득이한 사유로 직권 전원 요양하게 할 경우 그 타당성
- 장애등급 판정시 자문의사회의가 필요한 경우
- 간병급여 최초지급 및 재판정시 간병요구도에 따른 적정지급 여부 심사
- 합병증 등 예방관리의 기 유효기간 만료일 이전 6개월간 합병증 등 예방관리 진료이력이 없으나 유효기간 연장 신청서가 제출된 경우, 의학자문 결과 ‘연장 필요 소견’인 경우
- 보험급여의 일시지급 금액의 산정과 관련된 의학적 소견
- 특별진찰 결과로 진찰요구 목적에 따른 판정 또는 판단이 곤란한 경우
- 그 밖에 보험급여·진료비 및 약제비에 관한 사항으로서 공단 소속기관의 장이 자문의사회의 심의가 필요하다고 인정하는 사항

(3) 근골격계 특별진찰을 통한 업무관련성 평가

공단은 2017. 10. 근골격계질병에 대한 특별진찰을 통한 업무관련성 평가 계획(안)을 마련하여 시행 중인데, 이는 “요양급여 신청서 접수 시 재해조사 초기 단계부터 직업환경의학과 전문의의 적극적인 개입을 통한 전문성 및 신속성을 제고하고, 특별진찰 제도를 활용 재해노동자가 선택한 특진의료기관의 업무관련성 평가를 통하여 공정성 및 객관성 확보”하기 위한 것⁷⁵⁾이다.

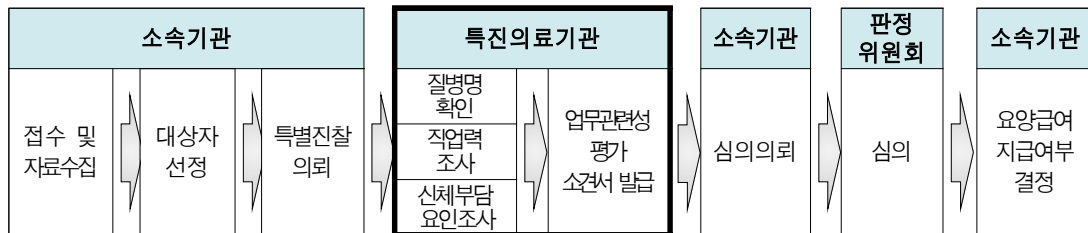
2. 개요

- **(내용) 근골격계 질병 산재신청에 대하여 특별진찰 활용** 특진의료기관의 직업환경의학과 전문의 등이 직업력 및 신체부담요인 조사 후 업무관련성 평가 실시
 - ※ 근거법령: 산재보험법 제119조 및 같은법 시행령 제117조
- (운영기간) 시행일부터 ~

75) 근로복지공단, “근골격계질병 특별진찰을 통한 업무관련성 평가 계획(안)”, 2017. 10.

- (적용대상) 건설업 일용직, 조리종사자, 요양보호사, 어린이집·이사집 센터·하역종사자 등 원직 복귀가 취약한 직종 및 폐업 사업장 소속 재해노동자 우선 적용
- (특진의료기관) 직업환경의학과 전문의가 있는 소속병원 6개소

3. 업무프로세스



- (접수 및 자료수집) 제출서류 검토, 직업력·업무관련·병력·상병관련 자료 수집
- (대상자 선정) 적용대상에 해당하는 노동자의 근골격계 질병 신청 건 중 특별진찰이 필요하다고 판단되는 건
- (특별진찰 의뢰) 신청인에게 소속병원 중 2개소를 제시 선택하도록 하고 선택한 의료기관에 수집한 자료를 첨부하여 특진의뢰
 - 20일 이내에 특별진찰 결과를 회신토록 협조
- (업무관련성 평가 소견서 발급) 소속기관이 제공한 자료, 신청인 면담, 현장조사 등 특별진찰 실시 후 업무관련 평가 소견서 발급 회신
- (판정위 심의의뢰 및 결정) 특별진찰 결과 회신 시 임상의학 전문의의 상병 확인 및 직업환경의학과 전문의의 업무관련성 평가 자문을 생략하고
 - 재해조사서 전산프로그램에 회신내용 및 조사내용을 입력·작성하여 관련자료를 첨부 판정위원회 심의의뢰 후 심의 결과 회신 시 그 내용에 따라 승인 또는 불승인 여부를 결정하여 신청인에게 통지

특진의료기관에서 업무관련성 평가 소견서가 발급 및 회신되는 경우에는, 임상의학 전문의의 상병 확인 및 직업환경의학과 전문의의 업무 관련성 평가 자문이 생략된다. 이는 근골격계 질병의 재해 인정의 신속성을 기하기 위한 것이나, 특진의료기관에서 시간이 지연되는 경우에는 전체적인 처리 소요기간이 지연될 수 있다.

(4) 근골격계 질병에 대한 패스트트랙

2022. 4. 28. 고용노동부장관은 산재보험법 제37조 제1항제2호 및 같은 법 시행령 제34조제3항에 따라 뇌혈관 질병 또는 심장 질병 및 근골격계 질병의 업무상 질병 인정 여부 결정에 필요한 사항을 개정하여 고시했다.⁷⁶⁾ 개정이유는 “근골격계 질병

의 업무상 질병 인정 여부 결정을 위한 업무 관련성의 판단기준에 상병, 직종, 근무기간, 유효기간 등 일정 기준을 충족할 경우 업무 관련성이 강하다고 평가할 수 있도록 규정을 개정(신설)함으로써 근골격계 질병에 대한 신속한 처리절차(Fast-track)를 도입하여 업무효율성을 제고하기 위한 것이고, **근골격계 질병 중 상병, 직종, 근무기간, 유효기간(신청인이 재해 근로자가 신체부담업무를 중단한 다음 날부터 최초 상병진단일 까지의 기간)을 충족할 경우 업무관련성이 강하다고 평가하는 것을** 주요 내용으로 한다.

라. 업무관련성의 판단

- 1) 신체부담업무를 업무관련성을 판단할 때에는 신체부담정도, 직업력, 간헐적 작업 유무, 비고정작업 유무, 종사기간, 질병의 상태 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.
- 2) 1)의 신체부담정도는 재해조사 내용을 토대로 인간공학전문가, 산업위생전문가, 직업환경의학 전문의 등 관련 전문가의 의견을 들어 평가하되, 필요한 경우 관련 전문가와 함께 재해조사를 하여 판단한다.
- 3) **별표 1에 해당하는 상병, 직종, 근무기간, 유효기간을 충족할 경우에는 업무관련성이 강하다고 평가한다.**

[표 2-3] 근골격계 질병 상병·직종·근무기간·유효기간 기준

신체부위	상병 명	직종명*	근무기간 (유효기간**)
목	경추간판탈출증	건설(용접공, 배관공, 형틀목공, 전기공, 미장공, 도장공, 경량철골공) 조선(용접공, 배관공, 취부공, 사상공, 도장공) 자동차(정비공), 제조업 용접공	10년 이상 (12개월 이내)
어깨	회전근개파열	건설(용접공, 배관공, 형틀목공, 석공, 전기공, 미장공, 도장공, 경량철골공, 새시조립 및 설치공, 인테리어공, 토목공, 조적공, 타일공, 건축공, 터널공, 관로공, 도배공) 조선(용접공, 배관공, 취부공, 사상공, 도장공, 비계공, 기계조립공, 전장공, 의장설치공) 자동차(부품조립공, 의장조립공, 정비공, 도장공, 엔진조립공) 타이어(성형공, 압출공, 정련공, 비드공, 검사원, 재단공) 주류 및 음료 배달원, 쓰레기수거원(재활용 포함), 급식조리원, 제조업 용접공, 가구제조원(배달 포함), 정육원, 마트 판매원, 향만하역원, 이사작업원	10년 이상 (12개월 이내)
팔꿈	내(외)	건설(용접공, 형틀목공, 철근공)	1년 이상

76) 고용노동부 2022. 4. 28. 고시, 「뇌혈관 질병 또는 심장 질병 및 근골격계 질병의 업무상 질병 인정 여부 결정에 필요한 사항」 일부개정 고시

치	상과염	조선(용접공, 취부공, 사상공, 도장공) 자동차(부품조립공, 의장조립공) 타이어(가류공, 정련공, 성형공, 압출공, 검사원) 제조업 용접공, 조리원, 급식조리원, 음식서비스 종사원, 정육원, 쓰레기수거원(재활용 포함), 건물 청소원	(2개월 이내)
손·손목	수근관 증후군	건설(용접공, 형틀목공, 석공, 미장공) 자동차(정비공, 의장조립공) 조선(용접공, 취부공, 도장공) 제조업 용접공, 조리원, 급식조리원, 음식서비스 종사원, 주방보조원, 정육원, 객실청소원	2년 이상 (6개월 이내)
	삼각섬유 연골복합 체파열	자동차(부품조립공, 의장조립공), 급식조리원 타이어(가류공, 정련공, 성형공, 압출공, 검사원)	5년 이상 (12개월 이내)
	드퀘르빙	자동차(부품조립공, 의장조립공) 조리원, 급식조리원, 제빵원	1년 이상 (2개월 이내)
허리	요추간판 탈출증	건설(용접공, 배관공, 형틀목공, 석공, 전기공, 철골공, 중기운전원) 조선(용접공, 배관공, 취부공, 사상공, 도장공) 자동차 정비공, 타이어 성형공 제조업 용접공, 쓰레기수거원(재활용 포함), 열차 정비공	10년 이상 (12개월 이내)
무릎	반월상 연골파열	건설(용접공, 배관공, 형틀목공, 석공, 전기공, 철근공, 미장공, 비계공) 조선(용접공, 배관공, 취부공, 사상공, 도장공, 의장조립공, 심출철목공, 전장공, 절단공, 보온공, 비계공, 선박정비공) 제조업 용접공, 택배원, 이사작업원, 쓰레기수거원 (재활용 포함), 어린이집 보육교사	5년 이상 (12개월 이내)

* 한국표준직업 분류와 일치하지 않을 경우, 상세정의는 근로복지공단에서 정하는 바에 따름

** 신청인이 신체부담 업무를 중단한 다음 날부터 최초 상병진단일까지의 기간

근골격계 질병에 대한 패스트트랙은 원처분기관의 결정 기간을 단축시키면서도 공정성과 합리성을 담보할 수 있는 방법이라고 평가할 수 있다. 나아가 향후 심사 및 재심사, 소송으로 이어지는 경우에 법원이 합리적으로 결정할 수 있는 기준으로 작용하여 산재보상에 관한 일관성을 담보할 수 있는 효과도 있을 것으로 판단된다. 현재는 근골격계 질병에 대한 기준만 제시되어 있으나 향후 이를 확대하여 뇌심혈관, 정신질환, 직업성암, 기타질환 등에 적용하는 방안도 고려해볼 필요가 있다.

3. 산재 심사

(1) 개관

심사청구란 산재보험법에 의하여 피재근로자와 수급권자에게 지급되는 보험급여의 결정에 대하여 이의가 있는 경우, 그 처분의 효력을 다투는 불복행위를 말한다. 산재보험에 관한 결정은 국민에게 보험급여의 수혜를 받을 수 있는 권리에 중대한 영향을 미치는 행위이므로 행정처분의 성질을 지닌다.⁷⁷⁾

1) 심사 - 산재보험심사관, 재심사 - 산재보험심사위원회(1963년 - 1995년 4월)

종전에는 「산업재해보상보험업무 및 심사에 관한 법률」이 산업재해보상보험법의 제정과 관련하여 동법상의 보험급여에 대한 이의를 심사하기 위하여 1963. 12. 16. 법률 제1625호로 제정·공포되어 적용되었다.

산업재해보상보험업무및심사에관한법률

[시행 1964. 1. 1.] [법률 제1625호, 1963. 12. 16., 제정]

[신규제정]

산업재해보상보험법에 의한 보험업무를 행하게 하기 위한 **산업재해보상보험사무소의 설치**에 관한 사항과 **보험급여에 관한 이의의 심사**에 관한 사항을 규정하여 보험급여의 공정을 기할 수 있도록 하려는 것임.

①보험료의 징수 및 보험급여에 관한 사항을 분장하게 하기 위하여 노동청장소속하에 산업재해보상보험사무소를 둘 수 있도록 함.

②노동청에 **산업재해보상보험심사관**을 두어 보험급여의 이의에 관한 사항을 심사하도록 하고, 심사관은 노동청소속 일반직국가공무원중에서 노동청장이 임명하도록 함.

③산업재해보상보험심사관의 결정에 이의가 있을 때는 산업재해보상보험심사위원회에 재심사를 청구할 수 있도록 함.

④산업재해보상보험심사위원회는 위원장을 포함한 위원 5인으로 구성되며, 위원장은 위원중에서 호선하고 위원은 사회보험에 관한 학식과 경험이 있는 자 중에서 노동청장을 경유 보건사회부장관의 추천으로 국무총리의 제청에 의하여 대통령이 임명하도록 함.

제1장 총칙

제1조 (목적) 이 법은 산업재해보상보험법에 의한 보험업무를 행하게 하기 위한 산업재

77) 이상국, 「산재보험법(II)」, 대명출판사, 2017, 796면.

해보상보험사무소의 설치에 관한 사항과 보험급여에 관한 이의의 심사에 관한 사항을 규정하여 보험급여의 공정을 기함을 목적으로 한다.

제2조 (보험사무소의 설치등) ①산업재해보상보험법에 의한 보험료의 징수 및 보험급여에 관한 사항을 분장하게 하기 위하여 노동청장소속하에 필요한 곳에 산업재해보상보험사무소(이하 “保險事務所”라 한다)를 둔다.

④보험업무를 감찰하게 하기 위하여 노동청에 감찰관 2인을 둔다.

제3조 (심사와 재심사) ①산업재해보상보험법에 의한 보험급여에 이의가 있는 자는 산업재해보상보험심사기관에게 심사를 청구하고 그 결정에 이의가 있는 자는 산업재해보상보험심사위원회에 재심사를 청구하고 그 재결에 이의가 있는 자는 행정소송을 제기할 수 있다.

제2장 심사

제1절 산업재해보상보험심사관

제4조 (산업재해보상보험심사관) ①제3조의 규정에 의한 심사를 행하게 하기 위하여 노동청에 산업재해보상보험심사관(이하 “審査官”이라 한다)을 둔다.

제2절 심사의 절차

제5조 (심사의 청구) 제3조의 규정에 의한 심사의 청구는 원처분을 행한 보험사무소의 관할구역에 관할하는 심사관(이하 “管轄審査官”이라 한다)에게 하여야 한다.

제11조 (심사관의 권한) ①심사관은 심사를 위하여 필요하다고 인정할 때에는 심사청구인의 신청에 의하거나 또는 직권으로 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 할 수 있다.

제3장 재심사

제1절 산업재해보상보험심사위원회

제16조 (설치) 제3조의 규정에 의한 재심사를 행하게 하기 위하여 노동청에 산업재해보상보험심사위원회(이하 “委員會”라 한다)를 둔다.

제17조 (구성) 위원회는 위원장 1인을 포함한 위원 5인으로 구성한다.

제22조 (회의) ①위원회의 회의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

②의장은 표결권을 가지며 가부동석인 때에는 결정권을 가진다.

제2절 재심사의 절차

제23조 (재심사의 상대방) 재심사에 있어서는 원처분을 행한 보험사무소의 소장을 상대방으로 한다.

동법은 ①노동청 산업재해보상보험심사관이 보험급여의 이의에 관한 사항을 심사하도록 하고, ②결정에 이의가 있는 경우 산업재해보상보험심사위원회에 재심사를 청구할 수 있도록 하였으며, ③재결에 이의가 있는 경우 행정소송을 제기할 수 있도록 규정하였다. 즉, 1995년 근로복지공단 설립 이전(근로복지공사)에는 노동부(현, 고용노동부)에 '산업재해보상보험심사관'을 두고 있었고, 심사관이 산재심사 관련 업무를 담당⁷⁸⁾하였다. 법률은 심사관을 노동부 소속 공무원 중에서 임명하고, 정원·자격·배치 및 직무에 관한 사항을 별도로 정하도록 규정하고 있었다. 동법은 이후 4회에 걸쳐 개정⁷⁹⁾되었고, 이후 산업재해보상보험법 제6장 심사 및 재심사 청구로 통합 운영되었다.

[표 2-4] 산업재해보상보험업무및심사에관한 법률 개정 연혁

구분	개정내용
1차 개정 (1970. 12. 31.)	산업재해보상보험사무소설치에 관한 근거 규정을 산업재해보상보험법에 규정함에 따라 이와 관련되는 조항을 삭제하고 산재심사위원회의 구성 및 위원의 임용자격등을 조정하려는 것임. ①종래 이 법에서 규정하였던 산재보험사무소의 설치에 관한 사항은 산업재해보상보험법에서 규정하도록 하고, 이 법에서는 보험급여에 관한 이의의 심사에 관한 사항만을 규정하도록 함. ②행정심판제도의 효율적인 이용을 도모하기 위하여 재심사의 기능을 가지고 있는 산재심사위원회에 사무국을 두는 한편 위원수도 2인 증가시켰을 뿐만 아니라, 위원의 자격과 임용절차를 엄격히 제한 내지 상세히 규정함. ③상임위원이 형의 선고를 받았거나 심신쇠약 또는 현저한 능력부족으로 직무를 수행하기 곤란한 때 이외는 그 의사에 반하여 면직되지 않도록 하고, 위원은 정당에 가입하거나 정치에 관여할 수 없도록 함. ④위원회의 재심사에는 노사대표자를 참여시킬 수 있도록 함.
2차 개정 (1981. 4. 8.)	노동청이 노동부로 개편됨에 따른 법 조문의 조정

78) 제4조 (산업재해보상보험심사관) ① 제3조의 규정에 의한 심사를 행하게 하기 위하여 노동부에 산업재해보상보험심사관(以下 “審査官”이라 한다)를 둔다. <개정 1981. 4. 8., 1987. 11. 28>

② 제1항의 심사관은 노동부소속공무원중에서 임명하며, 그 정원·자격·배치 및 직무에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.<개정 1987. 11. 28>

[전문개정 1970. 12. 31]

79) 제1차 개정 1970. 12. 31, 제2차 개정 1981. 4. 8, 제3차 개정 1987. 11. 28, 제4차 개정 1993. 8. 5.

3차 개정 (1987. 11. 28)	행정심판법이 제정(法律 第3755號, 1984.12.15)되어 행정심판청구기간이 연장되는 등 <u>행정구제제도가 개선되었으므로 이에 맞추어 이 법을 개정·보완함으로써 근로자의 권익을 최대한 보호하고 아울러 보험급여의 공정을 기하려는 것임.</u> ①산업재해보험급여에 대한 이의의 심사청구기간이 현재는 보험급여에 관한 통지를 받은 날로부터 60일이내로 되어 있는 바, 그 기간에 관하여는 행정심판법에 의하도록 함. ②심사청구인이 사망한 때에는 산업재해보상보험법에 의한 보험급여의 수급권자인 유족이 그 심사청구인의 지위를 승계하도록 함. ③노동부지방사무소의 소장이 보험급여의 결정을 서면으로 하거나 산업재해보상보험심사관이 심사의 청구에 대한 결정서의 등본을 심사청구인에게 송부하는 경우의 그에 대한 불복고지제도를 신설함. ④사건의 심리를 행한 산업재해보상보험심사관 또는 산업재해보상보험심사위원회위원의 질문에 답변을 하지 아니하거나, 허위의 답변을 하거나, 검사를 거부·방해 또는 기피한 자에 대하여는 현재는 3천원이하의 과료에 처하도록 한 것을 앞으로는 50만원이하의 과태료에 처하도록 함.
4차 개정 (1993. 8. 5.)	산업재해보상보험급여의 지급에 관한 <u>재심사청구의 사건이 크게 증가</u>하고 있는 추세에 적절히 대처하기 위하여 <u>산업재해보상보험심사위원회의 위원수를 7인에서 15인으로 늘리고, 위원 7인으로 구성되는 회의에서 보험급여의 지급에 관한 재심사청구사건의 대부분을 취급하도록 하여 보험급여의 지급에 관한 재심사 사무처리의 효율성을 높임으로써 산업재해를 입은 근로자들이 신속하게 보험급여를 지급받을 수 있도록 하려는 것임.</u> ①산업재해보상보험심사위원회의 위원 수를 현재의 7인이내에서 15인이내로 확대하고, 회의의 종류를 위원 7인으로 구성하는 회의와 위원 전원으로 구성하는 회의로 구분하여 운영하도록 함. ②재심사청구의 사건은 상임위원 2인·당연직위원 1인 및 위원장이 지명하는 위원 4인으로 구성하는 7인회의가 이를 취급하도록 하되, 그 7인회의에서 제시된 의견이 종전의 재결과 다른 경우등에는 위원 전원으로 구성하는 회의에서 이를 취급하도록 함.
폐지 (1995. 5. 1.)	산업재해보상보험업무및심사에관한법률은 이를 폐지한다.

2) 심사 - 근로복지공단 단독심, 재심사 - 산재보험심사위원회(1995년 5월 - 2008년 6월)

이후 1995년 개정 「산업재해보상보험법」에서 근로복지공단이 심사청구를 담당하도록 하여 심사관 제도는 폐지되었다.

산업재해보상보험법

[시행 1995. 5. 1.] [법률 제4826호, 1994. 12. 22., 전부개정]

[전문개정]

정부에서 직접 관리·운영하던 산업재해보상보험에 관한 일선업무를 노동부산하 근로복지공사에 위탁하게 됨에 따라 동 공사의 운영체제를 비수익적 성격을 가진 근로복지공단으로 개편하여 산업재해보상보험업무의 전문성과 효율성을 확보하고, 산업재해보상보험특별회계법 및 산업재해보상보험업무및심사에관한법률을 이 법으로 통합·정비함으로써 산업재해보상보험업무의 효율화를 촉진하려는 것임.

①근로자의 업무상 재해에 대한 보상보험업무와 그에 필요한 보험시설의 설치·운영 및 근로자복지증진사업을 전문적·효율적으로 추진하기 위하여 종전의 근로복지공사를 근로복지공단으로 개편하여 동 공단으로 하여금 이들 업무를 수행하게 함.

②근로복지공단은 대통령이 임명하는 이사장 1인을 포함하는 15인이내의 이사와 감사 1인으로 구성되며, 그 주요업무로 보험료의 징수, 보험급여의 결정·지급, 산업재해보상보험시설의 설치·운영, 근로자의 복지증진을 위한 사업 기타 정부로부터 위탁받은 사업 등을 수행하도록 함.

③산업재해보상보험업무를 근로복지공단에 위탁함에 따라 산업재해보상보험특별회계를 폐지하고, 산업재해보상보험기금을 설치하며, 동 기금은 보험료·기금운용수익금·적립금·기금의 결산상 잉여금·다른 기금으로부터의 출연금·차입금 및 기타 수입금등으로 조성하도록 함.

④근로복지공단이 행한 보험급여에 관하여 불복이 있는 자는 동 공단에 심사청구를 할 수 있고, 동 공단의 심사청구에 대한 결정에 관하여 불복이 있는 경우에는 노동부에 설치된 산업재해보상보험심사위원회에 재심사청구를 할 수 있으며, 동 심사청구 또는 재심사청구에 대한 결정 또는 재결은 각각 제기된 날부터 50일이내에 하도록 함으로써 근로자의 권익을 보호하고 보험급여업무의 공정성과 책임성을 확보하도록 함.

⑤근로복지공사는 근로복지공사법이 폐지됨과 동시에 해산되며, 동 공사의 재산·권리·의무 및 고용관계에 대하여는 근로복지공단이 이를 포괄승계하도록 함.

3) 심사 – 산재보험심사위원회, 재심사 – 산재보험재심사위원회(2008년 7월 이후)

2006. 12. 13. 경제사회발전노사정위원회는 노사정 합의를 통하여 산재 제도의 전반적인 개선에 관하여 합의하였다. 이 중 심사 절차와 관련된 내용을 살펴보면, 회의의 **효율적인 운영**을 위하여 전문위원회 및 분과위원회를 구성·운영하도록 한 점, 심사결정의 **공정성을 제고**하기 위하여 위원회 체계로 변경하도록 한 점 등이 확인된다.

산재보험 제도 개선에 관한 노사정 합의문(안)

우리의 산업재해보상보험제도는 지난 1964년에 도입된 이래 재해근로자의 치료와 보상, 사회복귀 촉진을 위해 그간 적용대상, 보상수준·범위 등이 지속적으로 확대되어 산업재해에 대한 사회안전망으로서의 역할을 수행하여 왔다.

그러나 그동안의 산재보험이 요양관리, 재활서비스, 급여체계 등 제도 전반에 걸쳐 신속·공정한 산재근로자 보호라는 본연의 취지에 미흡하여 각계로부터 산재근로자에 대한 보장성을 강화하는 한편 보험관리의 효율성을 기하도록 제도개혁의 필요성이 계속 제기되어 왔다.

이에 따라 노사정은 '06.5.23 노사정위원회에 노·사·정 및 공익이 참여하는 『산업재해보상보험발전위원회』를 설치하여 산재보험제도 전반의 문제를 공론화 하고 각계의 의견을 수렴하면서 집중적으로 그 개선방안을 모색하여 왔다.

그 결과, 산재보험 40년 역사상 최초로 노사정 협의를 통해 산재보험의 재정·징수, 요양·재활, 급여체계, 보험적용, 관리 운영체계 등 5개 분야, 42개 과제, 80개 항목에 이르는 포괄적인 합의를 이뤄냈다.

이번 산재보험제도 개선 합의는 부문별로 다음과 같은 방향으로 제도를 개선하는데 역점을 두었다.

첫째, 보험재정·징수와 관련하여 업종별 보험료 부담의 형평성을 제고하면서 보험재정의 중장기적 안정성을 확보하도록 하였다.

둘째, 요양·재활과 관련하여 양질의 의료·재활 서비스 확충을 통해 재해근로자의 직장·사회복귀를 촉진하되, 요양기준과 절차를 합리화 하도록 하였다.

셋째, 보험급여와 관련하여 저소득 근로자 및 직업재활 근로자의 보장성을 강화하는 한편, 재해근로자 상호간 급여의 형평성·공정성을 제고하도록 하였다.

넷째, 관리 운영체계와 관련하여 보험관리·운영에의 노사참여를 대폭 확대하고, 심사·재심사 제도의 공정성·전문성을 강화하도록 하였다.

앞으로, 우리 노사정은 이번 합의 정신을 바탕으로 산재보험제도가 지속 발전하여 산업재해에 대한 사회안전망으로서의 역할을 다하도록 지속적으로 함께 노력할 것을 다짐

한다.

2006년 12월 13일

노사정위원회 산업재해보상보험발전위원회

산재보험 제도 개선 합의사항

5. 관리·운영체계 부문

5-1 산업재해보상보험심의위원회

5-1-1 (위원회 운영규정 신설) 노·사·정·공익이 ‘보험사업에 관한 중요사항을 심의’하는 산업재해보상보험심의위원회는 실질 심의의 활성화를 위해 운영절차 등에 관한 규정을 마련한다.

5-1-2 (전문위원회 확대 개편) 산업재해보상보험심의위원회 회의의 효율적인 운영을 위하여 위원회 산하에 전문위원회를 설치하되, 운영, 요양·재활, 급여 등 분야별 분과위원회를 구성·운영한다.

5-1-3 (공익위원 선임) 산업재해보상보험심의위원회의 공익위원 선임시에는 사전에 노사단체의 의견을 수렴한다.

5-2 산재심사재심사 제도

5-2-1 (심사제도) 현재 보험급여 결정에 대한 심사청구시 단독심사 되고 있는 산재심사 제도는 심사결정의 공정성을 제고하기 위해 근로복지공단 본부에 ‘산업재해보상보험심사위원회’를 설치하여 심사 결정하는 위원회 체제로 변경한다.

5-2-2 (재심사제도) 현재 재심사 청구에 대한 심리를 담당하고 있는 ‘산업재해보상보험심사위원회’는 ‘산업재해보상보험재심사위원회’로 그 명칭을 변경한다.

5-2-3 (심사·재심사 위원수) 심사위원회 및 재심사위원회의 위원 수는 보험급여 분야별 전문가 확보를 위해 각 60명으로 하되, 각 위원회 위원 중 노사추천 위원의 비율은 전체 위원의 2/5 수준으로 하되, 공익위원 선임시에는 사전에 이를 노사단체에 고지한다.

5-3 근로복지공단·산업안전공단·산재의료관리원 운영에의 노사참여 확대

5-3-1 (노사추천 이사) 근로복지공단·산업안전공단·산재의료관리원 이사 중 노사추천 이사는 현행 각 1명에서 각 2명으로 확대한다.

5-3-2 (공단별 운영위원회 설치) 공단 이사회 안건의 실무 검토와 공단 사업의 평가를 위해 각 기관의 이사회 산하에 노사 및 전문가 등으로 구성되는 운영위원회를 설치·운영한다.

5-4 근로복지공단 자문의사 제도

5-4-1 (근로복지공단 자문의사제도) 근로복지공단 자문의사 제도 운영과 관련하여 전문 과목별 위촉·운영 및 노사추천 등의 기준을 구체적으로 규정하여 운영한다.

5-5 산재예방·산재보험 사업에의 노사공동 조사 연구사업 활성화

5-5-1 (산재 취약근로자 보호) 산업재해예방 및 산재보험에의 접근이 어려운 취약계층 근로자 보호를 위해 노사 공동으로 조사·연구사업 등을 활성화해 나가되 필요시 정부는 이를 적극 지원한다.

이에 따라 2007. 12. 14. 산업재해보상보험법 전부 개정으로 근로복지공단이 단독 심 체제로 심리·결정하던 심사청구 사건에 대하여 산재보험심사위원회를 설치하여 관계 전문가 등이 심리·결정하도록 하였다. 그리고 기존에 재심을 담당하던 산재심사위원회는 산재재심사위원회가 담당하도록 하였다. 개정이유는 이를 **심사의 객관성과 전문성 부족 등의 문제를 해소**하기 위한 것이라고 밝히고 있다. 정리하면, 근로복지공단에 관계 전문가 등으로 구성되는 산업재해보상보험 심사위원회를 설치하여 근로복지공단이 보험급여 결정 등에 관한 심사 청구 사건에 대하여 심리·결정할 때에는 동 심사위원회의 심의를 거치도록 하였다. 이를 통해 심사 청구 사건에 대한 근로복지공단의 심리·결정의 객관성과 전문성 확보, 공정성 문제 해소를 기대⁸⁰⁾하였다.

산업재해보상보험법

[시행 2008. 7. 1.] [법률 제8694호, 2007. 12. 14., 전부개정]

[전부개정]

◇개정이유

경제사회발전노사정위원회에서 합의·의결(2006. 12. 13)한 산업재해보상보험제도 개선안을 토대로 산재근로자에 대한 의료·재활서비스는 확충하되 산재근로자 및 의료기관의 요양관리는 합리화하여 산재근로자의 직업·사회복귀를 촉진하고, 저소득·재활근로자에 대한 보호를 강화하되 산재근로자 간 보험급여의 형평성과 합리성을 높이며, 보험급여결정 등에 관한 심사청구·재심사 청구의 전문성 및 공정성을 강화하려는 것임.

◇주요내용

차. 산업재해보상보험 심사위원회의 설치(법 제104조)

(1) 현재 보험급여에 관한 근로복지공단의 결정에 불복하는 경우에 제기하는 심사

80) 김수복, 「산업재해보상보험법」, (주)중앙경제, 2008, 665면.

청구 사건에 대하여 근로복지공단이 단독심 체제로 심리·결정하고 있어 객관성과 전문성 부족 등에 대한 문제가 제기되고 있음.

(2) 근로복지공단에 관계 전문가 등으로 구성되는 산업재해보상보험 심사위원회를 설치하여 근로복지공단이 보험급여 결정 등에 관한 심사 청구 사건에 대하여 심리·결정할 때에는 동 심사위원회의 심의를 거치도록 함.

(3) 심사 청구 사건에 대한 근로복지공단의 심리·결정의 객관성과 전문성이 높아지고 공정성 문제가 해소될 것으로 기대됨.

산업재해보상보험법상 보험급여에 관한 결정에 불복이 있는 자는 근로복지공단에 설치된 산재보험심사위원회에 심사청구를 할 수 있고 심사청구에 대한 결정에 불복이 있는 자는 산재보험재심사위원회에 재심사 청구를 할 수 있으나, 「행정심판법」에 의한 행정심판은 제기할 수 없다(제103조). 보험급여에 대한 심사 및 재심사 청구의 특수성으로 인하여 행정심판법에 대한 특별법으로 제정된 것이기 때문이다. 정리하면, 보험급여에 대한 이의 심사는 전문적·기술적인 지식이 요구되고 피해근로자나 그 유족의 보호를 위해서는 신속하고 간편하게 해결할 필요가 있다. 그러므로 일반 행정심판기관과는 다른 별도의 특수한 행정심판기관인 근로복지공단·산업재해보상보험심사위원회 등에 의한 심사제도를 채택하고 있다.⁸¹⁾

현행 산업재해보상보험법

제103조(심사 청구의 제기) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공단의 결정 등(이하 “보험급여 결정등”이라 한다)에 불복하는 자는 공단에 심사 청구를 할 수 있다.

② 제1항에 따른 심사 청구는 그 보험급여 결정등을 한 공단의 소속 기관을 거쳐 공단에 제기하여야 한다.

③ 제1항에 따른 심사 청구는 보험급여 결정등이 있음을 안 날부터 90일 이내에 하여야 한다.

④ 제2항에 따라 심사 청구서를 받은 공단의 소속 기관은 5일 이내에 의견서를 첨부하여 공단에 보내야 한다.

⑤ 보험급여 결정등에 대하여는 「행정심판법」에 따른 행정심판을 제기할 수 없다.

제104조(산업재해보상보험심사위원회) ① 제103조에 따른 심사 청구를 심의하기 위하여 공단에 관계 전문가 등으로 구성되는 산업재해보상보험심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)를 둔다.

81) 김수복, 「산업재해보상보험법」, (주)중앙경제, 2008, 644-645면 참고.

(2) 심사 청구의 기능

산업재해보상보험법은 보험급여에 관하여 당해 보험급여를 행한 공단의 소속기관을 거쳐 공단에 제기하도록 1차 심사권을 부여함으로써 **신속한 권리구제**와 업무의 **자율적 개선 효과**를 유도하고 있다.⁸²⁾

○ **(자율적 통제)** 심사제도는 행정심판의 성격을 가진다. 행정심판은 행정법 관계에 관한 법적 분쟁에 대하여 행정기관이 재결청이 되어 심리·판단하는 쟁송 절차를 뜻하는 것이므로 행정작용의 적법·타당 여부에 대한 제1차적 통제를 타부의 관여 없이 행정부가 자율적으로 하게 되어, 행정권의 자율성이 보장된다.

○ **(행정능률의 보장)** 사법절차에 의한 행정상 분쟁의 심판은 심리 절차의 공정 및 신중으로 인하여 개인의 권리구제에는 충실할 수 있으나 상당한 시일이 필요하기 때문에 행정능률에 어긋나는 일이 적지 아니하다. 행정쟁송의 계속 중에는 보험급여 관계는 불안정한 상태에 있으므로 오늘날과 같은 신속을 요하는 행정의 수행을 위하여 사법절차에 앞서 신속·간편한 심사제도를 인정함으로써 보험급여에 관한 분쟁의 신속한 해결을 도모하는 것이 합리적이다.

○ **(전문지식의 활용)** 현대산업사회에서 볼 수 있는 새로운 사회적·경제적 문제, 특히, 보험급여는 전문성과 기술성을 지니고 있는데 일반법원은 그러한 전문적·기술적 문제의 처리에는 적합하지 않은 점이 많다. 반면, 행정기관은 그러한 전문적·기술적 문제의 처리에 적합하게 조직되어 있으므로 적어도 행정쟁송의 제1차적인 단계에서는 전문기관인 행정청으로 하여금 그에 관한 분쟁을 심판하도록 하는 것이 필요하다. 보험급여에 관한 처분은 비교적 다량으로 행하여지고 심사 청구의 건수도 많기 때문에 보험급여의 공정한 지급과 심사안건의 적절한 처리를 위하여 전문적이고 기술적인 지식을 갖춘 특별한 심사기관을 설치하였다.

○ **(소송경제의 확보)** 사법절차는 법원·소송당사자 기타의 관계인에게 막대한 노력, 경비 등을 부담하게 할 뿐만 아니라, 심리에 상당한 장시간을 요하는 것이 보통이다. 이에 비하여 심사제도는 경비, 시간 등을 절감할 수 있다. 그러므로 심사제도를 인정하는 것은 사법절차(행정소송)와의 상호 보완관계 아래 전체로서 합리적인

82) 김수복, 「산업재해보상보험법」, (주)중앙경제, 2008, 645면.

행정쟁송제도를 이룩하는데 도움이 된다.

(3) 심사의 범위

심사청구가 제기되면 근로복지공단은 당해 사건에 대한 결정의 기초가 될 각종 사실 및 증거 등 자료를 수집하고 정리하는 절차를 밟게 되는데 이 절차를 '심리'라고 한다. '결정'이란 근로복지공단이 심사청구에 대한 심리의 결과를 판단하는 행위다. 즉, 심사 청구 사건에 대한 종국적 판단인 의사표시를 가리켜 결정이라 한다. 결정은 법률관계의 존부 또는 정부에 관한 분쟁에 대하여 근로복지공단이 일정한 절차를 거쳐서 판단·확정하는 행위이기 때문에 확인행위로서의 성질을 가진다. 결정은 특정한 보험급여 등에 관한 분쟁의 제기인 심사청구를 전제하는 것일 뿐만 아니라 판단작용이라는 점에서 법원의 판결과 성질이 비슷한 준사법행위라고 볼 수 있다.⁸³⁾ 근로복지공단은 당해 심사청구의 대상인 보험급여처분의 법률문제(적법·위법)에 한하지 아니하고 당·부당의 재량문제를 포함한 사실문제에 대하여도 심리할 수 있다. 심사청구는 위법한 보험급여 처분뿐만 아니라 부당한 보험급여처분에 대하여도 인정되기 때문이다.⁸⁴⁾

심리의 범위가 당해 심사청구의 취지에 의하여 제한되는지 여부에 관하여 견해의 대립이 있다. 적극설은 심사청구의 행정구제수단으로서의 성질에 중점을 두어 불이익 변경금지의 원칙 등이 심사청구의 심리·결정에도 타당하다고 본다. 소극설은 심사청구가 행정의 합법성 및 합목적성의 확보에 목적이 있는 점에 주안점을 두어 심사청구의 심리·결정에는 이러한 원칙이 적용되지 않는다고 한다. 청구의 행정구제적 기능을 살리기 위하여 심판청구에도 불고불리의 원칙과 불이익변경금지의 원칙이 적용됨을 명시(행정심판법 제47조)⁸⁵⁾하였으므로, 청구인이 심판청구를 하지 아니한 사항에 대하여 심리하거나 청구의 취지에 반하여 원처분보다 불이익한 내용을 심리·재결을 할 수 없다.⁸⁶⁾ 따라서 청구인이 심사청구를 하지 아니한 사항에 대하여

83) 김수복, 「산업재해보상보험법」, (주)중앙경제, 2008, 658면.

84) 김수복, 「산업재해보상보험법」, (주)중앙경제, 2008, 655면.

85) 행정심판법 제47조(재결의 범위) ① 위원회는 심판청구의 대상이 되는 처분 또는 부작위 외의 사항에 대하여는 재결하지 못한다.

② 위원회는 심판청구의 대상이 되는 처분보다 청구인에게 불리한 재결을 하지 못한다.

86) 김수복, 「산업재해보상보험법」, (주)중앙경제, 2008, 655면. 첫째, 처분청 자체나 처분청의 상급감독청이 심리·재결을 하게 되는 경우에는 심사 청구의 유무에 관계없이 직권에 의하여 이미 한 처분 등을 재심사할 수 있는 것이므로 불고불리의 원칙이나 불이익변경금지의 원칙이 타당하지 아니하다고 볼 수 있다. 둘째, 심사 청구의 심리·결정을 위하여 특별히 설치된 특별기관(산업재해보상보험심사위원회, 산업재해보상보험재심사위원회)이 심리·결정을 하는 때에는 심사 청구의 제기가 있음으로써 비로소 원처분을 심사할 수 있으므로 특별한 규정이 없으면 그의 심리결정에는 불고불리의 원칙과 불이익 변경금지의 원칙이 적용된다고 보아야 할 것이다.

심리하거나 청구의 취지에 반하여 원처분보다 불이익한 내용의 심리·재결을 할 수 없다.⁸⁷⁾

(4) 심사의 성격 및 원칙

심사청구에 대한 결정은 하자가 있는 보험급여처분으로 인한 개인의 권익침해를 구제하는 제도로써 준사법작용으로서의 성질을 가진다. 즉, 결정은 일정한 사실인정과 관계 법령의 해석·적용을 통하여 다툼이 있는 구체적 보험급여처분의 적법·타당성을 판단하는 행위로서 법원의 재판과 유사한 절차로서 준사법적 성질을 지닌다.⁸⁸⁾ 심리 절차의 기본원칙으로는 대심주의, 서면심리주의, 직권주의가 있다.⁸⁹⁾

○ **(대심주의)** 심사청구의 당사자를 심사청구인과 원처분을 한 공단으로 구분하여 대립 관계로 정립하고, 공격·방어의 방법을 통해 심리의 객관성과 공정성을 확보하기 위한 것이다.

○ **(서면심리주의)** 심사제도는 행정의 효율성과 경제성을 고려하여 서면심리주의를 채택하고 있다.

○ **(직권주의)** 직권주의란 당사자주의에 대응한 것으로서 심리의 진행을 심리기관의 직권으로 하는 동시에 심리에 필요한 자료를 당사자가 제출하는 것에만 의존하지 아니하고 직권으로 조사 수집하는 것을 말한다. 심사청구의 심리에서 직권주의가 요청되는 이유는 첫째, 심리의 간·신속을 도모하기 위한 것이며, 둘째, 개인의 권리구제의 측면뿐만 아니라 보험사업의 운영상 적정화를 도모하기 위한 공익적 측면이 있으므로 실질적 진실의 발견이 요구되기 때문이다.

(5) 심사결정의 효력

심사 결정의 효력으로는 구속력, 불가쟁력과 불가변력 등이 있다.⁹⁰⁾

87) 이상국, 「산재보험법(II)」, 대명출판사, 2017, 810-811면 참고.

88) 이상국, 「산재보험법(II)」, 대명출판사, 2017, 809면.

89) 이상국, 「산재보험법(II)」, 대명출판사, 2017, 811-812면 참고.

90) 이상국, 「산재보험법(II)」, 대명출판사, 2017, 817-818면 참고. 다만, 산재보험법은 형성력에 관한 규정을 두고 있지 않다. 형성력이란 기존의 법률관계에 변동은 가져오는 효력을 말하는데, 보험급여처분에 관한 심사청구는 행정처분을 한 공단을 기속하지만 심사결정에 의하여 해당 행정처분이 당연히 취소·변경되는 것은 아니고 그 결정에 따라 공단이 취소·변경하는 처분을 하여야 비로소 그 효력이 나타나게 된다.

○ **(구속력)** 결정의 구속력이란 심사청구의 당사자 기타 관계인이 그 결정의 취지에 따르도록 강제하는 효력을 말한다. 심사위원회의 결정이 있으면 피청구인인 공단은 결정의 내용을 실현할 의무를 지며, 원처분을 취소하는 내용의 결정이 있는 경우, 같은 사정하에서는 동일한 내용의 처분을 하지 못하게 된다.

○ **(불가쟁력과 불가변력)** 불가쟁력은 한번 결정을 받으면 다시 동일한 절차에 의하여 그 효력을 다투지 못하게 하는 것을 말한다. 따라서 심사 결정에 대하여 다시 심사청구를 제기하지 못하며, 결정 자체에 이의가 있는 경우에는 다른 절차인 재심사의 절차를 이용할 수 있을 뿐이다. 결정은 다른 일반 행정행위와는 달리 쟁송절차에 의하여 행하여진 것이므로 일단 결정을 한 이상 공단은 임의로 취소·변경할 수 없는 효력을 가진다.

○ **(기타 효력)** 심사위원회의 결정행위는 법률에 의하여 위임된 행정행위의 일종이므로 다른 행정행위 일반의 경우와 마찬가지로 공정력을 가진다. 즉, 결정은 당연히 무효에 해당되지 않는 한, 소정의 절차에 따라 취소·변경될 때까지는 일단 적법한 것으로 추정되어 유효하게 적용된다.

(6) 심사의 절차

공단의 결정에 대하여 불복하는 자는 공단에 심사청구를 제기할 수 있다(제103조). 심사를 제기할 수 있는 결정은 **보험급여·진료비·약제비에 관한 결정, 진료계획 변경 조치, 보험급여의 일시지급에 관한 결정, 합병증 등 예방관리에 관한 조치, 부당이득의 징수에 관한 결정, 수급권의 대위에 관한 결정**으로 규정되어 있다(제1항 제1호 내지 제7호). 이에 따라 해당 범위를 벗어나는 경우에는 일반행정심판 절차에 의하여 구제를 받을 수 있다. 심사청구는 보험급여 결정 등이 있음을 안 날로부터 90일 이내, 결정 등을 한 공단의 소속기관을 거쳐 공단에 제기하여야 한다(제2항 및 제3항). 특히, 보험급여의 결정 등에 대해서는 「행정심판법」에 따른 행정심판을 제기할 수 없다고 규정하고 있어(제5항), 일반행정심판에 대한 특별절차임을 명시하고 있다. 심사청구를 심의하기 위하여 공단에 관계 전문가 등으로 구성되는 산업재해보상보험심사위원회를 두며(제104조), 구성 및 운영에 관한 사항은 시행령에 별도로 규정되어 있다.

제99조(산업재해보상보험심사위원회의 구성)⁹¹⁾ ① 법 제104조제1항에 따른 산업재해보상보험심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)는 위원장 1명을 포함하여 150명 이내의 위원으로 구성하되, 위원 중 2명은 상임으로 한다. <개정 2010. 3. 26., 2015. 4. 14.>

제100조(심사위원회의 운영) ① 심사위원회의 위원장은 심사위원회의 회의를 소집하고, 그 의장이 된다. 다만, 위원장은 심사위원회의 원활한 운영을 위하여 필요하면 상임위원 또는 그 밖에 위원장이 지명하는 위원이 심사위원회의 회의를 주재하도록 할 수 있다. <개정 2016. 3. 22.>

공단은 심사청구서를 받은 날부터 60일 이내에 심사위원회 심의를 거쳐 심사청구에 대한 결정을 해야 하나, 부득이한 사유가 있는 경우 20일을 넘지 아니하는 범위에서 기간을 연장할 수 있다(제105조 제1항).

산재보험 심사업무처리규정

제10조(처리기간의 연장 사유 통보 등) ① 이사장은 법 제105조제1항 단서에 따라 심사청구에 대한 처리기간을 연장할 때에는 청구인에게 연장 사유와 처리예정 기간을 지체 없이 문서로 통지하여야 한다.

② 이사장은 청구인이 제8조제5항에 따른 보충서면 또는 추가 증거자료 제출 기한의 연장을 요청하면 10일 이내의 기간을 주어 보완하도록 할 수 있다. 다만, 지정한 기한까지 자료를 보완하지 아니하는 때에는 이미 제출된 자료만으로 심리·결정할 수 있다.

공단은 심사청구의 심리를 위하여 필요한 경우 ①청구인의 신청이나 직권으로 청구인이나 관계인을 지정 장소에 출석하게 하여 질문하거나 의견을 진술하게 하는 것, ②청구인이나 관계인에게 증거가 될 수 있는 문서나 그 밖의 물건을 제출하게 하는 것, ③전문적인 지식이나 경험을 가진 제3자에게 감정하게 하는 것, ④소속 직원에게 사건과 관계가 있는 사업장이나 그 밖의 장소에 출입하여 사업주·근로자, 그 밖의 관계인에게 질문하게 하거나, 문서나 그 밖의 물건을 검사하게 하는 것, ⑤심사청구와 관계가 있는 근로자에게 공단이 지정하는 의사·치과의사 또는 한의사의 진단을 받게 하는 것의 행위를 할 수 있다(제4항 제1호 내지 제5호).

공단의 불승인·부지급 결정 통보에 대해서는 심사청구를 제기하거나 바로 행정소

91) ② 심사위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 공단 이사장이 위촉하거나 임명한다.

1. 판사·검사·변호사 또는 경력 5년 이상의 공인노무사
2. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 조교수 이상으로 재직하고 있거나 재직하였던 사람
3. 노동 관계 업무 또는 산업재해보상보험 관련 업무에 10년 이상 종사한 사람
4. 사회보험이나 산업의학에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람

송을 제기할 수 있고, 심사청구 결정에 대해서도 재심사 청구를 제기하거나 행정소송을 선택할 수 있다. 즉, 심사 및 재심사는 임의 절차에 해당한다.

[그림 2-1] 심사·재심사 청구 절차도⁹²⁾



4. 산재 재심사

(1) 개관

2007. 12. 14. 산업재해보상보험법 전부 개정으로 심사청구에 대하여는 산업재해보상보험심사위원회에서, 재심사 청구는 산업재해보상보험재심사위원회에서 처리되도록 2심 제도를 명확히 하였다.⁹³⁾ 정리하면, 2008년 7월 이전에는 근로복지공단이 산업재해보상보험 심사 기능을, 산업재해보상보험 심사위원회가 현재의 재심사위원회 기능을 하였다.⁹⁴⁾ 이후 법 개정으로 2008년 7월 이후부터 산업재해보상보험 심사위원회가 심사를, 산업재해보상보험 재심사위원회가 재심사를 담당하게 되었다.

산업재해보상보험 재심사위원회 연혁⁹⁵⁾

- 2018.06.12. - 위원수를 90인으로 증원
- 2008.07.01. - 산업재해보상보험재심사위원회로 기관명칭 직제 개정, 위원수 60인으

92) 근로복지공단 홈페이지, <https://www.comwel.or.kr/comwel/comp/eval/psyc.jsp>(2023. 7. 20. 확인).

93) 김수복, 「산업재해보상보험법」, (주)중앙경제, 2008, 647면.

94) 1995년 이전에는 노동부 심사관이 심사업무를 담당하여 차이가 있다.

로 증원

- 1999.12.31. - 위원수를 30인으로 증원
- 1995.05.01. - 산업재해보상보험법에 위원회 설치 근거를 마련하고 산업재해보상보험 업무 및 심사에 관한 법률 폐지
- 1993.08.05. - 위원수를 15인으로 증원
- 1992.12.12. - 산업재해보상보험심사위원회 사무국직제 제정으로 사무국 신설, 상임위원 2인포함 사무국정원 10인을 둠
- 1970.12.31. - 산업재해보상보험심사위원회 사무국 설치근거 마련, 위원수를 7인으로 증원(상임위원 2인 포함)
- 1965.03.12. - 산업재해보상보험심사위원회 발족, 위원수 5인(상임위원 1인 포함)
- 1963.12.16. - 산업재해보상보험업무및심사에관한법률제정으로 위원회 설치근거 마련

산업재해보상보험법

[시행 2008. 7. 1.] [법률 제8694호, 2007. 12. 14., 전부개정]

제6장 심사 청구 및 재심사 청구

제103조(심사 청구의 제기)

제104조(산업재해보상보험심사위원회)

제105조(심사 청구에 대한 심리·결정)

제106조(재심사 청구의 제기) ① 제105조제1항에 따른 심사 청구에 대한 결정에 불복하는 자는 제107조에 따른 산업재해보상보험재심사위원회에 재심사 청구를 할 수 있다. 다만, 판정위원회의 심의를 거친 보험급여에 관한 결정에 불복하는 자는 제103조에 따른 심사 청구를 하지 아니하고 재심사 청구를 할 수 있다.

② 제1항에 따른 재심사 청구는 그 보험급여 결정등을 한 공단의 소속 기관을 거쳐 제107조에 따른 산업재해보상보험재심사위원회에 제기하여야 한다.

제107조(산업재해보상보험재심사위원회) ① 제106조에 따른 재심사 청구를 심리·재결하기 위하여 노동부에 산업재해보상보험재심사위원회(이하 “재심사위원회”라 한다)를 둔다.

② 재심사위원회는 위원장 1명을 포함한 60명 이내의 위원으로 구성하되, 위원 중 2명은 상임위원으로, 1명은 당연직위원으로 한다.

95) 산업재해보상보험 재심사위원회 홈페이지, <https://www.iaciac.go.kr/committee/history/main.do> (2023. 9. 17. 확인)

재심사 청구는 보험급여 등에 관한 공단의 원처분에 대한 심사결정에 대하여 이의가 있는 경우 불복하여 재심의를 하도록 요구하는 것을 말한다. 재심사의 성격과 효력은 심사청구에 의한 결정과 유사하다. 재심사의 청구는 원처분에 대한 심사청구절차를 경유해야 하는 전심절차를 준수해야 하나, 업무상 질병의 경우에는 심사절차를 거치지 아니하고 재심사를 청구할 수 있다.⁹⁶⁾ 공단의 보험급여에 대한 요양불승인 및 요양종결, 휴업급여나 장해급여, 간병급여, 유족급여 및 장의비의 부지급에 대하여는 그 처분을 취소하여 달라는 재심사를 청구할 수 있다. 또한, 보험급여의 결정지급에 대한 불이행 등을 이유로 이행을 요구하는 재심사, 유족급여의 지급이외에 수급권자로서 연금수급자에 해당되는지를 다투는 확인에 관한 재심사청구도 가능하다.⁹⁷⁾

(2) 재심사의 성격

재결이란 재심사청구에 대한 심리의 결과를 판단하는 행위를 말한다. 즉, 재심사 청구 사건에 대한 행정기관의 종국적 판단인 의사표시를 말한다. 재결은 행정처분에 대한 법률관계의 존부 또는 정당성에 관한 분쟁에 대하여 재결청이 일정한 절차를 거쳐서 판단 및 확정하는 행위이기 때문에 확인행위로서 성질을 가진다. 또한, 재결은 판단작용이기 때문에 일정한 사실 또는 법률관계의 존부 또는 정당성에 따라서 하지 않으면 아니 되는 기속행위이다. 재결은 특정한 처분 등에 관한 분쟁의 제기인 재심사 청구를 전제로 하는 것일 뿐만 아니라, 판단의 작용이라는 점에서 법원의 판결과 성질이 비슷한 준사법행위라고 할 수 있다.⁹⁸⁾

(3) 산업재해보상보험 재심사위원회

‘산업재해보상보험재심사위원회’는 재심사 청구 사건을 심리하고 재결하기 위하여 노동부 소속하에 설치한 행정기관을 말한다. 산업재해보상보험법은 재심사 청구에 대한 심리와 재결을 준사법화함으로써 객관적 공정성을 확보하도록 하기 위하여 재심사 청구사건에 대한 심리·재결권을 심사위원회에 부여하고 있다. 재심사위원회는 원처분청인 근로복지공단의 심사청구에 대한 결정에 불복이 있는 경우에 회부된 재심사 청구사건을 심리·재결할 수 있는 권한을 가진 행정위원회로 의결기관으로서의

96) 다만, 업무상질병판정위원회를 거친 경우에도 심사 청구를 제기할 수 있다.

97) 이상국, 「산재보험법(II)」, 대명출판사, 2017, 820-821면 참고.

98) 이상국, 「산재보험법(II)」, 대명출판사, 2017, 827-828면 참고.

성격을 가진다. 재심사 청구 사건에 대하여 심리 결과에 따라 재결할 내용을 독자적으로 의결할 수 있는 권한을 가지므로 재심사위원회의 심리·의결에 관하여는 고용노동부장관이라도 지휘·감독을 할 수 없다.⁹⁹⁾ 합의제 행정기관에 있어서 그 기능의 적절한 수행과 관련하여 가장 중요한 요소 중 하나가 구성이다. 산업재해보상보험법은 심사위원회가 재심청구사건이 가지는 특수성을 살리면서 당해 사건에 대한 심리·재결의 객관적 공정성을 유지할 수 있도록 하기 위하여 심사위원회의 구성에 관한 기본적인 사항을 규정하고 있다.¹⁰⁰⁾

산재보험법 제107조(산업재해보상보험재심사위원회)¹⁰¹⁾ ② 재심사위원회는 위원장 1명을 포함한 90명 이내의 위원으로 구성하되, 위원 중 2명은 상임위원으로, 1명은 당연직 위원으로 한다. <개정 2018. 6. 12.>

산재보험법 시행령 제106조(산업재해보상보험재심사위원회의 구성) ① 법 제107조에 따른 산업재해보상보험재심사위원회(이하 “재심사위원회”라 한다)에 위원장과 3명 이내의 부위원장을 둔다. <개정 2018. 12. 11.>

② 부위원장은 재심사위원회가 위원 중에서 선출한다.

③ 위원장은 재심사위원회를 대표하며, 위원회의 사무를 총괄한다.

④ 부위원장은 위원장을 보좌하며, 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없을 때에는 그 직무를 대행한다.

제107조(재심사위원회의 운영) ① 위원장은 재심사위원회의 회의를 소집하고, 그 의장이 된다. 다만, 재심사위원회의 원활한 운영을 위하여 필요하면 위원장의 명을 받아 부위원장이 재심사위원회의 회의를 주재할 수 있다

② 위원장은 재심사위원회의 회의를 소집하려면 회의 개최 5일 전까지 회의의 일시·장소 및 안건을 위원들에게 서면으로 알려야 한다. 다만, 긴급하게 회의를 소집하여야 할 때에는 회의 개최 전날까지 구두(口頭), 전화, 그 밖의 방법으로 알릴 수 있다.

③ 재심사위원회의 회의는 위원장 또는 부위원장, 상임위원 및 위원장이 회의를 할 때마다 지정하는 위원을 포함하여 9명으로 구성한다. 이 경우 위원장이 지정하는 위원 중에는 법 제107조제5항제2호의 자격이 있는 위원과 같은 항 제5호의 자격이 있는 위원이 각각 1명 이상 포함되어야 한다. <개정 2010. 3. 26.>

④ 재심사위원회의 회의는 제3항에 따른 구성원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다. 이 경우 제3항 후단에 따른 자격이 있는 위원이 각각 1명 이상 출석하여야 한다.

99) 김수복, 「산업재해보상보험법」, (주)중앙경제, 2008, 668면.

100) 김수복, 「산업재해보상보험법」, (주)중앙경제, 2008, 669면.

101) ⑤ 재심사위원회의 위원장 및 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 고용노동부

산재보험법은 재심사위원회 위원의 제척·기피·회피에 관한 사항을 규정하고 있는데(제108조), 이는 심사위원회에 준용된다(제104조). 재심사 청구의 심리와 재결에 관하여는 심사의 심리와 결정에 관한 규정이 준용된다(제109조).¹⁰²⁾ 재심사위원회의 심리는 공개하여야 하나, 청구인의 신청이 있으면 공개하지 아니할 수 있다(시행령 제109조). 재심사위원회는 재심사의 심리 경과에 대하여 심리조사를 작성해야 하며(시행령 제110조), 재심사 청구의 효율적인 심리를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에는 전문 분야별 소위원회를 구성·운영할 수 있다(시행령 제111조). 고용노동부장관은 산업재해보상보험, 산업의학, 산업간호, 유해물질 관리 및 방사선 등 재심사위원회의 재심사 업무에 필요한 전문적인 조사·연구를 위해 5명 이내의 조사연구원을 둘 수 있다(시행령 제112조).

(4) 재심사 절차

심사청구 결정에 불복하는 자는 산업재해보상보험재심사위원회(이하, '산재재심사위원회'라 함)에 재심사 청구를 할 수 있는데, 판정위원회의 심의를 거친 보험급여 결정에 불복하는 자는 심사청구를 하지 않고 바로 재심사 청구를 할 수 있다(제106조 제1항). 재심사 청구는 보험급여 결정 등을 한 공단의 소속 기관을 거쳐 산업재해보상보험재심사위원회에 제기하여야 하며, 심사 결정이 있음을 안 날부터 90일 이내 제기하여야 한다. 다만, 심사청구를 거치지 아니하고 재심사 청구를 하는 경우에는 보험급여에 관한 결정이 있음을 안 날로부터 90일 이내에 제기하여야 한다(제2항 내지 제3항).

장관의 제청으로 대통령이 임명한다. 다만, 당연직위원은 고용노동부장관이 소속 3급의 일반직 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직 공무원 중에서 지명하는 사람으로 한다. <개정 2010. 1. 27., 2010. 6. 4., 2020. 5. 26.>

1. 3급 이상의 공무원 또는 고위공무원단에 속하는 일반직 공무원으로 재직하고 있거나 재직하였던 사람

2. 판사·검사·변호사 또는 경력 10년 이상의 공인노무사

3. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교에서 부교수 이상으로 재직하고 있거나 재직하였던 사람

4. 노동 관계 업무 또는 산업재해보상보험 관련 업무에 15년 이상 종사한 사람

5. 사회보험이나 산업의학에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람

⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 위원에 임명될 수 없다(각호 생략).

⑦ 재심사위원회 위원(당연직위원은 제외한다)의 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있고, 위원장이나 위원의 임기가 끝난 경우 그 후임자가 임명될 때까지 그 직무를 수행한다. <개정 2010. 1. 27., 2018. 6. 12.>

⑧ 재심사위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 그 의사에 반하여 면직되지 아니한다(각호 생략).

102) 심사와 재심사의 제도가 별도로 규정되면서 각각 서로의 제도를 준용하고 있어 체계정합성이 다소 미흡하다고 판단된다.

[그림 2-2] 산재 재심사 사건처리 절차¹⁰³⁾



5. 감사원 및 중앙행정심판위원회 구제 절차

(1) 감사원

감사원은 국가의 세입·세출의 결산, 국가 및 법률이 정한 단체의 회계검사와 행정기관 및 공무원의 직무에 관한 감찰을 하기 위하여 설치된 대통령 소속 하의 중앙행정관청인 헌법기관이다(헌법 제97조). 감사원의 지위에 대해서는 감사원을 행정부에 귀속시키면서도 행정각부·국무총리·국무회의로부터 자유로운 특수한 최고행정기관이라고 보는 견해, 감사원이 행정부의 수반으로서의 대통령에 속하는 행정관청이지만 직무상으로는 대통령으로부터 독립되어 있다는 견해, 감사원이 국가원수로서의 대통령에 소속되어 있을 뿐 입법부와 행정부 그 어느 편에도 속하지 아니하는 독립기관이라는 견해 등이 있다.¹⁰⁴⁾ 감사원은 결산 및 회계검사권(감사원법 제21조 이하), 직무감찰권(제24조), 회계관계법령의 제정, 개폐 및 해석적용에 관한 의견제시권(제49조), 감사대상기관 이외의 자에 대한 협조요구권(제50조), 감사결과에서 문제

103) 산업재해보상보험 재심사위원회 홈페이지, <https://www.iaciac.go.kr/policy/procedure/main.do> (2023. 10. 16. 확인).

104) 류지태·박종수, 「행정법신론」, 박영사, 2021, 807면.

가 있는 사안인 경우 변상책임 유무의 판정(감사원법 제31조), 징계 등 요구권(제32조), 시정 등 요구권(제33조), 개선 등 요구권(제34조), 고발권(제35조), 재심의(제36조) 등의 권한을 갖는다.

「감사원법」 제3장은 심사청구에 관하여 규정하고 있는바, 감사원의 감사를 받는 자의 직무에 관한 처분이나 그 밖에 '감사원 감사사무 처리규칙(이하 '감사원규칙'이라 함)'¹⁰⁵⁾으로 정하는 행위에 관하여 이해관계가 있는 자는 감사원에 그 심사의 청구를 할 수 있다(제43조). 심사청구는 '감사원규칙'으로 정하는 바에 따라 청구의 취지와 이유를 적은 심사청구서로 하되, 청구의 원인이 되는 처분이나 그 밖의 행위를 한 기관의 장을 거쳐 제출하여야 한다(동조 제2항). 심사청구는 원인이 되는 행위가 있음을 안 날로부터 90일 이내, 있는 날로부터 180일 이내 심사의 청구를 해야 한다(제44조). 심사청구의 심리나 결정, 행정소송과의 관계 및 관계기관의 조치에 관한 규정은 다음과 같다.

제45조(심사청구의 심리) 심사청구의 심리는 심사청구서와 그 밖에 관계기관이 제출한 문서에 의하여 한다. 다만, 감사원은 필요하다고 인정하면 심사청구자나 관계자에 대하여 자료의 제출 또는 의견의 진술을 요구하거나 필요한 조사를 할 수 있다.

제46조(심사청구에 대한 결정) ① 감사원은 심사의 청구가 제43조 및 제44조와 감사원 규칙으로 정하는 요건과 절차를 갖추지 못한 경우에는 이를 각하한다. 이해관계인이 아닌 자가 제출한 경우에도 또한 같다.

② 감사원은 심리 결과 심사청구의 이유가 있다고 인정하는 경우에는 관계기관의 장에게 시정이나 그 밖에 필요한 조치를 요구하고, 심사청구의 이유가 없다고 인정한 경우에는 이를 기각한다.

③ 제1항 및 제2항의 결정은 특별한 사유가 없으면 그 청구를 접수한 날부터 3개월 이내에 하여야 한다.

④ 제2항의 결정을 하였을 때에는 7일 이내에 심사청구자와 관계기관의 장에게 심사결정서 등본을 첨부하여 통지하여야 한다.

제46조의2(행정소송과의 관계) 청구인은 제43조 및 제46조에 따른 심사청구 및 결정을 거친 행정기관의 장의 처분에 대하여는 해당 처분청을 당사자로 하여 해당 결정의 통지를 받은 날부터 90일 이내에 행정소송을 제기할 수 있다.

제47조(관계기관의 조치) 관계기관의 장은 제46조에 따른 시정이나 그 밖에 필요한 조

105) 감사원 감사사무 처리규칙

치를 요구하는 결정의 통지를 받으면 그 결정에 따른 조치를 하여야 한다.

제48조(일사부재리) 제46조에 따른 심사결정이 있는 사항에 대하여는 다시 심사를 청구할 수 없다. 다만, 각하한 사항에 대하여는 그러하지 아니하다.

특기할 점은, 감사원은 이해관계인으로부터 심사청구가 있는 경우에 그에 대한 결정으로 행정기관이 행한 처분을 직접 취소·변경할 수 없고, 관계행정기관의 장에게 시정 기타의 필요한 조치를 요구할 수 있는데 그치며, 그러한 요구가 있으면 관계행정기관이 요구받은 조치를 행하도록 되어 있다는 점이다.¹⁰⁶⁾ '감사원 규칙'에 의하면, 감사대상은 "법 제22조¹⁰⁷⁾ 및 제23조¹⁰⁸⁾에 따라 회계감사를 받거나 법 제24조¹⁰⁹⁾에 따라 직무감찰을 받는 대상"으로 정의되어 있으며, 근로복지공단 역시 감사 대상에 포함된다.

근로복지공단의 처분을 대상으로 한 감사원의 심사청구 현황은 다음과 같다. 감사원 심사청구의 취소율은 2022년 기준 0.8%이며(2022년 3건 취소), 취소율은 매우 낮은 것으로 파악된다.

감사원 심사청구 현황¹¹⁰⁾

가. 감사원 심사청구 신규 접수건수: 324건

- 21년도 358건 대비 34건(9.5%) 감소
- 전년도 대비 요양·보상분야 9.5% 감소, 적용·징수분야 3.78% 감소
(요양·보상: 328건 → 297건, 적용·징수: 27건 → 26건)

나. 감사원 심사청구 취소율: 0.8%

- 21년도 1.6% 대비 0.8%p 감소
- 22년도 확정사건 366건 중 3건 취소

<감사원 심사청구 전체 현황>

106) 정하중·김광수, 「행정법개론」, 법문사, 2022, 1297면.

107) 감사원법 제22조(필요적 검사사항)

108) 제23조(선택적 검사사항)

109) 제24조(감찰 사항) ① 감사원은 다음 각 호의 사항을 감찰한다.

1. 「정부조직법」 및 그 밖의 법률에 따라 설치된 행정기관의 사무와 그에 소속한 공무원의 직무
2. 지방자치단체의 사무와 그에 소속한 지방공무원의 직무
3. 제22조제1항제3호 및 제23조제7호에 규정된 자의 사무와 그에 소속한 임원 및 감사원의 검사대상이 되는 회계사무와 직접 또는 간접으로 관련이 있는 직원의 직무
4. 법령에 따라 국가 또는 지방자치단체가 위탁하거나 대행하게 한 사무와 그 밖의 법령에 따라 공무원의 신분을 가지거나 공무원에 준하는 자의 직무

구분	접수			확정사건결과						계류중
	계	이월	신규	계	기각	취소	일부 취소	각하 등	취소율	
21년	590	232	358	173	210	5	0	92	1.6	283
22년	607	283	324	366	276	3	0	87	0.8	241
증감	17	51	-34	193	66	-2	0	-5	-0.8	-42
증감 률	2.9	22.0	-9.5	111.6	31.4	-40.0	0.0	-5.4	-50.0	-14.8

(2) 중앙행정심판위원회

「행정심판법」 제6조 제1항에 따른 행정청¹¹¹⁾ 외의 국가행정기관의 장(국무총리 또는 행정각부의 장관 등) 또는 그 소속 행정청, 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이 경우 교육감을 포함한다) 또는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 의회(의장, 위원회의 의장, 사무처장 등 의회 소속 모든 행정청을 포함), 지방자치법에 따른 지방자치단체조합 등 관계 법률에 따라 국가·지방자치단체·공공법인이 공동으로 설립한 행정청의 경우에는, 그 행정청의 처분 또는 부작위에 대한 심판청구에 대하여 국민권익위원회에 두는 중앙행정심판위원회에서 심리·재결한다(동법 제6조 제2항).

산재보험 급여의 불승인 또는 부지급에 관한 사항은 원칙적으로 중앙행정심판위원회의 심리·재결 대상이 아니다. 다만, 산재보험법에 명시하지 않은 사항의 경우에는 중앙행정심판위원회가 심리·재결할 권한을 가질 수 있는데, 「진폐의 예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률(이하, '진폐법'이라 함)」상 위로금¹¹²⁾에 관한 결정이

110) 근로복지공단 내부 자료

111) 1. 감사원, 국가정보원장, 그 밖에 대통령령으로 정하는 대통령 소속기관의 장

2. 국회사무총장, 법원행정처장, 헌법재판소사무처장 및 중앙선거관리위원회사무총장

3. 국가인권위원회, 그 밖에 지위·성격의 독립성과 특수성 등이 인정되어 대통령령으로 정하는 행정청

112) 제24조(진폐위로금의 종류와 지급 사유) ①이 법에 따른 진폐위로금의 종류는 다음과 같다. <개정 2010. 5. 20.>

1. 작업전환수당

2. 진폐재해위로금

3. 삭제 <2010. 5. 20.>

②제1항제1호에 따른 작업전환수당은 근로자가 제21조제2항에 따라 작업전환되는 경우에 지급한다.

③ 제1항제2호에 따른 진폐재해위로금은 「산업재해보상보험법」 제91조의8의 진폐판정에 따른 진폐장해등급(이하 “진폐장해등급”이라 한다)이 결정된 근로자에게 지급한다. 다만, 진폐장해등급이 결정되지 아니한 근로자가 진폐로 사망한 경우에는 「산업재해보상보험법」 제91조의4제3항에 따라 진폐유족연금을 산정할 때 결정되는 진폐장해등급을 기준으로 그 유족에게 지급한다. <개정 2010. 5. 20.>

④ 제3항 단서에 따라 진폐재해위로금을 받을 수 있는 유족의 범위는 「산업재해보상보험법」 제5조제3호 및 제65조를 준용한다. <개정 2010. 5. 20.>

⑤ 삭제 <2010. 5. 20.>

대표적이다. 중앙행정심판위원회 홈페이지에서 보면, 1996년부터 최근까지 약 100건의 진폐재해위로금, 진폐장해위로금, 진폐보상, 진폐유족위로금, 진폐관리구분, 진폐근로자자녀장학금 등에 관한 재결례가 대표사례로 제시되고 있다.

예시 - 중앙행정심판위원회 재결(2022-7376) 진폐재해위로금 지급거부처분 취소청구

4. 관계법령

진폐의 예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률 제13조, 제24조, 제25조

진폐의 예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률 시행규칙 제17조

산업재해보상보험법 제36조, 제81조, 제91조의3, 제91조의5, 제91조의6, 제91조의7, 제91조의8

산업재해보상보험법 시행령 제21조, 제83조의2, 별표 6, 별표 11의 3

6. 이 사건 처분의 위법·부당 여부

나. 판단

1) 피청구인은 고인은 개정 산재보험법 적용을 받는 자이므로 법에 규정된 진폐 진단절차가 아닌 임의 검사자료를 근거로 청구된 진폐재해위로금은 진폐심사회의 심의대상이 될 수 없다는 취지로 주장하나, 진폐재해위로금은 소정의 분진작업에 종사한 근로자가 진폐에 걸려 장애등급 판정을 받은 경우에 산재보험금과 함께 국가에 청구할 수 있는 권리인데, 다만 산재보험법에서 진폐로 산재보험금 등을 지급받은 근로자로 하여금 정밀진단이 종료된 날부터 1년이 지나 다시 이를 청구할 수 있도록 하고, 공단에게는 근로자의 정밀진단을 의뢰하도록 한 것은 한번 걸리면 호전 가능성이 없이 계속 악화되는 진폐의 특성을 고려한 것으로서 근로자가 생전에 최소 1년마다 진폐의 경과를 확인하여 상향된 산재보험금 등을 받을 수 있도록 한 취지로 보아야 할 것이며, 산재보험법 제91조의7, 제91조의8에서 피청구인이 근로자의 정밀진단 결과에 대하여 진폐심사회의 심사를 거쳐 진폐 판정을 하도록 한 것은 위에서 본 바와 같이 근로자가 생전에 이를 청구한 경우에 적용되는 것이지, 근로자가 청구 전에 사망하여 물리적으로 피청구인의 정밀진단 절차를 밟을 수 없게 된 경우에 대해서까지 적용할 것은 아니라 할 것이다.

2) 또한, 피청구인은 임의 검사결과를 인정할 경우 산재보험법의 문언에 명백히 반하는 것이고 산재보험법의 개정 취지를 완전히 형해화 하는 것이라고 주장하나, 산재보험법 제81조는 미지급 보험급여에 대한 유족의 청구 권리를 규정하고 있고, 피청구인은 진폐 근로자가 사망한 경우에도 여전히 진폐심사회의에서 해당 임의 검사자료를 심사한 결과 나타난 자료의 정확성이나 신빙성 등을 고려하여 진폐 판정을 할 수 있으며, 이러한 전문적 심사를 거쳐 미처 공단의 추가 검증절차를 이행하기 전에 진폐로 사망한 근로자가 구제될 가능성을 배제할 수 없는 점 등을 고려하면, 피청구인의 위 주장 또한 받아들일

기 어렵다.

3) 위와 같은 사정을 종합적으로 고려할 때, 청구인이 제출한 고인의 X-ray 검사 기록은 진폐심사회의 심의 대상이 될 수 없다는 이유로 한 피청구인의 이 사건 처분은 위법·부당하다.

7. 결 론

그렇다면 청구인의 주장을 인정할 수 있으므로 청구인의 청구를 받아들여기로 하여 주문과 같이 재결한다.

한편, 산업재해보상보험과 관련하여 다수의 재결례가 존재하나, 대부분 산재보험의 적용이나 사업주 부담 보험료의 납부에 관한 것으로 확인되며, 특이한 유형으로는 산업재해보상보험 의료기관 지정신청 거부처분 취소청구 등이 있다.

- 산업재해보상보험 사업종류변경신고 반려처분 취소청구
- 산업재해보상보험급여액 납입고지처분 취소청구
- 고용보험료 및 산업재해보상보험료 징수처분 취소청구
- 산업재해보상보험 사업종류변경신고 반려처분 취소청구
- 산업재해보상보험급여액 징수처분 무효확인청구
- 산업재해보상보험 개별실적요율 승계이의신청 반려처분 취소청구
- 산업재해보상보험 의료기관 지정신청 거부처분 취소청구
- 산업재해보상보험 보험관계 성립통지 취소청구
- 고용보험료 및 산업재해 보상보험료 경감특례정산결정 무효확인청구
- 고용보험료 및 산업재해보상보험료 반환불가통지 반환이행청구 등

산업재해보상보험과 관련된 중앙행정심판위원회의 행정심판 현황은 다음과 같으며, 행정심판 취소율은 대체로 감사원 심사청구보다 높은 것으로 나타난다. 다만, 여기서 보상은 대부분 진폐법에 따른 보상에 한정되는 것으로 추정된다.

행정심판 현황¹¹³⁾

가. 행정심판 신규 접수건수: 329건

○ 21년도 355건 대비 26건(7.3%) 감소

○ 전년도 대비 보상분야 8.3% 감소, 적용분야 6.1% 증가, 징수분야 10.3% 증가, 임금채권분야 25.0% 감소

(보상: 228건 → 209건, 적용: 33건 → 35건, 징수: 39건 → 43건, 임금채권: 40건 → 30건)

나. 행정심판 취소율: 20.3%

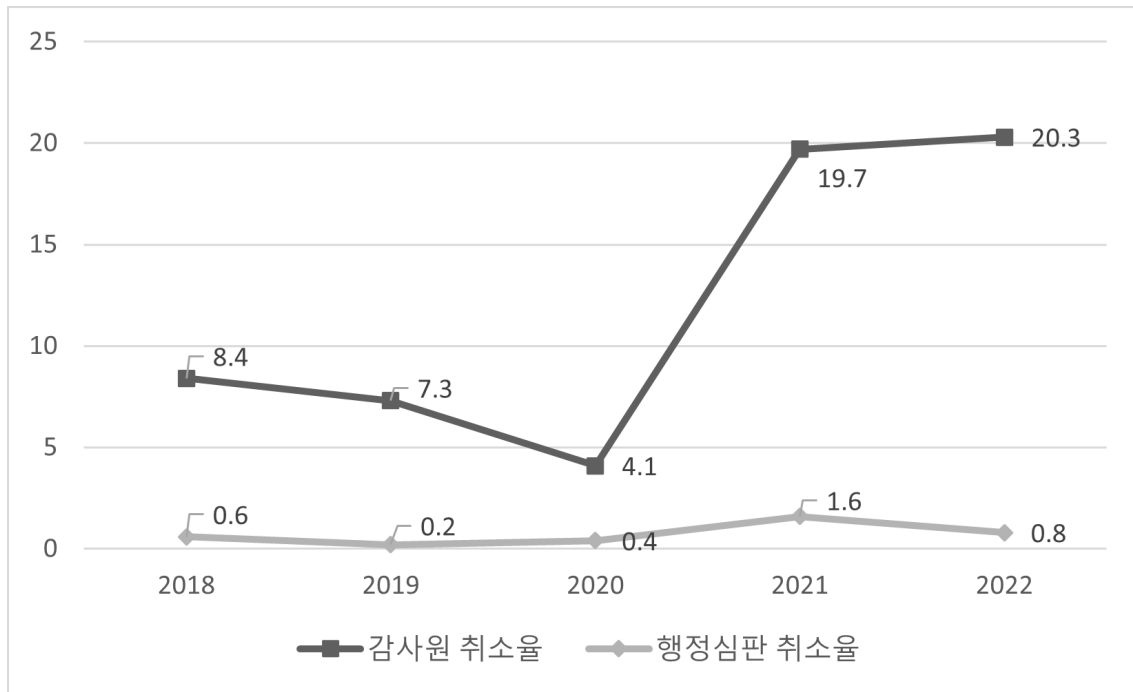
○ 21년도 19.7% 대비 0.6%p 증가

○ 22년도 확정사건 376건 중 77건 취소

<행정심판 전체 현황>

구분	접수			확정사건결과						계류중
	계	이월	신규	계	기각	취소	일부 취소	각하 등	취소율	
21년	522	167	355	417	254	82	7	74	19.7	105
22년	434	105	329	379	196	77	12	94	20.3	55
증감	-88	-62	-26	-38	-58	-5	5	20	0.6	-50
증감 률	-16.9	-37.1	-7.3	-9.1	-22.8	-6.1	71.4	27.0	3.1	-47.6

[그림 2-3] 감사원 및 중앙행정심판 취소율 비교



6. 유사 제도 - 고용보험심사위원회 등의 운영 현황 및 특성

(1) 고용보험심사위원회

1) 개요

고용보험심사위원회는 「고용보험법」 제99조에 규정되어 있다. 고용보험 피보험자격의 취득·상실에 대한 확인(제17조), 실업급여(제4장) 및 육아휴직 급여와 출산전후휴가 급여(제5장) 등에 관한 처분에 대하여 이의가 있는 경우 제89조의 **심사관**에게 심사를 청구할 수 있고, 결정에 이의가 있는 경우 **심사위원회**에 재심사를 청구할 수 있다(고용보험법 제87조). 즉, 고용보험은 고용보험 피보험자격, 실업급여, 육아휴직 및 출산전후휴가 급여에 관한 사항에 대하여 심사관 심사, 심사위원회 재심사 제도를 두고 있다. 이러한 방식은 1995년 이전 산재보험법의 산재보험 심사 방식과 동일하다고 할 수 있다.

2) 근거 규정

고용보험법 제87조는 심사와 재심사에 관한 사항을, 제89조는 심사를 담당하는 고용보험심사관을, 제99조는 재심사를 담당하는 고용보험심사위원회에 관한 사항을 규정해두고 있다.

고용보험법 제87조(심사와 재심사) ①제17조에 따른 피보험자격의 취득·상실에 대한 확인, 제4장의 규정에 따른 실업급여 및 제5장에 따른 육아휴직 급여와 출산전후휴가 급여등에 관한 처분[이하 “원처분(原處分)등”이라 한다]에 이의가 있는 자는 제89조에 따른 심사관에게 심사를 청구할 수 있고, 그 결정에 이의가 있는 자는 제99조에 따른 심사위원회에 재심사를 청구할 수 있다. <개정 2012. 2. 1.>

②제1항에 따른 심사의 청구는 같은 항의 확인 또는 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에, 재심사의 청구는 심사청구에 대한 결정이 있음을 안 날부터 90일 이내에 각각 제기하여야 한다.

③제1항에 따른 심사 및 재심사의 청구는 시효중단에 관하여 재판상의 청구로 본다.

89조(고용보험심사관) ①제87조에 따른 심사를 행하게 하기 위하여 **고용보험심사관**(이하 “심사관”이라 한다)을 둔다.

제99조(고용보험심사위원회) ①제87조에 따른 재심사를 하게 하기 위하여 고용노동부에 고용보험심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)를 둔다. <개정 2010. 6. 4.>

②심사위원회는 근로자를 대표하는 사람 및 사용자를 대표하는 사람 각 1명 이상을 포함한 15명 이내의 위원으로 구성한다. <개정 2020. 5. 26.>

③제2항의 위원 중 2명은 상임위원으로 한다.

고용보험법 시행령 제121조(심사관의 자격) 법 제89조에 따른 고용보험심사관(이하 “심사관”이라 한다)은 고용노동부 소속 공무원으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 임명한다. <개정 2010. 7. 12., 2021. 6. 8.>

1. 고용노동부에서 일반직 5급 이상 공무원이나 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 보험에 관한 심사 또는 재심사의 청구에 관련된 업무에 1년 이상 종사한 사람

2. 고용노동부에서 일반직 5급 이상 공무원이나 고위공무원단에 속하는 일반직공무원으로서 보험 업무에 2년 이상 종사한 사람

3. 그 밖에 제1호나 제2호의 사람에 해당하는 자격이 있다고 고용노동부장관이 인정하는 사람

제122조(심사관의 배치·직무) ① 심사관은 고용노동부에 둔다. <개정 2010. 7. 12.>

② 심사관은 고용노동부장관이 지정하는 심사업무와 심사청구에 대한 사례 연구를 담당한다. <개정 2010. 7. 12.>

(2) 건강보험분쟁조정위원회

1) 개요

건강보험분쟁조정위원회는 「국민건강보험법」 제89조에 규정되어 있다. 가입자 및 피부양자의 자격, 보험료 등, 보험급여, 보험급여 비용에 관한 공단의 처분에 이의가 있는 자는 공단에 이의 신청을 할 수 있고, 요양급여비용 및 요양급여의 적정성 평가 등에 관한 심사평가원의 처분에 이의가 있는 공단이나 요양기관 그 밖의 자는 심사평가원에 이의신청을 할 수 있다(제87조 제1항 내지 제2항). 즉, 건강보험에 관한 이의신청은 내용에 따라서 공단과 심사평가원으로 이분되어 있다. 이의 신청에 대한 결정에 불복하는 자는 건강보험분쟁조정위원회에 심판청구를 할 수 있다(제88조).

2) 근거 규정

건강보험법 제87조는 공단 및 심사평가원에 대한 이의신청에 관한 사항을, 제88조는 건강보험분쟁조정위원회에 관한 사항을 규정하고 있다. 국민건강보험법은 심사 및 재심사라는 용어를 사용하고 있지만 이의신청이 심사에 관한 기능을, 건강보험분쟁조정위원회의 심판청구가 재심사의 기능을 하는 것으로 평가할 수 있다.

국민건강보험법 제87조(이의신청) ① 가입자 및 피부양자의 자격, 보험료등, 보험급여, 보험급여 비용에 관한 공단의 처분에 이의가 있는 자는 **공단에 이의신청**을 할 수 있다.

② 요양급여비용 및 요양급여의 적정성 평가 등에 관한 심사평가원의 처분에 이의가 있는 공단, 요양기관 또는 그 밖의 자는 **심사평가원에 이의신청**을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항에 따른 이의신청(이하 “이의신청”이라 한다)은 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 문서(전자문서를 포함한다)로 하여야 하며 처분이 있는 날부터 180일을 지나면 제기하지 못한다. 다만, 정당한 사유로 그 기간에 이의신청을 할 수 없었음을 소명한 경우에는 그러하지 아니하다.

④ 제3항 본문에도 불구하고 요양기관이 제48조에 따른 심사평가원의 확인에 대하여 이의신청을 하려면 같은 조 제2항에 따라 통보받은 날부터 30일 이내에 하여야 한다.

제88조(심판청구) ① 이의신청에 대한 결정에 불복하는 자는 제89조에 따른 **건강보험분쟁조정위원회**에 심판청구를 할 수 있다. 이 경우 심판청구의 제기기간 및 제기방법에 관하여는 제87조제3항을 준용한다.

제89조(건강보험분쟁조정위원회) ① 제88조에 따른 심판청구를 심리·의결하기 위하여 보건복지부에 건강보험분쟁조정위원회(이하 “분쟁조정위원회”라 한다)를 둔다.

② 분쟁조정위원회는 위원장을 포함하여 60명 이내의 위원으로 구성하고, 위원장을 제외한 위원 중 1명은 당연직위원으로 한다. 이 경우 공무원이 아닌 위원이 전체 위원의 과반수가 되도록 하여야 한다. <개정 2014. 1. 1., 2018. 12. 11.>

(3) 국민연금재심사위원회

1) 개요

국민연금재심사위원회는 「국민연금법」 제111조에 규정되어 있다. 가입자의 자격, 기준소득월액, 연금보험료, 그밖의 이 법에 따른 징수금과 급여에 관한 국민연금공

단 또는 건강보험공단의 처분에 이의가 있는 자는 처분을 한 국민연금공단 또는 건강보험공단에 심사청구를 할 수 있고(제108조), 심사청구 사항의 심사를 위하여 국민연금공단에 국민연금심사위원회를, 건강보험공단에 징수심사위원회를 둔다(제109조). 즉, 심사에 관한 사항은 국민연금심사위원회와 건강보험 징수심사위원회가 담당한다.

심사청구 결정에 불복하는 자는 국민연금재심사위원회에 재심사를 청구할 수 있고(제110조), 이를 담당하기 위하여 보건복지부에 국민연금재심사위원회를 둔다(제111조).

2) 근거 규정

심사청구는 각 국민연금관리공단과 건강보험공단으로 나누어져 있으나, 재심사는 국민연금재심사위원회가 담당하고 있다. 심사청구는 국민연금심사위원회 및 징수심사위원회에서 이루어지고, 재심사는 국민연금재심사위원회가 담당하고 있다.

국민연금법 제108조(심사청구) ① 가입자의 자격, 기준소득월액, 연금보험료, 그 밖의 이 법에 따른 징수금과 급여에 관한 공단 또는 건강보험공단의 처분에 이의가 있는 자는 그 처분을 한 공단 또는 건강보험공단에 심사청구를 할 수 있다. <개정 2009. 5. 21.>

② 제1항에 따른 심사청구는 그 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에 문서(「전자정부법」 제2조제7호에 따른 전자문서를 포함한다)로 하여야 하며, 처분이 있는 날부터 180일을 경과하면 이를 제기하지 못한다. 다만, 정당한 사유로 그 기간에 심사청구를 할 수 없었음을 증명하면 그 기간이 지난 후에도 심사 청구를 할 수 있다. <개정 2009. 5. 21., 2010. 2. 4.>

제109조(국민연금심사위원회 및 징수심사위원회) ① 제108조에 따른 심사청구 사항을 심사하기 위하여 공단에 국민연금심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)를 두고, 건강보험공단에 징수심사위원회를 둔다. <개정 2009. 5. 21.>

② 심사위원회 및 징수심사위원회의 구성·운영 및 심사 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <개정 2009. 5. 21.>

[제목개정 2009. 5. 21.]

제110조(재심사청구) ① 제108조에 따른 심사청구에 대한 결정에 불복하는 자는 그 결정 통지를 받은 날부터 90일 이내에 대통령령으로 정하는 사항을 적은 재심사청구서에 따라 국민연금재심사위원회에 재심사를 청구할 수 있다. <개정 2015. 1. 28.>

② 제1항에 따른 재심사청구의 방법 및 절차 등은 보건복지부령으로 정한다. <신설 2015. 1. 28.>

제111조(국민연금재심사위원회) ① 제110조에 따른 재심사청구 사항을 심사하기 위하여 보건복지부에 국민연금재심사위원회(이하 “재심사위원회”라 한다)를 둔다. <개정 2008. 2. 29., 2010. 1. 18.>

② 재심사위원회는 위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다. 이 경우 공무원이 아닌 위원이 전체 위원의 과반수가 되도록 하여야 한다. <신설 2018. 12. 11.>

국민연금법 시행령 제89조(심사위원회의 구성) ① 법 제109조제1항에 따른 국민연금심사위원회(이하 “심사위원회”라 한다)는 위원장 1명을 포함한 26명 이내의 위원으로 구성한다. <개정 2011. 12. 8.>

제102조의2(징수심사위원회의 구성·운영 및 심사 등) ① 법 제109조제1항에 따른 징수심사위원회(이하 “징수심사위원회”라 한다)는 위원장 1명을 포함한 25명의 위원으로 구성한다.

제104조(재심사위원회의 구성 등) ① 법 제111조제1항에 따른 국민연금재심사위원회(이하 “재심사위원회”라 한다)는 위원장 1명을 포함한 20명 이내의 위원으로 구성한다. <개정 2013. 8. 6.>

제105조(재심사위원회의 위원장) ① 재심사위원회의 위원장은 보건복지부 연금정책국장으로 한다. <개정 2008. 2. 29., 2010. 3. 15., 2011. 12. 8., 2019. 6. 11.>

② 위원장에게 사고가 있으면 위원장이 지명하는 위원이 그 직무를 대행한다.

(4) 의의 및 시사점

고용보험, 건강보험, 국민연금 모두 심사와 재심사, 또는 이에 준하는 제도를 두고 있는 것으로 파악된다. 특히, 고용보험의 경우, 심사관 제도를 두고 있어 1995년 산재보험법 개정 이전의 심사 제도와 유사하다. 이에 비하여 건강보험은 형식적으로 2단계의 심사 구조를 갖고 있었으나 각각 이의신청과 심판청구라는 용어를 사용하면서 심사 및 재심사라는 용어를 사용하지 않고 있었고, 국민연금은 심사결정 주체가 이원화되어 있어 이를 이용하고자 하는 국민에게 다소 어렵게 느껴질 소지도 있었다.

산재보험은 고용보험 심사 제도와 유사했으나, 이후 근로복지공단 단독심을 거쳐 현재 산재보험심사위원회로 변경되어 많은 차이를 보인다. 산재보험급여의 지급 결정은 재해근로자 또는 유족에게 매우 중요하다. 이에 따라 지급 결정의 합리성과 공정성에 대한 요청이 강해졌고 노동부 심사관, 근로복지공단 단독심 제도에서 위원회 방식으로 변경된 것으로 판단된다.

심사관 또는 단독심 제도는 위원회 방식보다 노동부 또는 근로복지공단 내부에서 결정이 이루어지므로 신속하고, 산재보험 제도의 목적과 취지를 고려한 합리적·합목적적 결정을 하게 될 개연성이 높다. 반면, 이 과정에서 **재해자 입장의 고려, 선행 처분의 위법·부당성에 대한 검증, 다양한 의견에 대한 교차 검증은 상대적으로 약해 질 가능성이 있다.** 산재보험 제도는 이러한 점을 종합적으로 고려하는 한편, 사회적 합의의 내용 등을 종합적으로 고려하여 위원회 방식의 현재 심사 및 재심사 제도로 변경된 것으로 평가할 수 있다.

한편, 고용보험, 국민연금, 건강보험과 관련된 심사 등의 제도에서는 소위원회나 전문위원회에 관한 별도의 규정을 두고 있지 않은 것으로 파악되었다. 이에 비하여 산재보험은 위원회의 심의를 보조하게 하기 위하여 전문위원회를 둘 수 있다는 규정을 두고 있다(산재보험법 제8조). 특히, 시행령은 전문위원회를 산재보험정책전문위원회, 산재보험요양전문위원회, 산업안전보건전문위원회로 구분하고 있어, 필요에 따라서 이를 증감하는 것이 가능하다. 그렇다면, 종래 심사관 또는 단독심에서 심사 위원회로 변경되면서 2번의 위원회(심사위원회 및 재심사위원회)를 거치므로 상대적으로 약화될 수 있는 심사의 신속성, 효율성, 행정적 판단 등의 기능을 소위원회 활용을 통해 보완하는 방안도 고려해 볼 수 있다.

산업재해보상보험법 시행령 제8조(전문위원회) ① 법 제8조제3항에 따라 위원회에 산업재해보상보험정책전문위원회, 산업재해보상보험요양전문위원회 및 산업안전보건전문위원회를 둔다. <개정 2010. 2. 24.>

② 제1항에 따른 전문위원회는 위원회 위원장의 명을 받아 다음 각 호의 구분에 따른 사항을 검토하여 위원회에 보고한다. <개정 2010. 2. 24.>

1. 산업재해보상보험정책전문위원회: 산업재해보상보험의 재정·적용·징수·급여·재활 및 복지에 관한 사항

2. 산업재해보상보험요양전문위원회: 요양급여의 범위나 비용 등 요양급여의 기준 및 요양관리에 관한 사항

3. 산업안전보건전문위원회: 산업안전보건에 관한 중요정책 및 제도개선에 관한 사항

- ③ 각 전문위원회는 25명 이내의 위원으로 구성하되, 비상임으로 한다.
- ④ 산업재해보상보험정책전문위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 위원장이 위촉한다. <개정 2010. 2. 24., 2010. 7. 12.>
1. 고용노동부에서 산업재해보상보험 업무를 담당하는 4급 이상 일반직 공무원
 2. 총연합단체인 노동조합 또는 전국을 대표하는 사용자 단체가 각각 추천하는 사람
 3. 사회보험의 재정·적용·징수·급여 등에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람
- ⑤ 산업재해보상보험요양전문위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 위원장이 위촉한다. <개정 2010. 2. 24., 2010. 7. 12.>
1. 고용노동부에서 산업재해보상보험 업무를 담당하는 4급 이상 일반직 공무원
 2. 총연합단체인 노동조합 또는 전국을 대표하는 사용자 단체가 각각 추천하는 사람
 3. 산업의학 등 전문과목별 의학적 전문지식과 경험이 풍부한 사람
- ⑥ 산업안전보건전문위원회의 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 위원장이 위촉한다. <신설 2010. 2. 24., 2010. 7. 12.>
1. 고용노동부에서 산업안전보건 업무를 담당하는 4급 이상 일반직 공무원
 2. 총연합단체인 노동조합 또는 전국을 대표하는 사용자 단체가 각각 추천하는 사람
 3. 산업안전보건에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람
- 제8조의2(조사·연구위원)** ① 산업재해보상보험과 산업재해 예방에 관한 사항을 조사·연구하게 하기 위하여 위원회에 산업재해보상보험·산업안전공학·기계안전·전기안전·화공안전·건축안전·토목안전·산업의학·산업간호·산업위생·인간공학·유해물질관리·안전보건 관련 법령 및 산업재해통계, 그 밖에 필요한 각 분야별로 2명 이내의 조사·연구위원을 둘 수 있다.
- ② 조사·연구위원은 해당 분야에 관한 학식과 경험이 풍부한 사람 중에서 고용노동부장관이 임명한다. <개정 2010. 7. 12.>
- [본조신설 2010. 2. 24.]

7. 산업재해 심사·재심사 제도에 관한 헌법재판소 결정

(1) 개요

헌법재판소 2000. 6. 1. 선고 98헌바8 결정(산업재해보상보험법 위헌소헌 사건)사건은 헌법 제107조 제3항에서 규정하고 있는 사법 절차 준용의 의미, 산업재해 보험급여 결정에 대한 행정소송을 제기하기 위하여 심사청구 및 재심사 청구의 행정심판을 거치도록 한 것이 헌법 제107조 제3항에 위반되는지, 행정심판 전치제도가

재판청구권을 침해하는지에 관하여 판단하였다.

(2) 결정 요지

헌법 제107조 제3항은 “재판의 전심절차로서 행정심판을 할 수 있다. 행정심판의 절차는 법률로 정하되, 사법절차가 준용되어야 한다”고 규정하고 있으므로, 입법자가 행정심판을 전심절차가 아니라 종심 절차로 규정함으로써 정식재판의 기회를 배제하거나, 어떤 행정심판을 필요적 전심절차로 규정하면서도 그 절차에 사법절차가 준용되지 않는다면 이는 헌법 제107조 제3항, 나아가 재판청구권을 보장하고 있는 헌법 제27조에도 위반된다. 여기서 말하는 “사법절차”를 특징짓는 요소로는 판단기관의 독립성·공정성, 대심적(對審的) 심리구조, 당사자의 절차적 권리보장 등을 들 수 있으나, 위 헌법 조항은 행정심판에 사법절차가 “준용”될 것만을 요구하고 있으므로 위와 같은 사법절차적 요소를 엄격히 갖춰야 할 필요는 없다고 할지라도, 적어도 사법절차의 본질적 요소를 전혀 구비하지 아니하고 있다면 “준용”의 요구에마저 위반된다.

산업재해보상보험법이 규정하고 있는 심사청구·재심사청구의 절차와 여기에 보완적으로 적용되는 행정심판법의 심리 절차까지 고려하여 살펴보면, 심사청구·재심사청구의 절차는 전체적으로 **대심주의 구조**에 가깝도록 배려되어 있다고 할 수 있고, 증거조사신청권 등 **당사자의 절차적 권리**가 상당히 보장되어 있으며, 재결의 절차와 방식, 재결의 효력 등의 면에서도 **사법절차를 준용**하고 있다. 재결기관의 독립성·공정성에 관하여 보건대, 재심사청구의 재결기관인 산업재해보상보험심사위원회는 그 구성과 운영에 있어서 심의·재결의 독립성과 공정성을 객관적으로 신뢰할 수 있을만 하고, 심사청구의 경우에도 근로복지공단인 그 재결기관으로 되어 있다는 점만으로 심의·재결의 독립성과 공정성이 본질적으로 배제되어 있다고 하기 어려우며 심사청구에 관한 결정에 불복이 있는 자는 재심사청구의 기회가 보장되어 있다. 그렇다면 전체적으로 볼 때 위 법에서 규정한 심사청구·재심사청구제도는 헌법 제107조 제3항에 위반된다고 할 수 없다.

헌법 제107조 제3항은 행정심판의 절차를 법률로 정하도록 하고 있으므로 입법자는 행정심판을 통한 권리구제의 효율성, 행정청에 의한 자기시정의 개연성, 문제되는 행정심판사항의 특성 등 여러 가지 요소를 감안하여 입법정책적으로 행정심판절차의 구체적 모습을 형성할 수 있다. 산업재해보상업무에는 업무와 재해 간의 의학적인 인과관계, 신체 장애의 정도, 요양의 필요성 등 고도의 의학·법학·보험정책적 전문성과 기술성이 요구되어 이에 관한 행정기관의 전문성을 충분히 살릴 필요가

크므로 다른 일반의 행정처분과는 달리 특수한 전심절차를 둔 것에 합리성을 인정할 수 있고, 심사청구·재심사청구제도는 통상의 소송절차에 비하여 간편한 절차에 의해 시간과 비용을 절약하는 가운데 신속하고도 효율적인 권리구제를 꾀할 수 있다는 장점이 있으며, 비록 국민의 재판청구권을 제약하는 측면이 있는 것도 사실이나, 심사청구·재심사청구의 전치로 인한 노고와 시간, 즉 재판청구권의 제약의 정도는 경미한데 비하여 그로 인하여 달성되는 공익은 매우 크다고 할 것이므로, 심사청구·재심사청구제도가 행정심판절차 형성에 관한 입법형성권의 한계를 벗어나 국민의 재판청구권을 침해하는 제도라고 할 수 없다.

(3) 평가

헌법재판소는 일반행정심판이 아닌 별도 제도인 산재보험 심사·재심사 제도가 헌법이 정하고 있는 행정심판의 사법절차 준용 원리에 반하지 않는다고 판단하면서 심사 및 재심사 제도가 대심주의 구조에 가까운 점, 증거조사신청권 등 절차적 권리가 보장되어 있는 점, 절차와 방식 그리고 효력이 사법절차를 준용하고 있는 점, 재심사위원회가 심의·재결의 독립성과 공정성의 신뢰가 있는 점, 심사청구의 경우에도 이것이 본질적으로 배제될 수 없는 점 등을 근거로 제시하였다. 나아가 이와 같은 특수한 전심절차는 고도의 의학적·법학적·보험정책적 전문성과 기술성이 요구되는 등 행정기관의 전문성이 필요한 점, 간편한 절차로 인한 시간·비용 절약이 국민의 권리 보장이나 공익에 미치는 영향이 큰 점 등을 고려할 때 당위성과 합리성이 있다고 판단하였다.

헌법재판소는 산재보험 심사 및 재심사 제도가 헌법에 위반되지 않는다는 근거로 대심주의 구조, 증거조사신청권 등을 들었으나 이는 형식적인 제도의 규정만을 근거로 삼아 판단했다는 점에서 제도운영의 실질이 이에 미치지 못하는 경우라면 이러한 결과가 동일하게 적용될 수 있는지 의문이 있을 수 있다. 예를 들어서 증거조사신청권¹¹⁴⁾의 경우, 청구인의 신청에도 불구하고 “할 수 있다”는 재량의 여지를 두

114) 제105조(심사 청구에 대한 심리·결정) ④ 공단은 심사 청구의 심리를 위하여 필요하면 청구인의 신청 또는 직권으로 다음 각 호의 행위를 할 수 있다.

제109조(재심사 청구에 대한 심리와 재결) ① 재심사 청구에 대한 심리·재결에 관하여는 제105조제1항 및 같은 조 제3항부터 제5항까지를 준용한다.

산재보험법 시행령 제103조(심리를 위한 조사) ① 법 제105조제4항에 따른 심사 청구에 대한 심리를 위한 조사 신청은 다음 각 호의 사항을 적은 문서로 하여야 한다.

1. 심사 청구 사건명
2. 신청의 취지 및 이유
3. 출석할 관계인의 이름 및 주소(법 제105조제4항제1호의 경우만 해당한다)
4. 제출할 문서나 그 밖의 물건의 표시 및 그 소유자 또는 보관자의 이름과 주소(법 제105조제4항제2호의 경우만 해당한다)

고 있어 실제 신청에도 불구하고 조사가 이루어지지 않는 경우도 적지 않은 것으로 파악된다.

한편, 이와 관련하여 근로복지공단의 심사 청구는 행정심판이 아닌 이의신청에 해당하므로 엄격하게 사법절차의 준용을 요구하는 것은 적절하지 않다는 견해¹¹⁵⁾도 확인된다. 해당 견해는 심사청구는 재심사 청구와 달리 객관성·공정성을 갖춘 산업재해보상보험심사위원회가 재결하는 것이 아니라 처분청인 근로복지공단이 결정을 하도록 되어 있어 이를 쟁송절차인 행정심판으로 볼 수는 없고 처분청이 불복에 대해 심사·결정한다는 점에서 단지 강학상 '이의신청'에 해당하며, 사법절차의 준용이 요구되지 않으므로 판단기관의 객관성, 공정성, 대심적심리구조, 당사자의 절차적 보장의 요소들을 갖추 것을 요구하는 것은 이의신청 제도가 가지는 신속성을 저해하여 그 효용성을 상실하게 한다고 본다.

하지만, 산재보험법에 의하면 심사는 원처분기관인 근로복지공단 내 산재심사위원회의 '결정'으로, 재심사는 별도의 독립된 기관인 산재재심사위원회의 '재결'로 명시되어 판단기관과 처분의 성격을 달리 보고 있는 것으로 해석될 수 있다. 나아가 헌법재판소 역시 심사청구에 대해서 "근로복지공단이 그 재결 기관으로 되어 있다는 점"을 별도로 언급하고 있다. 이러한 점을 고려하면 산재 권리구제 절차개선과 관련하여 심사청구의 성격을 행정심판이라고 보는 경우¹¹⁶⁾라 하더라도 재심사에 비하여

5. 감정할 사항 및 그 이유(법 제105조제4항제3호의 경우만 해당한다)

6. 출입할 사업장이나 그 밖의 장소의 명칭·소재지, 질문할 사업주·근로자, 그 밖의 관계인의 이름·주소, 검사할 문서나 그 밖의 물건의 표시(법 제105조제4항제4호의 경우만 해당한다)

7. 진단받을 근로자의 이름 및 주소(법 제105조제4항제5호의 경우만 해당한다)

② 공단이 법 제105조제4항에 따라 조사를 한 경우에는 다음 각 호의 사항을 적은 조서를 작성하여야 한다. 이 경우 법 제105조제4항제1호에 따라 심사 청구인 또는 관계인으로부터 진술을 받은 경우에는 진술조서를 작성하여 첨부하여야 한다.

1. 사건번호 및 사건명
2. 조사의 일시 및 장소
3. 조사대상 및 조사방법
4. 조사의 결과

115) 최진수, "행정심판 제도의 구조에 관한 고찰", 『공법연구』(제43집 제2호), 2014, 193-194면 참고.

"여기까지 사법절차의 준용을 요구하여 뿐만 아니라 근로복지공단은 그 자신이 처분청이자 동시에 판단기관이므로 판단기관의 객관성·공정성과는 거리가 멀다. 사법절차 준용이 요구되는 경우라 하더라도 그 준용의 강도는 사안마다 다르다는 점을 심본 고려한다고 하더라도, 이런 경우까지 사법절차 준용의 요구를 충족하였다고 보는 것은 구체적 타당성을 위한 교육지책이라는 느낌을 지울 수 없다. 만약 이와 같이 본다면 사법절차 준용의 요구를 충족하지 못한 경우가 어디 있겠는가 하는 의문도 생긴다. 그것은 비록 당해 사안에서의 구체적 타당성이나 정의에 부합할지는 모르나 결국은 사법절차 준용 여부를 판단하는 잣대를 과도하게 낮춤으로써 대부분의 행정심판이 사법절차 준용의 요청을 갖춘 것으로 보게 될 것이고, 이는 헌법 제107조 제3항이 행정심판에 사법절차 준용을 요구하는 취지에 반할 뿐만 아니라, 나아가 행정심판을 통한 국민의 권리구제를 크게 약화시키는 결과가 된다고 할 것이다. 이러한 헌법재판소 판례의 태도는 결국, '행정심판'과 '이의신청' 등 '기타 행정불복절차'를 구별하지 못한 데 기인한 것이라고 생각된다. 정리하면, 입법자는 실질적 의미의 행정심판 중에서 사법절차의 준용이 요구되는 것들은 이를 '행정심판(일반행정심판 또는 특별행정심판)'의 모습으로, 사법절차의 준용이 요구되지 않는 것들은 이를 '기타 행정불복절차'의 모습으로 형성한 것이라 할 것이다.

제도를 더욱 간이 또는 신속하게 변경하는 것이 법적으로 용인될 여지는 더 크다고 판단된다.

II. 산재 원처분 및 권리구제 통계

1. 원처분

(1) 업무상 재해 신청 및 승인현황

업무상 재해 신청 및 승인현황을 살펴보면, 업무상 사고 승인율은 95%를 상회하나, 질병의 경우 약 60% 정도로 확인된다. 업무상 질병의 경우, 상병의 발생 경위 및 업무와의 인과관계에 관한 규명이 어려워 불승인되는 경우가 적지 않기 때문으로 분석된다. 원처분기관인 근로복지공단의 결정은 유형별로 일정한 승인율을 보여, 인정기준과 그 적용이 안정된 것으로 파악된다.

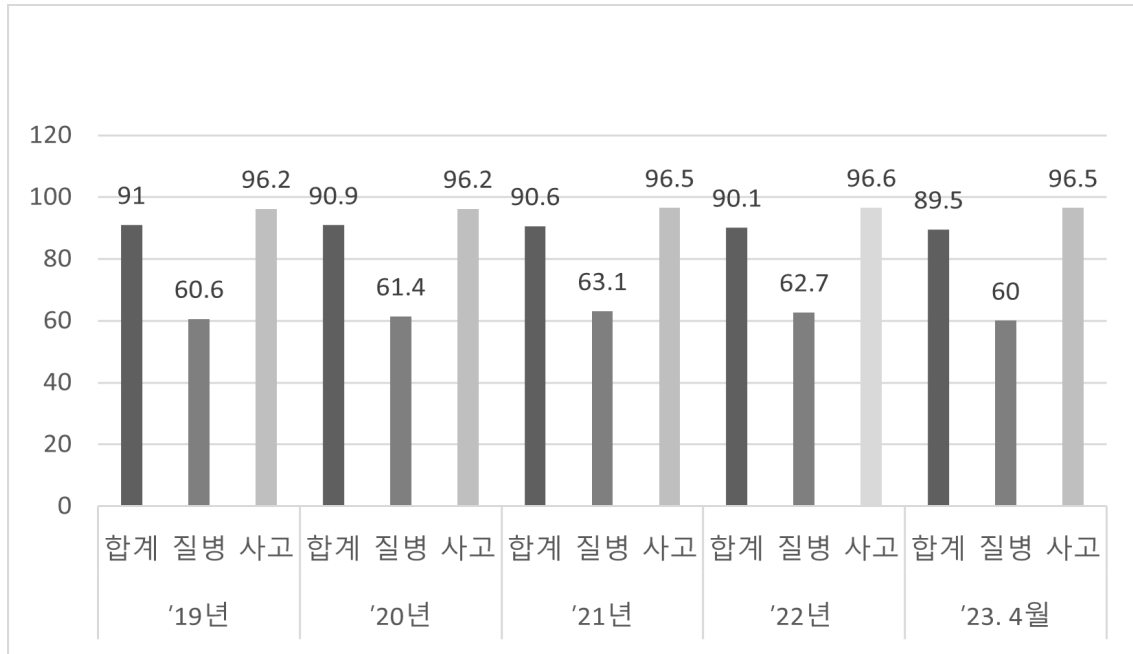
[표 2-5] 업무상 재해 신청 및 승인현황

구분	접수건수	처리건수				
		구분	계	승인	불승인	승인율(%)
'19년	147,678	합계	124,988	113,727	11,261	91.0
		질병	18,266	11,075	7,191	60.6
		사고	106,722	102,652	4,070	96.2
'20년	147,512	합계	123,921	112,670	11,251	90.9
		질병	18,634	11,432	7,202	61.4
		사고	105,287	101,238	4,049	96.2
'21년	168,927	합계	141,727	128,466	13,261	90.6
		질병	24,871	15,699	9,172	63.1
		사고	116,856	112,767	4,089	96.5
'22년	181,792	합계	150,862	135,983	14,879	90.1
		질병	28,796	18,043	10,753	62.7
		사고	122,066	117,940	4,126	96.6
'23. 4월	61,710	합계	52,954	47,384	5,570	89.5
		질병	10,139	6,085	4,054	60.0
		사고	42,815	41,299	1,516	96.5

※ (처리건수) 근로복지공단 최초요양 1회차 결재기준

116) 참고로 근로복지공단은 산업재해보상보험심사위원회를 “공정하고 신속한 심의를 통해 권리구제받을 수 있는 제도”라고 평가하고 있다.

[그림 2-4] 업무상 재해 신청 및 승인현황

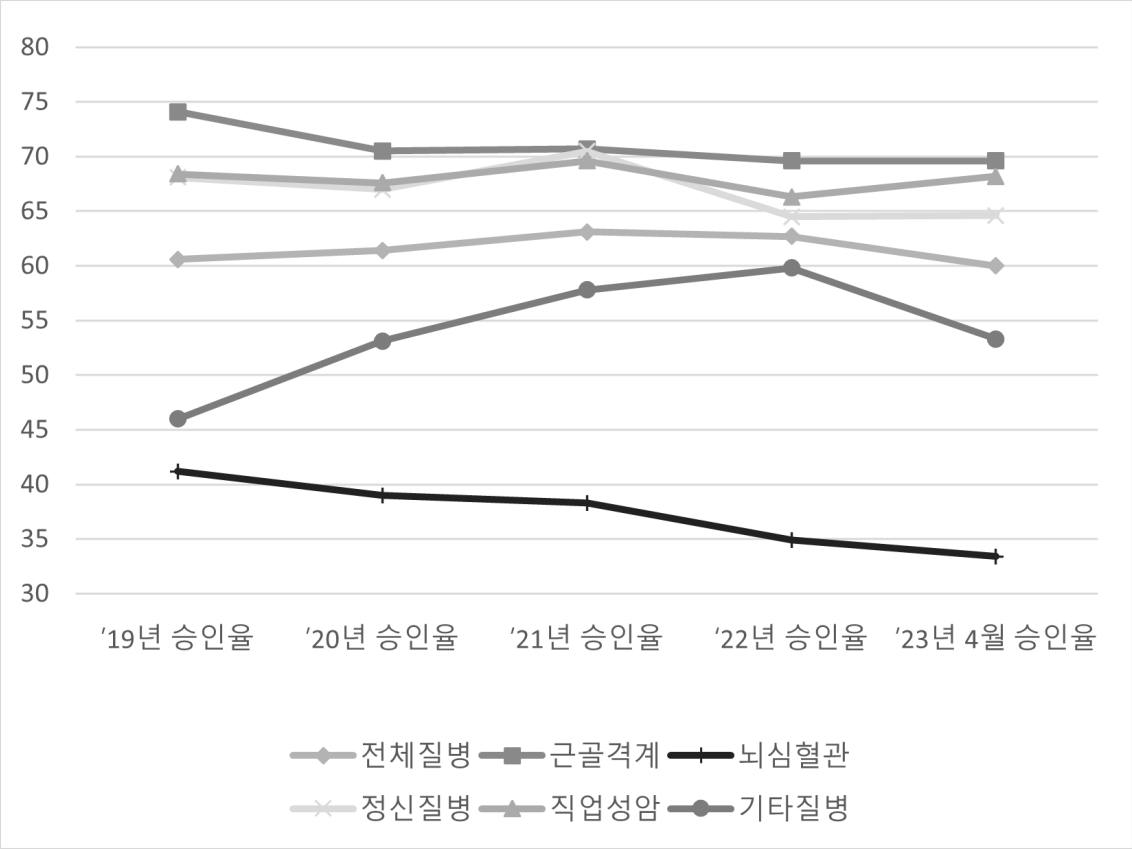


업무상 질병 신청 및 승인현황을 살펴보면, 전체 질병과 비교하여 근골격계, 정신 질병, 직업성 암은 승인율이 비교적 높았고, 뇌심혈관 및 기타 질병은 낮았다.

[표 2-6] 업무상 질병 신청 및 승인현황

구분		전체질병	근골격계	뇌심혈관	정신질병	직업성암	기타질병
'19년	신청	18,266	9,426	2,694	313	367	5,466
	승인	11,075	6,984	1,111	213	251	2,516
	승인율	60.6	74.1	41.2	68.1	68.4	46.0
'20년	신청	18,634	9,925	2,380	561	487	5,281
	승인	11,432	6,997	928	376	329	2,802
	승인율	61.4	70.5	39.0	67.0	67.6	53.1
'21년	신청	24,871	12,449	2,276	696	576	8,874
	승인	15,699	8,802	872	491	401	5,133
	승인율	63.1	70.7	38.3	70.5	69.6	57.8
'22년	신청	28,796	12,491	1,922	657	720	13,006
	승인	18,043	8,695	671	424	477	7,776
	승인율	62.7	69.6	34.9	64.5	66.3	59.8
'23년 4월	신청	10,139	4,554	649	212	299	4,425
	승인	6,085	3,168	217	137	204	2,359
	승인율	60.0	69.6	33.4	64.6	68.2	53.3

[그림 2-5] 업무상 질병 승인율



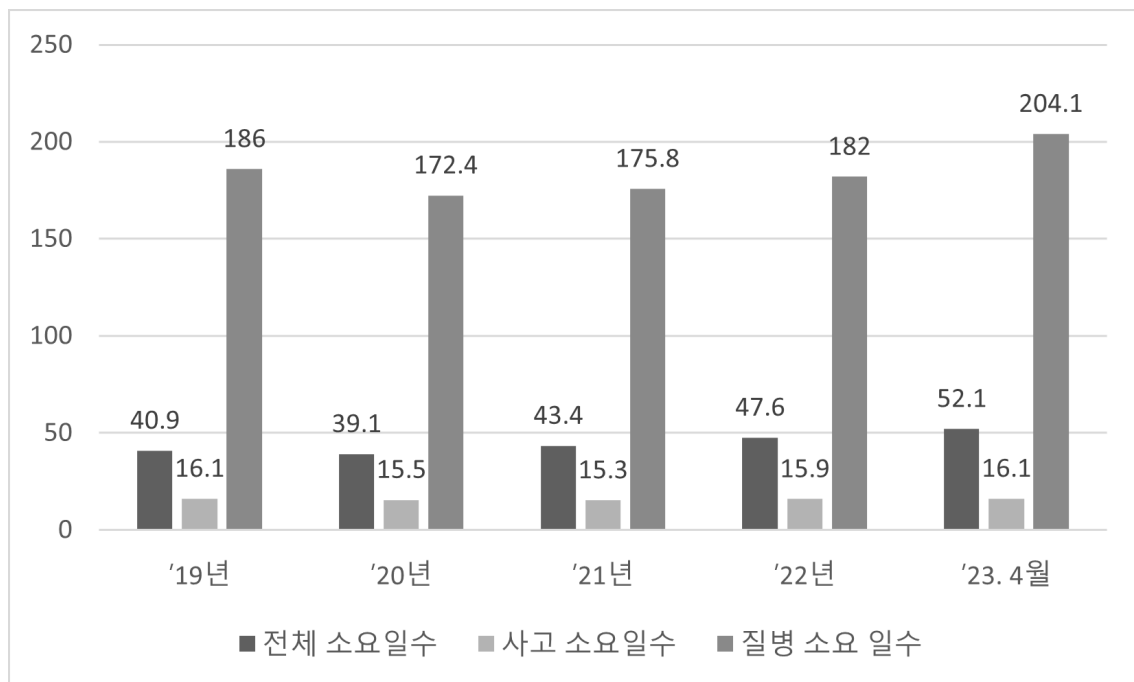
(2) 업무상재해 처리 소요일수 현황

업무상재해 처리 소요일수의 경우 사고는 15~16일, 질병의 경우 170~200일 가량 소요되고 있는 것으로 파악된다. 이는 원처분 기관의 업무상 재해 처리 소요일수를 단축하기 위해서 업무상 질병 판정에 소요되는 시간을 경감하는 것이 매우 중요하다는 것을 나타낸다.

[표 2-7] 업무상재해 처리 소요일수 현황

구분	전체		사고		질병	
	처리 건수	소요일수	처리 건수	소요일수	처리 건수	소요 일수
'19년	124,988	40.9	106,722	16.1	18,266	186.0
'20년	123,921	39.1	105,287	15.5	18,634	172.4
'21년	141,727	43.4	116,856	15.3	24,871	175.8
'22년	150,862	47.6	122,066	15.9	28,796	182.0
'23. 4월	52,954	52.1	42,815	16.1	10,139	204.1

[그림 2-6] 업무상재해 처리 소요일수 현황

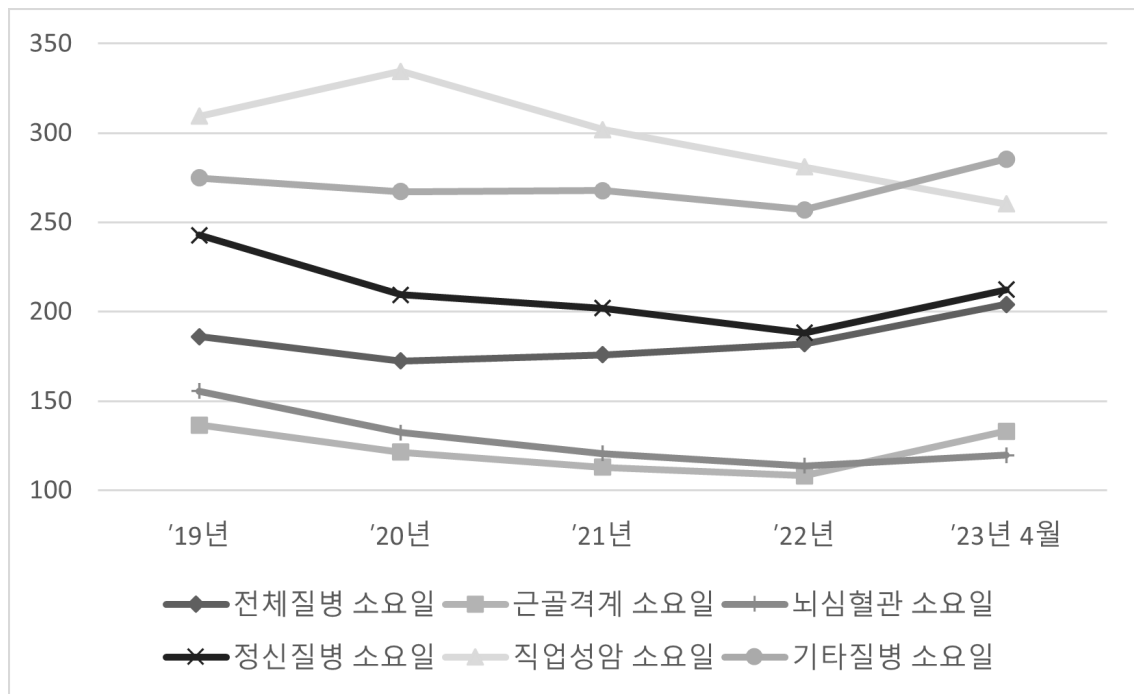


업무상 질병 처리 소요일수는 질병별로 편차가 매우 큰 것으로 나타났다. 직업성 암과 기타 질병의 처리 소요일수가 상대적으로 긴 것으로 나타났고, 근골격계와 뇌심혈관의 처리 소요일수는 상대적으로 짧았다. 특히, 근골격계 질병의 경우, 앞서 살펴본 패스트트랙 도입과 관련하여 2022년 소요일수가 줄어든 것으로 나타나 향후 이러한 경향이 유지될 수 있을지 주목된다.

[표 2-8] 업무상질병 처리 소요일수 현황

구분	전체질병		근골격계		뇌심혈관		정신질병		직업성암		기타질병	
	처리 건수	소요 일수	처리 건수	소요 일수	처리 건수	소요 일수	처리 건수	소요 일수	처리 건수	소요 일수	처리 건수	소요 일수
'19년	18,266	186.0	9,426	136.5	2,694	155.6	313	242.8	367	309.3	5,466	274.8
'20년	18,634	172.4	9,925	121.4	2,380	132.4	561	209.5	487	334.5	5,281	267.1
'21년	24,871	175.8	12,449	113.0	2,276	120.6	696	202.0	576	301.9	8,874	267.7
'22년	28,796	182.0	12,491	108.2	1,922	113.8	657	188.2	720	281.0	13,006	257.1
'23년 4월	10,139	204.1	4,554	133.1	649	119.6	212	212.3	299	260.2	4,425	285.5

[그림 2-7] 업무상질병 처리 소요일수 현황



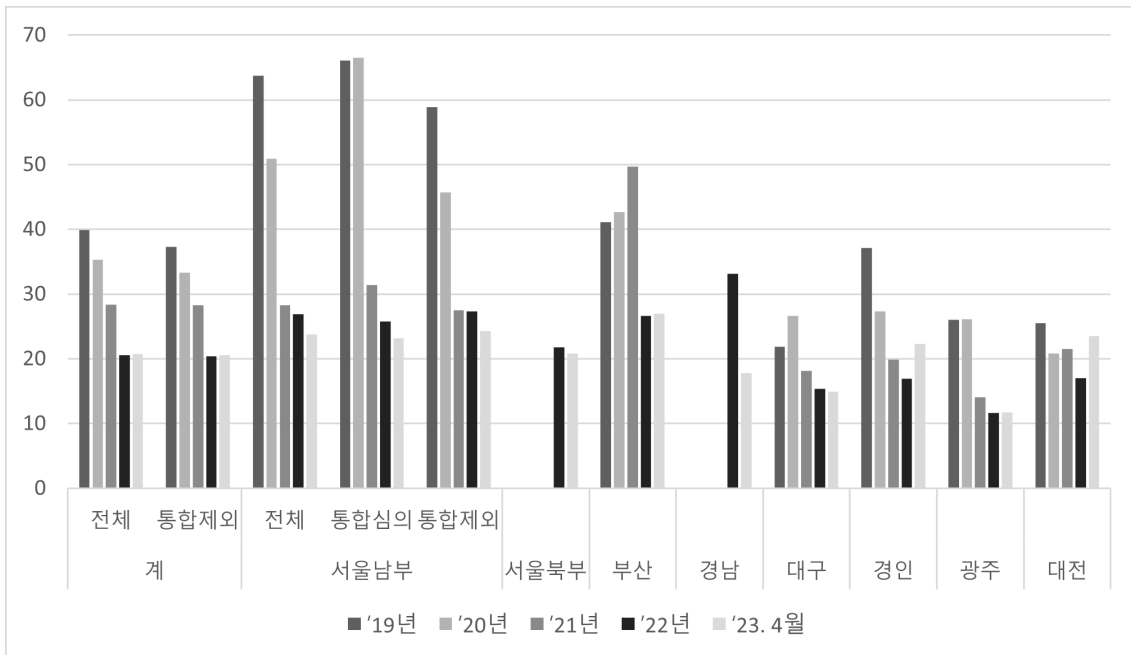
(3) 업무상질병 심의 및 전문(역학)조사 현황

판정위원회 심의 결정 소요 기간은 지속적으로 단축되어 대체로 20일 전후로 파악된다. 다만, 지역별 차이는 일정 부분 존재했다.

[표 2-9] 판정위원회 심의결정 소요기간 현황

구분	계		서울남부			서울북부	부산	경남	대구	경인	광주	대전
	전체	통합 제외	전체	통합 심의	통합 제외							
'19년	39.9	37.3	63.7	66.1	58.9	-	41.1	-	21.9	37.1	26.0	25.5
'20년	35.3	33.3	50.9	66.5	45.7	-	42.7	-	26.6	27.3	26.1	20.8
'21년	28.4	28.3	28.3	31.4	27.5	0.0	49.7	0.0	18.1	19.9	14.1	21.5
'22년	20.6	20.4	26.9	25.8	27.3	21.8	26.6	33.1	15.4	16.9	11.6	17.0
'23. 4월	20.7	20.6	23.8	23.2	24.3	20.8	27.0	17.8	14.9	22.3	11.7	23.5

[그림 2-8] 판정위원회 심의결정 소요기간 현황



업무상 질병 전문(역학)조사는 산업안전보건연구원과 직업환경연구원이 담당하고 있는데, 최근 들어 소요 기간이 증가한 것으로 나타났다.

산업안전보건연구원 직업성질환 역학조사¹¹⁷⁾

- ① **사업주, 근로자대표, 보건관리자, 건강진단기관 의사** : 「산업안전보건법」 제125조에 따른 작업환경측정 또는 동법 제129조부터 제131조에 따른 건강진단결과만으로 직업성질환 이환여부의 판단이 곤란한 근로자의 질병에 대하여, 사업주, 근로자대표, 보건관리자(보건 관리대행기관을 포함) 또는 건강진단기관의 의사가 역학조사를 요청하는 경우
- ② **근로복지공단** : 「산업재해보상보험법」 제10조에 따른 근로복지공단이 정하는 바에

- 따라 업무상질병여부의 결정을 위하여 역학조사를 요청하는 경우
- ③ **한국산업안전보건공단** : 한국산업안전보건공단(산업안전보건연구원)이 직업성질환의 예방을 위하여 필요하다고 판단하여 「산업안전보건법 시행규칙」 제224조 제1항에 따른 역학조사평가위원회의 심의를 거친 경우
- ④ **지방고용노동관서장** : 그 밖에 직업성질환의 이완여부로 사회적 물의를 일으킨 질병에 대하여 작업장내 유해요인과의 연관성 규명이 필요한 경우 등으로서 지방고용노동관서의 장이 요청하는 경우

근로복지공단 작업환경연구원 역학조사¹¹⁸⁾

업무상 질병으로 근로복지공단에 요양 신청된 호흡기 질환 중 근로복지공단 지사(지역본부)에서 근로복지공단 작업환경연구원으로 자문의뢰를 한 경우 역학조사를 통해 업무관련성 여부를 심의하고 있다.

요양 신청한 근로자를 면담하고 의무기록을 검토하여 직업력과 질병력을 확인하는 한편, 요양 신청된 질병이 정확하지 않거나 다른 질병의 가능성이 있으면 특진을 실시하여 정확한 진단을 한다. 사업장을 방문하여 작업환경을 확인하고, 유해물질의 측정 및 분석을 통해 노출평가를 실시한다.

필요에 따라 본인 혹은 동료 근로자의 생체시료를 분석하고, 국내·외 문헌을 검토한다. 이를 토대로 작성한 역학조사 보고서를 분야별 내·외부 전문가로 구성된 업무상 질병심의회위원회에 제출하여, 업무상질병 여부에 대한 판단을 한 다음 해당 근로복지공단 지사에 회신한다.

[표 2-10] 업무상질병 전문(역학)조사 현황

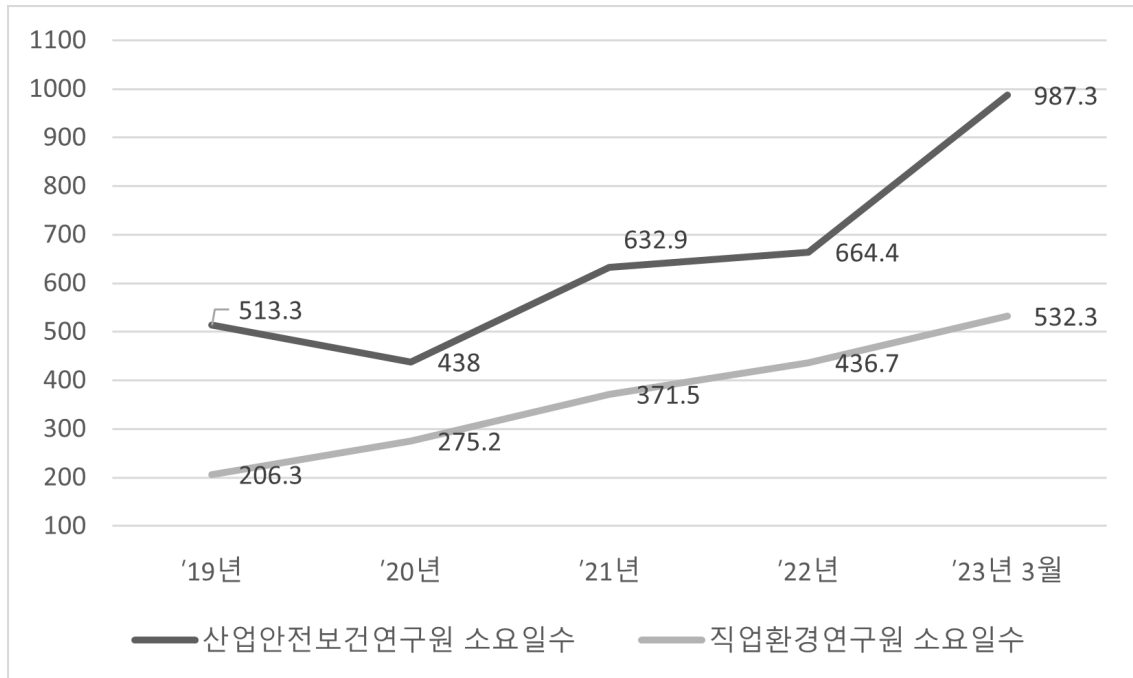
구분	산업안전보건연구원			직업환경연구원		
	의뢰	회신	소요일수	의뢰	회신	소요일수
'19년	111	59	513.3	703	548	206.3
'20년	54	70	438.0	553	491	275.2
'21년	83	68	632.9	596	457	371.5
'22년	36	58	664.4	438	398	436.7
'23년 3월	7	7	987.3	95	116	532.3

※ 분기별 통계(민원서류 반려건 포함)

117) 안전보건공단 산업안전보건연구원 홈페이지, <https://oshri.kosha.or.kr/oshri/professionalBusiness/occupationalDisease.do>(2023. 7. 21. 확인).

118) 직업환경연구원 홈페이지, <https://www.comwel.or.kr/lab-lung/busi/work/genl.jsp>(2023. 7. 21. 확인).

[그림 2-9] 업무상질병 전문(역학)조사 소요일수



2. 심사청구

(1) 심사제도 변화기의 통계

○ 심사제도는 1963년부터 1995년 4월까지 고용노동부 산재보험심사관 제도, 1995년 5월부터 2008년 6월까지 근로복지공단 단독심 제도, 2008년 7월 이후 산재보험심사위원회 제도로 변화하여 현재에 이르고 있다.

- 특히, 2008년 7월 근로복지공단 단독심에서 심사위원회 방식으로 변경된 것은 제도의 변경·보완 수준을 넘은 질적인 변화라고 평가할 수 있다.

- 통상 단독심은 빠른 의사결정을 통해 신속성을 확보할 수 있는 장점이 있고, 이에 비하여 심사위원회 방식은 신속성보다는 공정성 확보에 적합한 제도로 여겨진다.

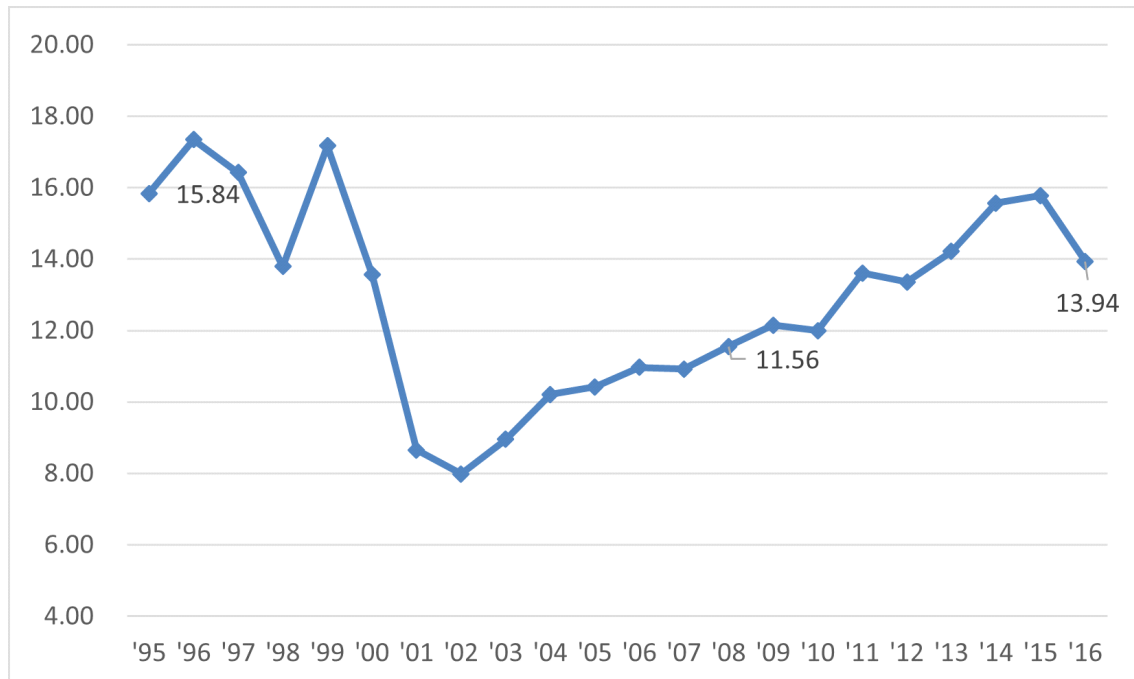
- 이에 따라 단독심 시기의 취소율과 제도 변경 이후의 취소율을 비교하여 살펴볼 필요가 있다.

○ **심사 취소율의 연도별 추이**를 살펴보면, 근로복지공단으로 산재심사 업무가 이관된 1996년 이후 2000년까지는 13.80~17.35%의 취소율을 보이다가, 2001년 8.66%, 2002년 7.98%로 크게 감소하였다. 이후 2015년까지 15.79%로 점진적으로 증가하는 추세를 보인다.

[표 2-11] 산재 심사 취소율 연도별 추이¹¹⁹⁾

연도	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05
합계	3,529	4,063	5,084	5,197	4,250	3,204	3,973	3,470	3,831	4,494	6,370
취소	559	705	835	717	730	435	344	277	343	459	664
취소율 (%)	15.84	17.35	16.42	13.80	17.18	13.58	8.66	7.98	8.95	10.21	10.42
연도	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16
합계	8,458	8,871	7,854	7,843	8,014	8,024	8,469	8,265	8,371	8,489	8,157
취소	928	969	908	953	962	1,092	1,132	1,175	1,303	1,340	1,137
취소율 (%)	10.97	10.92	11.56	12.15	12.00	13.61	13.37	14.22	15.57	15.79	13.94

[그림 2-10] 산재 심사 취소율 연도별 추이



119) 이 자료 및 이후의 심사에 관한 자료는 근로복지공단 산재심사위원회 보유 자료를 제공받아 가공한 것임. 취소율 자료와 달리 '처리 소요 기간'에 대한 자료는 확인이 어려웠음.

- 심사위원회 제도 변경 시점인 2008년을 기준으로 살펴보면 2008년 취소율은 11.56%이며, 이후 꾸준히 상승하다가 2015년 15.79%를 정점으로 다음해인 2016년 13.94%로 감소한 것으로 나타난다. 다만 이는 일시적인 현상일 뿐 그 이후의 취소율이 지속적으로 감소된 것은 아니고 최근의 자료(이하 [표 2-13] 참고)를 보더라도 2017년부터 2022년까지는 14.1~17%의 취소율을 보여 큰 폭의 변화는 없었다.

○ 통계자료를 살펴보면, 산재심사 취소율은 심사위원회 제도 변화를 기점으로 상승하였으나 이전에도 일정 기간 이러한 추세가 지속되고 있어 심사위원회 제도가 취소율에 직접적인 영향을 미쳤는지 여부는 판단하기 어렵다.

- 다만, 심사위원회 제도 전환 이후의 취소율이 직전 10년보다 올라갔으므로 위원회 방식을 통한 재해자의 권리 구제가 어느 정도 강화된 것으로 평가할 수 있다.

○ 한편, **산재 급여별 취소율 현황**을 살펴보면, 다음과 같다.

- 휴업급여의 변동 폭은 큰 것으로 나타났는데, 이는 전체 신청 건수가 많지 않기 때문으로 판단된다. 결정 건수의 과반 이상을 차지하는 요양급여는 전체 취소율과 유사한 형태를 보이는데, 이는 요양급여가 사실상 전체 통계 추이에 결정적인 영향을 미치기 때문이다.

- 유족급여의 취소율은 2011~2013년 사이에 소폭 하락한 경우를 제외하고는 비슷한 추이를 유지하고 있는 것으로 파악된다. 장해급여의 경우, 2014~2015년에 소폭 상승한 경우를 제외하고는 비슷한 추이를 유지하고 있다.

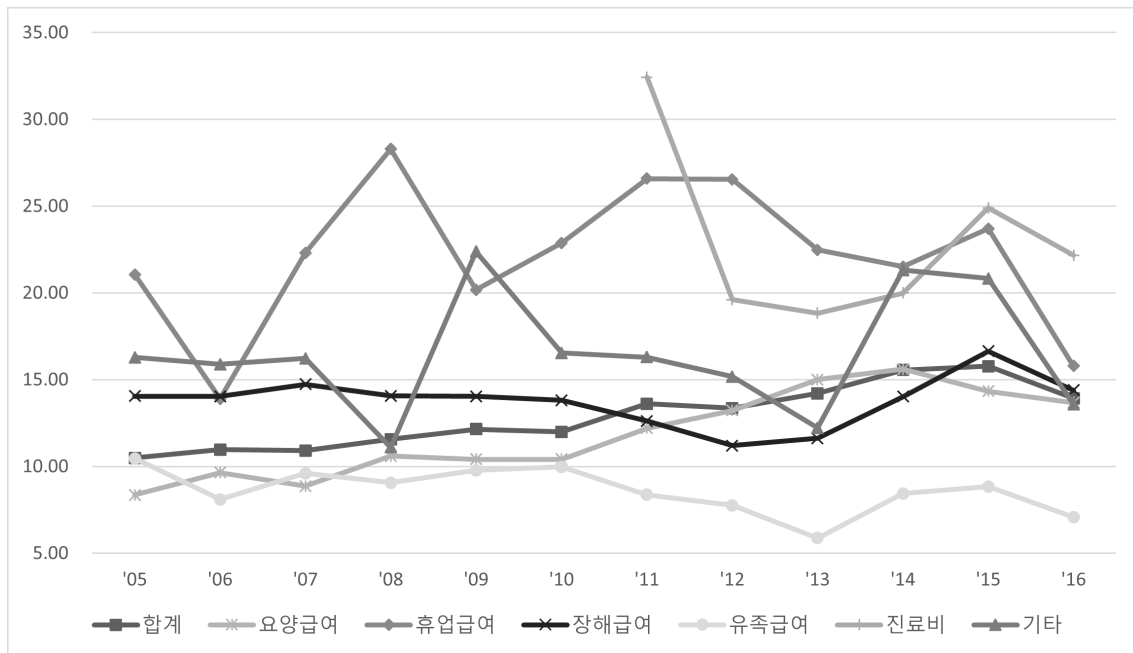
[표 2-12] 산재 급여별 취소율 현황

연도	구 분	결 정					취소율 (%)
		합계	취소	기각	각하	기타	
'05	합 계	6,370	668	5,421	207	74	10.49
	요 양 급 여	3,984	333	3,455	153	43	8.36
	휴 업 급 여	76	16	56	4	-	21.05
	장 해 급 여	1,316	185	1,085	24	22	14.06
	유 족 급 여	478	50	419	7	2	10.46
	기 타	516	84	406	19	7	16.28
'06	합 계	8,458	928	7,235	237	58	10.97
	요 양 급 여	5,407	522	4,711	151	23	9.65
	휴 업 급 여	151	21	105	21	4	13.91
	장 해 급 여	1,710	240	1,432	20	18	14.04

	유 족 급 여	567	46	509	8	4	8.11
	기 타	623	99	478	37	9	15.89
'07	합 계	8,871	969	7,656	53	193	10.92
	요 양 급 여	5,783	513	5,115	127	28	8.87
	휴 업 급 여	224	50	167	6	1	22.32
	장 해 급 여	1,723	254	1,434	24	11	14.74
	유 족 급 여	500	48	441	9	2	9.60
	기 타	641	104	499	27	11	16.22
'08	합 계	7,854	908	6,680	176	90	11.56
	요 양 급 여	5,116	543	4,423	118	32	10.61
	휴 업 급 여	159	45	101	4	9	28.30
	장 해 급 여	1,450	204	1,220	20	6	14.07
	유 족 급 여	463	42	410	8	3	9.07
	기 타	666	74	526	26	40	11.11
'09	합 계	7,843	953	6,664	146	80	12.15
	요 양 급 여	5,097	531	4,416	98	52	10.42
	휴 업 급 여	218	44	159	9	6	20.18
	장 해 급 여	1,651	232	1,399	11	9	14.05
	유 족 급 여	399	39	349	9	2	9.77
	기 타	478	107	341	19	11	23.38
'10	합 계	8,014	962	6,835	141	76	12.00
	요 양 급 여	5,001	521	4,352	86	42	10.42
	휴 업 급 여	188	43	135	5	5	22.87
	장 해 급 여	1,528	211	1,299	11	7	13.81
	유 족 급 여	421	42	357	17	5	9.98
	기 타	876	145	692	22	17	16.55
'11	합 계	8,024	1,092	6,727	126	79	13.61
	요 양 급 여	5,085	621	4,322	90	52	12.21
	휴 업 급 여	173	46	124	3	-	26.59
	장 해 급 여	1,546	195	1,326	11	14	12.61
	유 족 급 여	442	37	396	8	1	8.37
	진 료 비	410	133	269	4	4	32.44
	기 타	368	60	290	10	8	16.30
'12	합 계	8,469	1,132	7,074	171	92	13.37
	요 양 급 여	5,365	710	4,497	104	54	13.23
	휴 업 급 여	275	73	193	8	1	26.55
	장 해 급 여	1,652	185	1,423	21	23	11.20
	유 족 급 여	387	30	346	9	2	7.75
	진 료 비	316	62	239	9	6	19.62
	기 타	474	72	376	20	6	15.19
'13	합 계	8,265	1,175	6,872	138	80	14.22
	요 양 급 여	5,247	788	4,318	97	44	15.02
	휴 업 급 여	307	69	231	6	1	22.48
	장 해 급 여	1,694	197	1,467	15	15	11.63
	유 족 급 여	340	20	315	3	2	5.88
	진 료 비	276	52	211	6	7	18.84
	기 타	401	49	330	11	11	12.22
'14	합 계	8,371	1,303	6,851	113	104	15.57
	요 양 급 여	5,068	791	4,150	68	59	15.61
	휴 업 급 여	316	68	237	7	4	21.52
	장 해 급 여	1,953	274	1,642	18	19	14.03

	유 족 급 여	367	31	329	4	3	8.45
	진 료 비	245	49	186	5	5	20.00
	기 타	422	90	307	11	14	21.33
'15	합 계	8,489	1,340	6,974	80	95	15.79
	요 양 급 여	4,888	701	4,078	48	61	14.34
	휴 업 급 여	346	82	257	1	6	23.70
	장 해 급 여	2,234	372	1,831	13	18	16.65
	유 족 급 여	317	28	282	3	4	8.83
	진 료 비	253	63	188	2	-	24.90
	기 타	451	94	338	13	6	20.84
'16	합 계	8,157	1,137	6,827	75	118	13.94
	요 양 급 여	4,244	581	3,564	50	49	13.69
	휴 업 급 여	304	48	244	5	7	15.79
	장 해 급 여	2,744	395	2,285	11	53	14.40
	유 족 급 여	325	23	297	2	3	7.08
	진 료 비	194	43	150	-	1	22.16
	기 타	346	47	287	7	5	13.58

[그림 2-11] 산재 급여별 취소율 현황



(2) 최근의 심사 통계

근로복지공단 보도자료에 의하면, 2022년 산재 노동자 1,493명이 산재심사위원회 심사 청구를 통하여 권리구제를 받은 것으로 확인¹²⁰⁾된다.

120) 근로복지공단 2023. 3. 20. 보도자료, “2022년 산재노동자 1,493명 소송없이 권리구제 받아 -산재 심사위원회 심사청구 통해 비용 부담 없이 60일 이내 결정-”

- ☐ 근로복지공단은 업무상 재해에 대한 보상을 받지 못한 노동자가 법원에 소송을 제기하기 전에 공단에 심사를 청구하면 공정하고 신속한 심의를 통해 권리구제 받을 수 있도록 산업재해보상보험심사위원회를 운영하고 있다.
- 위원회는 법률·의학·사회보험 분야 외부 전문가 150명으로 구성되어 산재보험급여 관련 처분이 잘못되었을 경우 이를 바로 잡아 공정하게 노동자의 권리와 이익을 보호하고 있다.
 - 법원 소송을 통해 구제를 받으면 소요되는 시일이 길고 소송비 등이 발생하지만 공단 심사청구는 60일 이내에 그 결과를 빨리 받아 볼 수 있고 비용도 들지 않는다는 장점이 있다.
- ☐ 위원회는 적극행정 등을 통해 작년에 접수된 심사청구 10,107건 중 산재노동자 1,493명의 권리를 구제하였다.

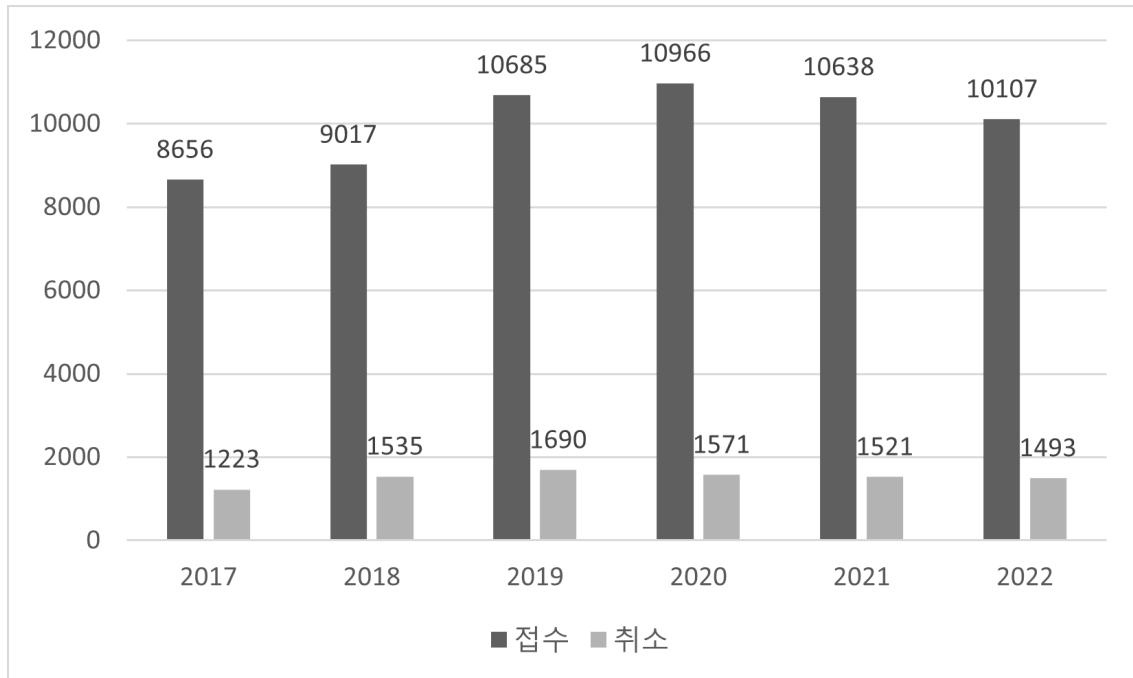
산재심사에 관한 2017~2022년의 통계¹²¹⁾를 살펴보면, 2017년 이후 산재 심사 접수 건은 2020년까지 증가하다 이후 감소세를 보인다.

[표 2-13] 산재 심사 연도별 현황

연도	접수	취소	취소율(%)
2017	8,656	1,223	14.1
2018	9,017	1,535	17
2019	10,685	1,690	15.8
2020	10,966	1,571	14.3
2021	10,638	1,521	14.3
2022	10,107	1,493	14.8

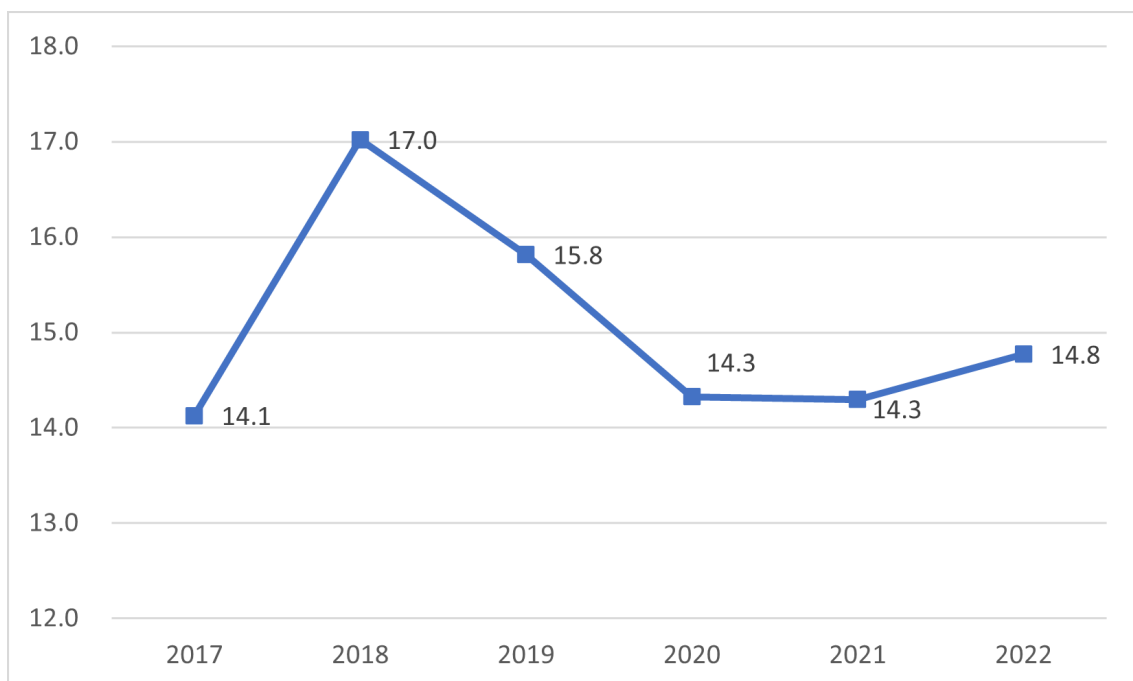
121) 공공데이터포털 홈페이지, <https://www.data.go.kr/data/15105030/fileData.do>(2023. 7. 20. 확인); 근로복지공단 2023. 3. 20. 보도자료, “2022년 산재노동자 1,493명 소송없이 권리구제 받아 -산재심사위원회 심사청구 통해 비용 부담 없이 60일 이내 결정-”를 합쳐서 작성함.

[그림 2-12] 산재 심사 연도별 접수 및 취소 건수



취소율의 경우, 통상 14~15%대를 보이거나 2017년의 경우에는 이례적으로 17%로 높게 나타난 것으로 확인된다.

[그림 2-13] 산재 심사 연도별 취소율



(3) 평가

이상에서의 분석과 관련하여, 과거 산재보험심사관 제도와 현재의 산재보험심사위원회 제도와 평가해 보자면 당시의 산재보험심사관제도나 단독심 제도가 현재의 심사위원회 제도보다 근로자들에게 유리한 제도였다고 단정하기는 어렵다. 물론 1995년부터 2000년 사이에 고용노동부 산재보험심사관 제도에 뒤이은 근로복지공단 단독심 제도 아래에서 산재심사 취소율은 2000년대 초반보다 높은 비율을 보여주고 있는 것은 사실이다.

그러나 산재보험급여의 종류, 판단기준 등에 관한 현재의 보험급여제도와 보험환경이 당시의 보험급여제도와 환경과 비교하여 사뭇 달라진 점이 많기 때문에 이러한 점을 고려하지 않고 사소한 채 단순비교하기는 어렵기 때문이다. 요컨대 심사 취소율의 단순비교만으로 현재 심사위원회 제도의 우열을 쉽게 판단하기는 어렵다고 할 것이다.

3. 재심사청구

산재재심사위원회는 1996년부터 2022년까지의 통계자료¹²²⁾를 제공하고 있다. 재심사의 경우, 최근 접수 건수가 꾸준히 증가하고 있는데 2000년대 초중반에 3천 건 내외였던 것이 현재는 4천 건을 넘어 5천 건에 이르고 있다.

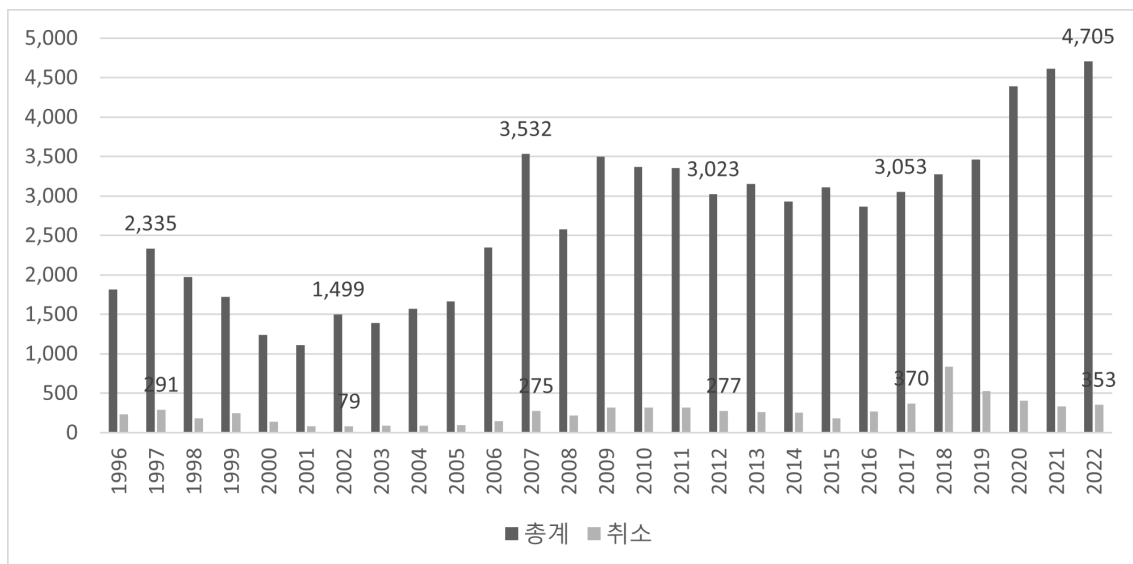
[표 2-14] 산재 재심사 연도별 현황

구분연도	총계	취소	기각	각하	취소율(%)
1996	1,816	230	1,158	68	12.7
1997	2,335	291	1,952	92	12.5
1998	1,977	185	1,734	58	9.4
1999	1,722	247	1,428	47	14.3
2000	1,240	137	1,058	45	11.0
2001	1,114	79	1,011	24	7.1
2002	1,499	79	1,405	15	5.3
2003	1,394	91	1,287	16	6.5
2004	1,568	90	1,460	18	5.7
2005	1,664	94	1,547	23	5.6
2006	2,347	147	2,170	30	6.3

122) 산업재해보상보험재심사위원회 홈페이지, <https://www.iaciac.go.kr/info/statistics/main.do>(2023. 7. 20. 확인).

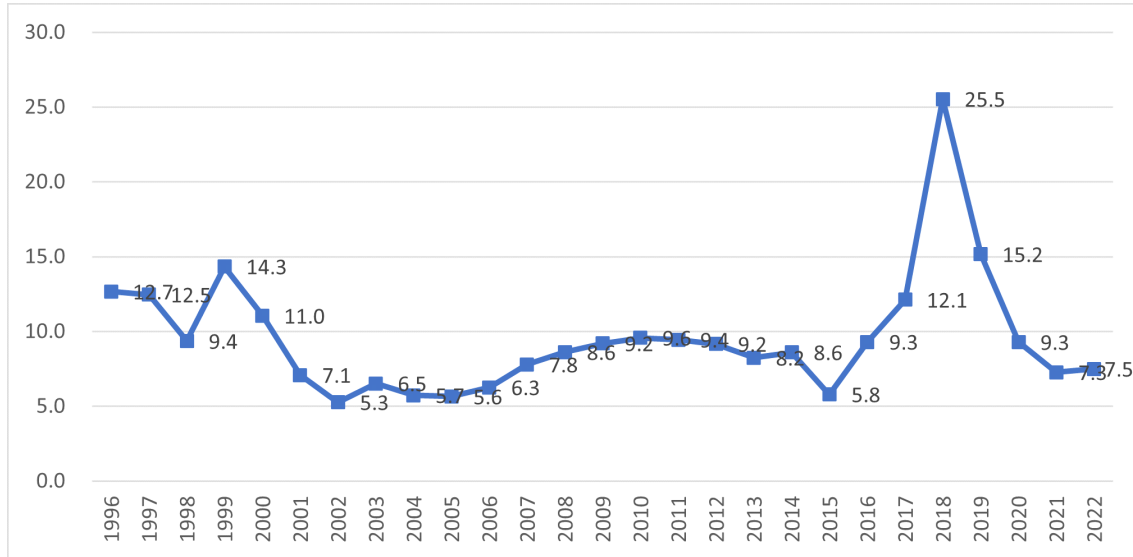
2007	3,532	275	3,211	46	7.8
2008	2,576	222	2,315	39	8.6
2009	3,499	322	3,135	42	9.2
2010	3,371	323	3,003	45	9.6
2011	3,356	317	3,000	39	9.4
2012	3,023	277	2,700	46	9.2
2013	3,155	260	2,846	49	8.2
2014	2,928	252	2,642	34	8.6
2015	3,107	180	2,896	31	5.8
2016	2,869	267	2,560	42	9.3
2017	3,053	370	2,652	31	12.1
2018	3,273	836	2,400	37	25.5
2019	3,462	525	2,880	57	15.2
2020	4,392	408	3,936	48	9.3
2021	4,617	336	4,235	46	7.3
2022	4,705	353	4,311	41	7.5

[그림 2-14] 산재 재심사 연도별 접수 및 취소 건수



취소율의 경우 2000년대 초중반 10% 미만이었으나, 2017년 이후 최대 25%까지 증가하였다. 최근에는 약 7%대의 취소율을 보이고 있다. 2017~2019년의 기간을 제외하면 최근에는 대체로 10% 내의 취소율을 보이고 있는 것으로 나타난다.

[그림 2-15] 산재 재심사 연도별 취소율



III. 산재 권리구제에 관한 실태

1. 대리인 조사

(1) 조사 개요

산재 업무수행을 주된 업무로 하는 대리인을 대상으로, 업무를 수행하면서 최초 신청 및 심사·재심사 단계에서 느낀 고충 등을 자유롭게 문답하여 청취하는 방식으로 인터뷰를 실시하였다. 인터뷰는 2023. 5. 16(화) - 통영, 22(월) - 부산, 24(수) - 서울에서 진행되었다.

(2) 조사 내용

1) 조사자1 - 통영 소재 노무법인 공인노무사

- (지침·규정 적용의 편차) 재해자의 권익을 보호하는 내용으로 근로복지공단(이하 ‘공단’이라고 함)의 내부 지침이나 규정이 개정되더라도 이러한 내용이 일률적으로 적용되지 않고, 지사별 - 담당자별 적용에 편차가 생기는 경우가 있음.
- 즉, 지침 또는 규정 개정 이후 상당 기간이 경과해도 판단 과정에서 일률적으로 적용되지 않는 경우가 존재함.

- 대리인이 없거나 지적하지 않는 경우에는 재해자가 불이익을 겪는 경우도 있음.

○ **(부당한 추가 절차 적용)** 규정 등에 명확하게 규정된 절차가 아님에도 불구하고, 담당자의 재량으로 추가 절차에 따르도록 지시하여 처리가 지연되는 경우가 발생함.

- 대표적인 사례로 특진 결과가 불명확하다는 이유로 재특진 외에 재재특진까지 요구하는 사례가 있음.

- 소음성 난청의 경우, 특진 시 3회의 검진을 거쳐야 하므로(1~2개월 경과), 대기시간까지 합치면 결과 판정까지 1년 가깝게 시간이 소요되는 경우도 존재함.

<대표사례> 근거 없는 재재특진의 요구

소음성 난청의 경우 진단명에 대한 정확한 장해판정을 위해 실시하는 특별진찰에서 총 6번의 검사를 시행하고도 공단에서는 재특진 검사를 요구하는 경우가 있음.

재특진 시행과 관련하여 ‘명백한 이유’를 밝히도록 하고, 산재법 시행령 및 소음성 난청 지침에 명시된 것과 같이 3번씩 2회의 검사 이후에는 검사 결과로 판정이 이루어질 필요가 있다는 의견 제시함.

○ **(업무관련성 특별진찰 절차의 문제)** 산재 처리 절차의 개선으로 업무상 질병에 관한 ‘업무관련성 특별진찰’이 실시되고 있음. 이는 종래 공단 담당자가 조사하는 방식에서 의학적 전문성을 갖춘 병원에 조사 및 판단을 일정부분 위임한 것으로 이해할 수 있음.

- 문제는 업무관련성 특별진찰을 담당하고 있는 병원에서 ‘산업재해보상’에 관한 이해도가 낮거나, 병원 업무처리 담당자의 경험 부족, 병원 간 업무처리에 관한 편차 발생 등으로 처리가 지연되거나 불합리한 결과가 초래되는 경우가 늘어나고 있다는 점임.

<대표사례> 업무관련성 특별진찰 지연

소음성 난청에 대한 장해급여 청구 사건이 증가하였으나 특정 병원에 한정된 업무관련성 특별진찰로 인해 재해조사 시간이 상당 소요되어 사건 처리가 지연되고 있음.

- 창원병원: 평균 접수 후 6개월 이상 소요, 업무관련성 조사 약 6 ~ 8개월 이상
- 대전병원: 평균 접수 후 5개월 이상 소요, 업무관련성 조사 약 5 ~ 7개월 이상
- 동해병원: 평균 접수 후 10개월 이상 소요, 업무관련성 조사 약 10개 ~ 12개월 이상

<대표사례> 특진의료기관 기피 현상

업무관련성 특별진찰과 관련하여, 지역별 · 판정 주체별 편차가 크게 나타나 승인 · 불승인 빈도나 업무처리 성향에 따라 특정 특진의료기관을 선택하는 등의 경향이 발생함.

예를 들면, 소음성 난청 업무처리개선안에 “노인성 난청과 소음성 난청은 그 구별이

명확하지 않고, 노인성 난청으로 진단되었더라도 소음 노출 경력이 업무상 질병 인정 기준을 충족하고 소음 노출로 인해 연령증가에 따른 자연경과적 청력손실을 더욱 빠르게 진행시켰다면 업무상 질병으로 인정해야 한다”고 명시되어있음에도, 업무관련성 특별진찰 소견서상 단순히 “노인성 난청입니다.” 또는 “노인성 난청의 가능성이 있습니다.”로 판단하여 공단으로 이관하는 특정 특진의료기관이 있음.

이러한 경우에 공단은 해당 의견만을 받아들여 기계적으로 불승인 처분을 하는데, 이에 따라 재해자 및 대리인이 해당 특정 특진의료기관은 기피하고, 다른 특진의료기관으로 몰리는 문제가 발생함.

업무 관련성 특별진찰 소견서상 업무상 질병 여부 판단 시 같은 상병의 비슷한 사례의 승인·불승인의 여부를 공유 및 검토하고 업무처리개선 및 고시 내용 등을 적극적으로 적용하는 등 판단 주체별 편차를 줄일 방안이 모색될 필요가 있음.

- **(업무상 질병 업무처리 관련)** 업무상 질병과 관련된 부당한 업무처리 사례로, 일반 건강검진 결과를 불승인 처분에 반영하는 이중잣대 적용, 전체 근무 기간과 직종을 고려하지 않은 처분, 업무관련성이 인정되는 경우도 퇴행성 질환을 소극적으로 판단하는 경우 등을 지적함.

<대표사례> 업무관련성 인정되는 퇴행성 질환의 불승인 처분

예를 들어, 근골격계질환 중 척추 협착증과 관련하여, 신체 부담 업무로 자연 경과적 변화가 더욱 빠르게 진행된 것이 의학적으로 인정되면 업무상 질병으로 보아야 하나, 자문의 소견상 “개인적 퇴행성 질환이다”라고 되어있을 시 업무관련성 인정되는 경우에도 불승인 처리하고 있음. 업무관련성 있는 경우 자연경과적 변화와 해당 퇴행성의 정도를 의학적으로 판단하여 업무상 질병 여부를 결정하는 것이 바람직함.

- **(공단 운영과 관련된 개선 건의사항)** 공단 운영과 관련된 개선점으로는 지사별 업무처리 방식 및 속도 차이, 공단 담당자의 소통 부재, 대리인을 배제한 업무 처리, 작업환경연구원의 조사 장기화, 지사별 상이한 지침 처리 등이 문제로 지적됨.

<대표사례> 지사별 업무처리 방식 및 속도 차이

동일한 사건에 대해 지사별로 지침 적용이 상이한 부분이 존재하여 업무의 진행에 있어 일관성이 저해되는 경우가 빈번하게 발생하는 사례 있음.

공단 지사마다 업무처리 속도가 크게 차이 나는 경우가 있음. 예를 들어 난청 사건과 관련하여 창원지사에서 2개월이 지나도 접수 기록만 되었을 뿐 담당자 미배정, 신청서와 이하 서류 미확인된 경우가 많음. 이와 달리 태백지사는 특별진찰 의뢰까지 5

일 만에 처리할 때가 있음. 각 사건의 처리기한이 명확하게 확립되고 그 처리 기한 안에 사건이 처리될 수 있도록 시스템 구축이 필요함.

<대표사례> 조사 장기화

직업환경연구원 전문 조사 역학조사와 관련하여, 의뢰 접수 후 약 10개월 이상 16개월이 소요되는 등 조사가 장기화됨.

- **(심사 및 재심사 관련 문제)** 산재 심사 및 재심사 처리와 관련해서, 절차상 문제점으로 지적된 일반적인 사항은 다음과 같음.

<대표사례> 처리기한 장기화

심사, 재심사 청구 시 위원회 위원들이 증원되었음에도 처리기한이 너무 오래 걸리는 문제가 있음.

2) 조사자2 - 부산 소재 노무법인 공인노무사

- **(특진 관련 문제)** 난청 등의 일부 상병의 경우, 2~3회 여러 번의 특진이 반복되는 문제가 존재함. 또한, 특진이 가능한 상급종합병원을 확대하여 특진 소요 기간 등을 줄이는 방안을 모색할 필요가 있음.

- 즉, 현재 산재 절차가 지연되는 이유 중 상당수가 특진 때문으로 판단되므로, 특진에서 시간을 경감시키는 방안 마련이 필요하겠음.

- **(전문가인 공단 담당자의 역할 및 참여 개선 필요)** 이전에는 공단 직원이 조사에 직접적으로 관여하거나 참여하는 비중이 높게 절차가 구성되어 있었으나, 최근에는 이러한 절차가 상당 부분 병원 등의 기관으로 이전되었는데, 이에 따른 부작용이 존재함.

- 기존 공단 담당자 조사 방식에서 조사 업무 등을 병원으로 이관한 이유는 공단의 업무 부담을 경감시키기 위한 것으로 판단되나, 현재 병원의 업무 부담이 동일하게 증가한 상태임. 즉, 현재 뇌심질환이나 근골격계질환의 경우, 실질적으로 조사기관인 병원 등에 아웃소싱을 준 것으로 평가할 수 있음.

- 근골격계 업무력 조사의 경우, 현재 대학병원 등에서 진행되는데, 이를 제대로 수행 가능한 인원이 없는 경우가 존재함. 예를 들어, 담당 직원이 사무를 변경하거나, 새로 입사한 경우 산업재해에 관한 이해 정도가 굉장히 낮은 경우가 존재함.

- 이를 해결하기 위해서 ①기존처럼 공단 담당자가 조사를 직접 진행하는 방안, ②조사 담당 병원 및 담당자에 대한 교육 프로그램을 마련하여 조사 편차 등을 줄이는 방안 등이 필요하다는 의견임.

- 산업재해보상 체계는 합리성과 공정성, 신속성을 모두 담보하는 방향으로 운용되어야

하는데, 현재의 방법을 입법목적에 최적화된 것이라고 평가하기는 어렵다는 입장임.

<대표사례> 공단 담당자의 소극적인 역할

공단지사 담당자는 기존의 업무조사 등을 상당 부분 특진 기관, 병원 등에 이관하여 업무 부담이 감소한 상태로 판단됨. 문제는 이러한 업무 변화에 따라서 담당자의 업무처리 방식도 다소 소극적으로 변했다는 점임.

판단에 결정적인 영향을 미칠 수 있는 서류 등을 적극적으로 요구하거나, 피해자와 연락하는 경우는 거의 없으며, 소극적으로 자료 취합 기능에만 집중하는 경향이 있음. 이에 따라 조직 전체가 산재 처리에 소극적으로 대응하거나 처리하는 상황으로 평가됨.

○ **(심사 및 재심사 관련 개선점)** 심사 및 재심사 과정에서 피해자의 ‘조사요청’이 가능하나, 실제로 이루어지는 경우는 거의 없음.

- 심사 및 재심사는 선행 최초 처분의 미흡한 점을 확인하고 개선할 수 있는 기회이나, 그 실효성이 매우 낮음. 실제 피해자가 조사를 요구하더라도 극소수만 받아들여지고, 나머지는 특별한 사유 등의 통지 없이 인정되지 않음. 조사요구의 실효성을 높이기 위한 방안 마련이 필요함.

- 한편, 사용자의 자료 제출 의무를 강화하는 방안 마련이 필요함. 예를 들어, 근골격계 질환에 있어서 작업 동영상은 매우 중요하나, 사용자가 제출하지 않는 경우에는 이를 확보할 방법이 없음. 판정에 영향을 미치는 중요한 내용이므로 제출 등을 강제할 방안이 모색되어야 하겠음.

3) 조사자3 - 서울 소재 법무법인 공인노무사

○ **(특진 절차에서 합리성이 담보되지 못한 경우)** 병원에서 진행되는 특진 절차의 경우, 개인의 특수성을 충분히 고려하지 못하거나 일관성이 떨어지는 등 운영상의 문제점 존재함.

<대표사례> 공단에서 특정 병원으로 특진을 보낸 이후, 해당 병원의 결과를 신뢰하지 않는다고 발언함

공단의 안내에 따라 특정 병원에서 특진을 진행하였으나, 추후 공단 담당자가 해당 병원의 특진 결과를 신뢰하기 어렵다는 취지의 발언을 함.

<대표사례> 특진 과정에서 낮은 지능 등 개인의 특수성이 고려되지 않은 경우

소음성 난청의 경우, 판단의 일관성이 중요하며, 이에 따라 지시를 즉각적으로 이행하는 것이 중요함. 문제는 지능이 낮아서 지시사항을 바로 이행하지 못하면, 불이익을 받을 가능성이 높아지는데, 실제로 지능이 낮은 재해자가 판정의 일관성 문제로 3회의 재재특진(총 9회)을 받은 사례가 있음.

○ **(업무상 질병 조사 방식의 문제점)** 업무 관련 조사를 근로복지공단이 아닌, 다른 기관(창원병원, 고신대병원, 근로복지공단 부산의원) 등에서 진행함에 따라 여러 문제가 발생하고 있음.

- 조사 등이 여러 기관에서 진행되고 있는데, 업무의 일관성이나 전문성은 낮은 상태임. 이에 따라 교육 등을 통하여 업무의 일관성을 확보하고 전문성을 제고할 수 있는 방안 마련이 시급한 상황임.

- 현재 진행되는 조사 방식은 전문가인 대리인이 없으면 불이익을 당하기 쉬운 구조라고 판단됨. 대리인 유무와 관계없이 정확히 안내를 받고 불이익을 받지 않도록 제도 개선이 필요함.

- 한편, 이는 원처분기관인 지역 지사가 재해 결정에 관여하는 정도가 낮아지면서 발생하는 문제라고 평가할 수 있음. 즉, 전문성이 낮고 경험이 부족한 기관이 조사를 담당함에 따라 실제 결과에 승복하기 어려운 사례 등이 빈번하게 발생하고 있음.

○ **(형식적으로 진행되는 심사 절차의 개선 필요성)** 재심사에 비하여 산재 심사는 굉장히 형식적으로 진행되는 측면이 있음. 심사 단계에서 원처분기관의 부당한 처분이 시정되길 기대하기는 어려우며, 실제 원처분기관의 결정이 변경되는 사례도 거의 없음.

- 응답자는 산재만 전문으로 처리하고 있으나, 최근 10년간 심사에서 원처분이 취소된 사례는 없었다고 함. 심사 절차는 하나 마나 한 형식적인 절차라는 인식이 형성되어 있음.

○ **(재심사의 지연으로 인한 문제)** 현재 재심사의 경우 6~8개월이 소요되고 있어 재해자에게 고통이 발생하는 경우 있음.

<대표사례> 재심사 지연으로 인한 경제적 손실

폐암으로 최초 승인을 받고 요양 중인 근로자에 대하여, 요양 종료 및 휴업급여 미지급 결정됨. 이에 대하여 재심사에서 다투었으나, 처리 기간이 길어지면서 경제적 궁핍으로 인하여 폐 절제로 몸이 안 좋은 상태임에도 경비 근로를 함. 이후 오랜 기간이 경과해서 재심사에서 요양 및 휴업급여 부지급 처분이 취소되었으나, 실제 근로를 제공한 기간에 휴업급여가 발생하지 않아 경제적으로 손실을 보는 한편 건강도 악화되었음.

○ **(업무 담당자의 전문성 부족)** 공단 담당자의 경우, 순환보직, 산재 업무 중에서도 여러 질병 등을 담당하는 등의 문제로 전문성이 부족한 경우가 있음. 또한, 이를 조직적으로 개선하기 위한 프로세스도 다소 부족하다고 여겨짐.

- 즉, 담당자의 업무미숙이나 전문성 부족은 공단의 조직적 문제인데, 이를 단순히 개인의 문제라고 생각하고 조직적으로 해결하려는 노력이 충분하지 않음.

교육이나 주요 규정 및 지침 적용에 관한 전파 등이 필요하다는 의견임.

<대표사례> 공단 내부 규정의 미숙지

공단 담당자가 공단의 내부 규정을 제대로 인지하지 못해서 대리인이 공단에 팩스로 해당 내용을 송부한 사례 있음.

4) 소결

인터뷰 결과, 업무처리 지연 및 지침 미적용 등이 주된 문제로 지적되었다. 세부적으로 지사 담당자들의 잦은 발령과 부서 이동으로 전문 지식이나 업무처리 속도가 다르고, 각 부속기관(근로복지공단 소속 병원, 직업환경연구원, 질병판정위원회)에서도 이에 따라 업무처리 기간이 지연되고 있는 것으로 파악된다. 각 관할 지사의 이슈(자주 발생하는 상병과 민원 접수)에 맞춰서 인원 보강이 필요한데, 강원지역본부/광주지역본부에 진폐보상부가 개설된 것은 산재보상 업무처리와 관련된 바람직한 정책 방향이라는 의견이 제시되었다.¹²³⁾

또한, 지침이 있음에도 불구하고 자의적으로 해석하거나, 전문적인 조사 없이 일반화하여 적용하는 문제, 지침 적용에 있어 객관적이지 못한 부분도 지적되었다. 이와 관련하여 지침을 재해자에게 적용할 때 기준과 원칙을 설정하고, 객관적으로 적용하여 합리적인 결과가 나오면 이러한 불만도 줄어들 것이라는 의견이 있었다.

심사 및 재심사의 지연은 상시 지적되고 있는 문제이며 개선이 필요한 것으로 파악된다.

2. 근로복지공단 간담회

2023. 6. 12. 근로복지공단 본사에서 연구진, 공단 담당자가 참여하여 간담회를 실시하였고, 산재 절차 개선에 관하여 다음과 같이 논의하였다.

123) 예를 들어, 조선소 밀집 지역 관할지사에 소음성 난청이나 근골격계 전담팀을 구성하는 방안.

○ **쟁송 절차 단순화 방안**

- 현재 재심사 기간이 6개월 이상 소요되고 있어 이를 줄일 수 있는 방안 마련 필요.
- 심사 및 재심사 단계에서 상병의 진단명을 확인 또는 확정하기 위한 논의에 많은 시간이 소요되므로, 심사 또는 재심사 단계에서는 원처분의 상병명 확정이나 진단이 정확한지 등은 다루지 않고 산재보상정책적 측면의 논의에 집중하는 방안도 고려해볼 수 있음.
- 현재 재심사 단계에서 다양한 방면의 전문가가 많이 참여하고 있어 지연되는 것은 아닌지 고민 필요.

○ **공단 이의제기 심사방식 개선 방안**

- 심사장 처리방식과 심사위원회 처리 방식에 관한 해외입법례 비교검토 필요. 심사위원회 처리 방식의 효율성에 관한 검토 필요.
- 산재심사의 경우 담당자가 평균 월 34건을 처리하는데 비하여, 재심사는 12~15건을 처리하고 있어 심사와 재심사 단계에서 각 업무가 효율적으로 이루어지고 있는지 검토해볼 필요 있음.

○ **업무상질병 사건 신속처리 방안**

- 특진, 업무관련성 특별진찰 등 개선 방안에 관하여 논의.

○ **기관 간 근로자성 판단 충돌 해결 방안**

- 최근 있었던 사례로, 고용노동청에서 근로자성을 인정하였고 근로복지공단이 이를 바탕으로 산재보상을 하였으나, 직후 고용노동청이 근로자성 인정 처분을 번복하여 근로복지공단도 보상 결정을 취소하고 지급한 산재보험급여 반환 청구를 하였음. 이러한 문제를 예방하기 위한 방안 마련 필요

IV. 의의 및 시사점

현행 산재 권리구제 절차 현황 등과 관련하여 다음의 시사점이 도출된다.

첫째, 현행 권리구제 제도 중에서 산재 심사와 재심사는 구분되는 제도이며, 운영 원리와 절차 등을 일부 다르게 설정하는 것도 가능하다고 판단된다. 현행 헌법은 행정심판에 준사법적 절차 원리를 적용하도록 규정하고 있는데, 이러한 구조는 기본적으로 재심사 제도에 더욱 적합하다고 판단된다. 현행 심사제도가 원 처분기관인 행정 그렇다면 근로복지공단 내부에서 이루어지고 있어 이를 행정심판이 아닌

일종의 이의제기 절차로 평가하는 견해도 존재한다. 이러한 점을 종합적으로 고려하면, **심사제도는 더욱 간이하고 신속한 제도로 기능하도록 하되, 재해자의 권리구제에 관한 기능과 절차 보장 등에 관한 사항은 재심사 단계에서 보완하는 방안을 고려해 볼 수 있다.**

둘째, 현행 산재보험법은 산재심사와 재심사를 별도로 규율하고 있으나 양 제도의 규정을 교차로 준용하는 등 체계 적합성이 다소 미흡한 상황인 점도 문제 소지가 있다. 이는 일반 국민의 규정의 적용과 해석을 어렵게 하여 권리 구제에 악영향을 미칠 우려가 있다. **산재보험법 개정을 통하여 심사와 재심사 제도를 체계적으로 정비할 필요가 있다.**

셋째, **원처분 기관의 결정과 심사 및 재심사 기간을 단축시킬 수 있는 방안이 마련**되어야 한다. 먼저, 원처분 기관의 결정을 보면, 업무상 사고에 비하여 업무상 질병의 처리에 소요되는 기간이 매우 긴 것으로 나타났다. 이를 개선하기 위하여 근골격계질병에 대한 특별진찰, 패스트트랙 등의 제도를 도입하였으나 초기 단계이므로 향후 성과를 더욱 지켜볼 필요가 있다. 근골격계 질병에 대한 신규 제도 도입현황을 모니터링하여 문제점을 개선하는 한편, 다른 질병에도 확대 적용하는 방안이 마련될 필요가 있다. 한편, 심사 및 재심사의 경우, 법정 기한을 초과하는 만성적인 처리 기간 지연이 발생하고 있다. 이는 해당 기관 내의 행정 지연보다는 의학적 소견에 대한 판단 및 검증 과정에 기인한 것으로 추정된다. 이를 개선하기 위하여 노동위원회와 같이 처리 기간 내 심의 등을 의무적으로 개최하는 한편, 의학적 소견을 추정 등으로 대체하거나 산재와 관련된 별도의 의학적 소견 방식을 개발 및 보급하는 등의 고민이 필요하다고 판단된다.

제3절 업무상 질병에 대한 판정

[그림 2-16] 업무상 질병의 발생형태에 따른 분류체계



I. 업무상 질병 판정을 위한 실무 절차

1. 업무상 질병판정위원회 심의대상

산재보험법 제38조 제1항은 업무상 질병의 인정 여부를 심의하기 위하여 공단 소속기관에 업무상질병판정위원회(이하 “판정위원회”라 한다)를 둔다고 규정하는 한편, 판정위원회의 심의에서 제외되는 질병과 판정위원회의 심의 절차는 고용노동부령으로 정하도록 하고 있다(동조 제2항). 업무상 질병은 원칙적으로 판정위원회의 심의를 거쳐 결정하도록 하고 있다. 또한, 이처럼 업무상질병판정위원회의 심의를 거쳐 업무상 질병의 인정 여부가 결정된 경우에 대해서는 불복절차인 산업재해보상보험심사위원회 심의대상에서는 제외할 수 있도록 하고 있다.¹²⁴⁾ 따라서 근로복지공단 소속기관의 장¹²⁵⁾은 판정위원회의 심의가 필요한 질병에 대하여 보험급여의 신청 또는 청구를 받으면 판정위원회에 업무상 질병으로 인정할지에 대한 심의를 의뢰해

124) 진폐와 이황화탄소 중독인 경우에도 마찬가지로 심사위원회 심의 제외 대상이다(시행령 제102조 제2호 내지 제3호)

125) 이때 소속기관장이란 근로복지공단의 「직제규정」에 따른 지역본부장 또는 지사장을 말한다(업무상 질병판정위원회 운영규정 제2조 제5호). 또한 요양업무처리규정

야 한다(시행규칙 제8조).

근로복지공단 '요양업무처리규정' 제10조는 소속기관장은 요양급여의 신청 대상이 되는 상병이 법 제38조에 따른 업무상질병판정위원회의 심의 대상인 때에는 업무상 질병판정위원회에 심의를 의뢰하여 그 결과에 따라 요양급여의 지급 여부를 결정하도록 하고 있다. 이 경우 판정위원회의 심의 의뢰 절차 및 방법에 관한 사항은 공단의 '업무상질병판정위원회 운영규정'에서 별도로 정하고 있다. 요양업무처리의 관할과 관련해서 요양업무처리규정 제47조 제1항에 따르면 최초 요양급여 신청 및 진폐에 대한 요양급여 신청에 관한 업무는 근로자가 소속된 사업장을 관할하는 소속 기관장이 처리하도록 하고 있다.¹²⁶⁾

2. 업무상 질병판정위원회 심의대상에서 제외되는 질병

판정위원회의 심의에서 제외되는 질병에 대해서는 시행규칙 제7조(판정위원회의 심의에서 제외되는 질병)에서 정하고 있는데 ① 진폐, ② 이황화탄소 중독증, ③ 유해·위험요인에 일시적으로 다량 노출되어 나타나는 급성 중독 증상 또는 소견 등의 질병, ④ 영 제117조 제1항 제3호¹²⁷⁾에 따른 특별진찰을 한 결과 업무와의 관련성이 매우 높다는 소견이 있는 질병, ⑤ 시행규칙 제22조 각 호의 기관¹²⁸⁾에 자문한 결과 업무와의 관련성이 높다고 인정된 질병, ⑥ 그 밖에 업무와 그 질병 사이에 상당인과관계가 있는지를 명백히 알 수 있는 경우로서 공단이 정하는 질병이 그것이다.

진폐와 관련해서는 공단은, 근로자가 요양급여 등을 청구하면 「진폐의 예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률」(이하 진폐근로자보호법) 제15조에 따른 건강진단 기관에 진폐 판정에 필요한 진단을 의뢰하고(법 제91조의6 제1항), 그 진단결과에 대하여 제91조의7에 따른 진폐심사회의의 심사를 거쳐 요양급여의 지급 여부, 진폐장해등급과 그에 따른 진폐보상연금의 지급 여부 등을 결정한다(법 제91조의 8 제1항 내지 제2항).

이황화탄소 중독증에 대해서는 공단 요양업무처리규정 제43조(이황화탄소중독증

126) 다만, 노무제공자의 최초 요양급여 신청 및 진폐에 대한 요양급여 신청에 관한 업무는 요양급여신청 소견서를 발급한 의료기관을 관할하는 소속기관장이 처리한다(요양업무처리규정 제47조 제1항 단서).

127) 시행령 제117조(진찰 요구 대상 등) ① 법 제119조에 따라 공단이 진찰을 요구할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다. 3. 업무상의 재해인지 판단하기 위한 진찰(기타 제1호 내지 제2호 및 제4호 내지 제5호 생략)

128) 시행규칙 제22조(업무상 질병에 관한 자문) 공단이나 판정위원회는 업무상 질병 여부를 결정할 때 그 질병과 유해·위험요인 사이의 인과관계 등에 대한 자문이 필요한 경우 다음 각 호의 기관에 자문할 수 있다. 1. 「한국산업안전보건공단법」에 따른 한국산업안전보건공단 2. 그 밖에 업무상 질병 여부를 판단할 수 있는 기관

판정절차 등)이 정하고 있는데 이에 의하면 소속기관장은 이황화탄소 중독증에 대한 요양급여 신청을 받은 때에 판정에 필요한 검사를 할 수 있는 산재보험 의료기관에 정밀진단을 의뢰하고, 정밀진단 결과를 통보받으면 규칙 제43조에 따라 이황화탄소 중독증에 걸렸는지 여부를 판정하여 판정결과 및 요양에 관한 결정을 하도록 하고 있다(동조 제1항 및 제2항).

끝으로 시행규칙 제7조 제6호에서 "업무와 그 질병 사이에 상당인과관계가 있는지를 명백히 알 수 있는 경우로서 공단이 정하는 질병"이란 업무상질병판정위원회 운영규정 제5조(판정위원회의 심의 제외 질병)에 따르면 ① 산업재해보상보험법 제49조에 따른 추가 상병 요양급여를 신청한 질병, ② 법 시행령 제34조제3항 별표 3 제7호 차목에 따른 소음성 난청, ③ 석면폐증, ④ 시행규칙 제22조에 따른 자문을 거친 광업 종사경력자의 만성폐쇄성폐질환, 또는 법 제119조에 따른 진찰 결과 만성폐쇄성폐질환 진단기준에 미달하는 경우, ⑤ 시행령 제34조제3항 별표 3 제6호 바목·사목, 제9호 가목·다목, 제12호 바목·사목에 해당하는 질병을 말한다. 마지막 별표 3의 제6호, 제9호, 제12호와 관련되는 질병의 목록은 다음과 같다.

별표 3(시행령 제34조 제3항 관련)

6호. 피부질병

：바. 덥고 뜨거운 장소에서 하는 업무 또는 고열물체를 취급하는 업무로 발생한 땀띠 또는 화상

사. 춥고 차가운 장소에서 하는 업무 또는 저온물체를 취급하는 업무로 발생한 동창(凍瘡) 또는 동상

9호. 감염성 질병

：가. 보건의료 및 집단수용시설 종사자에게 발생한 다음의 어느 하나에 해당하는 질병

- 1) B형 간염, C형 간염, 매독, 후천성면역결핍증 등 혈액전파성 질병
- 2) 결핵, 풍진, 홍역, 인플루엔자 등 공기전파성 질병
- 3) A형 간염 등 그 밖의 감염성 질병

다. 옥외작업으로 발생한 찰저상무시증 또는 신증후군 출혈열

12호. 물리적 요인에 의한 질병：

：바. 덥고 뜨거운 장소에서 하는 업무로 발생한 일사병 또는 열사병

사. 춥고 차가운 장소에서 하는 업무로 발생한 저체온증

다만, 위 별표3의 질병 목록은 포괄주의 외에도 열거주의를 채택한 데 따른 목록이라는 점을 고려할 때 업무상질병판정위원회 운영규정이 이처럼 제한적으로 인정

한 질병 목록이 시행규칙 제7조의 취지를 충분히 반영하고 있는지에 대해서는 다소 의문의 여지가 있다.

3. 심의 절차

근로복지공단은 업무상 질병에 관한 요양급여 신청을 접수한 후에, 질병명 확인, 재해 조사, 재해조사서 작성, 공단 전문의사 내지 특별진찰 등의 의학적 소견 확인, 업무상 질병판정위원회 심의 의뢰 등의 절차를 거쳐 산재 인정 여부를 결정한다.

(1) 요양급여신청소견서

먼저 업무상 질병의 상병 상태를 기술하는 요양급여신청소견서와 관련하여 공단의 '요양업무처리규정' 제7조 제1항에 따르면 소속기관장은 근로자가 최초로 요양급여를 신청하려는 때에는 그 근로자에게 별지 제2호서식의 요양급여신청서에 별지 제3호서식의 요양급여신청소견서를 첨부하여 신청하게 하되, 신청 대상 상병이 뇌혈관·심장질환이면 별지 제3호의2서식의 업무상질환 전문소견서(뇌심혈관계질환), 허리·부위·어깨·부위 근골격계질환이면 별지 제3호의3서식의 업무상질환 전문소견서(근골격계질환)를 첨부하게 할 수 있다. 다만, 별지 제3호서식의 요양급여신청소견서를 제출할 수 없는 사정이 있는 경우에는 신청 대상이 되는 상병과 치료기간 등이 명시된 진단(소견)서를 첨부하여 신청하게 할 수 있다.

(2) 재해조사

다음으로 재해조사와 관련해서는 '요양업무처리규정' 제4조(재해조사)에 따르면 소속기관장은 법 제36조제1항에 따른 보험급여의 신청 또는 청구를 받은 때에는 근로자의 재해가 법 제37조에 따른 업무상의 재해에 해당하는지 여부를 조사(이하 "재해조사"라 한다)하여야 하고(동조 제1항) 나아가 소속기관장은 제2항에 따른 재해조사를 실시할 때 해당 사업장 등을 방문하여 유해·위험요인에 대한 현장 확인 조사를 수행하여야 한다(동조 제8항). 현장 확인 조사의 대상은 다음 3가지이다. 첫째, 반복적인 신체부담 업무로 근골격계질환이 발생되었다고 신청인이 주장하는 경우(다만, 사무직 근로자 등 작업형태를 제출서류만으로 확인할 수 있는 경우는 제외), 둘째, 업무상 과로 또는 스트레스로 인하여 뇌혈관질환, 심장질환 또는 정신질환이 발생되었다고 신청인이 주장한 경우로서 과로 또는 스트레스에 대한 사실에 대하여

현장 확인이 필요한 경우, 셋째, 그 밖에 유해인자 또는 화학물질에 의한 질병이 발생된 경우로서 소속기관장이 현장 확인이 필요하다고 판단하는 경우이다(동조 제8항).¹²⁹⁾

다만 소속기관장은 재해조사 대상이 「뇌혈관 질병 또는 심장 질병 및 근골격계 질병의 업무상 질병 인정여부 결정에 필요한 사항(고용노동부 고시 제2022-40호)」 제2호(근골격계에 발생한 질병) 라목 3) 별표 1(이하 이 항에서 “고시 별표 1”이라 한다)이 정한 상병, 직종, 근무기간, 유효기간을 충족할 경우에는 그 사실을 신청인 등에게 알리고 현장 확인 조사를 생략할 수 있다(동조 제10항 본문). 업무상 질병 판정과 관련한 현장조사를 생략하고 업무상질병판정위원회에 심의 의뢰가 된다는 점에서 이는 일종의 패스트트랙 절차라고 할 수 있다. 하지만 신청인 등이 문서 등으로 현장 확인 조사를 요청하여 고시 별표 1 적용 대상 여부에 대한 확인이 필요하다고 판단하는 경우 현장 확인 조사를 실시할 수 있다.(동조 제10항 단서).

(3) 특별진찰

산업재해보상보험법 119조(진찰 요구)은 공단으로 하여금 보험급여에 관하여 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 보험급여를 받은 사람 또는 이를 받으려는 사람에게 산재보험 의료기관에서 진찰을 받을 것을 요구할 수 있다고 하는데 이를 특별진찰이라고 한다. 특별진찰 실시의 목적들 중에서 특히 업무상 질병과 깊은 관련을 가지는 부분이 바로 업무상의 재해인지를 판단하기 위한 진찰이다 (시행령 제117조 제1항¹³⁰⁾). 다시 말해서 업무 관련성 특별진찰의 중요한 목적 중 하나는 무엇보다 요양급여신청의 대상인 질병의 상병명 진단을 확인하기 위한 것이다. 통상 요양급여신청서를 접수한 소속기관장이 특별 진찰을 실시한다. 이때 소속기관장은 해당 산재근로자에게 별지 제8호서식의 특진의료기관 선택 확인서를 받도록 하고 있다(요양업무처리규정 제18조 1항). 현재 근골격계 질환과 소음성 난청을 중심으로 특별진찰을 실시하고 있다.

한편, 시행령에서는 특별진찰을 실시하는 특진의료기관으로서 산재보험법 제43조 제1항제1호에 따른 공단에 두는 의료기관, 산재보험법 제43조 제1항 제2호에 따른

129) 현재 요양급여신청의 약 15% 정도가 현장조사를 하고 있다.

130) 시행령 제117조(진찰 요구 대상 등) ① 법 제119조에 따라 공단이 진찰을 요구할 수 있는 경우는 다음 각 호와 같다.

1. 업무상의 재해로 요양 중인 근로자에 대한 계속 요양의 필요성을 판단하기 위한 진찰
2. 장애등급 또는 중증요양상태등급의 판정을 위한 진찰
3. 업무상의 재해인지 판단하기 위한 진찰
4. 재요양이 필요한지 판단하기 위한 진찰
5. 법 제61조에 따른 간병이 필요한지 판단하기 위한 진찰

상급종합병원, 그밖에 이에 해당하지 않는 산재보험 의료기관 중 「의료법」 제3조제2항 제3호 바목에 따른 종합병원으로 규정하고 있다(시행령 제118조 제1항).

(4) 업무상 질병에 관한 자문

산재보험법 시행규칙 제22조(업무상 질병에 관한 자문)에 따르면 공단이나 판정위원회는 업무상 질병 여부를 결정할 때 그 질병과 유해·위험요인 사이의 인과관계 등에 대한 자문이 필요한 경우에 관련 기관에 자문을 할 수 있도록 하고 있다.

이에 따라 공단의 요양업무처리규정 제9조(업무상 질병 여부에 관한 자문)에 의하면 소속기관장은 근로자의 질병에 대하여 재해조사 외에 시행규칙 제22조에 따른 업무상 질병에 관한 자문이 필요한 경우 원칙적으로 공단 측 직업환경연구원에 자문하도록 규정하고 있으면서 다만, 시행령 제34조에 따른 업무상 질병 인정기준에 명시되어 있지 않은 질병, 또는 이 인정기준에 질병과 유해요인은 명시되어 있으나 질병과 유해요인의 인과관계 및 다른 유해요인에 대한 조사가 필요한 질병은 한국 산업안전보건공단에 자문하고, 소음성 난청 등과 같이 유해요인에 대한 측정 등이 필요한 질병은 직업환경의학 외래기관으로서 작업환경 측정 및 시료 분석 등을 할 수 있는 인력·시설·장비를 갖춘 기관(예컨대 서울산재의학센터)에서 정해서 자문하도록 하고 있다(동조 제1항).

한편, 요양업무처리규정에 따르면 이처럼 소속기관장이 시행규칙 제22조 2호에 해당하는 기관(직업환경연구원, 한국산업안전보건공단 등)에 자문을 구하려는 경우에는 요양급여신청서 및 관련 재해조사 자료를 붙여 미리 이사장에게 적정 여부 등에 대한 의견을 묻도록 하고 공단 이사장은 자문의 필요성 여부 및 해당 자문기관을 정하여 소속기관장에게 알리도록 하고 있다(제9조 제4항 및 제5항).¹³¹⁾

(5) 업무별 의학 자문 기준

공단에서 제정하여 시행하는 산업재해보상보험 의학 자문 운영 지침(개정 2023. 1. 31. 지침 제2023- 1호)에 따르면 최초 요양급여의 지급 여부를 결정하는 때에는 해당 상병 분야의 진료과목 전문의 자격을 가진 자문의사에게 의학 자문을 하도록 하는 것을 기본원칙으로 하고 있다. 그러나 일정한 경우에는 이러한 자문을 생략할 수도 있다.

131) 이를 판단하기 위해 이사장은 업무상질병자문위원회를 둘 수 있다(규정 제9조 제10항).

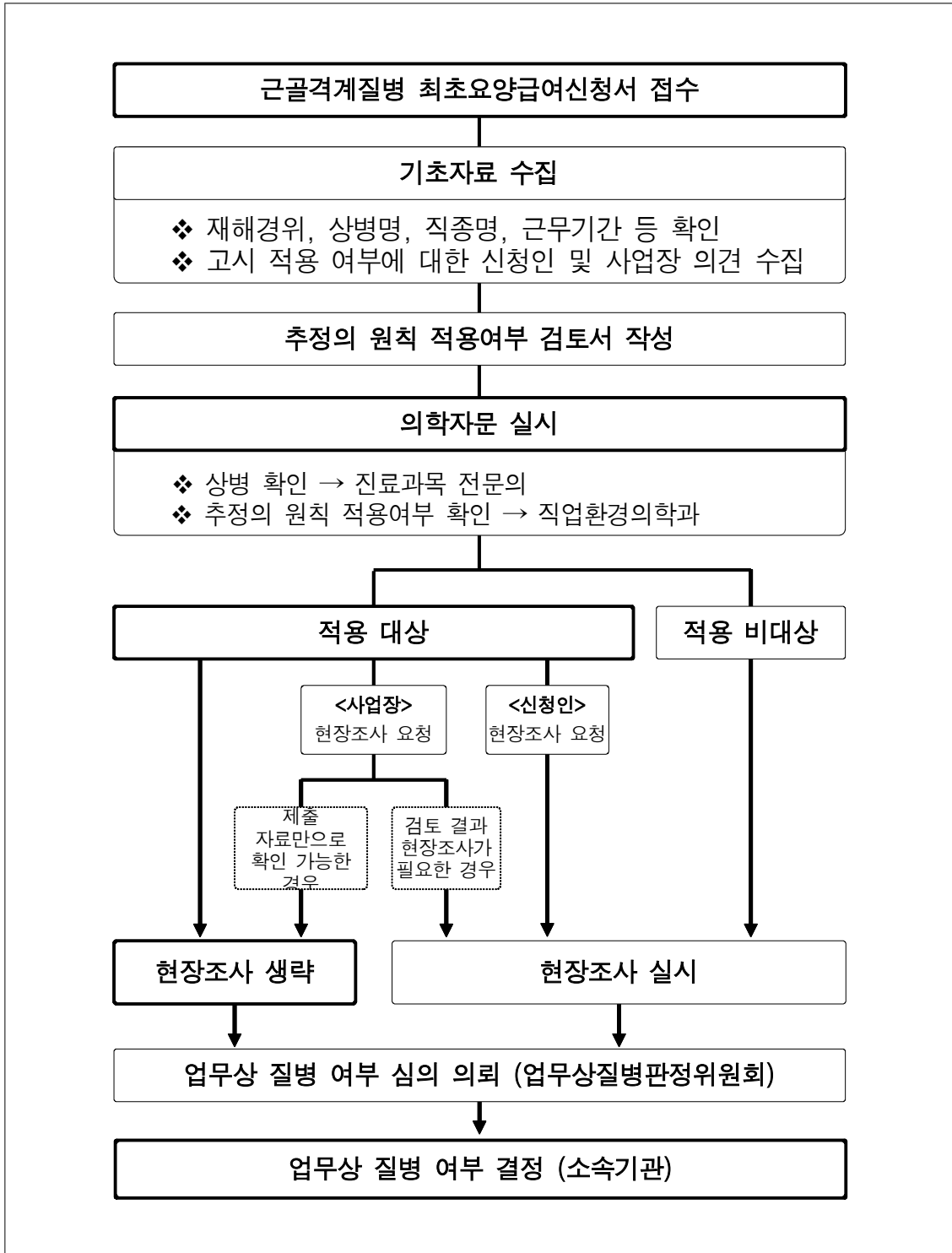
이러한 자문 생략에 해당하는 경우로서는 첫째, “근골격계질환, 뇌혈관·심장질환, 정신질환”으로 업무관련성 특별진찰 결과 상병명 확인 및 업무관련성 평가 내용이 있는 경우, 둘째, “근골격계 질환, 뇌혈관·심장 질환, 정신 질환, 직업성 암 또는 감염병”으로 업무상질병판정위원회 심의대상인 경우(다만, 이 경우에도 재해조사 방향, 추정의 원칙 적용 대상 여부 판단 등을 위해 의학 자문이 필요한 경우나 요양기간, 요양방법, 수술의 필요성 등에 대하여 해당 진료과목 전문의 자문이 필요한 경우에는 의학자문을 실시), 셋째, “직업성 암”으로 업무상질병자문위원회 자문 또는 전문(역학)조사 결과 상병명 확인 및 업무관련성 평가 내용이 있는 경우, 넷째, “소음성 난청”으로 업무상질병자문위원회¹³²⁾ 자문, 업무관련성 특별진찰 또는 원스톱 장해판정 결과 업무관련성 판단 및 장해등급 결정이 가능한 경우, 다섯째, “만성폐쇄성폐질환”으로 직업환경연구원의 전문(역학)조사를 거친 경우 또는 업무상질병자문위원회 자문 결과 상병명 확인 및 업무관련성 평가 내용이 있는 경우, 여섯째, 업무상 사고 또는 출퇴근 재해로 발생한 상병이 절단, 골절(척주 제외), 찰과상, 타박상·진탕, 열상·좌상, 화상에 해당하고, 해당 진료과목 전문의 진단 또는 진료기록지(영상판독, 수술기록)를 통해 확인되는 경우인데, 다만 기존 상병의 악화 여부나 재해와 인과관계에 관한 의학적 자문이 필요한 경우는 제외한다.

특히, 근골격계 질환과 관련해서는 (사전 자문) 현장 재해조사 이전에 조사대상 작업 판단, 조사방식 등에 대하여 필요한 경우에 직업환경의학과 상시자문의사에게 사전 자문을 얻도록 하고 있다. 다만, 직업환경의학과 상시자문의사가 없는 소속기관은 원칙적으로 인근 소속기관의 상시자문의사에게 자문을 받되, 업무 형편상 불가피한 경우에 한하여는 수시자문의사에게 자문받도록 하고 있다. 다음으로 근골격계 질환과 관련한 추정의 원칙 적용 대상 여부를 판단하기 위하여 상병명 확인은 해당 진료과목 전문의에게 자문하고, 추정의 원칙 적용여부는 직업환경의학과 전문의에게 자문을 하도록 하고 있다.¹³³⁾

132) 요양업무처리규정 제9조 ⑩ 이사장은 제5항에 따른 자문의 필요성 및 자문기관 판단 및 제2장에 따른 재해조사에 대한 자문을 하기 위하여 법 제11조제3항 및 제4항에 따라 40명 이내의 직업환경의학 전문의 등으로 구성된 자문위원회를 둘 수 있다.

133) 산업재해보상보험 의학 자문 운영 지침 4면 참고

[그림 2-17] 근골격계 다빈도 상병 업무상 질병 조사 및 판정절차 도식도¹³⁴⁾



134) 발생빈도가 높은 근골격계 상병 업무상질병 조사 및 판정 지침(제정 및 시행일자 2022.7.1. 근로복지공단 제2022-25호) 8면에서 인용

기타 질병으로서 정신 질병과 관련해서는 자해행위 또는 정신질환에 대하여는 '정신건강의학과' 전문의 자격을 가진 자문의사에게 임상적 소견에 대한 의학 자문을 한다.

소음성 난청과 관련해서는 이비인후과 또는 직업환경의학과 전문의 자격을 가진 자문의사에게 자문을 하도록 하고 있다. 이때 소음성난청 관련하여 특별진찰 또는 의학 자문 결과, 장애판정이 곤란한 경우 '장애판정위원회'에서 심의하게 한다.

다음으로 석면폐증과 관련해서는 특별진찰 실시에 따른 관련 자료를 첨부하여 '석면심사회의'에 심의를 의뢰하지만 '원발성 폐암' 및 '악성중피종'이 석면폐증과 같이 발병한 경우에는 업무상질병판정위에 심의를 의뢰한다.

만성폐쇄성폐질환처럼 소속기관에서 처리하는 업무상질병판정위원회의 심의 제외건은 내과(호흡기) 또는 직업환경의학과 등 해당 분야 전문의의 의학 자문을 받되, 특별진찰에 따른 폐기능 검사의 신뢰도 및 일초량, 일초율에 대해서도 함께 의학 자문을 한다.

끝으로 감염병과 관련해서는 재해 조사 결과를 바탕으로 내과(감염내과, 호흡기내과 등), 가정의학과, 이비인후과 및 직업환경의학과 등 전문의에게 자문하되, 발병원인 및 잠복기간 등 해당 질병에 대한 의학 자문이 필요한 경우 해당 진료과목 전문의에게 자문하도록 하고 있다.¹³⁵⁾

(6) 소속기관장에 의한 업무상질병판정위원회 심의 의뢰

업무상질병판정위원회 심의 절차와 관련하여 산업재해보상보험법 제38조 제2항의 위임에 따라 시행규칙 제8조(판정위원회의 심의 절차) 제1항은 공단의 분사무소인 소속기관의 장은 판정위원회의 심의가 필요한 질병에 대하여 보험급여의 신청 또는 청구를 받으면 판정위원회에 업무상 질병으로 인정할지에 대한 심의를 의뢰하도록 하고 있다. 소속기관장은 법 제36조 제1항에 따른 보험급여의 신청 또는 청구를 받은 경우로서 그 신청 또는 청구가 업무상 질병의 인정 여부에 관한 것이면 7일 이내에¹³⁶⁾ 별지 제1호의 업무상질병판정 심의의뢰서에 따라 그 소속 기관의 소재지를 관할하는 판정위원회에 업무상 질병의 인정 여부에 대한 심의를 의뢰하여야 한다(업무상질병판정위원회 운영규정 제4조 제1항). 「요양업무처리규정」별지 제1호 서식에 따른 재해조사서, 주치의사 및 해당 상병분야의 진료과목에 대한 전문의 자격을

135) 산업재해보상보험 의학 자문 운영 지침 5면 참고

136) 그러나 이 7일의 심의의뢰 기간에는 시행규칙 제21조 제2항 제2호부터 제6호까지에 해당하는 기간(현장조사, 산재보험 의료기관 조사, 특별진찰, 보험가입자 의견청취, 역학조사기간 등)은 포함하지 아니한다. 그만큼 실제 판정까지의 기간은 길어지는 것이다.

가진 자문의사의 소견서 등 관련 서류를 첨부하여야 한다. 다만, 「산업재해보상보험 의학 자문 운영지침」에서 자문 생략 대상으로 정하고 있는 질병은 의학 자문을 생략할 수 있다(동 운영규정 동조 제2항).

이에 따라 판정위원회는 심의를 의뢰받은 날부터 20일 이내에 업무상 질병으로 인정되는지를 심의하여 그 결과를 심의를 의뢰한 소속 기관의 장에게 알려야 하는데 다만 부득이한 사유로 그 기간 내에 심의를 마칠 수 없으면 10일을 넘지 않는 범위에서 한 차례만 그 기간을 연장할 수 있도록 하고 있다.

업무상질병판정위원회의 심의회의는 뇌혈관계질병, 근골격계질병, 내과계질병 및 정신질병으로 구분(다만, 서울남부업무상질병판정위원회는 제4조제1항 단서에 따라 심의의뢰된 질병별로 구분)하여 개최하는 것을 원칙으로 한다(운영규정 제9조 제2항). 판정위원회의 위원장은 심의회의에 참석할 위원을 지정할 때에는 「의료법」 제77조에 따른 전문의와 직업환경의학과 전문의를 각각 2명 이상 지정해야 한다. 다만, 규칙 제6조제2항제5호에 따른 인간공학 또는 산업위생관리 분야 전문가를 심의회의에 참석할 위원으로 지정하는 경우에는 직업환경의학과 전문의 1명을 줄여 지정할 수 있다(운영규정 제11조 제2항).

한편, 업무상질병판정위원회에서 업무상 질병의 인정 여부에 대한 심의사건의 판정에 필요한 검토 및 조사 등을 담당하는 사건담당자는 심의사건의 신청인 또는 청구인 등 당사자의 주장 내용과 소속기관의 재해조사 내용 등을 검토하는 한편 심의사건이 영 제34조 제3항 별표3의 제2호에 따른 근골격계에 발생한 질병으로서 동시에 10명 이상이 요양을 신청한 경우 또는 업무 관련성 여부에 대한 전문적인 조사가 필요하다고 인정되는 경우에는 의사·치과의사·한의사나 산업위생관리 분야 등 관계 전문가 중에서 판정위원회 위원장이 지정하는 사람 또는 근골격계 질병에 관하여 전문성이 있는 기관이나 단체에 업무와의 관련성 여부에 대하여 작업평가를 실시하게 할 수 있다(운영규정 제8조).

(7) 산재심사와 업무상질병판정위원회와의 관계

산재보험법 시행령 제102조 제1항 제1호는 “업무상질병판정위원회의 심의를 거쳐 업무상 질병의 인정 여부가 결정된 경우”를 심사위원회의 심의 제외 대상으로 보면서, 제2항은 “제1항에도 불구하고 심사 청구 중 공단이 심사위원회의 심의를 거쳐 결정할 필요가 있다고 인정하는 경우”에는 심사위원회의 심의를 거쳐 결정할 수 있다고 규정하고 있다. “산재보험 심사업무처리규정” 제17조는 ① 업무상질병판정위원회와 관계 전문가 간 의학적 소견이 상이한 경우, ② 심사결정에 영향을 미칠 수

있는 새로운 사실관계가 확인되는 경우, ③ 직업성질병자가 동시에 10명 이상 발생한 경우, ④ 언론보도 등 사회적 관심사항에 해당되는 경우에는 업무상질병판정위원회를 경유한 경우라도 심의회의에 상정할 수 있다고 규정하고 있다. 해당 조문의 구조를 살펴보면, 업무상질병판정위원회를 거치는 경우, 산재심사를 제기하더라도 심사위원회 심의회의 생략을 원칙으로 하는 것으로 파악된다. 그렇다면, 업무상질병판정위원회를 경유한 사건에 대해서는 심사청구를 생략하고 바로 재심사 청구를 제기하도록 하는 것이 효율성·신속성 측면에서 바람직하다고 판단된다.

산재보험법 제105조(심사 청구에 대한 심리·결정) ② 제1항 본문에도 불구하고 심사 청구 기간이 지난 후에 제기된 심사 청구 등 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는 경우에는 심사위원회의 심의를 거치지 아니할 수 있다.

산재보험법 시행령 제102조(심사위원회의 심의 제외 대상) ① 법 제105조제2항에서 “대통령령으로 정하는 사유”란 해당 심사 청구가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. <개정 2010. 7. 12., 2010. 11. 15.>

1. 법 제38조에 따른 업무상질병판정위원회의 심의를 거쳐 업무상 질병의 인정 여부가 결정된 경우

2. 진폐인 경우

3. 이황화탄소 중독인 경우

4. 제97조제1항에 따른 각하 결정 사유에 해당하는 경우

5. 삭제 <2020. 1. 7.>

6. 그 밖에 심사 청구의 대상이 되는 보험급여 결정등이 적법한지를 명백히 알 수 있는 경우

② 제1항에도 불구하고 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 심사 청구 중 공단이 심사위원회의 심의를 거쳐 결정할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 심사위원회의 심의를 거쳐 결정할 수 있다.

산업재해보상보험 심사업무처리규정

제16조(심사위원회 심의제외 대상) ① 영 제102조제1항제6호에 따른 “보험급여 결정등이 적법한지를 명백히 알 수 있는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 영 제43조제3항제1호 또는 영 제44조에서 정한 절차(자문의사회의)를 위반하여 이루어진 원처분에 대한 심사청구

2. 원처분기관장이 원처분이 잘못된 것임을 인정하는 심사청구

3. 법, 영 또는 「산업재해보상보험 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다)을 잘못 적용한 원

처분으로서 청구인의 주장을 전부 인용하여야 할 것으로 인정되는 심사청구

4. 심사청구의 대상이 되는 원처분의 근거가 된 법령의 개정 등 사정 변경으로 심사청구에 대한 인용 여부가 명백하게 된 경우

5. 심사청구·재심사청구·행정소송 등에서 결정·재결·판결을 받은 후 사실관계 및 법률관계의 변동이 없음에도 동일한 사안에 대하여 다시 원처분을 받고 심사청구를 제기한 경우

6. 그 밖에 법·영·규칙에서 정한 절차를 위반하여 이루어진 원처분에 대하여 제기된 심사청구

② 이사장은 제1항제1호부터 제3호까지 및 제6호에 해당하는 심사청구에 대하여는 심사장에게 다른 심사청구에 우선하여 신속하게 심리하게 할 수 있다.

제17조(업무상질병판정위원회 경유 사건) 영 제102조제1항제1호에 해당하는 사건 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 심의회의에 상정할 수 있다. <개정 2020. 9. 4.>

1. 업무상질병판정위원회와 제44조에 따른 관계 전문가 간 의학적 소견이 상이한 경우
<개정 2020. 9. 4.>

2. 심사결정에 영향을 미칠 수 있는 새로운 사실관계가 확인되는 경우

3. 직업성질병자가 동시에 10명 이상 발생한 경우

4. 언론보도 등 사회적 관심사항에 해당되는 경우

II. 업무상 질병 판정위원회의 운영 현황

1. 업무상질병 판정위원회의 심의회의 개최 현황

[표 2-15] 업무상질병 판정위원회의 심의회의 개최 현황

(단위: 회, 건, %, %p)

구분		전체		서울		부산		대구		경인		광주		대전	
		회의 횟수	심의 건수	회의 횟수	심의 건수	회의 횟수	심의 건수	회의 횟수	심의 건수	회의 횟수	심의 건수	회의 횟수	심의 건수	회의 횟수	심의 건수
회의 횟수/ 건수	2020년	1,525	15,903	387	3,742	332	3,708	115	1,236	293	3,132	241	2,376	157	1,709
	2021년	1,611	17,374	395	3,678	369	4,338	135	1,469	320	3,560	213	2,271	179	2,058
	증감	86	1,471	8	△64	37	630	20	233	27	428	△28	△105	22	349
주당 심의 횟수	2020년	4.9		7.4		6.4		2.2		5.6		4.6		3.0	
	2021년	5.2		7.6		7.1		2.6		6.2		4.1		3.4	
	증감	0.3		0.2		0.7		0.4		0.5		△0.5		0.4	
회당 심의 건수	2020년	10.4		9.7		11.2		10.7		10.7		9.9		10.9	
	2021년	10.8		9.3		11.8		10.9		11.1		10.7		11.5	
	증감	0.4		△0.4		0.6		0.1		0.4		0.8		0.6	

2021년을 기준으로 보면 업무상질병 판정위원회의 심의회의의 전체 회의횟수는 1,611회를 개최하여 전년(2020년) 동기 1,525 대비 86회(5.6%)가 증가하였다(광주를 제외한 모든 판정위원회에서 회의횟수 증가). 이에 따라 심의건수도 전체 17,374건으로서 전년(2020년) 동기 15,903건 대비 1,471건(9.2%)가 증가하였다. 연도별 회당 평균 심의건수는 13.7건('16년) → 13.3건('17년) → 10.5('18년) → 10.2('19년) → 10.4건('20년) → 10.8건('21년)으로 안정적인 추세를 보이고 있다.

2. 업무상 질병 판정위원회의 심의결정 소요기간¹³⁷⁾

앞에서 보았듯이 판정위원회 심의 결정 소요 기간은 지역별 차이는 존재하지만 지속적으로 단축되어 대체로 20일 전후의 기간이 소요되고 있다. 이는 심의회의의

137) 업무상질병판정위원회에 심의접수일부터 판정서 결재완료일까지 기간을 말한다.

전체 회의횟수의 증가에 따라 나타난 결과로 보인다. 심의결정 소요기간은 2022년 기준 20.6일(통합심의건 제외 시 20.4일)로 2019년 동기 39.9일 대비 19.3일 감소했다. 2022년 기준으로 경남(33.1)과 부산(26.6), 그리고 서울북부(21.8)가 평균 소요기간 대비해서 높은 지역이다.

[표 2-16] 판정위원회 심의결정 소요기간 현황

(단위: 일)

구분	계		서울남부			서울북부	부산	경남	대구	경인	광주	대전
	전체	통합 제외	전체	통합 심의	통합 제외							
'19년	39.9	37.3	63.7	66.1	58.9	-	41.1	-	21.9	37.1	26.0	25.5
'20년	35.3	33.3	50.9	66.5	45.7	-	42.7	-	26.6	27.3	26.1	20.8
'21년	28.4	28.3	28.3	31.4	27.5	0.0	49.7	0.0	18.1	19.9	14.1	21.5
'22년	20.6	20.4	26.9	25.8	27.3	21.8	26.6	33.1	15.4	16.9	11.6	17.0
'23. 4월	20.7	20.6	23.8	23.2	24.3	20.8	27.0	17.8	14.9	22.3	11.7	23.5

그러나 판정위원회에 심의접수일을 기준으로 하는 심의결정 소요기간이 아니라 요양급여신청이 접수된 때로부터 판정이 날 때까지의 기간을 기준으로 할 때에는 산재근로자 입장에서는 여전히 길다. 근골격계질환 산재 평균 처리기간은 2019년 기준 136.5일, 2020년 10월 기준 120.5일이다. 뇌심혈관계질환의 경우 2019년 기준 156일로 추산됐고 직업성 암의 경우 2018년 기준으로 341일이다. 2020년 업무상 질병판정 처리기간은 평균 172.4일이었다.

산재보험법 시행규칙 제21조(요양급여의 결정 등) 제1항에 따르면 “공단은 법 제 41조에 따른 요양급여의 신청을 받으면 그 신청을 받은 날부터 7일 이내에 요양급여를 지급할지를 결정하여 신청인 및 보험가입자에게 알려야 한다”고 규정하고 있다. 그러나 이 처리 기간 7일에는 ① 판정위원회의 심의에 걸리는 기간, ② 법 제 117조 및 법 제118조에 따라 사업장 등에 대한 조사와 산재보험 의료기관에 대한 조사에 걸리는 기간, ③ 법 제119조에 따른 특별진찰에 걸리는 기간, ④ 시행규칙 제20조에 따른 요양급여 신청과 관련된 서류의 보완에 걸리는 기간, ⑤ 시행규칙 제20조 제2항에 따른 보험가입자에 대한 통지 및 의견 청취에 걸리는 기간, ⑥ 업무상 재해의 인정 여부를 판단하기 위한 역학조사나 그 밖에 필요한 조사에 걸리는 기간은 산입하지 않는다(동조 제2항). 이 때문에 법으로 정한 기한과 실무상 처리기간에 차이가 크게 발생하고 있다.

III. 소결 : 업무상 질병 사건의 신속한 판정을 위한 방안 검토

현 산재보상보험 요양 승인과정에서 제기되는 가장 큰 절차적 문제점 중 하나는 공단의 결정이 내려지기까지 소요되는 기간이 길다는 것인데 그 주된 원인은 업무상 사고보다는 업무상 질병 판정 처리의 장기화 현상이다. 따라서 산재보험 업무처리절차 개선의 핵심은 업무상 질병 사건에 대한 처리 기간의 단축에 있다고 볼 수 있다. 산재보험법의 규율 목적은 산업재해에 따른 제반 손해를 합리적으로 전보하고 건강과 노동능력을 회복하는 데 필요한 제반 사항을 제도화하는 데 있지만, 그 운영에 있어서 중요한 것은 신속보장 원칙과 조화를 꾀하는 것도 간과해서는 안 될 목표이기 때문이다. 업무상 질병 신청사건의 신속한 판정을 위해 절차적 개선방안을 모색함에 있어서 현행 법령상의 제도를 재검토할 부분을 요약하면 다음과 같다.

우선 시행규칙 제21조 제2항에 **요양급여 지급 여부 결정과 관련한 처리 기간에 산입하지 않는 것으로 열거된 사유** 중 산재보험법 제117조 및 제118조에 따라 사업장 등에 대한 조사와 산재보험 의료기관에 대한 조사에 걸리는 기간(제2호), 산재보험법 제119조에 따른 특별진찰에 걸리는 기간(제3호), 산재보험법 시행규칙 제20조제2항에 따른 보험가입자에 대한 통지 및 의견 청취에 걸리는 기간(제5호)에 대해서는 **개선 필요성이 있는지 검토할 필요**가 있다. 무엇보다 이것이 법규정과 현실의 괴리가 무척이나 크게 벌어지는 원인이 되고 있고 신청인 측의 불만의 원인이 되기 쉽기 때문이다.

둘째, **특별진찰 대상 질병을 근골격계질병, 소음성 난청 등 이외에도 좀 더 확대하는 것이 방안이 될 수 있는지 검토**가 필요하다. 판정위원회의 심의에서 제외되는 질병 목록과 관련하여 시행규칙 제7조는 유해·위험요인에 대한 역학조사 결과 또는 한국산업안전보건공단 등 시행규칙 제22조에 따른 기관에 자문한 결과 업무 관련성이 높다고 인정된 질병이나 시행령 제117조 제1항 제3호에 따른 특별진찰 결과 업무 관련성이 매우 높다는 소견이 있는 경우(특히 근골격계질병)에는 질병판정위원회 심의 없이 바로 업무상 재해를 인정할 수 있도록 하고 있다. 나아가 산업재해보상보험 의학 자문 운영지침에 따르면 특진의료기관에서 업무관련성 평가 소견서가 발급 및 회신되는 경우에는, 임상의학 전문의의 상병 확인 및 직업환경의학과 전문의의 업무관련성 평가 자문이 생략된다. 재해인정의 신속성을 기하기 위한 것이다. 이러한 방안들을 좀 더 유기적으로 포섭하여 체계화시킬 필요가 있을 것이다.

한편, 특별진찰의 결과 제시된, 대상 질병의 상병명은 공단 자문의사의 확인을 거쳐 업무상질병판정위 심의는 물론 향후 산업재해보상보험 재심사위원회에서도 원칙적으로 최대한 존중되도록 하는 방안을 강구할 필요가 있다.

셋째, **패스트트랙의 대상확대와 효과적인 운영방안을 검토**해 볼 필요가 있다. 위에서 언급한 안전보건공단 자문이나 특별진찰 절차는 그 자체로 상당한 시간이 소요되는 측면이 있기 때문에 설령 판정위원회의 심의에서 제외된다고 하더라도 그것이 바로 결정 소요기간 단축에 기여한다고 말하기는 어렵다. 따라서 패스트트랙을 활용할 수 있는 질병 목록의 확대가 필요하다. 예컨대 시행규칙 제7조 제6호에서 "업무와 그 질병 사이에 상당인과관계가 있는지를 명백히 알 수 있는 경우로서 공단이 정하는 질병"에 대해서는 업무상질병판정위원회 운영규정 제5조가 판정위원회의 심의에서 제외되는 질병으로 하고 있는데, 현행 산재보험법 시행령 제34조 제3항 별표 3에서는 일부(제6호 바목·사목, 제9호 가목·다목, 제12호 바목·사목)만이 인정되고 있어서 이를 그 외 업무관련성 인정이 상대적으로 수월한 질병 목록으로 좀 더 확대할 수 있는지 검토할 필요가 있다. 이와 함께 패스트트랙은 특별한 사정(예컨대 상병명에 대한 전문의의 의견불일치 경우)이 없는 한, 원칙적으로 질판위 심의 없이 신속한 결정을 내리는 것이 좀 더 효과적인 운영방안이 되는지 검토해 볼 필요가 있다.

넷째, 업무상질병판정위원회, 산업재해보상보험심사위원회나 재심사위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위해 둘 수 있도록 한 **소위원회와 전문위원회 제도**가 실제로 업무상 질병 판정의 소요기간 단축에의 기여 정도를 평가(2021년도 전문위원회 개최 건수 없음)하여, **제도개선 방안을 모색할** 필요가 있다.

요컨대 업무상 재해 처리 기간의 지연의 큰 원인인 업무상 질병 여부를 둘러싼 판정기간을 단축하는 것이 절차개선에서 중요한 과제가 될 것이기 때문에 업무상 질병을 중심으로 절차적 개선방안을 검토하고자 한다. 구체적인 개선방안을 검토 수립함에 있어서 비교법적 시사점을 찾기 위해서 이하에서는 외국(독일과 영국, 일본)의 입법례를 검토한다. 물론 제3장에서 다루는 이들 나라들은 우리나라와는 법제도적 시스템 및 이와 관계된 산재보험 배경 및 문화가 상이하기 때문에 직접적인 차용을 하기에는 한계가 분명하다는 점은 미리 고려해야 한다. 그럼에도 불구하고 개선방안을 강구함에 있어서는 주요한 시사점을 얻을 수 있을 것이다.

제3장 외국의 입법례

제1절 독일

I. 독일 산업재해보험제도 일반

1. 역사적 발전 과정과 특징

(1) 역사적 발전 과정

1) 제국시대와 산업혁명(Kaiserreich und industrielle Revolution)

독일 법정사고보험(gesetzliche Unfallversicherung), 즉 산업재해보험제도(=산재보험¹³⁸⁾)의 역사는 19세기 후반부터 시작되었다.¹³⁹⁾ 당시 산업화는 한때 농업으로 특징지어졌던 독일을 빠르게 변화시켰다. 공장들은 말 그대로 바닥에서 뿔어져 나오고 있었고, 그로 인해 독일의 경제구조에 근본적인 변화가 일어났다. 이러한 상황은 급격한 인구 증가로 인해 새로운 일자리가 필요했던 당시의 상황과도 적절히 맞아 떨어졌다.

그러나 갑작스러운 경제구조의 변화는 동시에 기존의 사회질서를 부정적으로 바꾸게 되었다. 점점 더 많은 사람들이 농업과 공예에서 벗어나 공장에서 일하는 노동자로 생계를 꾸리고 되었으나, 그들에게 노동자로서의 권리는 거의 없었다. 임금은 낮고, 근로 시간은 길며, 근로 조건은 때때로 비참한 수준이었다.¹⁴⁰⁾ 무엇보다 안전에 극히 취약한 작업 조건으로 인해 공장 내 작업장 사고 건수는 기하급수적으로 증가했다. 1854년에 처음 설치·운영되었던 소수의 “공장 검사관(Fabrikinspektoren)”에 의해서 통제될 수 있는 수준이 아니었다.

138) 다른 특별한 언급이 없는 한 ‘산업재해보험제도’ 또는 ‘산재보험’은 독일의 그것을 가리킨다.

139) 이하에서 소개되는 독일 법정사고보험(=산업재해보험제도)의 역사적 발전 과정에 관하여 독일 법정재해보험기구(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.  찾아가기 <https://www.dguv.de/de/index.jsp>, 2023. 9. 14. 최종확인) 참조.

140) 독일의 교육학자 아돌프 디스터웨그(Adolph Diesterweg)는 당시 섬유공장의 아동노동에 관한 보고서에 다음과 같이 설명한다: “... 잠시 후, 그것은 기계적으로 회전하고, 두드리고, 두드리고, 망치질하며, 분에서 분으로, 정오의 종이 한 시간 동안 노동자들을 풀어줄 때까지 계속된다. 아이는 집으로 달려가서, 점심 식사로 작은 빵을 먹고, 오후 1시에 감옥으로 다시 돌아가 저녁 7시나 8시까지 분, 시간 단위로 일을 계속한다.”(Hg: DASA, Dortmund, 2003, S. 11).

당시 근로자에게 사고가 발생하는 경우, 재해근로자는 어떠한 보험도 갖고 있지 않았고, 종종 해고되어 실직 상태에 있게 되었다. 이런 상황에 대처하고자 독일은 1871년 '사업주책임법(Haftpflichtgesetz für Unternehmer)'을 제정하였으나, 이 법도 상황을 거의 바꾸지 못했다. 왜냐하면 사고를 당한 근로자가 사업주의 과책을 증명해야 했기 때문이다.

이렇듯 노동자의 열악한 작업환경은 지속적으로 더욱 더 악화되었고, 그로 인해 노동자의 삶 또한 비참한 수준에 이르게 되었다. 당시 독일은 사업주와 피용자 사이의 이익관계는 오롯이 사적 영역에 속하는 것으로 이해하였으나, 현실에서는 노동자의 작업장 내의 안전 문제가 지배적인 사회적 문제가 되었다. 이로써 수많은 사회단체들이 노동자의 현실을 방관하지 않게 되었고, 노동자를 위한 "노동자보험(Arbeiterversicherung)"으로 노동자를 보호할 것을 요구하게 되었다.¹⁴¹⁾

오토 폰 비스마르크 수상(Reichskanzler Otto von Bismarck, 1815-1898)은 노동자가 빈곤한 근본 원인이 그들의 오랜 질병에 있다고 판단했다. 노동자는 성실히 삶을 살아가지만, 질병으로 인해 빈곤해지고, 그럼에도 스스로 질병을 이겨낼 수 있는 여력이 없다는 점을 인정하였다.¹⁴²⁾ 따라서 노동자에게 사고가 발생하면 그들의 경제적 상황과 무관하게 그 피해노동자가 법정사고보험에 의해서 보호되어야 함을 강조했다. 무엇보다 그 비용은 사업주와 국가가 전적으로 부담해야 함을 강조했다. 당시 많은 기업들이 비용 상승을 우려했지만, 철강 산업과 같은 일부 기업가들은 성장하는 산업이 건강하고 만족스러운 노동자로부터 기인한다는 점을 분명히 했다. 비스마르크는 법정사고보험에 의한 노동자 보호를 통해 노동자와 국가가 대립 관계가 아닌 화해와 협력의 관계로 나아가길 희망했다.

2) 산재보험의 구조와 내용(Strukturen und Aufgaben)

제국의회는 1883년부터 1889년까지 6년 동안 오늘날 현대 사회보험의 토대가 된 3가지 보험에 관한 법을 제정했다. 그것은 건강보험, 사고보험과 연금보험이다. 이 가운데 사고보험법(Unfallversicherungsgesetz)은 1884년 7월 6일에 제정되었으며,

141) https://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/125_jahre/index.jsp (2023. 9. 14. 최종확인).

142) Heinrich Braun, Industrialisierung und Sozialpolitik in Deutschland, Köln/Berlin, 1956, S.76.

그 4가지 특징은 다음과 같다:

첫째, 보험재정은 전적으로 사업주의 책임으로 하고, 반면 사업주는 민사 책임에서 면책된다. '기업의 등급과 그 기업의 위험도에 따른 보험료 납부'의 원칙은 「직종별 산재보험조합(Berufsgenossenschaft, 'BG'. 이하 '산재보험조합')」의 설립을 통해 도입되었다. 제국보험청은 1885년 6월 5일에 55개의 산재보험조합을 공표하였다. 같은 해에 사고보험을 위한 국가 차원의 집행기구를 설치하였다.

둘째, 산재보험조합은 가입 기업들의 자치행정(Selbstverwaltung)에 의해 운영되었고, 노동자의 참여를 긍정하는 목소리는 많지 않았다. 자치행정 내에서 노동자와 사업주가 함께 참여하는 평등은 1951년이 되어서야 비로소 실현되었다.

셋째, 한편 사고보험 도입 이후 사고보험은 우선 '위험한' 사업장에 종사하는 노동자에 대해서만 적용되었고, 이러한 상황은 이후에도 계속되었으며, 모든 노동자에 대한 보험적용은 1942년에 처음 이루어졌다.

넷째, 무엇보다 재해근로자의 재활 및 보상과 함께, 사고예방 또한 법정사고보험의 주요한 대상이다. 산재보험조합은 설립 1년 후인 1886년에 사고예방규칙을 처음으로 제정·공포하였다. 그리고 1900년까지 산재보험조합은 단지 사업장 내에서만 사고예방이 이루어질 수 있도록 할 '권리'를 가지고 있었고, 이후 그 권리는 산재보험조합의 '의무'가 되었다. 그 결과로, 예를 들어 기술감독관(Technischer Aufsichtsbeamte)이 1910년에 이미 339명에 이르렀다.¹⁴³⁾

3) 바이마르공화국(Weimarer Republik)

1925년은 사고보험법의 점진적인 확대에 있어 중요한 해이다. 격렬한 정치적 논쟁 후에 사고보험이 처음으로 직업병(Berufskrankheiten)까지 확대되었다. 직업병에 속하는 질병에는 납(Blei), 인(Phosphor), 수은(Quecksilber), 비소(Arsen), 벤젠(Benzol), 황탄(Schwefelkohlenstoffe), 파라핀(Paraffin), 타르(Teer), 탄트라(Anthrazen), 피치(Pech)로 인한 질병뿐만 아니라, 광부의 기생충병(Wurmkrankheiten), 방사선(Röntgenstrahlen)으로 인한 질병, 폐질환(Lungenkrankheit) 등이 포함되었다.¹⁴⁴⁾

143) https://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/125_jahre/struktur/index.jsp (2023.

9. 14. 최종확인).

144) 이후 100년 가까이 지난 오늘날 직업병의 목록은 지속적으로 확장되어 왔으며, 2023. 9. 14. 현재

1925년에는 노상재해(Wegeunfälle)가 보험보호의 대상이 되었고, 나아가 법적 예방이 상당한 수준으로 확대되었으며, 그에 따라 예방의무 또한 확대되었다. 당시 제국보험법(Reichsversicherungsordnung, 'RVO') 제848조는 산재보험조합으로 하여금 "기술, 의료 및 경제 효율에 따라 가능한 한 사고를 예방하고 부상자에게 효과적인 응급처치를 제공해야 한다."고 규정하였고, 그 이유에 "위험한 손해를 방지하는 것이 발생한 손해보다 유리하고 이익이 된다."는 점을 분명히 했다.

사고예방을 위해 산재보험조합과 보험당국(Unfallkasse)은 노동자와 사업주의 사고 예방에 대한 인식을 고취시키기 위해 사진이나 영화와 같은 현대매체를 사용하였다. 제1차 세계대전의 결과와 세계경제위기에도 불구하고, 사고예방은 바이마르공화국에서 어느 정도 진전을 이루었다. 다만 사고보험은 경기침체로 인해 재정적인 어려움을 겪게 되었다. 많은 기업들이 더 이상 보험료를 지불할 수 없게 되었고, 때때로 미납보험료는 연간 총액의 60%에 달했다. 이에 독일 정부는 1932년에 긴급조치를 통해 연금과 임금을 삭감했지만, 그럼에도 상대적으로 안정되어 있던 산재보험조합은 「자치운영의 원칙(Selbstverwaltungsprinzip)」에 따라서 요보호 노동자의 보호를 계속해서 이어나갔다.¹⁴⁵⁾

4) 제3제국 시대와 제2차 세계대전 이후(Drittes Reich und Nachkriegszeit)

① 제3제국 시대

제3제국(Drittes Reich)¹⁴⁶⁾의 기간 동안에도 사고보험의 조직 형태와 내용의 본질에는 영향을 받지 않았다. 다만 산재보험조합이 주도하는 자치운영이 폐지되고 "지도자원칙(Führerprinzip)"이 시행되었다. 다시 말해 각각의 직종별 산재보험조합이 자치적으로 운영했던 사고보험의 주도권이 국가 주도로 이전된 것이다.

국가사회주의(Nationalsozialismus)는 기본적으로 산업재해와 직업병 예방에 대한 지대한 관심을 가지고 있었다. 국가사회주의의 목표는 국가 경제 및 군사 계획의 전제조건으로서 "국민 건강"을 강화하는 것이었다. 다만 국가사회주의가 사고보험의 행정 영역에 끼친 명백한 영향력은 산재보험조합에서 유대인 기업들을 추방하는 것

직업병 목록에 등재된 질병은 82개이다. 이에 관하여 보다 자세한 것은 목차 II. 1. 참조..
145) https://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/125_jahre/weimar/index.jsp (2023. 9. 14. 최종확인).

146) 독일 역사에서 제3제국(Drittes Reich)은 이른바 국가사회주의시대(Die Zeit des Nationalsozialismus, 1933년~1945년)를 가리킨다.

이었다. 그럼에도 불구하고 법정사고보험법의 가장 중요한 발전 중 하나는 1942년에 예외 없이 모든 노동자에게 보험 혜택이 확대된 것이었다.

② 제2차 세계대전 이후

제2차 세계대전 이후, 독일이 동독과 서독으로 나누어진 것처럼, 사고보험도 동독과 서독에서 다르게 시행되었다. 동독에는 단일의 통합사회보험만이 시행되었고, 노동자 보호는 국가 주도로 이루어졌다. 반면 서독은 나치 시대 사고보험의 구조적 변화를 모색하였고, 1951년에 '평등한 자치운영(paritätische Selbstverwaltung)'이 도입되었다. 1960년대에는 "모든 적절한 수단"을 통하여 사고를 우선적으로 예방(Verhütung)해야 한다는 점을 강조함으로써 사고보험의 원칙을 재확인했다.

더불어 1971년에 학교사고보험(Schülerunfallversicherung)이 수립되면서 모든 학생과 유치원생은 노상사고에 대하여 보험보호를 받게 되었다. 또한 인명구조원이나 자원봉사자도 일정한 상황 하에서 사고보험에 의하여 보호를 받을 수 있게 되었다.¹⁴⁷⁾

5) 독일의 통일과 사고보험의 발전(Einheit und neueste Entwicklungen)

독일의 통일 이후 법정사고보험은 오늘날의 모습으로 변화하기 시작했다. 보험의 구조와 내용이 새롭게 변모하거나 수립되었고, 산재보험병원들이 설립되었다. 특히 1996년의 사회법전 제7권(SGB VII)과 산업안전보건법(Arbeitsschutzgesetz)을 통해 사고보험의 '예방적 사고'는 업무상사고(Arbeitsunfälle)와 직업병뿐만 아니라, 척추 관련 질병이나 정신질환과 같은 근로조건 따른 건강상 위험발생의 방지로까지 광범위하게 확대되었다.

2008년에는 사고보험현대화법(Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz, 'UVMG')이 시행되었고, 동법에 의해서 사고보험이 산업구조의 변화에 잘 대처해나간 것으로 평가된다. 산재보험조합과 국가는 산업안전보건전략의 범주에서 협업을 통해 사고보험을 계속해서 발전시켜 나갔고, 「독일 법정재해보험기구(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V., 'DGUV')」는 그 결과물이라 할 수 있다.¹⁴⁸⁾

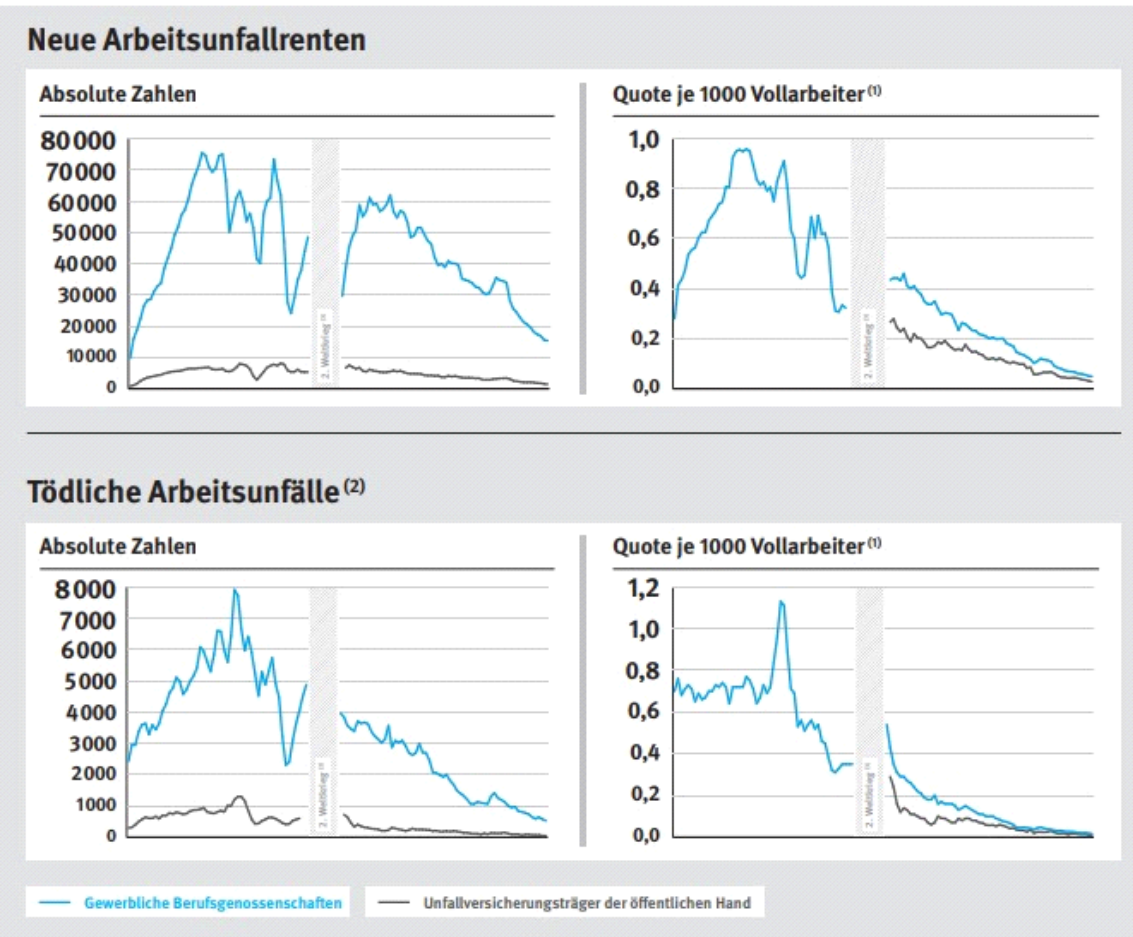
¹⁴⁷⁾

https://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/125_jahre/nachkriegszeit/index.jsp(2023. 9. 14. 최종확인).

¹⁴⁸⁾ https://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/125_jahre/einheit/index.jsp(2023. 9. 14. 최종확인).

요컨대 독일 법정사고보험제도의 운영 원칙과 목적은 재해의 보상과 재활, 그리고 무엇보다 사고예방에 있다.

[그림 3-1] 독일 산재 관련 근로자 수 변화 추이(1886년 이후)¹⁴⁹⁾



149) ① [그림 3-1]은 1886년 이후 산재(Arbeitsunfall)로 인한 연금수급자 수 및 사망사고 수의 변화 추이를 보여주고 있다. ② 첫 번째 추이곡선(Neue Arbeitsunfallrenten)은 1886년 이후 산재 연금수급자 수의 변화 추이를 보여주는데, 전자(Absolute Zahlen)는 절대 수치의 변화를, 후자(Quote je 1000 Vollarbeiter)는 전일제근로자 1,000명당 산재 연금수급자 수의 변화를 나타낸다. ③ 두 번째 추이곡선(Tödliche Arbeitsunfälle)은 1886년 이후 사망자를 야기한 사고 수의 변화 추이를 보여주는데, 전자(Absolute Zahlen)는 사망사고 수의 절대 수치의 변화를, 후자(Quote je 1000 Vollarbeiter)는 전일제근로자 1,000명당 사망사고 수의 변화를 나타낸다. ④ 파란색 추이 곡선은 '민간부문'의 변화양상을, 검은색 추이 곡선은 '공공부문'의 변화양상을 보여준다.

[그림 3-2] 독일 산재 관련 근로자 수 감소 추이(1956년 이후)¹⁵⁰⁾



(2) 특징

독일 산재보험의 특징은¹⁵¹⁾은, 첫째, 산재보험제도의 도입 초기 그 적용대상은 저소득의 육체 근로자와 사무직 근로자로 한정되었다는 점과, 산재보험제도의 적용, 급여 제공 및 보험료의 징수 등 실질적인 운영(Verwaltung)이 '산업별 연대 원칙(Industrieverbandsprinzip)'에 따라 업종별로 구분된 '직종별 산재보험조합'에서 수행하도록 했다는 점이다.

위와 같은 조합주도의 자치 운영방식은 공제조합제도를 바탕으로 한 '직종별 사회공동체 의식'의 오랜 전통을 반영한 것으로 이해된다. 직종별 산재보험조합은 '자치 운영의 원리(Selbstverwaltungsprinzip)'에 따라서 각각의 개별 조합에 소속된 노동자와 사용자

150) ① [그림 3-2]는 1956년 이후 독일의 산재로 인한 연금수급자 수 및 사망사고 수의 '감소' 변화를 보여주고 있다. ② 파란색은 '민간부문'의 감소 변화를, 검은색은 '공공부문'의 감소 변화를 나타낸다. ③ 두 그림에서 동일하게 상단(Neue Arbeitsunfallrenten)은 1956년과 2008년 사이에 절대 감소 수치를, 하단(Tödliche Arbeitsunfälle)은 같은 기간 산재 사고 '사망자' 수의 감소 수치를 나타낸다.

151) 독일 재해보험의 특징에 관하여

<https://mm.inje.ac.kr/app/board/attach/viewer.do?boardNo=178&articleNo=9987&attachNo=7861>, 2면 이하. (2023. 9. 14. 최종확인).

의 대표들에 의해 운영하는 방식을 채택하였다.¹⁵²⁾

둘째, 독일 산재보험은 '적용대상', '보호되는 위험'과 '급여수준'이 점진적으로 확대되었다는 특징을 가진다.

1) 적용대상의 확대

법정사고보험의 도입 초기에는 저임금 육체노동자를 중심으로 제도가 운영되었으나, 점차 고소득 및 사무직 근로자에게까지 그 적용범위가 확대되었다. 그리고 1942년부터는 마침내 전체 임금근로자가 사고보험의 적용대상자가 되었다. 1971년부터는 학교 사고보험(Schülerunfallversicherung)이 창설되어 비경제활동인구에게도 사고보험이 적용됨으로써 법정사고보험제도의 사회정책적 기능이 강화되었다. 나아가 동독과 서독이 통일되면서, 종전 서독에서 시행되었던 산재보험법이 1991년 1월 1일부터 독일 전역으로 전면 확대·적용되었다. 또한 과거 분단시대에 동독에서 발생한 산재 근로자에 대한 현금급여가 서독의 방식으로 재산정되어 지급됨으로써, 급여의 현실화도 이루어졌다.

2) 보호되는 위험의 확대

독일의 재해보험은 종전 작업장 내의 산업재해에 한정된 보상 위주의 제도운영에서 1925년 이후 직업병과 통근재해로까지 제도의 보호 범위를 확대하게 되었다. 이후 직업병 종류의 확대는 물론 통근재해의 인정규정 또한 지속적으로 완화되어 출퇴근 시 우회경로 상의 재해에 대해서도 제도의 보호가 이루어질 수 있게 되었다. 이 이외에도 독일의 재해보험은 각종 자원봉사, 인명구조, 의용소방대 등과 같은 공익적 행위의 과정에서 발생한 사고에 대해서도 산업재해로 인정하여 동등한 제도적 보호가 이루어졌다.

3) 급여 수준의 확대

독일의 재해보험은 초기의 단순한 재해보상적 기능에서 재해예방 및 피해자의 재활적 기능 등 사업의 다각화를 도모하였다. 그 결과 재해보험은 보험재정의 안정화는 물론 국민경제적 차원에서 노동력의 건전한 보호·육성에 기여할 수 있게 되었다.

152) 이러한 평등주의가 도입된 시기가 1951년임은 앞서 언급한 바와 같다.

아울러 급여수준 또한 지속적으로 인상되었고, 종전 산업재해로 인해 신체상의 손실에 대한 이른바 '최저보상원리'에서 '생활수준보상원리'로 전환되었다. 독일 산재보험제도의 역사적 발전 과정과 그 특징을 시간적 순서에 따라서 정리하면 다음과 같다.

[표 3-1] 독일 산재보험제도의 역사적 발전 과정의 특징

확대 대상	연도	내용
적용대상의 확대	1884	- 산재보험법 도입 - 연간소득이 2,000Mark 미만의 광산업 갱내 근로자, 철거업 종사 근로자, 공장 및 조선업 근로자, 위험시설 건설근로자, 굴뚝 소제 근로자 등에 한정하여 당연적용
	1885	- 철도업, 선박업, 운수업, 철도업, 우체국 기타 국영기업 종사 근로자의 제도적용을 위하여 국가책임의 특별재해보상제도 설립
	1886	- 농업 및 임업 부문의 피고용자의 당연가입 - 공무원과 군인에 대한 재해보상제도 도입
	1887	- 해운업과 건설업 종사 근로자에게 재해보험 확대적용
	1900	- 재해보험 당연가입 요건으로서 연간소득의 상한선을 3,000Mark로 상향조정 - 재해보험 사업내용과 관련하여 개별 조합간 상이한 규정을 대대적으로 통일 - 재소자에 대한 재해보험 적용
	1911	- 제국보험법의 제정 - 연간소득의 상한선을 5,000Mark로 인상
	1928	- 세일즈맨 및 관리직 종사 피고용자의 재해보험 당연적용 - 인명구조, 범죄의 방지 등 공공의 이익을 위해 종사하다 피해를 입은 의사상자에 대한 재해보험 적용
	1937	- 견습생 및 직업교육 수강자의 재해보험 확대적용
	1939	- 전체 농업경영자와 가족종사자에 대한 재해보험 당연적용
	1942	- 재해보험의 적용대상을 전체 임금근로자 확대 - 재해보험의 관리방식을 종전 사업장 단위의 관리방식에서 인(人)별 관리방식으로 전환
	1971	- 유치원 원아, 학생, 대학생의 재해보험 확대적용
	1991	- 공적연금 및 재해보험 전환법에 의거하여 서독의 재해보험법을 동독지역으로 확대적용 - 과거 동독 시절 발생한 산업재해에 대한 현금급여를 서독 수준으로 인상(다만 급여산정의 기준이 되는 연간평균소득은 지역별 별도 적용)
보호되는 위험의 확대	1911	- 제한적인 범위 내에서 특수 직업병을 산업재해로 인정
	1925	- 11가지의 직업병에 대하여 산업재해로 인정 - 통근재해제도의 도입 - 직업재활사업의 실시

		- 중증 산재장애인의 아동에 대한 수당지급
	1929	- 산업재해 인정 직업병의 종류 22가지로 확대
	1936	- 직업병 26가지로 확대
	1963	- 재해보험개정법의 도입으로 의사방문 또는 현금의 인출을 위해 은행방문 도중 입은 사고의 업무상 재해로 인정 - 직업병 인정요건의 완화 - 재해예방사업의 강조와 정부차원의 재해예방 보고서 발간 의무화 - 개별 직업조합간 재정조정제도의 도입
	1971	통근재해 인정기준의 완화
	1974	- 개별 사회보장제도별로 수행해 오고 있던 장애인의 재활사업을 역할분담과 공동사업의 차원에서 총괄적으로 조정할 수 있도록 하는 재활조정법 도입
급여 수준의 확대	1918	- 물가연동제를 도입하여 재해보상연금의 실질가치 보전
	1931/ 1932	- 재해보험 급여의 대대적 축소
	1952	- 급여수준 및 내용의 확대와 최저생계보장제도의 도입
	1957	- 장애보상연금에 대한 평균임금 슬라이드제도의 도입
	1978	- 공적연금과 재해보험의 장해연금간 병급조정 규정의 도입
	1983	- 장해연금의 평균임금 슬라이드방식을 공적연금제도와 통일
	1986	- 유족연금 수급권의 인정에 있어서 성별 차별의 철폐

2. 산업재해보험제도의 체계적 이해

(1) 이원적 산업안전보건 체계

독일의 산업안전보건 체계는 일반적으로 '정부' 및 '산재보험 관장기관(직종별 산재보험조합)'의 이원적 체계로 이해된다. 우선 연방정부(Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 'BMAS')와 16개의 주(州) 정부는 산업안전보건 관련 법제의 설치 및 운용 주체가 되고, 산재보험조합에서 마련한 재해예방규칙을 승인한다. 반면 직종별 산재보험조합(Berufsgenossenschaft, 'BG'. 이하 '산재보험조합')은 재해예방규칙의 제정 및 산재의 인정과 처리에 관한 실질적인 역할을 담당한다.

[표 3-2] 독일의 이원적 산업안전보건체계

	연방정부 및 16개 주(州) 정부	산재보험조합(BG)
법령 제정 및 규칙의 승인	- 법령의 제정 - 재해예방규칙의 승인	- 재해예방규칙의 제정 - 산재의 인정 및 처리
관리·감독	주(州) 정부 근로감독관	산재보험조합의 기술감독관

(2) 산업재해보험제도의 구조

독일의 사회보장제도는 크게 사회부조(Sozialhilfe), 부양(Versorgung), '사회보험(Sozialversicherung)'으로 구성되어 있다. 여기에서 사회보험(Sozialversicherung)은 현재 '질병보험(1883년)', '연금보험(1889년)', '요양보험(1995년)', '실업보험(1927년)' 및 '산재보험(1884년)'으로 나뉘어 운용된다.

1884년에 처음 시행된 독일 산재보험은 오늘날 독일 법정재해보험기구(DGUV)가 관장하고 있는데, 법정재해보험기구는 종전에 산업부문(민간부문, gewerbliche Berufsgenossenschaft)과 공공부문(Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand)이 분리되어 있던 것을 2007. 6. 1.에 합병한 것이다.

산업부문(민간부문) 산재보험조합(이하 '산재보험조합')은 법정 보험사고(gesetzliche Unfallversicherung)를 관장하며, 심리적 부화로 인한 자살 등의 산업재해의 예방, 재활 및 보상에 대한 권한을 가진다.

산재보험조합은 다시 '화학산업부문 산재보험조합(BG RCI)', '에너지산업부문 산재보험조합(BG ETEM)', '금속산업부문 산재보험조합(BGHM)' 등 9개 직종별 산재보험조합으로 구성·운영되고 있다.¹⁵³⁾

(3) 산업재해보험제도의 규율

산업재해와 관련해서는 1996. 8. 7. 사회법전 제7권 안에 산재보험이 통합되었다. 산재보험도 일종의 책임보험(Pflichtversicherung)이기 때문에, 여타의 책임보험과의 관계가 문제된다. 예를 들어 피해 근로자가 사고로 인해 가해자에게 손해배상청구권을 가지는 경우에, 피해 근로자는 산재보험조합에 대해서 이른바 「산재보험급여 우선청구권」에 의해 산재보험급여를 청구하게 되고, 이때 피해 근로자가 가해자에

153) 독일 산업별·직종별 산재보험 운영조합: Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI); Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM); BG Holz und Metall (BGHM); Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten (BGN); Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU); Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG); Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft (BG Verkehr); Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW); Berufsgenossenschaft Handel und Warendistribution (BGHW).

대해서 가지는 손해배상청구권은 산재보험조합에 이전되며(사회법전 제7권 제110조 제1항 제1문)¹⁵⁴⁾, 이로써 산재보험조합이 결과적으로 가해자에 대하여 과실비율에 따른 구상권(Regress)을 행사하게 된다.

산업재해(Arbeitsunfall)에 대해서는 사회법전 제7권 제8조 제1항이 규정하고 있다. 산재보험의 물적 적용범위와 관련하여 산업재해의 개념 이전에는 산재보험의 보호 단위가 사업 단위였기 때문에 업무상 재해(Betriebsunfall)의 개념이 사용되었는데, 보호 단위가 사업 단위에서 사람 단위로 변경되면서, 업무상 재해의 개념이 오늘날의 산업재해로 대체되기에 이르렀다.

사회법전 제7권 제8조 제1항 제1문은 산업재해에 대하여 (동 법) 제2조, 제3조 또는 제6조에 따른 보험적용(보험보호)을 받는 행위로 인한 피보험자의 사고(Unfall)라고 하며 규정하고 있다. 그리고 이때 동 조 제2항에 따르면 그 사고(Unfall)는 일정한 시간에 외부로부터 신체에 가해진 영향력이 건강상의 손상 또는 사망을 야기하는 사건(Ereignis)이라고 한다.

요컨대 심리적 부화로 인한 결과가 산재보험의 보호영역에 포섭되기 위해서는, 첫째, 사고를 야기한 행위가 보험의 보호를 받을 수 있는 행위이어야 하며, 둘째, 결과로서 나타난 사고가 외부로부터 신체에 가해진 영향력에 의해서 건강상의 손상이나 사망을 야기하는 사건이어야 한다. 그러한 경우에 한하여 사회법전 제7권 제8조 제1항, 제2항이 규정하는, 보험의 보호를 받는 산업재해에 해당할 수 있다.

(4) 산업재해보험제도의 적용

1) 일반

① 인적 적용범위

제국보험규칙이 처음 제정되었을 당시에는 그 보호영역과 보호대상이 (예를 들어) 철도, 광산, 조선, 제련, 석재, 채석장 등의 육체노동자에 한정되어 있었다. 그러나 보험제도가 발전함에 따라서 당연히 보호 영역과 보호 대상이 점점 확대되어 나갔

154) 사회법전 제7권 제110조 제1항 제1문에 따르면, 사용자 또는 동료 근로자 등이 동 법상의 민사책임을 면한 경우에 그 자가 고의 또는 중과실로 보험사고를 유발한 경우에는 이로 인해 사회보험조합(예를 들어 질병보험, 요양보험, 산재보험 등)이 지출한 비용에 대해서는 그 자가 책임을 부담한다. 다만 책임의 범위는 민법상 손해배상청구권에 제한된다.

으며, 특히 제국보험규칙의 제정을 기점으로 종래에 산재보험의 보호 '단위'가 사업을 열거하는 방식에서 직접 사람을 규율하는 방식으로 서서히 변경되었다(이른바 Betriebsversicherung → Personenversicherung의 변경). 요컨대 산재보험의 본질과 법률적 목적이 사업과 사람 간에 상호 긴밀성을 유지하면서, 사업 중심에서 사람 중심으로 옮겨가게 된 것이다.

② 물적 적용범위

앞서 언급된 것처럼 산재보험의 인적 적용범위와 물적 적용범위는 상호 밀접한 관련성을 가질 수밖에 없다. 즉 제국보험규칙의 제정 당시에 산재보험의 물적 적용범위는 위험성이 높은 사업에 종사하는 근로자들에 한정되었고, 이러한 고위험성 사업 근로종사자를 업무상 재해(Betriebsunfall)로부터 보호하는 것이 제국보험규칙의 1차 목적이었다.¹⁵⁵⁾ 따라서 사고(Unfälle)가 업무와 시간적·장소적으로 동떨어져 있는 경우에는 그저 개인적 불행으로 간주되었던 것이 사실이다.

그러나 이후 판례가 업무와 순수하게 시간적·장소적으로 동떨어져 있다고 하더라도, 예를 들어 일정 장소를 벗어난 행사 등에서 입은 사고 또는 특히 「트라우마로 인한 정신적 상해」를 일종의 보험사고의 결과(Unfallfolge)로 인정하게 되었다.¹⁵⁶⁾ 무엇보다 이른바 '업무수행성' 등과 관련하여 그 판단기준이 더 이상 장소적 측면에 국한되어 판단되지 않았으며, 보험사고가 발생한 원인이 유일한 행위에 의할 것을 요구하지도 않게 되었다. 말하자면 종래 자연과학적·철학적 관점에서 물리적으로 접근했던 방식에서, 복수의 원인과 조건들을 동가치한 것으로 간주하게 된 것이다.

③ 인과관계의 판단기준: '원인적 관련성'

결과적으로 일정한 사고가 산재보험의 보호영역에 존재하는지, 즉 사고 피해자에게 산재보험법상 보험청구권이 인정되는지 여부는 '발생한 사고'와 그 '결과' 사이에 원인적 관련성(ursächlicher Zusammenhang, 이른바 '중요설', 이하에서는 번역상의 정확성 등의 이유에서 '원인적 관련성'으로 표현한다)이 있는지가 결정적이 되었다. 예를 들어 복수의 조건이 경합하는 경우에 일반적인 상당인과관계를 기준으로 하지 않고, 산재보험제도의 입법목적에 고려하여 보다 중요하게 보이는 인과관계를 「채택」하는 방식을 취하게 된 것이다.

155) 업무상 재해(Betriebsunfall)의 개념은 이후에 보험 단위가 사업 단위에서 인적 단위로 변경되면서, 자연스럽게 산업재해(Arbeitsunfall)의 개념으로 변화하였다. 사회법전 제7권 제8조 제1항 참조.

156) Schulin(Hrsg.)/Breuer, Handbuch des Sozialversicherungsrechts, Bd. 2, Unfallversicherungsrecht, 1996, § 1 Rn. 86.

이로써 독일 산재보험은 보험사고인지 여부, 특히 인과관계의 유무를 발생한 사고와 결과 사이에 원인적 관련성이 있는지에 따라서 판단하게 된다. 이러한 원인적 관련성을 따를 경우에는 인과관계와 귀책의 문제가 구별되고, 인과관계는 조건설에 따라서, 결과귀속은 개별 요소들의 중요성에 따라서 판단하게 된다.

2) 적용의 유형

① 산재보험 법규정에 따른 적용

재해보험제도의 당연적용 대상은 다음과 같은 사람과 행위가 된다. 재해보험제도의 당연가입 대상은 일차적으로 소득의 수준·직종·종사상의 지위에 상관없이 모든 근로자가 되며, 나아가 가내근로자(Heimarbeiter)·가내공업자(Hausgewerbtreibende)와 함께 일하는 배우자도 의무가입이 적용된다. 그리고 고용촉진법이나 연방사회부조법에 근거하여 신고의무(예를 들어 실업신고·자산조사를 위한 소득신고 등)를 수행하거나, 해당 기관의 지시에 따라 제반의 사업(예를 들어 자활사업이나 구직활동 등)에 참여하는 사람들이 재해보험의 적용대상이 된다.

농업부문의 자영농민과 가족종사자가 재해보험의 적용대상이 된다. 그리고 영리를 목적으로 하는 연안운송업자와 연안어업 종사자 그리고 가족종사자 또한 당연히 재해보험에 가입하여야 한다.

재해보험법은 공익을 위하여 활동하는 사람들을 적용대상으로 하고 있다. 구체적으로 사회의료시설·복지시설·재난구호·시민보호·생명구호 등을 위하여 무보수로 활동하는 사람, 공공기관·시설·종교단체·교육기관에서 명예직으로 활동을 하는 사람 그리고 의사상자가 재해보험의 보호를 받게 된다. 뿐만 아니라 헌혈자·장기기증자·자원봉사자로서 적십자요원·제3세계 개발원조자와 이를 위한 교육생 등이 재해보험의 적용을 받게 된다. 이 이외에도 법원이나 검찰의 요구에 따라 관련 서류의 제출이나 증인으로 소환된 사람·기업의 인턴요원·채용시험 참가자 등도 재해보험의 적용대상이 된다.

재해보험법은 근로자가 아닌 다음과 같은 사람에게도 적용이 되고 있다. 첫째, 직업교육생·견습생·유치원원아·학생·대학생으로서 관할 시설이나 통학과정에서 발생한 사고에 대하여 재해보험의 보호가 이루어지게 된다. 그리고 교육기관의 지시에 따

라 별도의 시설에서 수행하는 사업에 참여하는 사람들도 재해보험의 적용을 받게 된다. 둘째, 사회복지기관에서 자활사업(Selbsthilfe)의 일환으로 실시하는 주택건설·농지의 개간과 경작·공장부지의 개간·공공시설의 건설 등에 참여하는 사람들이 재해보험의 적용대상이 된다. 셋째, 제반의 사회복지제도에서 실시하는 재활사업에 참여하는 사람들에 대하여 재해보험의 적용이 이루어지게 된다. 넷째, 장기수발보험법의 제정과 함께 주당 최소한 14시간 이상 요수발자를 간병하는 사람들이 재해보험의 적용을 받게 된다. 이 경우 적용의 대상은 요수발자의 가족이나 취업을 목적으로 하지 않는 가정봉사원이 된다. 다섯째, 임신 중 유해한 작업환경으로 인해 태아에게 장애가 발생하였을 경우 출생 시부터 재해보험의 보호가 이루어지게 된다. 여섯째, 재소자로서 법으로 정한 강제노역을 수행하는 사람도 재해보험의 적용대상이 된다.

비록 재해보험법에서 구체적으로 명시하고 있지 않으나, 제반의 정황을 감안해 볼 때 근로자로 판단이 될 경우 재해보험제도의 당연적용 대상이 된다. 이와 관련한 사례로서 특정한 기업의 판매대행자(예를 들어 자동차 딜러), 보험중개인, 프리랜서(예를 들어 자유기고자, 예술가, 합창단원 등)들이 재해보험제도의 당연적용을 받게 된다.

② 산재보험조합의 정관에 따른 적용

재해보험법 제3조에서는 개별 직업조합들이 자체의 정관(Satzung)을 통하여 별도의 적용대상을 설정할 수 있도록 하고 있다. 이 경우 대상자들은 본인의 의사에 상관없이 의무적으로 해당 직업조합에 가입을 하여야만 한다.

개별 직업조합의 정관에 의한 적용대상은 일차적으로 해당 관할영역의 기업주와 함께 일하는 배우자가 된다. 이 이외에도 타 재해보험제도의 적용을 받고 있지 않는 사람으로서 기업의 방문자와 통행자도 직업조합의 정관에 의해 보호의 대상이 된다.

(5) 산재보험 담당기관

1) 산재보험 관장기관

독일은 통합적 법정재해보험기구(DGUV)를 설치하여 전체적으로 산재보험을 관장하고 있으며, 총 6개의 지역본부를 두고 있다. 법정재해보험기구는 민간부문과 공공

부문으로 나뉜다. 민간부문에서는 산재보험조합이 법정재해보험을 제공하고, 공공부문에서는 재해보험기금이 법정재해보험을 제공한다. 이러한 법정 산재보험의 관장 기관은 사회법전 제7권(SGB VII) 제114조에 규정되어 있다. 오늘날 민간부문을 관장하는 9개의 산재보험조합과 1개의 농업분야 산재보험조합, 그리고 공공부문을 관장하는 19개의 재해보험기금 등이 설치되어 있다.

법정재해보험기구의 특징은 크게 두 가지로 요약된다. ① 법정재해보험기구는 법정 기구임에도 불구하고 그 조직과 운영이 정부로부터 독립되어(selbstständig) 있다. 산재보험조합의 의사결정은 실제로 보험료를 납부하는 사용자와 보험을 제공받는 피보험자 대표로 구성된 보험협회 내의 이사회를 통해 이루어진다.¹⁵⁷⁾ 이로써 산재보험조합은 그 운영에 있어서 일종의 자치권을 가진 행정조직으로 이해된다.

② 산재의 예방, 치료, 재활, 보상이 법정재해보험기구의 통합된 체계 내에서 이루어진다. 이를 통하여 분산된 행정절차로 인해 발생할 수 있는 소모적인 비용이 절감될 수 있다. 법정재해보험기구의 통합시스템 내에서, 사용자는 산재의 예방을 위한 실질적이고 구체적인 지원에 보다 용이하게 접근할 수 있고, 근로자는 재해 발생 시 치료, 재활, 보상을 위한 종합적인 보험을 제공받을 수 있다.

2) 산재병원

사회법전 제7권 제34조에 의하여, 산재보험조합은 피보험자에게 신속·정확한 치료 및 요양 등을 보장하기 위하여 산재의사 및 병원을 지정·운영할 수 있다. 현재 총 13개의 병원 시설이 운영되고 있으며, 10개의 산재병원, 1개의 직업병 전문병원과 2개의 응급시설로 구성된다.¹⁵⁸⁾

157) 이사회는 6년마다 개최되는 보험협회회의에서 투표로 선출된다.

158) 이와 더불어 약 600개의 전문적인 요양시설도 운영되고 있다.

[표 3-3] 산재보험 병원 시설¹⁵⁹⁾

구분	시설명 및 위치
산재병원	BG Klinikum Unfallkrankenhaus Berlin(베를린)
	BG Universitäts-klinikum Bergmannsheil Bochum(보쿰)
	BG Klinikum Duisburg(뒤스부르크)
	BG Unfallklinik Frankfurt am Main(프랑크푸르트)
	BG Klinikum Bergmannstrost Halle(할레)
	BG Klinikum Hamburg(함부르크)
	BG Klinik Ludwigshafen(루트비히스하펜)
	BG Unfallklinik Murnau(무르나우)
	BG Nordsee Reha-Klinik(노르트제 레하)
	BG Klinik Tübingen(튀빙겐)
직업병 전문병원	BG Klinik für Berufskrankheiten in Bad Reichenhall(바트 라이헨할)
응급시설	BG Unfallbehandlungsstelle Berlin(베를린)
	BG Ambulanz Bremen(브레멘)

3) 산재의사

산재의사는 산재보험조합과 보험의사협회(Kassenärztliche Bundesvereinigungen) 간에 체결된 계약에 근거하여(사회법전 제7권 제34조) 산재의사절차(Durchgangsarztverfahren)에 참가하는 의사를 말한다.¹⁶⁰⁾ 이때 계약의 내용은 '요양의 실시, 산재의사의 보수 및 의료제공에 대한 정산의 종류와 방법'¹⁶¹⁾ 등이다. 산재가 발생한 경우에 재해근로자는 반드시 산재의사의 진단과 요양을 받아야 한다. 만약 재해가 경미하여 일반의사에게 치료를 받는 경우에도 일반의사는 재해근로자의 치유 경과에 대하여 산재의사로부터 확인을 받아야 한다. 이런 측면에서 산재의 인정과 처리 과정에서 산재의사의 역할이 강조된다.¹⁶²⁾

159) <https://www.bg-kliniken.de/standorte/> (2023. 9. 14. 최종확인). 종전에는 산재병원이 9개, 직업병 전문병원이 2개 운영되었으나, 현재는 산재병원이 10개, 직업병 전문병원이 1개 운영되는 것으로 파악된다.

160) 법정재해보험기구는 산재의사의 자격 요건 및 그 유지와 최소에 관하여 상세한 규정을 마련해 두고 있다. https://www.dguv.de/medien/landesverbaende/de/med_reha/documents/d_arzt3.pdf (2023. 9. 14. 최종확인).

161) 원문을 소개하면 다음과 같다: Durchführung der Heilbehandlung, die Vergütung der Ärzte sowie die Art und Weise der Abrechnung der ärztlichen Leistungen(SGB VII § 34 Abs. 3).

162) 독일의 산재의사제도에 관하여 보다 자세한 것은 신영규·오상호, 「독일 산재의사 신고제도 도입 필요성」에 대한 연구, 안전보건공단, 2016. 10.

II. 직업병(업무상 질병)의 처리

1. 개관

독일은 산재보험 보호대상으로서 직업병(Berufskrankheit=업무상 질병, 이하 '직업병')에 관하여 사회법전 제7권(SGB VII) 제9조에서 비교적 자세히 정하고 있다.

우선 직업병은 규칙(Berufskrankheiten-Verordnung)¹⁶³⁾ 제2조, 제3조 혹은 제6조에 따라 보험의 보호를 받는 행위의 결과로 피보험자가 입은 질병을 뜻한다. 연방정부는 의학적 소견에 따라 특정한 인적 집단이 그들의 업무를 통하여 타인보다 현저히 높은 정도로 노출되어 있는 '특별한 영향력'에 의해 야기되는 질병을 규칙에서 직업병으로 규정할 수 있다. 이때 연방정부는 질병이 특정 위험 분야에서의 업무로 야기되었거나, 그 업무의 위험이 당해 질병의 발생, 악화, 재발의 원인이 됨으로써 '업무를 중단해야 하는 경우'에만 이 질병이 직업병이라고 규정할 수 있다. 나아가 선박기업의 피보험자가 육지에서 휴가를 보내는 기간 동안 어디까지 직업병에 대해 보험이 적용되는지도 규칙으로 정할 수 있다(동조 제1항).

[표 3-4] 독일 직업병 목록 등재 질병의 수(2023년 9월 14일 현재)

질병의 원인 / 관련 질병	질병의 수(82개)
화학적 원인(chemische Einwirkungen)	33개
물리적 원인(physikalische Einwirkungen)	20개
병원체(Infektionserreger), 기생충(Parasiten)	4개
기관지(Atemwege), 폐(Lungen), 늑막(Rippenfell), 복막(Bauchfell), 난소(Eierstöcke) 관련 질병	21개
피부(Haut) 관련 질병	3개
그밖의 원인으로 인한 질병 [광부의 안구 진탕(震盪, Augenzittern)]	1개

규칙으로 규정하지 않았거나 규칙이 정한 요건을 충족하지 못한 질병이 새로운 의학 지식에 의해 판정 시점에서 제1항 제2문에 따른 요건을 만족시킨다면, 재해보

163) 독일은 직업병 관련 법제(Berufskrankheiten-Recht)로서 현행 '직업병 규칙(Berufskrankheiten-Verordnung, BKV)'을 1997. 10. 31.에 제정하여 같은 해 12. 1.부터 시행해오고 있다(BGBl. I S. 2623 이하). 이로써 종전의 관련 규칙들은 그 효력을 상실했다(BGBl. I S. 2624). 현행 직업병 규칙은 12개의 조문으로 구성되며, 직업병으로 분류될 수 있는 구체적인 인정기준(즉 원인, '직업병 목록')을 정하고 있다(Anlage 1).

험기관은 이 질병을 보험사고로서의 직업병으로 인정해야 한다(동조 제2항). 그리고 보험이 적용되는 업무의 특별한 조건으로 인해 동조 제1항에 따른 규칙에서 언급한 직업병 위험이 높은 업무에 종사하는 피보험자가 이러한 질병에 걸리고, 보험이 적용되는 업무 외에는 원인이 될 만한 단서를 발견할 수 없다면, 이 질병은 보험에 가입된 업무에 의해 야기되었다고 추정할 수 있다(동조 제3항). 나아가 어떤 질병을 직업병으로 인정하는 요건 자체가 질병의 발생, 악화, 재발의 원인이 되었거나 될 수 있는 업무를 중단하는 것이라면, 사고보험기관은 수행된 위험 업무를 중단하기 전(前)에 직업병으로 인정하기 위한 기타의 요건이 충족되었는지 여부를 결정해야 한다(동조 제4항).

직업병으로 인한 재해급여 지급의 기준시점은 근로 불능의 시점, 치료가 필요하게 된 시점 또는 피보험자에게 유리할 경우에는 연금 자격이 있는 취업 능력 감소 시점이다(동조 제5항).¹⁶⁴⁾ 연방정부는 규칙으로 직업병의 발생, 악화 혹은 재발을 방지하기 위한 재해 관련 급여의 요건, 종류 및 범위를 정할 수 있다(동조 제6항 제1호).

2. 직업병의 인정 절차¹⁶⁵⁾

(1) 직업병 인정기준

우리과 마찬가지로, 독일에서도 직업병으로 인정되는 기준은 노동시장에서 중요한 사항이다. 따라서 '직업병 목록'에 특정 질병이 등재되기 위해서는 일정한 절차를 거치게 되며, 의학적인 검증과정을 거쳐 직업과 관련이 있다고 인정된 질병들이 직업병으로 정해진다.

직업병 인정목록의 작성과 관련하여 연방노동사회부에는 독립적인 자문위원회가 설치·운영되고 있다(이하 '자문위원회'). 자문위원회는 교수, 의사, 실무전문가 등으로 구성된 상임기구로서, 2개월에 1회 종일회의가 이루어진다. 자문위원회에서 논의 중인 사항은 그 결정이 있기 전까지 공개되지 않는다. '회의의 주된 내용'은 질병의 특정 직업이나 직무와의 연관성, 즉 인과관계의 판정이다. 만약 새로운 직업병이 확

164) 이는 업무상재해(보험사고) 관련 급여에 대한 규정이 보험사고의 발생 시점에 맞추어져 있는 것과 비교된다.

165) 이하에 관하여 보다 자세한 것은

<https://www.oftersheim.de/service-bw/verfahren/Feststellung%20einer%20Berufskrankheit:file:///C:/Users/User/Downloads/30-Ablauf-Verfahren-Berufskrankheit.pdf> (2023. 9. 14. 최종확인) 참조.

인되는 경우에 그 소급 적용은 제한적으로 인정되고 있다.

직업병 목록에 병명이 등재되기 위해서는 자문위원회의 사례조사가 요구된다. 이는 독일뿐만 아니라 다른 국가의 사례를 통해서도 이루어지며, 특정 직업에서 비정상적으로 많이 발생하는 질병인지 여부를 확인하는 절차이다. 예를 들어 근육 압력으로 인한 마비나 석면에 의한 폐암 등이 자문위원회에 의해 인정 요구가 있었고, 초기에는 일부 산재근로자에 대해서 인정되었으나, 현재에는 모든 산재근로자에게 인정되고 있다.

다만 직업병 목록에 등재되기 위한 '특정되고 일괄된 기준'이 있는 것이 아니다. 즉 자문위원회에서 실질적인 검증을 거쳐 직업과 관련된 질병이라고 인정되면, 자문위원회가 그것을 목록에 직업병으로 등재할 것을 제안한다. 그리고 역학조사와 실증분석을 거쳐 어느 질병이 일정한 근로조건에서 발병한다는 점이 증명된다면 이 질병은 직업병으로 인정된다.¹⁶⁶⁾

직업병의 경우 사후적으로 처치가 이루어지는 경우가 많으므로, 가능한 한 신속한 산재보험 행정처리가 요구된다. 예를 들어 석면에 의한 종양은 대부분 악성이고, 이후 통상 6개월 내에 사망에 이르기 때문에, 6개월 안에 산재보험 행정처리를 해주어야 한다. 무엇보다 해당 질병은 95%가 석면으로만 발병한다. 따라서 만약 어느 근로자에게서 해당 종양이 발견되었고, 그 근로자가 석면 관련 업무에 종사했는지 여부만 확인되면, 하루를 일했어도 해당 질병과 업무의 인과관계를 인정할 수 있으므로, 산재로 인정된다. 이로써 근무 기간을 묻지 않는다.

(2) 직업병 인정과정

근로자에게 직업병 목록에 있는 질병에 발병했다고 해서 항상 직업병으로 인정되어 산재보험으로 처리되는 것이 아니다. 이들에 대해서는 개별적인 조사 과정을 거치게 되며, 조사 방법은 매우 어려운 과정이다. 예를 들어 피부병의 경우 업무수행 과정에서 발병했더라도, 피부병 자체가 각 개인의 선천적 요인(민감성 등)이 작용하기 때문에 직업병으로 인정하기 어렵다. 또는 어릴 때부터 강력한 음약에 지속적으로 노출됨으로써 상당한 정도의 청각장애가 이미 발생했던 경우, 업무수행 과정에

166) 직업병 목록에 등재된 질병 중에는 단지 병명 또는 증상만 기재된 것이 있는 반면, 예를 들어 일정 기간 이상 특정 장소에서 일을 했어야 된다는 세부적인 조건이 들어 있는 것도 있다.

서 그 청각장애가 악화되더라도 직업병으로 인정되기 어렵다.

반면 페인트공이 직접 분말을 섞어 용액을 만드는 경우 분말을 통해 발암물질을 흡입하더라도 20~30년이 지난 후에야 비로소 방광암이 발병하기 때문에, 그때에도 직업병으로 인정될 수 있다. 이처럼 직업병의 경우 그 인정 여부를 결정하는 과정에서 발병에 관여했거나 관여할 가능성 있는 여러 가지 복합적인 요인들이 고려되기 때문에, 업무상 재해(사고보험, Unfallversicherung)와 달리 신고 건수 중 대략 40% 정도가 산재보험이 적용되는 직업병으로 인정되고 있다.¹⁶⁷⁾

직업병 인정 여부에 관한 최종결정은 산재보험조합의 '담당직원'이 하게 된다. 산재보험조합의 담당직원은 자문의사로부터 자문을 받고, 이른바 기술감독관(어느 사업장에서 어떤 물질을 다루는지를 알고 있음)을 통해 의사소견서를 검토한다. 담당 직원에게 의학지식이 요구되지만, 그보다 담당직원의 경험에 의한 결정이 중요하며, 이는 그 담당직원의 소관에 속한다.

직업병으로 인정되는 시점까지의 진료비는, 건강보험에서 먼저 지급하고, 차후에 직업병으로 인정되면 건강보험조합과 산재보험조합 간에 사후정산을 하게 된다. 즉 건강보험자와 산재보험자 간의 정산제도로 운용되며, 재해근로자는 치료만 받으면 되고, 진료비와 관계가 없다. 다만 건강보험급여와 산재보험급여에는 약간의 차이가 있으므로, 만약 재해근로자가 건강보험에서 지급하지 않는 부분을 자비로 지출한 경우에는, 추후에 직업병으로 인정되면 산재보험조합이 재해근로자에게 그 지출 비용을 지급해 준다.¹⁶⁸⁾

한편 의사는 직업병으로 확정될 때까지의 치료비를 일단 건강보험에 청구한다. 건강보험은 법률에 의해 당시 상황에서의 진료비를 지불할 의무가 있고, 다만 산재보험의 적용 대상자로 확정된 이후부터는 지급의무를 면하게 된다. 산재의사는 직업병으로 의심되는 재해근로자를 산재보험조합에 신고할 의무가 있고(사회법전 제7권 제202조), 이와 관련하여 이해가 상반되는 건강보험조합과 산재보험조합의 감시를 받는다고 하겠다. 건강보험 또는 산재보험 가운데 어느 경우에 의하더라도 치료하

167) 통계에 따르면 2021년 한 해 동안 123,000건 이상 직업병으로 인정되었다.

<https://www.dguv.de/de/zahlen-fakten/bk-geschehen/index.jsp> (2023. 9. 14. 최종확인).

168) 예를 들어 건강보험에서 지급하지 않음에도 불구하고, 재해근로자가 원해서 다인실이 아닌 1인용 병실을 사용하면서 직접 자비로 병원에 건강보험 미지급 병실료 차액을 지급한 경우 차후에 직업병으로 인정되면, 그 비용이 산재보험에 의하여 지급되어야 하는 때에는 재해근로자에게 차액이 지급된다. 또한 건강보험에서 적게 지급하는 휴업급여도 추후에 산재보험을 통해서 보전될 수 있다.

는 부분에 대해서는 차이가 없다.

산재보험조합이 산재의사로부터 직업병으로 의심된다는 신고를 받은 경우에는 조사를 시작하게 된다. 산재보험조합은 재해근로자의 병력 및 경력에 대한 정보를 요구하게 되고, 이때 재해근로자에게 서면, 전화 또는 직접 방문하여 정보조사가 이루어지기도 한다. 재해근로자의 상태가 중한 경우에는 재해근로자의 경력과 병력에 대한 조사를 직접 하기도 하지만, 이는 부가적인 서비스의 차원으로서 조합의 의무사항은 아니다. 예를 들어 석면 관련 악성종양의 경우 산재보험조합의 직원이 직접 재해근로자를 방문하여 재해근로자가 해야 할 서류처리를 대신 처리해주게 된다. 통상 이러한 업무는 산재보험조합에 소속한 사회사업가나 조합직원이 하게 된다.

직업병 인정 여부에 대한 산재보험조합의 조사 기간은 질병의 종류에 따라 다르지만, 대체로 수개월 정도 소요된다. 이 조사가 끝나면 조합에서 직업병 여부를 결정하게 되며, 직업병으로 결정되면 모든 비용은 산재보험에서 부담하게 된다. 건강보험조합과 산재보험조합 간에는 지난 시기에 대한 진료비를 상호 정산하게 된다.

앞서 잠깐 언급했듯이, 직업병의 경우 통계적으로 신고 건수 중 약 40%만 인정되므로 상당히 비효율적이라는 비판이 계속해서 제기되고 있으며, 이런 이유에서 건강보험으로 처리되는 건수가 과반수를 넘는다. 특히 직업병으로 확정되기 전이라도 재해근로자에게 산재보험이 적용될 필요가 있다는 견해에 대해서는, 건강보험은 노사 양측이 보험료를 부담하고, 산재보험은 사업주만 부담한다는 점에서, 직업병으로 확정되지 않은 상태에서 산재보험을 우선 적용하는 것은 정의관념에 부합하지 않는다고 본다.

한편 산재보험수가가 건강보험수가보다 고가이기 때문에, 병원(의사)의 입장에서는 산재보험의 우선 적용을 주장할 수도 있을 것이다. 그러나 병원(의사)들이 직업병 치료를 수입원으로 하는 경우는 많지 않으며, 오히려 산재사고가 주수입원이 된다. 또한 직업병으로 인정되면 그때부터 산재보험처리가 되기 때문에 그 인정되기까지의 기간까지 건강보험에서 처리하고 정산하면 된다. 산재보험에서 더 높은 수가를 주는 것은 특수치료의 경우이며 일반치료를 요구하는 경우는 건강보험과 차이가 없고, 건강보험에서 지급하지 않은 부분에 한하여 산재보험에서 지급하게 된다.

3. 직업병의 처리 절차

(1) 신고

직업병 신고는 산재의사의 의무사항이다. 따라서 산재의사가 재해근로자를 치료하는 과정에서 직업병인지 의심되는 경우 산재보험조합에 신고해야 한다(사회법전 제 7권 제202조). 신고를 접수한 산재보험조합은 자문의(Beratende Artzt; Betriebsarzt)를 배정하여 신고 의사의 진단서를 검토하고, 산재보험조합 내 기술위원회에 신고하여 당해 사업장에서 직업병이 발생할 수 있는가를 검토하게 된다.

검토할 때 기초가 되는 것은 직업병 규칙(Berufskrankheiten-Verordnung)으로서, 동 규칙에 근거하여 검토가 이루어진다. 자문의와 기술위원회에서 검토한 결과를 토대로 산재보험조합이 직업병 인정 여부를 최종결정하게 되며, 이때 산재로 인정되지 않는 재해근로자는 산재보험조합을 연방사회법원에 제소할 수 있다.

재해근로자가 직업병인지 모르고 병원을 찾게 되면 일단 건강보험으로 치료하고 산재의사도 건강보험에서 진료비를 받는다. 건강보험조합은 치료내용 확인을 통해 산재의사가 부당하게 건강보험으로 처리하지 못하도록 통제한다.

산재병원도 직업병의 확정진단과는 아무런 관계가 없다. 산재의사가 진단서에 기재한다고 해서 직업병으로 인정되는 것이 아니며, 산재의사가 산재보험조합에 직업병으로 인정해야 한다고 조언을 할 뿐이다. 직업병 여부는 산재보험조합에서 결정하는 것이므로, 산재보험조합에서 직업병을 불승인하면 직업병으로 인정되지 않는다. 이에 대해 재해근로자는 연방사회법원에 산재보험조합을 제소할 수 있을 뿐이다.

(2) 증명

1) 병명 진단

병명은 우선 산재의사의 진단에 의하여 확정된다. 병명이 확정되는 과정은 재해근로자가 아닌, 산재보험조합이 수행하게 된다. 즉 산재보험조합이 해당 질병의 발병 여부에 대한 진단이 나올 때까지 모든 절차를 진행해야 한다. 그리고 재해근로자가

어느 사업장에서 어떠한 업무에 종사했는지, 특정 물질로부터 영향을 받았는지 등을 조사하게 되고, 해당 질병이 그 물질에 기인한 것인지 조사를 진행한다.

2) 인과관계의 증명

직업병 인정을 위해서 재해근로자는 근무 장소와 기간, 의심되는 물질, 산재의사 진단서 등 필요한 자료를 제출해야 할 의무가 있다. 각각의 질병마다 서식이 상이하며, 산재보험조합이 이것을 재해근로자에게 보내면 재해근로자가 직접 작성해서 산재보험조합으로 보내준다. 재해근로자의 상태가 중한 경우에는 산재보험조합의 직원 등이 서류작성을 대행하는 서비스를 제공하기도 하지만, 이는 법정 의무가 아닌 부가서비스에 해당함은 앞서 언급한 바와 같다.

재해근로자가 일정한 근무 환경에서 업무 도중에 자신이 취급하게 되는 '특정 물질'에 의해서 단지 질병이 발병했다는 점을 증명하더라도 이것이 곧 직업병으로 인정되는 것이 아니다. 중요한 것은 의학적 연관성, 즉 의학적 인과관계에 대한 증명이다.

이런 이유에서 직업병에 있어서는, 일단 진단명이 직업병 목록에 등재되어 있는 경우에는 직업병으로 인정하고, 그 반대증명을 산재보험조합이 부담하도록 하자는 비판이 꾸준히 제기되고 있다. 이를 통해서 재해근로자를 더욱 두텁게 보호하고, 만약 산재보험조합을 통해서 직업병이 아닌 것으로 밝혀지면 건강보험으로 처리하는 방법을 도입할 것을 주장한다. 근로자가 직업병임을 주장하기가 현실적으로 어려운 상황에서, 증명책임을 산재보험조합에게 부담시키자는 주장은 일견 타당하게 보이기도 한다.

4. 이의신청과 조정

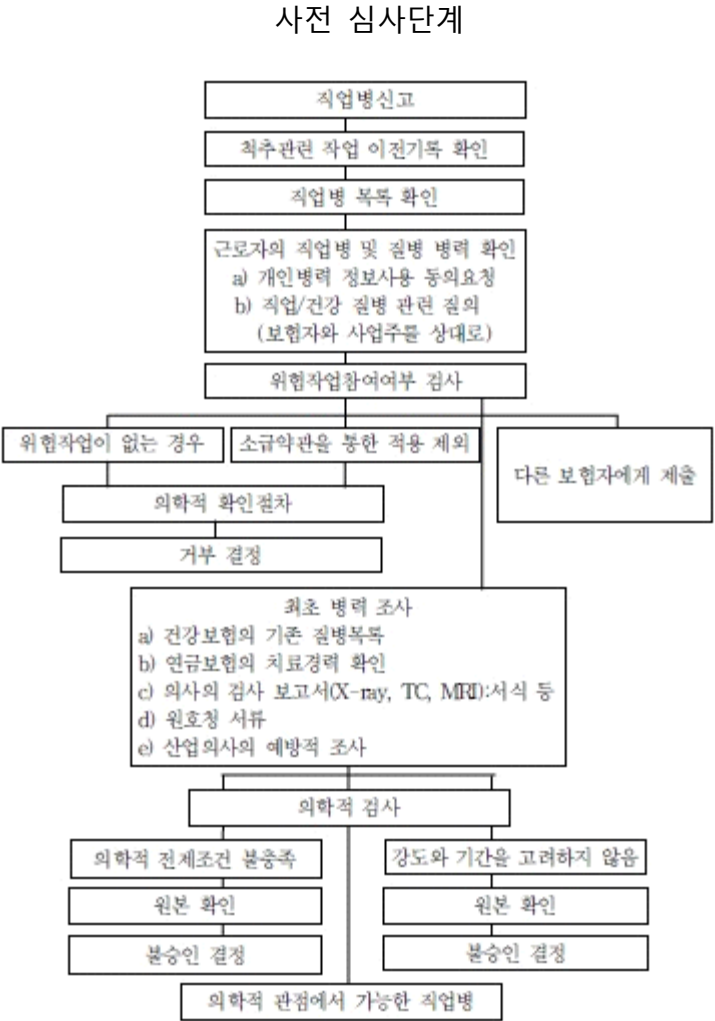
직업병 판정에 관한 모든 절차는 조합에서 수행한다. 모든 절차를 종결했음에도 직업병이 아니라거나 의학적으로 분명하게 증명을 할 수 없다고 판정한 경우, 재해근로자가 이에 대해 이의신청을 하게 되면 산재보험조합 내 이의심사위원회가 검토를 하게 된다. 그럼에도 번복 결정이 나지 않고 재해근로자 또한 결정에 불복하는 때에는, 사회법원에 제소를 해서 소송을 통한 결정을 요구할 수 있다.

이의심사위원회의 결정에 대해서 재해근로자가 불복하여 사회법원에서 다루게 된

다. 사회법원에서는 다른 보험 관련 기구와 마찬가지로 판사가 증명해야 할 의무가 있다. 즉, 원고가 제기한 문제에 대해 판사는 연금을 더 주어야 하는지에 대해 모든 조사를 판사가 수행하게 된다.

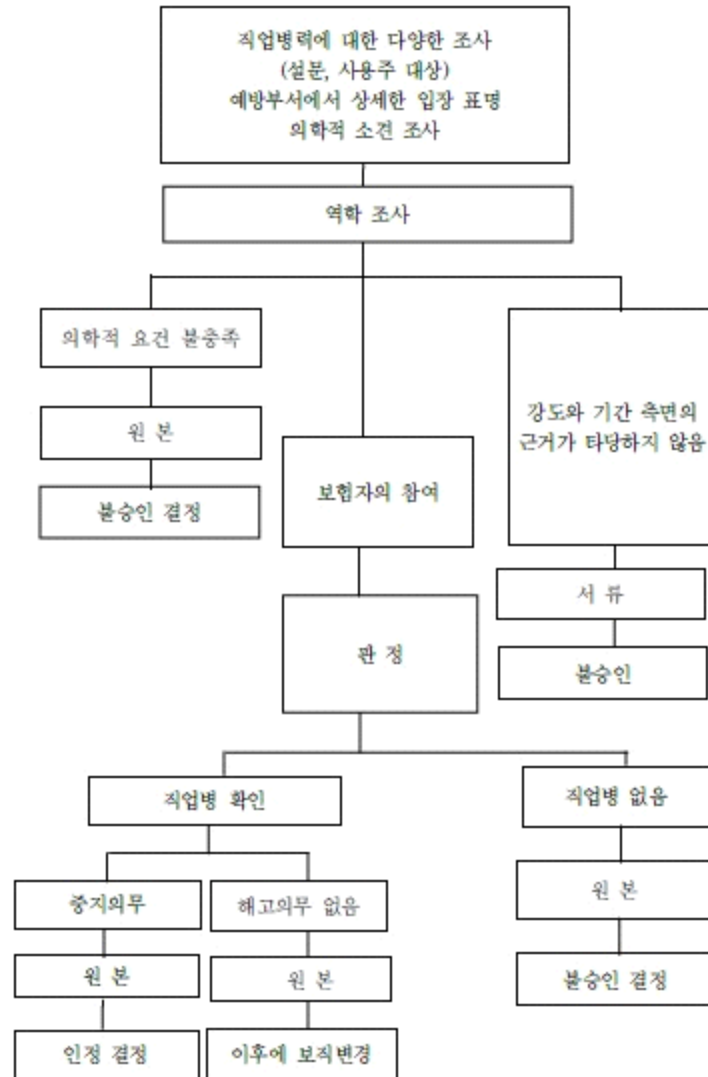
판사는 3명으로 구성되며, 1명은 전문판사이고 2명은 명예판사(노사 각각 1명씩)이다. 판사 3명이 이 사건에 대한 조사를 통해 판결을 하게 되면, 판결에 불복하면 전문판사로만 구성된 2심으로 가게 된다. 대부분 사건이 2심에서 마무리된다고 하며, 3심까지 가는 경우는 드물다. 대부분의 경우 이의심사위원회에서 결정이 존중된다.

[그림 3-3] 직업병 인정 절차¹⁶⁹⁾



169) 이현주 외 5명, 「외국의 산재보험제도 연구 -선보장·후정산제도를 중심으로-」 (정책연구 2004-1), 2004. 8., 한국노동연구원, 43-44면.

정식 심사단계



5. 현황

피재근로자가 직업병으로 인한 사고보험의 적용을 받기 위한 절차는 크게, ① 산재의사의 산재의심 신고 → ② 산재보험조합의 직업병 인정의 순서로 진행된다. 이러한 점에 기초하여 현황을 살펴보면 다음과 같다.¹⁷⁰⁾

170) 이하에서 소개되는 직업병 관련 통계 자료에 관하여 “DGUV-Statistiken für die Praxis 2022 (<https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/4767>)” 각 해당 부분 참고 (2023. 10. 15. 최종확인).

(1) '산재보험조합별' 직업병 의심 신고 건수

통계자료에서 소개되는 2010년 이후 '산재보험조합별' 직업병 의심 신고 건수는 아래 [표 3-5]와 같다. 특징적인 것은, 2020년에는 그전 시기(2010년, 2015년)보다 의심 신고 건수가 2만여 건 증가했고, 2021년과 2022년에는 각각 그 전년도보다 10만여 건씩 급격하게 증가했다는 점이다. 이러한 현상은 무엇보다 COVID-19에 기인하는 것으로 이해된다.

[표 3-5] '산재보험조합별' 직업병 의심 신고 건수¹⁷¹⁾

	2010	2015	2020	2021	2022
(민간) 산재보험조합	64,721	69,874	88,472	181,225	299,238
원료 및 화학	8,579	7,302	6,997	6,479	6,439
목재 및 금속	14,707	15,732	15,125	16,621	16,772
에너지, 섬유, 전기, 미디어	5,418	5,856	5,864	5,819	5,914
건설	10,501	13,613	15,821	16,492	18,228
식품	5,203	4,209	3,075	2,724	2,868
무역 및 상거래	3,774	4,247	3,648	3,805	3,923
운송, 물류, 통신	1,814	1,965	2,185	2,328	2,435
관리	4,005	4,254	3,913	4,648	4,831
보건 및 복지	10,720	12,696	31,884	122,309	237,828
공공부문	5,447	7,030	17,917	46,366	70,691
합계	70,168	76,904	106,389	227,591	369,929
학교사고보험	109	87	102	139	212

(2) '산재보험조합별' 직업병 인정 건수

위 [표 3-5]와 같은 기간 동안 인정된 '산재보험조합별' 직업병 건수는 아래 [표 3-6]과 같다. 따라서 위 [표 3-5]의 해당 수치에서 아래 [표 3-6]의 해당 수치를 제

171) "DGUV-Statistiken für die Praxis 2022

(<https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/4767>)" S. 72 (2023. 10. 15. 최종확인).

외한 '수치'는 직업병으로 의심되어 산재의사에 의해서 신고되었으나, 각 산재보험 조합에 의하여 직업병으로 판명되지 않은(nicht bestätigt) 건수를 나타낸다.

[표 3-6] '산재보험조합별' 직업병 인정 건수¹⁷²⁾

	2010	2015	2020	2021	2022
(민간) 산재보험조합	14.615	15.658	29.270	95.355	163.271
원료 및 화학	4.362	2.166	1.891	1.654	1.410
목재 및 금속	4.545	4.989	5.159	5.771	5.022
에너지, 섬유, 전기, 미디어	1.103	1.353	1.711	1.658	1.377
건설	2.013	4.053	5.015	5.330	4.915
식품	398	565	432	1,718	839
무역 및 상거래	361	692	585	1.609	890
운송, 물류, 통신	187	265	575	473	421
관리	701	706	856	1.474	1.384
보건 및 복지	945	869	13.010	75.668	147.013
공공부문	839	1.135	7.893	28.235	36.206
합계	15.454	16.793	37.163	123.590	199.477
학교사고보험	7	9	18	36	65

(3) 연도별 직업병 의심 신고 건수, 인정 건수, 연금수급자 수

아래 [표 3-7]은 1993년부터 2022년까지 「(민간) 산재보험조합, 공공부문과 학교 사고보험」 전체 영역에서 직업병 의심 신고 건수, 인정 건수, 직업병으로 인한 연금 수급자 수를 보여준다. 특징적인 것은 2016년에 전년도 대비 '직업병 의심 신고 건수'에 비해서 '직업병 인정 건수'가 4천~5천여 건 증가했다는 점이다. 이는 2015. 1. 1.부터 새로운 직업병이 직업병 목록에 등재되었기 때문으로 해석된다. 또한 2020년을 기점으로 하여 2021년, 2022년 직업병 의심 신고 건수와 인정 건수가 급격하게 증가한 것은 COVID-19에 기인한 것으로 이해된다.

172) "DGUV-Statistiken für die Praxis 2022

(<https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/4767>)" S. 73 (2023. 10. 15. 최종확인).

[표 3-7] 연도별 직업병 의심 신고 건수, 인정 건수, 연금수급자 수¹⁷³⁾

연도	직업병 의심 신고 건수	직업병 인정 건수	직업병으로 인한 연금수급자 수
1993	101,851	18,635	5,984
1994	93,296	20,318	6,835
1995	87,431	22,938	7,135
1996	90,304	23,212	7,536
1997	85,406	22,577	7,469
1998	82,376	19,976	6,072
1999	80,282	18,633	5,693
2000	78,029	18,000	5,304
2001	73,551	17,950	5,503
2002	68,196	17,722	5,443
2003	62,130	16,778	5,085
2004	60,965	16,784	5,021
2005	59,919	15,920	5,459
2006	61,457	14,156	4,781
2007	61,150	13,383	4,123
2008	60,736	12,972	4,312
2009	66,951	16,078	6,643
2010	70,277	15,461	6,123
2011	71,269	15,262	5,407
2012	70,566	15,291	4,924
2013	71,579	15,656	4,815
2014	71,685	16,112	5,155
2015	76,991	16,802	5,049
2016	75,491	20,539	5,365
2017	75,187	19,794	4,956
2018	77,877	19,748	4,813
2019	80,132	18,156	4,667
2020	106,491	37,181	5,056
2021	227,730	123,626	5,331
2022	370,141	199,542	4,893

173) “DGUV-Statistiken für die Praxis 2022
(<https://publikationen.dguv.de/detail/index/sArticle/4767>)” S. 75 (2023. 10. 15. 최종확인).

III. 시사점

독일 직업병의 산재 신고 및 인정과 관련하여 특히 주목할 만한 특징은, ① 산재의 인정 절차는 산재보험조합이 주도하고, 산재보험조합에 의하여 판정된다는 점, ② 산재 신고와 관련하여 신고의무자가 산재의사라는 점이다.¹⁷⁴⁾ 전자는 한국과 독일 간에 「산재보험제도의 체계」 상 차이점을 분명하게 드러내고, 후자는 특히 직업병(업무상 질병)의 인정 절차에서 관여하게 되는 의사의 역할에서 명확한 차이점을 보여준다고 하겠다.

1. 독일 재해보험 운영의 기본원칙과 시사점

(1) 독일 재해보험 운영의 기본원칙

1) 직종별 산재보험조합 운영방식

독일의 재해보험제도는 각 직종별 산재보험조합이 자치운영의 원칙에 따라서 분산되어 운영되고 있고, 각각의 개별 조합들은 직종별 관할영역이 엄격하게 구분된다.

① 장점

첫째, 직종별 분리운영방식은 직종별로 고유하게 발생할 수 있는 피해현상에 대하여 가장 적합하고 전문적인 급여나 서비스를 제공할 수 있다. 또한 소속 집단별로 특수한 복지 욕구를 적절하게 반영해 줄 수 있다.

둘째, 직종별 분리운영방식은 개별 조합 구성원 상호 간의 동질성을 유지하여 조직의 연대성이 비교적 긴밀하게 유지될 수 있도록 한다. 즉 구성원 공동의 관심사를 해결하기 위해 필요로 하는 비용의 부담과 관련하여 합의를 용이하게 도출할 수 있고, 동시에 혜택의 배분에 있어서 갈등을 최소한의 수준에서 억제할 수 있다.

셋째, 직종별 분리운영방식은 행정적 측면에서 제도운영의 유연성과 민주성을 유

174) 나아가 당사자가 산재보험조합의 판정에 불복하는 경우 구제절차는 산재보험조합의 이의심사위원회 및 사회법원에서 다루어진다. 우리와 비교할 때 절차 단계가 ‘한 단계’ 간소화되어 있다는 특징을 가진다.

지할 수 있다.

② 단점

첫째, 다양한 조합의 운영으로 인하여 국가 전체적으로 보면 행정관리비용이 과도하게 발생하는 측면이 있다.

둘째, 동일한 위험에도 불구하고 종종 직종별 산재조합별로 보험료의 수준이 차이를 보이게 되어 형평성의 문제를 야기할 수 있고, 다른 한편으로는 제도 자체가 다소 복잡하게 보일 수 있어서 불편함을 초래할 수 있다.

셋째, 공동체의 규모가 협소하여 사회보험제도로써 재해보험제도의 위험분산 기능과 분배적 기능이 제한을 받게 될 수 있다.

2) 자치운영(Selbstverwaltung) 방식

독일 재해보험제도의 자치운영은 근로자와 사용자를 대표하는 대의원들이 각자의 판단과 책임을 바탕으로 자율적으로 제도를 운영하고, 국가는 법률에 근거하여 총괄적인 감독권을 행사하는 방식을 채택해 오고 있다. 여기서 조합별로 자치운영의 대상이 되는 의결사안으로는 법정급여를 제외한 임의급여 또는 부가급여의 내용과 수준, 보험료의 조정 및 재정운용, 관리인력의 채용, 행정관리조직의 구성, 각종 위원회의 운영방식 등이 있다.

독일 재해보험제도의 자치운영은 다음과 같은 기본정신을 바탕으로 하고 있다 (Blüm, 1993). 첫째, 분산운영의 원칙으로서 재해보험제도는 다수의 조합에 의해 운영되고 있다. 이러한 분산운영방식이 가입자간 동질성 확보를 통한 연대의식 제고, 소속 집단의 특수수요를 제도에 반영, 가입자의 제도 접근성 제고 등의 측면에서 장점을 가진다는 것은 앞서 언급한 바와 같다.

둘째, 참여민주주의의 원칙이다. 개별 조합의 경영과 의사결정에 가입자 및 사용자 대표를 참여하도록 함으로써 가입자의 욕구가 최대한 제도에 반영될 수 있는 제도적 여건이 구축되어 있다.

셋째, 권력분산의 원칙이다. 조합운영과 재정운용에 있어서 독립성을 확보함으로써 관료화 문제와 정부의 정치 자의적 개입이 최소화될 수 있도록 하고 있다.

넷째, 다원주의의 원칙이다. 여러 사회집단(노동조합, 가입자단체, 사용자단체 등)에게 제도참여의 기회를 제공함으로써 사회의 다양한 욕구가 제도에 반영될 수 있도록 하고, 아울러 내부적 이해조정 절차를 통하여 갈등의 요인이 사전에 해결될 수 있도록 한다.

다른 한편, 자치운영방식은 외견상 관리운영기구의 다양성으로 인하여 낭비적 요인으로 작용할 수 있다는 지적이 가능할 것이다. 그러나 이는 실질적인 의미에서 행정관리비용의 통제기능을 수행하고 있다. 일반적으로 재해보험 행정기구의 경우 다른 일반기관과 마찬가지로 조직을 확대하려는 욕구를 가지고 있지만, 이를 적절하게 통제할 수 있는 정부의 물리적 감독기능에는 상당한 한계가 있게 마련이다. 이러한 측면에서 자치운영기구는 행정조직의 확대본능에 대하여 견제와 자동조절기능을 담당할 수 있다.

독일 재해보험조합의 경영에 대한 중요한 의사결정은 가입자와 사용자의 대표로 구성된 자치기구에서 수행해 오고 있다. 이러한 자치기구는 인적 구성의 특성상 가입자와 사용자의 비용부담 최소화과 수혜자의 욕구충족 극대화라는 이중적 목표를 추구하게 되어, 재해보험조합의 조직규모를 적절하게 조절하고 감독하는 기능을 수행할 수 있다.¹⁷⁵⁾

(2) 시사점

독일 재해보험제도의 체계나 운영방식은 우리와 분명한 차이를 보이고, 그에 따라 직업병(업무상 질병)의 인정 절차가 우리와 상이하게 됨은 당연할 귀결이라고도 여겨진다. 그럼에도 일반론 혹은 기술적 관점에서 보자면, 다음과 같은 점에서 우리에게 시사하는 바가 없지 않다.

① 현행 우리의 권리구제절차는 원처분(근로복지공단 지사·지역본부 담당) → 원처분에 대한 이의제기(산업재해보상보험심사위원회) → 심사처분에 대한 이의제기

175) 독일 재해보험의 기본원칙에 관하여

<https://mm.inje.ac.kr/app/board/attach/viewer.do?boardNo=178&articleNo=9987&attachNo=7861>, 24면 이하. (2023. 9. 14. 최종확인).

(산업재해보상보험재심사위원회) → 재심사처분에 대한 이의제기(법원소송)로 이루어진다.

그러므로, 첫째, 원처분의 전문성을 보다 강화하는 방향으로 발전시켜 그 정당성을 제고함으로써 이에 대한 이의제기 가능성을 낮추거나,¹⁷⁶⁾ 둘째, 이의제기가 있더라도 '원처분에 대한 이의제기 및 심사처분에 대한 이의제기'의 절차적 단계를 축소할 수 있는 방향으로 절차가 수정될 수 있을 것이다.

② 독일과 단계적으로 비교해 보면, 독일 산재보험조합이 직업병 판정까지 수행하는 과정은, 우리의 근로복지공단 지사·지역본부의 '원처분'에 해당한다. 이후 당사자가 산재보험조합의 판정에 불복하는 경우 이의제기를 통해 이루어지는 산재보험조합 내 이의심사위원회의 검토단계는, 그에 대해 불복하는 경우 다음 단계는 사회법원에서 다투게 되므로, 우리의 산업재해보상보험 '심사위원회 및 재심사위원회'에 해당하는 것으로 이해된다. 재심사처분에 이의제기를 하는 경우 법원에서 다투게 된다는 점은 우리와 독일이 동일하다.¹⁷⁷⁾

요컨대 절차적 단계를 고려할 때 산재인정절차를 단축하기 위해서는, ① 원처분에 대한 이의제기 가능성을 낮추는 방향으로 원처분이 이루어져야 한다는 점, ② 심사위원회와 재심사위원회 단계를 '하나의 단계'로 축소할 필요가 있다는 점, ③ 이를 위해서는 (일반론적 관점에서) 심사의 전문성 강화와 당사자의 참여 기회를 보다 더 확보할 필요가 있다는 점이 도출될 수 있을 것이다.

2. 독일 「산재의사의 신고의무」와 시사점

(1) 독일 산재의사 신고의무

독일에서 운영되고 있는 산재의사의 산재의심 신고의무는 당연히 산재의사제도의 수립을 전제로 한다. 독일의 산재의사는 피재근로자가 내원하여 초진하는 경우, 산

176) 이러한 고려가 오늘날 우리의 심사전문성이 독일에 비해 뒤떨어진다는 점을 보여주는 것이 아님은 물론이다.

177) 통계에 따르면, 독일 전체 산재소송 가운데 직업병 관련 소송이 대략 50%를 차지하고, 산재보험조합 및 그 이의심사위원회의 판정에 불복하여 사회법원에서 소송으로 다투더라도 분쟁의 80%는 지방사회법원에서, 나머지 20%는 주(州) 법원에서 소송이 종료되며, 연방사회법원에 상고하는 경우는 좀처럼 발견되지 않고, 소송으로 가는 경우라도 대략 선고의 90%가 산재보험조합의 승소로 마무리된다고 한다.

재 여부 및 요양방법 등을 판단하여 산재보험조합(BG)에 신고(보고)한다. 그리고 산재보험조합은 이에 대해서 직권으로 판정하여 산재의사가 피재근로자의 전문적 요양과 재활을 진행하도록 한다.

따라서 피재근로자의 산재 여부, 다시 말해서 산재보험을 통해서 피재근로자가 요양과 재활을 받을 수 있는지는 기본적으로 산재의사가 작성하는 산재의사보고서에 기초하여 산재보험조합이 '직권'으로 판정하고, 피재근로자의 요양과 재활의 모든 과정이 산재보험의 재원으로 진행된다. 물론 직업병 인정 여부에 대한 최종판단은 종국적으로 산재보험조합의 담당직원이 하게 되므로, 산재의사가 산재의심 신고를 했다 하더라도 산재보험조합의 판단이 이에 구속되는 것이 아님은 앞서 언급한 바와 같다. 이로써 피재근로자의 요양 및 재활과정이 피재근로자의 번거로운 신청절차 없이도 산재의사의 초진에 근거하여 자동적으로 진행될 수 있게 된다.

(2) 시사점

독일의 '산재의사제도'나 '산재의사 신고의무'는 '산재절차의 신속성과 편의성' 또는 '피재근로자의 신속하고 효과적인 요양과 재활'이라는 측면에서 우리에게 시사하는 바가 적지 않다고 여겨진다. 특히 독일의 산재의사제도는 피재근로자에 대한 「신속·정확한 진단」을 바탕으로 전문적인 요양과 재활을 위하여 노사합의를 바탕으로 만들어진 제도이라는 점에서 더욱 그러하다.

그러나 현재의 시점에서 산재의사제도를 우리 법제에 단기간에 도입하는 것에는 보다 신중한 검토가 요구된다 할 것이다. 왜냐하면, ① 우리의 산재보험제도 체계와 독일의 산재보험제도 체계가 분명한 차이를 보이고, ② 따라서 산업안전을 위해 필요한 노사합의나 건강보험을 비롯한 각종 사회보험체계 등 산재처리와 관련한 각종 제도의 조화롭고 적절한 정비가 필수적으로 요구되기 때문이다.

그럼에도 산재의사의 산재신고를 통해서 달성되는 목적, 즉 '산재절차의 신속성과 편의성 제고' 또는 '피재근로자의 신속하고 효과적인 요양과 재활'을 고려하면, 신고의무 자체는 「적용 가능한 일정한 방식과 절차」를 통해서 현재의 우리 제도에 수용될 수는 있다고 생각된다. 이에 관해서는 「보고서 제4장」에서 구체적으로 검토한다.

제2절 영국

I. 산재보험제도 일반¹⁷⁸⁾

1. 특징

영국은 산업혁명의 근원지로서, 산업사회에서 발생하는 산업재해에 대한 법적 구제방법에 대해 일찍부터 고민해온 국가이다. 당시 여러 국가와 마찬가지로 영국에서도 근로자의 업무상 상해에 대해 사업주에게 손해배상을 청구하는 방식이 주를 이루었다. 그러나 사업주의 배상 능력의 한계와 산업재해에 대한 입증책임이 근로자에게 과도하다는 문제로 무과실 책임주의에 따르는 산재보험제도를 마련하기 시작했다.

이에 영국은 1880년 사업주책임법(Employer's Liability Act of 1880)에서 1897년 노동자보상법(Workmen's Compensation Act 1897)으로 산업재해가 발생하면 근로자에 대해 산업재해와 업무관련성을 입증하도록 하고 사업주가 이에 대해 보상하도록 규정하였다. 당시에 산재가 빈번히 발생하던 탄광 산업에 있어서 진폐증, 면폐증 및 합병 질환 급여제도(Pneumoconiosis, Byssinosis and Miscellaneous Diseases Benefit Scheme)를 마련하여 보상금의 하한을 마련하여 산업별로 보상체계를 마련하기도 하였다.

그리고 1911년 국민보험법(National Insurance Act 1911)을 제정하면서 사회적 위험의 유형과 관계없이 소득보장관련 모든 사회보험을 단일제도로서 운영하도록 하여 산재보험제도를 국민보험으로 포섭하였다. 1946년 국민보험법(National Insurance Act 1946)에서 정액기여-정액급여 방식의 사회보험을 수립하였고, 산재보험제도는 1946년, 1965년, 1967년 몇 차례의 개정을 거친 뒤 1973년 사회보장법(Social Security Act 1973)에서 국민보험과 산재보험을 단일화하여 현재까지 운영하고 있다.¹⁷⁹⁾

위와 같이 영국은 공적 산재제도를 운영하면서 별도로 사적 사용자 책임보험을 의무병행하여 운영하도록 하는데, 이로써 노동자가 소사용자의 과실 여부를 따져 임금손실분이나, 의료비, 정신적 보상, 장래발생예상손실 등의 재정적 손해를 청구할

178) 영국 정부의 산업재해장해급여 가이드라인(Industrial Injuries Disablement Benefits: technical guidance, 2023.7.11.)을 토대로 작성하였으며, 관련 규정과 그 밖의 참고문헌은 각주로 인용하였음.

179) 김근주(2016), 영국 산업재해보상제도의 보호범위, 한양법학 제27권 제2호, 한양법학회, 44-47면.

수 있다.¹⁸⁰⁾

2. 체계

영국은 사회보험을 통합운영하고 있으므로 산재 제도만을 전담하는 기관은 없다. 다만, 산재장해급여에 대한 감독과 운영은 고용연금부 (Department for Work and Pensions), 치료와 재활에 대한 감독과 운영은 보건사회복지부(Department of Health and Social Care)의 국민보건서비스(National Health Service)에서 담당한다.¹⁸¹⁾

영국은 국민보험으로 산업재해보상제도를 편입하여 비기여 급여로서 운영하는 복지국가 중 하나이다. 영국의 산재보상제도는 업무상 사고(accidents)에 따른 장애(disablement) 또는 특정 직업상 위험으로 규명된 70여 가지의 업무상 질병(diseases) 중 하나로 인한 장애에 대한 무과실 급여를 제공한다.

이 제도는 직업훈련제도 또는 그 과정에 참여한 자들을 대상으로 한다. 이 제도에 따라 지급되는 급여를 산업재해제도급여(Industrial Injuries Scheme Benefits, IISB)라고 한다. 산업재해제도급여에는 산업재해장해급여, (상시/정률)간병수당, 특별중증장애수당, 소득(감소)수당, 퇴직수당이 있다.

산업재해급여는 사고 또는 업무상 질병에 해당하는 자가 취업상태에 있거나, 직업훈련제도 또는 과정에 참여하고 있는 사람들에게 지급된다(Legislation (1) - SS C&B Act 1992 sec 2(1)(a)). 자영업 또는 HM군의 복무로 인하여 발생하는 사고 또는 질병은 이 제도에 포함하지 않는다(Legislation (3) - SS C&B Act 1992 sec 115).¹⁸²⁾

그 밖에 영국은 국민들이 업무 외 질병에 대한 소득보장을 위하여 1946년 국민보험법 제정시 사회보험 방식의 상병급여를 도입하였는데,¹⁸³⁾ 현행 상병급여제도는 미취업자, 근로자, 자영업자 등이 아픈 경우 수급 요건에 따라 법정상병급여(Statutory Sick Pay (SSP))와 고용지원수당(Employment and Support Allowance (ESA))을 지급하고 있다. 법정상병급여는 근로자가 아픈 경우에 사용자가 의무적으로 제공해야 하는 1차적 제공이 이루어지고 이에 대하여는 영국 국세청 HMRC(HM Revenue and Customs)의 관리가 이루어진다. 고용지원수당은 법정상병급여의 수급

180) 한희지(2020), 영국의 산재제도 개요, 근로복지연구원, 4면.

181) 한희지(2020), 영국의 산재제도 개요, 근로복지연구원, 6면.

182) 산재사망급여를 제외한 모든 산업재해장해급여는 면세이다.

183) 김종수(2016), 상병급여제도에 관한 소고, 사회보장법 연구 제5권 제1호, 서울대학교 사회보장법연구회, 1·7면.

요건에 충족하지 못하거나 수급 기한의 만료 이후에 신청할 수 있고(신규 및 반복 신청자 대상)¹⁸⁴⁾, 영국 노동연금부 DWP(Department for Work and Pensions)를 통해 받게 된다.¹⁸⁵⁾

II. 업무상 질병의 처리

1. 개관

(1) 산업재해장해급여의 수급자격

영국의 산재보험 제도에서 산업재해장해급여와 상병급여는 핵심적 급여이다.¹⁸⁶⁾ 특히 산업재해장해급여는 업무상 사고 또는 업무상 질병으로 인해 장애를 입은 사람, 승인된 직업훈련제도 또는 과정에 있는 동안 장애가 발생한 사람들에게 지급하는 주간급여(a weekly benefit)이다. 수급자의 자격 요건은 취업자(employed earners) 또는 취업자로 간주할 수 있는 사람에 대하여만 적용한다. 그 밖에 승인된 직업훈련제도 및 과정에 있는 자에게 사고나 사건이 발생한 경우에도 적용한다 (Legislation (8) - SS C&B Act 1992 sec 94 -accidents) (Legislation (9) - SS C&B Act 1992 sec 108 -prescribed diseases). 여기서 취업자는 고용계약에 따라 영국 내에서 유급으로 고용된 자이거나 임원을 포함한다(Legislation (10) - SS C&B Act 1992 sec 2(1)(a)). 그 밖에 취업자가 아닌 일부 사람들은 급여를 수급받을 수 있는데, 임시 경찰관, 파견직원, 자영업으로 소득에 있어 1종 국민보험 기여금의 책임이 있는 파견직원(agency staff)Legislation (11) - SS (Employed Earners Employment for Industrial Injuries Purposes) Regs 1975 Sched 1 Part 1 & Sched 3), 사고 및 사건 당시 직업훈련제도 또는 과정에 있는 자를 포함한다.

(2) 산업재해장해급여의 신청

① 취업자 또는 직업훈련제도 및 그 과정에 있는 자가 일하는 동안 질병이 발병했다고 생각되면 즉시 산업재해장해급여를 청구할 수 있다. 사고가 발생한 경우에

184) 박찬임(2021), 복지체제와 취업자 소득지원 정책, 한국노동연구원, 72면.

185) 김기태·이승윤(2018), 한국 공적 상병수당 도입을 위한 제도 비교연구 및 정책제언, 사회복지정책 제45권 제1호, 한국사회복지정책학회, 14면.

186) 김근주(2016), 영국 산업재해보상제도의 보호범위, 한양법학 제27권 제2호, 한양법학회, 61면.

는, 사고가 발생하고 2개월 후에 신청해야 한다. 이는 사고 후 첫 15주(일요일 제외 90일) 동안에는 급여를 받을 수 없고 이 기간이 지난 후에 정상적인 의학 검사를 수행할 수 있기 때문이다.

② 급여 신청과 관련된 의학적 증거, 사고 보고서의 사본이 있는 경우 신청 양식과 함께 보내되, 새로운 보고서를 받고자 청구를 미루어서는 안된다.

③ 이하의 경우에 대하여 산업재해장해급여를 지급하지 않기 때문에, 급여를 온전히 받기 위하여는 신청을 미루어서는 안된다.

- 급여 신청 이전 3개월 이상 동안(Legislation (17) - SS (C&P) Regs 1987 reg 19(1) & Sched 4)

- 기타 사고 또는 질병으로 산업재해장해급여를 받는 경우 청구일로부터 1개월 이전(Legislation (18) - SS&CS (D&A) Regs 1999 reg 7(2))

- 직업성 난청에 대한 신청에는 다른 규칙이 적용된다. 신청일 이전 동안에는 급여를 받을 수 없다.

④ 신청일자란 작성이 완료된 신청양식이 DWP(노동부, Department for Work and Pensions)사무소에 접수된 일자이다. 양식의 모든 세부 사항을 주의깊게 작성하고 가능한 빨리 제출하는 것이 매우 중요하다(Legislation (19) - SS (C&P) Regs 1987 reg 6).

(3) 급여의 규모

급여의 규모는 수급자의 장애 수준에 따라 다르다. 장애의 정도는 의학적 견해나 평가는 질병으로 인한 모든 장애를 고려한다. 당사자의 장애 또는 당사자가 질병에 걸리기 전에 발생한 다른 원인으로 인해 발생하는 경우, 어떤 경우에도 다른 원인으로 인해 존재할 수 있는 장애의 정도는 계산되지 않지만 두 가지 원인 간의 상호작용은 평가에 포함된다.

당사자의 장애가 영구적으로 평가되고 변경되지 않을 경우 평생 장애에 대한 '최종'평가를 받을 수 있다. 또는 완전히 회복될 가능성이 있는 경우 평가가 최종적이지만 제한된 기간 동안일 수 있다. 또는 제한된 기간 동안 잠정적 평가를 받을 수 있으며, 이 기간이 끝나면 재검토 및 장애 평가를 다시 받게 된다(Legislation (61) - SS C&B Act 1992 Sched 6(2)).

이러한 장애의 수준은 의학자문의(medical advisor)가 1-100%의 범위에서 평가한다. 신청자의 장애 수준이 14%이상인 경우 주간 연금(a weekly pension)으로 지급된다(Legislation (65) - SS C&B Act 1992 sec 103(2), SS (C&P) Regs 1987 reg 22). 산업재해장애급여는 최초 15주(일요일을 제외한 90일) 동안은 지급되지 않는다(Legislation (36) - SS C&B Act 1992 sec 103(6)).

2023년과 2024년에는 장애 수준 100%에 해당하는 수급자는 주당 최대 £207.60를 받는 것으로 책정되었다.¹⁸⁷⁾ 장애가 14% 미만으로 평가되는 경우 일반적으로 급여가 지급되지 않는다.

[표 3-8] 영국 산업재해장애급여의 장애 수준별 주당 급여(2023-2024)

장애 수준(%)	주당 급여
100	£207.60
90	£186.84
80	£166.08
70	£145.32
60	£124.56
50	£103.80
40	£83.04
30	£62.28
20	£41.52

자료 : Department for Work & Pensions, Benefit and Pension Rates-Industrial Injuries Disablement Benefit,

법정상병급여(SSP)는 주당 £109.4의 법정상병급여를 지급하고 급여는 최대 28주 동안 사용자가 지불한다. 급여는 병가를 낸 4일째부터 법정상병급여를 받을 수 있다.¹⁸⁸⁾

187) House of Commons Library(2023), Industrial Injuries Benefit Constituency casework, Published Thursday, 25 May, 2023

188) 영국 정부 홈페이지(www.gov.uk), Statutory Sick Pay (SSP)

2. 업무상 질병 인정 절차

(1) 업무상 질병의 명칭

영국은 산업재해장해급여를 수급받을 수 있는 업무상 질병의 명칭을 법률에서 명시하고 있다(Legislation (43) - SS C&B Act 1992 sec 108(1)). 질병이나 상해는 모든 사람에게 공통적인 위험이 아닌, 개인의 직업에서 발생하는 위험에 대하여 규정한다. 사회보장규정(1985)에서 명시하는 업무상 질병은 원인에 따라 4개의 유형으로 구분한다. A 물리적 원인, B 생물학적 원인, C 화학적 원인, D 기타 원인으로 구분하고 총 질병은 70가지 이상이다(Legislation (44) - SS (II) (PD) Regs 1985 Sched 1).

[표 3-9] 영국 업무상 질병의 주요 질병 명칭

- 천식(asthma)
- 만성 기관지염 또는 폐기종(만성 폐쇄성 폐질환(COPD))
- 난청(deafness)
- 진폐증(pneumoconiosis, 규폐증 및 석면폐증 포함)
- 광산근로자의 무릎 골관절염(osteoarthritis of the knee)
- 업무상 질병 A11((previously known as vibration white finger, 진동 백지)
- 듀피트렌구축(Dupuytren's contracture; 섬유증)
- 진폐증(pneumoconiosis, 석면폐증(asbestosis))
- 미만성 중피종(diffuse mesothelioma)
- 석면폐증을 동반한 폐의 원발성 암종(primary carcinoma of the lung)
- 석면폐는 없지만 특정 업무에서 석면에 광범위한 노출이 있는 폐의 원발성 암종
- 일측 또는 양측 흉막 흉막 비후(pleural thickening)

자료 : 영국 정부 홈페이지(www.gov.uk), Industrial Injuries Disablement Benefit 참조.

업무상 질병으로 명시하고 있는 질병의 명칭에 대하여는 영국의 산업재해자문위원회(The Industrial Injuries Advisory Council (IIAC))에서 국무장관에게 권고하는 형식을 취한다(Legislation (45) - SS C&B Act 1992 sec 108(2)). 산업재해자문위원회는 해당 질병이 직업상 위험하다고 판단되는 경우에만 해당 질병을 질병 목록으로 추가할 것을 권고한다.

산업재해급여를 신청하는 업무상 질병이 관련 규정에 해당하지 않거나, 특정 질병에 대한 신청자의 직업병 명칭이 매칭되지 않는 경우, 급여를 받지 못할 수 있다.

다만, 사고성 질병은 산업재해규정(the industrial accident provisions)에 따라 급여를 받을 수 있다. 그러나 당사자가 특정 질병에 대한 급여를 받을 자격 요건에 해당하지 않는다고 하여 반드시 당사자가 청구한 질병에 걸리지 않는다는 의미는 아니다. 당사자는 해당질병에 대한 급여를 받기 위하여 법에 명시된 기준을 충족하지 못한다는 의미일 뿐이다. 예를 들어, 광산근로자는 기왕증이 있는 경우 만성폐쇄성 폐질환(chronic obstructive pulmonary disease-COPD)에 대한 급여가 거부될 수 있다. 다만, 실제 근로 이력이 규정에 명시된 직업 기준에 충족하면 급여를 받을 수 있다. 일부 근로자는 어떠한 일을 수행하든지 질병에 걸릴 수 있다. 따라서 일반의 영역에서 일반적으로 나타나는 질병도 중요한 부분이다.¹⁸⁹⁾

(2) 신청자의 주요 증명 내용

업무상 질병에 대한 급여를 청구하는 신청자는 <업무상 질병에 대한 산업재해장해급여청구서>¹⁹⁰⁾에서 업무와 질병에 대한 사항을 기재하여 제출해야 한다. 특히 “PART4. 직무, 직업훈련제도, 질병” 부분에서는 이하의 사항에 대한 기재를 요구한다.

- ① 신청 질병의 업무상 질병 번호는?
- ② 신청 질병이 신청자의 직업 및 근로 기록과 관련이 있는가? 신청자의 업무가 질병을 유발할 수 있는가?
- ③ 신청 질병으로 신청자가 고통스러운가? 또는 신청 질병으로 고통받은 적이 있는가?
- ④ 신청 질병이 취업의 특성 또는 직업훈련제도의 특성으로 인한 것인가?
- ⑤ 신청 질병의 발병 날짜는?¹⁹¹⁾
- ⑥ 신청 질병으로 인하여 관련된 기능을 상실하였는가?

189) 정슬기(2022), 영국의 산재보상제도와 합리성 판단기준, 사회법연구 제48호, 한국사회법학회, 291면.

190) Department for Work and Pensions(2023), Diseases: Industrial Injuries Disablement Benefit interactive claim form, Last updated : 30 June 2023

191) 질병의 발병 날짜는 질병으로 인해 처음으로 신체의 능력을 상실한 날짜이다. 개시일은 급여가 실제로 지급되는 날짜보다 빠를 수 있다. 이는 급여가 지급되는 날짜가 청구 기한 및 기타 기준에 따라 결정되기 때문이다(Legislation (59) - SS (II) (PD) Regs 1985 reg 6(2)(b)).

[그림 3-4] 업무상 질병에 대한 산업재해장해급여청구서 예시

Part 4: About your work or your approved employment training scheme or course and your disease Tell us which disease you have and about the job or training you were doing which you think caused your disease. Give as much information as you can. You can get a list of prescribed diseases and jobs you can claim Industrial Injuries Disablement Benefit for from our website at www.gov.uk If you cannot access the list of diseases online or you are not sure which disease you should claim for, contact us for help by calling 0800 121 8379.		
31 Which disease do you have? 	34 What type of work or training do you think caused your disease? 	35 In what way has the disease affected you?
32 Please state the prescribed disease number if you know it 		
33 On what date do you think you started to suffer from the disease? If you are not sure of the date, give an approximate date DD/MM/YYYY 		
Please tell us about all the employers or training providers you did this type of work for. Start with the most recent employer or training provider. If you need to tell us about more than 2 employers or training providers, tell us about them in Part 9 .		

국민의 상해에 대해서는 국민보험의 방식으로 보장하고 있기 때문에 급여의 신청자는 신청 시 해당 급여 신청 자격만 갖추 것을 요구한다. 즉 업무와 질병 사이의 인과관계를 엄격하게 입증해야 하는 것이 아닌 신청하는 방식으로 이루어진다. 다만 산업재해장해급여를 신청하는 자가 취업자로서 고용이 인정되지 않는 경우에 한하여 급여 청구가 허용되지 않는다. 자격 요건과 관련하여 이의를 제기하고자 하면 당사자의 서류가 국세청(the Inland Revenue)으로 이송된다.

3. 업무상 질병 처리 절차

① 신청서의 접수

신청자는 업무상 질병으로 생각한 날짜 또는 그 이후에 언제든지 신청할 수 있다. 신청 질병에 대한 의학적 증거를 신청 양식과 함께 보내야 하며, 신청을 미뤄서는 안 된다. 그 이유는 신청일로부터 3개월 이상의 기간 이후, 기지급받은 산업재해장해급여가 있는 경우 신청일로 1개월 이상 지난 후부터 급여를 지급받을 수 있기 때문이다.

신청자는 산업재해장해급여센터에서 신청 양식을 받거나, 산업재해장해급여지침에서 양식을 받아 신청서를 작성해야 한다. 그리고 신청 날짜는 DWP에 접수한 날짜

이다.

② 서면확인서 수령

신청 양식이 접수되었다는 서면 확인서를 받게 된다.

③ 관련자에 대한 사실확인

행정기관은 다음의 사항을 확인하기 위하여 고용주/훈련계획제공자에게 연락할 수 있다.

- 취업기간
- 신청자가 취업기간 중에 있었다거나, 고용훈련제도 또는 과정에 있다는 것
- 공식적인 도구(tools)를 사용했거나, 질병과 관련된 업무를 수행했다는 사실

④ 건강검진

신청자의 서류는 의료서비스에 참조될 것이며 신청자는 건강검진의 참여를 요청 받을 수 있다(Legislation (52) - SS Act 1998 sec 19(1)). 다만 건강검진을 받고 정당한 이유없이 출석하지 않으면 신청은 불허된다(Legislation (53) - SS Act 1998 sec 19(3)).

건강검진은 산업재해에 대한 특별한 과정을 이수한 경력직 의사(experienced medical practitioners) 1인 또는 2인이 실시한다. 건강검진은 비공개로 진행되지만, 만약 의사가 허락하는 경우에 대하여는 누군가와 동행할 수 있다. 또한 신청자의 장애에 대한 의견을 제시하는 데 도움이 된다고 생각되면, 청구 양식에 포함되지 않은 모든 증거를 의사에게 제시할 수 있다. 이전 산업재해로 인해 병원에 다녔다면 의사가 병원에 추가 정보를 요청할 수 있다. 의사는 병원 기록(Hospital case notes)을 추가적으로 요청하거나 신청자의 GP(지역보건의)¹⁹²⁾에게 기록 및 소견을 요청할 수 있다.

건강검진에서 의사는 신청자가 업무상 질병으로 고통받고 있는 여부, 질병으로 신체능력상실(Loss of faculty)¹⁹³⁾ 여부, 장애 수준(Degree of disablement) 및 예상되

192) general practitioner: 병원이 아닌 지역 담당 의료 기관에서 일반적인 진료를 하는 의사(옥스퍼드 영한사전)

193) 신체적 정신적 능력의 상실이란 신체 기관의 힘이나 기능의 일부 상실을 의미한다. 신체장애를 일으키지 않는 경우에도 능력 상실에는 손상(disfigurement)이 포함될 수 있다. 신체능력의 상실이 장애로 이어지는지 여부는 질병으로 인한 당사자의 상태를 동일한 연령 및 성별의 정상적인 건강한 사람의 상태와 비교하여 결정한다(Legislation (58) - Commissioners Decisions R(I)7/67 and R(I)1/81).

는 지속시간에 대한 소견을 작성하여 사무처에 제출한다. 특히 의사는 해당 질병이 취업자의 업무 특성으로 인한 것인지에 대하여 소견을 제시한다.

⑤ 수급여부의 결정

검강검진 결과에 대하여 당국의 담당 공무원¹⁹⁴⁾은 의사의 견해와 증거를 검토하여 신청에 대한 지급 결정, 급여의 규모, 급여수급시기에 대하여 신청자에게 서면으로 알려준다.

수급여부에 대한 결정은 당사자의 신체적, 정신적 상태만을 고려한다. 기본 산업재해장해급여는 당사자의 직업의 유형이나 소득손실의 영향을 받지 않는다. 당사자가 업무에 복귀했는지 여부와 상관없이 지급될 수 있으며 소득에 따라 달라지지 않는다.

⑥ 패스트 트랙 사례(Fast track cases)

산업재해장해급여는 업무상 질병 B에 해당하는 모든 석면 관련 질병 및 업무상 질병 D3, D8, D9, D10 및 D11 등을 포함하여 말기 암을 포함하는 청구에 대해서 패스트 트랙 사례로 처리한다. 관련 법률이나 가이드라인에서는 패스트 트랙에 해당하는 질병의 범위가 확정하고 있는 것은 아니다. 다만 신청자의 질병이 심각한 직업병에 해당하거나, 앞으로 생존기간이 길지 않은 경우에 적용하고 있어 패스트 트랙이 적용되었던 대상 질병의 범위가 실무상으로 점차 확대되는 것으로 해석할 수 있다.

패스트 트랙 사례는 일반적으로 심각한 질병에 적용한다. 해당 질병에 대해서는 항상 우선적으로 진료를 받을 수 있도록 의료기관으로 보낸다. 신청자의 고용 문제를 확인하는 동안 신청절차를 신속하게 처리하기 위한 서비스이다.¹⁹⁵⁾

194) 담당 공무원(the officials are known as Decision Makers)은 의사 결정자로 불리는데, 국무장관이 의사결정 권한을 담당 공무원에게 위임하였다(Social Security Act 1998 sec1.2)

195) DWP(2003), A guide to Industrial Injuries Benefits, p.34.

[표 3-10] 영국 업무상 질병상 패스트 트랙 주요 질병 명칭

B. 생물학적 원인(Conditions due to biological agents) B1. 탄저병 B2. 점막 마비제 B3. 렙토스피라에 의한 감염 B4. 강직구증 B5. 결핵 B6. 외인성 알레르기성 폐포염(농민의 폐 포함) B7. 브루셀라 속의 유기체에 의한 감염 B8. 바이러스 성 간염 B9. 연쇄구균에 의한 감염 D. 그 밖의 조건(D. Miscellaneous Conditions) D3. 미만성 종피종(흉막, 심낭 또는 복막 종피의 원발성 신생물). D8. 다음 중 하나 또는 둘 다를 동반하는 증거가 있는 원발성 폐암종:- (a) 석면폐증; (b) 양측 미만성 흉막 비후. D9. 양측 미만성 흉막 비후.
--

자료 : The Social Security (Industrial Injuries) (Prescribed Diseases) Regulations 1985
SCHEDULE 1 PART I LIST OF PRESCRIBED DISEASES AND THE OCCUPATIONS FOR WHICH THEY ARE PRESCRIBED.

패스트 트랙에 해당하는 주요 업무상 질병에는 말기 암이 있다. 따라서 자동으로 가장 높은 100% 보상을 받는데, DWP에서는 이러한 수급자에 대해 대면 평가를 요구하지 않고 오직 서면을 통해서만 심사한다.

4. 이의신청과 조정

사실확인이 불인정되면 신청은 불허됨으로써 당국은 관련 결정 서면을 신청자에게 송부한다. 그리고 담당 공무원은 해당 결정의 내용과 불복시 항소권리에 대하여 알려준다. 산업재해장해급여에 대한 부지급결정에 불복하는 신청자는 재심사, 대체 결정, 항소제기 등을 청구할 수 있다.¹⁹⁶⁾

¹⁹⁶⁾ Department for Work & Pensions, NI260 - A guide to Revision, Supersession and Appeal-Decision makers, April 2009.

이의신청의 사유는 다음의 경우에 해당해야 한다. ① 신청자의 청구를 처리하는 기관의 실수가 있거나 중요한 증거를 놓쳤다고 생각하는 경우, ② 신청자가 결정 이유에 동의하지 않는 경우, ③ 신청자가 결과를 다시 검토받기를 원하는 경우가 그러하다. 다만 일부의 경우에는 재심을 받을 수 없는데, 재심을 받을 수 있는지 여부는 최초의 결정문 원본/에 명시되어 있다. 재심을 신청하는 자는 1개월 이내에 청구해야 한다.

먼저 의무 재심사(mandatory reconsideration; 또는 대체결정(Revision and supersession))이다. 담당 공무원이 해당 신청 사항을 재검토하고 지급 요건에 해당하는 경우에는 다시 항소할 필요 없이 신속하고 경제적으로 결정을 변경할 수 있는 간단한 절차이다. 재심사제도의 경우 1개월 이내에만 신청할 수 있다(Social Security Act 1998 sec 9). 대체결정의 경우 수정을 신청하지 않고 향후에 신청자가 결정에 불복한다고 생각되어 신청하는 절차이다. 불승인 결정 이후 신청자의 상황이 변경되더라도 결정은 대체된다(Social Security Act 1998 sec 10). 재심사(mandatory reconsideration) 청구시 재심사 청구 날짜, 신청자 정보, 국민보험번호 등을 기재하고 재심청구의 이유로서, 새로운 의학적 증거, 전문의 등의 의학적 보고서 및 치료 계획서, 은행명세서 또는 급여명세서 등을 함께 제출해야 한다. 재심사에 대한 심사가 이루어지면, 해당 기관에서는 재심사 결과에 대해 '필수 재심사 통지서(mandatory reconsideration notice)'를 송부한다. 해당 결정서에는 결정의 이유와 근거가 되는 증거를 설명하고 있다.

만약 재심사에 동의하지 않으면, 사회보장 및 자녀 양육비 재판소(First-tier Tribunal)에 항소할 수 있다. 최초 급여 결정서에 따라 필수 재심사가 필요한 경우와 즉시 항소를 할 수 있는 경우가 나뉘는데, 재심사의 신청과 같이 최초 결정 이후 1개월 또는 의무 재심사 통보 이후 1개월 이내에 항소해야 한다. 법원에서 항소를 심리하기까지는 다소 시간이 소요됨에 따라, 행정소송을 제기하는 경우 재심사 절차를 거치도록 한다.¹⁹⁷⁾

5. 현황

2019년 9월을 기준으로 산업장해급여 신규 신청의 대부분(81%)이 패스트 트랙이 아닌 신청인 것으로 나타났다. 또한, 최초로 산업재해장해급여 신청서를 작성하는 사람들은 최종 평가 결과에 관계없이 자신에게 장해 등의 상태에 있다고 인식하고

197) 한국보건사회연구원(2018), 영국의 사회보장제도, 295면 참조.

있었다.

건강검사 및 장해평가 결과, 2019년 기준 업무상 사고 중 대다수(57%)의 장해 비율이 1~19이고, 1% 정도의 장해 비율이 95~100인 것으로 나타났다. 이에 비해 2019년 업무상 질병의 33%에서는 장해 비율이 1~19이고, 47%에서는 장해 비율이 95~100인 것으로 나타났다. 즉 업무상 사고에 비해 업무상 질병으로 산업재해장해급여 신청자들의 장해율이 더 높은 것으로 평가하고 있다.¹⁹⁸⁾

영국 노동연금부(DWP)는 산업재해장해급여 분기별 통계에서 급여 지급과 관련된 통계 자료를 발표하고 있다. 업무상 질병과 관련된 주요 통계 내용은 다음과 같다.¹⁹⁹⁾

[표 3-11] 영국의 산업재해장해급여 청구 건수

연도	분기	업무상 질병	업무상 사고
2016	1분기(3월)	3,520	2,440
	2분기(6월)	3,320	2,280
	3분기(9월)	3,350	2,110
	4분기(12월)	2,980	1,820
2017	1분기	2,940	2,020
	2분기	2,940	1,860
	3분기	3,000	1,860
	4분기	2,880	1,540
2018	1분기	2,700	1,540
	2분기	2,560	1,370
	3분기	2,460	890
	4분기	1,680	680
2019	1분기	2,480	1,040
	2분기	2,280	980
	3분기	2,440	1,000
	4분기	2,440	930
2020	1분기	2,870	1,030
	2분기	1,240	400
	3분기	2,490	740

198) The Social Security (Industrial Injuries Benefit and Personal Independence Payment: Equality Impact Assessment-Results, 2021.2.23.(legislation.gov.uk)

199) 영국 정부 홈페이지(www.gov.uk), Industrial Injuries Disablement Benefit: quarterly statistics(www.gov.uk); 2022년 12월 마지막으로 업데이트 된 통계자료이다.

산업재해장해급여의 청구 건수는 업무상 질병이 업무상 사고보다 높게 나타난다. 업무상 사고 관련 청구 건수는 매년 감소하고 있지만, 업무상 질병 건수는 비슷한 비율을 유지하고 있다.

[표 3-12] 업무상 질병의 유형별 청구 건수

연도 분기	합계	관절 활막염 (A8)	직업 성 난청 (A10)	진동 백지 (A11)	손목 터널 증후 군 (A12)	무릎 의 골관 절염 (A14)	진폐 증 (D1)	미만 성 중피 증 (D3)	일측 또는 양측 미만 성 흉막 비후 (D9)	기관 지엽 및 폐기 증 (D12)	기타
2016년 1분기	3,520	20	330	460	160	410	660	580	230	200	500
2분기	3,320	30	280	410	210	350	650	540	230	160	450
3분기	3,350	20	240	370	200	350	670	600	230	190	490
4분기	2,980	20	220	330	140	310	560	580	220	170	440
2017년 1분기	2,940	20	240	380	150	290	560	530	190	180	400
2분기	2,940	20	230	360	160	300	530	580	210	170	400
3분기	3,000	20	200	360	200	290	640	500	250	170	370
4분기	2,880	10	190	320	160	260	580	580	230	190	370
2018년 1분기	2,700	30	190	290	120	220	540	560	230	170	360
2분기	2,560	20	150	270	130	210	560	510	220	180	320
3분기	2,460	10	120	170	90	150	560	710	230	160	260
4분기	1,680	10	100	170	100	140	360	350	130	100	220
2019년 1분기	2,480	20	170	250	100	170	560	530	220	170	290
2분기	2,280	20	150	210	110	180	460	500	170	140	330
3분기	2,440	20	160	200	120	190	520	540	200	170	330
4분기	2,440	20	140	190	120	180	450	540	200	170	420
2020년 1분기	2,870	20	150	230	110	180	430	560	190	120	880
2분기	1,240	10	60	80	30	50	190	440	100	70	220
3분기	2,490	20	90	220	90	180	560	510	220	160	450

업무상 질병의 대상 질병은 앞서 설명한 바와 같이, A 물리적 원인, B 생물학적 원인, C 화학적 원인, D 기타 원인으로 나뉘고 있는데 노동연금부에서 파악한 급여 청구가 많이 나타나는 질병들을 제시하고 있고 그 중에서 D유형 중 진폐증과 미만성 중피증에 대한 청구가 가장 높은 것으로 파악된다.

[표 3-13] 업무상 질병 승인 건수

연도	분기	청구 건수	승인 건수
2016	1분기	3,520	1,610
	2분기	3,320	1,580
	3분기	3,350	1,510
	4분기	2,980	1,450
2017	1분기	2,940	1,210
	2분기	2,940	1,260
	3분기	3,000	1,340
	4분기	2,880	1,400
2018	1분기	2,700	1,270
	2분기	2,560	1,300
	3분기	2,460	1,340
	4분기	1,680	1,320
2019	1분기	2,480	1,330
	2분기	2,280	1,200
	3분기	2,440	1,150
	4분기	2,440	1,190
2020	1분기	2,870	1,260
	2분기	1,240	540
	3분기	2,490	560

산업재해장해급여 청구 중 업무상 질병에 대한 청구 건수가 소폭 감소하면서 승인 건수가 다소 감소한 것으로 보인다. 2019년 코로나 사태로 업무상 질병의 청구 건수가 다소 감소한 것으로 파악되며 2020년 3분기 승인 건수가 상당히 낮은 점은 판단 자체를 가동하는 데 무리가 있어 승인 건수가 낮게 나왔다는 설명이다.

노동연금부에서 제시하고 있는 통계에 따르면 업무상 질병과 업무상 사고에 대한 급여 청구건수가 점차 감소하고 있는데, 산업 전체에 대한 산업재해의 감소에 따른 결과인지, 타 보험급여와의 연계로 취업자 등의 산업재해장해급여 청구 건수가 감소한 것인지에 대해서는 정확하게 파악하기는 어렵다. 또한 패스트트랙의 청구건수와 승인건수도 별도로 발표하고 있지 않다.

다만, 이상의 통계들을 통하여 업무상 사고보다는 업무상 질병에 대한 청구 건수가 많다는 점, A 물리적 원인에 의한 업무상 질병 건수가 점차 줄고 있으나 D 기타 원인에 의한 업무상 질병 건수는 상당히 유지가 되고 있다는 점, 패스트트랙의 업무상 질병 유형인 B 생물학적 원인에 대한 업무상 질병 청구 건수가 비교적 적다는

점 등을 파악할 수 있다.

III. 시사점

1. 기금의 운용

우리나라는 산재보험이 다른 사회기금과 분리되어 운영되고 있다. 따라서 산업재해로 인한 장애와 질병이 인정되지 않으면 다른 사회보험의 보상을 받는 것이 거의 불가능하다. 그러나 영국에서는 국민보험으로서 재해에 대한 보상을 통합하여 운영하고 있어 취업자가 산재보상을 받지 못하면 국민보험상의 일반장애급여 및 질병급여와 같은 다른 유사 급여를 신청 및 수급할 수 있고, 상황이나 시기에 따라 수급의 내용을 변경할 수 있어 소득보장의 대체 방식으로 활용이 가능하다.

특히, 영국의 산재보험이 국민보험에 통합되어 있는 만큼, 기여금에 관계없이 보상급여를 받을 수 있다는 점은 산업재해로 인한 장애를 사회적 보상의 대상으로 보고 있기 때문이며, 피해자의 고의 과실 여부와 관계없이 넓은 의미로서 '고용'과 관계가 있다면 산업재해로 인정하여 급여를 제공하는 것이 타당하다는 사회적 합의에 기인한다.²⁰⁰⁾ 이처럼 국민의 상해에 대해 산재보험과 상해보험이라는 형식으로 접근하면서 재해보상의 사각지대를 최소화하고 있기 때문에, 산재급여 관련 총예산이 큰 비중을 차지하고 있지는 않다. 다만 산재 지급 사유에 해당하는 질병에 대해서는 최근까지도 인정 범위를 확대하는 노력을 하고 있다(최근 항공 승무원이 악성흑색종에 걸린 경우에 대한 산재로 인정한 바 있음)²⁰¹⁾

우리나라의 산재보상제도는 '사용자 찾기'의 방식으로²⁰²⁾ 산재의 적용대상을 확정하는 방식이나, 산재보험급여를 받기 위해 근로자가 재해와 업무 사이의 상당인과 관계를 입증해야 하는 방식을 취하고 있다는 점에서 영국에 비해 급여 수급이 용이하다고는 볼 수 없다.

2. 지급 요건

영국은 업무상 질병에 대항하는 질병의 명칭을 명시하고 있지만, 진단명이 질병의

200) 김근주(2016), 영국 산업재해보상제도의 보호범위, 한양법학 제27권 제2호, 한양법학회, 49면.

201) 한희지(2020), 영국 산재제도 관련 최신 동향 : 지급현황 및 지급범위 현실화 노력, 근로복지공단, 11면.

202) 박찬임, 저소득 취약계층 재해보장을 위한 산재보험제도 개혁방안, 한국노동연구원, 2022

명칭에 부합하지 않는다고 하여 자격 요건이 없다고 보지 않는다. 명시되어 있는 질병 명칭 이외에 관련된 직무에 대해서도 제시하고 있기 때문이다. 그러나 우리나라의 경우 업무상 질병에 해당하는 질병 명칭만 명시하고 있으며, 질병을 야기하는 원인에 대해서는 조사지침 등을 통해 서술적으로 풀이하고 있다.

또한, 업무상 질병 신청 과정에서는 패스트 트랙제를 운영하고 있는데, 사망을 앞두고 있을 정도로 심각한 질병에 있는 산재급여 신청자에 대해서는 서류 심사만으로도 보상금을 지급받을 수 있도록 하고 있다.

우리나라 근골격계질환의 경우에는 적용대상 요건이 되면 현장조사를 생략하고 제출된 자료로만 업무상질병판정위원회의 심리를 받을 수 있다. 다만 상병명, 직종명, 근무기간, 유효기간이 모두 충족되어야 하고, 이러한 과정에서 의학자문이 긍정적인 결과로 나와야 한다.²⁰³⁾ 따라서 영국의 패스트 트랙제와는 비슷하다고 보기도 어려운 체계이다.

3. 재심사 제도

영국과 우리나라는 모두 업무상 질병에 대해 신청자가 소정의 내용을 기재하고 관련 서류를 동봉하여 신청하는 방식을 취하고 있으나, 신청 이후 행정청에서 요구하는 병원의 진료를 받는 과정에서 우리는 일반진찰 및 특별진찰, 전문의 및 주치의 등 여러 단계의 진찰과 의학자문을 요구하고 있다. 특히 이러한 과정은 재심사 과정에서 재반복될 수 있다.

영국은 산업재해장해급여의 부지급 결정이 나오면 신청자는 이에 대한 재심사를 의뢰할 수 있는데, 의무 재심사를 통하여 담당 공무원이 신청 사항의 내용을 재검토하고 지급결정으로 변경하고 있으므로 신청자는 별도의 소송을 제기하지 않고서도 빠른 재결을 받을 수 있다.

우리나라는 업무상질병판정위원회-산재심사위원회-산재재심사위원회-행정소송이라는 재심사 제도를 갖고 있는데 신청자는 업무상질병판정위원회의 부지급 결정에 대해 나머지 3개의 기관에 대해 이의를 신청할 수 있다. 그러나 이는 새로운 심사 절차를 거쳐야 하기 때문에 영국에 비해 절차상 또는 심리상의 흠결에 대해서 빠른 결정을 받을 수 있는 구조라고 볼 수는 없다.

203) 근로복지공단, 발생빈도가 높은 근골격계 상병 업무상질병 조사 및 판정 지침, 2022.7.1

제3절 일본

I. 산재보험제도 일반

1. 특징

일본의 산재보험제도는 근로자가 산업재해를 당한 경우, 피해자와 유족에게 일정한 보상을 하는 제도를 산재보상이라고 하고, 일본에서는 이 제도가 만들어진 당초에는 노동기준법의 “제8장 재해보상”과 노재보험법의 산재보험의 두 가지 체제로 되었다. 노동기준법의 재해보상은 당연히 사용자의 개인보상이다.

하지만 영세한 사용자가 노동기준법에 규정되는 보상을 개인으로 행하는 것은 당연히 한계가 있어, 그렇기에 처음부터 산재보험이 마련되었던 것이다. 즉, 노동기준법 제8장에 규정되는 사용자의 근로자에 대한 재해보상의 발생을 보험사고로 하는 정부가 관장하는 강제가입보험으로 만들어진 것이다. 이와 같이 사용자의 재해보상 책임이 전제가 되고 있기 때문에, 보험료는 사용자(사업주)의 단독 거출이며, 보험급여의 대상은 노동기준법상의 근로자라는 구조를 취하고 있다.

그러나 그 후 법개정으로 노재보험법과 노동기준법의 괴리가 점차 발생하게 되었다. 산재보험의 특별가입제도가 그 특징인데, 노동기준법의 근로자가 아닌 중소기업주나 일인친방(一人親方라고 하여 건설업 등에서 도급을 맡아 행하는 개인사업주 또는 자영업자) 등을 업무의 실정, 재해의 발생상황 등에 비추어 노동기준법 적용근로자에 준하여 보호를 하기로 하는 실질적으로 취업자 거출의 임의가입보험이 마련되었다.

2. 체계

일본의 산재보험은 업무재해 및 출퇴근재해를 당한 근로자에게 신속하고 공정한 보호를 위하여 필요한 보험급여를 하고, 이와 함께 업무재해 또는 출퇴근 재해를 당한 근로자의 사회복귀 촉진, 피해근로자 및 그 유족의 원호, 근로자의 안전 및 확보 등을 도모하여 이로써 근로자의 복지 증진에 기여하는 것을 목적으로 한다(노재보험법 제1조).

일본의 산재보험법은 원칙적으로 근로자에게 적용되고, 사업주, 임원 등 근로자로 간주되지 않는 자에게는 원칙 적용되지 않는다. 하지만 산재보험에는 특별가입제도가 있어 그 제도에 가입한 노무제공자는 근로자와 마찬가지로 산재보험의 급여를

받을 수 있다. 이 특별가입은 ① 중소기업주과 그 사업에 종사하는 자는 그 사업에 대해 산재의 보험관계가 성립되어 있으며 산재보험의 사무처리를 노동보험사무조합(노동보험 사무처리를 대항하는 것을 후생노동대신의 인가를 얻은 단체)²⁰⁴⁾에 위탁하고 있는 것을 조건으로 노동보험사무조합을 통하여 산재보험에 가입, ② 개인사업주, 기타 자영업자 등 및 이러한 사업에 종사하는 자와 특정작업종사자 등도 일인친방, 특정작업종사자 등의 단체를 통하여 산재보험에 가입, ③ 해외파견자들의 특별가입이 있다.

또한, 일본에서는 근로자가 산업재해 및 출퇴근재해를 당한 때에는 적정하고 신속하게 요양보상, 휴업보상, 장애보상, 유족보상, 장제비, 상병보상연금, 개호(돌봄)보상 등의 산재보험급여가 이루어진다. 이러한 산재보험급여는 피재근로자 및 유족의 생활보장에 있어 중요하고, 그렇기 때문에 산재보험에 관한 결정에 대한 불복신청의 신청 등은 중요하다.

II. 업무상 질병의 처리

1. 개관

일본에서는 산재보상보험 청구절차는 노재보험법 시행 이후 2016년 3월 31일까지는 노동기준감독서의 산재보험 부지급 결정(행정처분)에 불복이 있는 경우에는 “노동보험심사관”에 대한 “심사청구”를 하고, 여기에서의 결정에 여전히 불복한 경우에는, 그 다음으로 “노동보험심사회”에 대한 “재심사 청구”를 하여 각각의 재결이 이루어진 경우에 피해자는 비로서 노동기준감독서의 “원처분”의 취소를 요구하여 법원에 제소하는 것이 가능하게 되는 시스템이었다(이중 불복신청 전치주의. 구 노재보험법 제38조 및 제40조). 그러나 그 후 노재보험법 개정법 제40조에 따라 노동보험심사관의 “심사청구”를 거친 후, 재심사청구를 할지, 바로 법원에 소제기를 할지에 대해 피해자에게 선택권이 부여되는 방식으로 개정되었다(2016년 4월 1일 시행).

이는 일본의 행정불복심사법 개정에 따른 불복신청절차의 실질화에 따라, 산재보험의 보험급여 결정에 대한 불복신청 절차도 개선된 것으로 평가된다. 이는 일본 정부가 행정불복심사법, 동법 시행에 관한 정비법, 행정절차법 관련 부분의 개정법

204) 일본은 우리나라와 같이 근로복지공단의 기관이 없고, 산재보험의 업무 등은 소관 노동기준감독서를 경우하여 도도부현 노동국에서 이루어지고 있다.

안 등을 개정하면서, (1) 공정상의 향상, (2) 이용편리함의 향상, (3) 국민의 구제수단의 충실 및 확대를 목표로 하여 이중전치 제도는 해소되거나, 법률에 따라서는 “일부폐지·일부존치”의 조치가 취해지게 되었다. 산재보험 청구절차에 대해서는 “이중전치”가 “일중전치화”(재심사 단계 = 노동보험심사회의 필연적 전치는 폐지되고, 재심사 청구 또는 법원에 제소는 청구인의 선택에 맡김) 되었다. 산재보험 청구절차에서는 이 전치일부폐지로 그친 것은, 통계적으로 대량의 불복신청이 있고, 즉시 법원에 제소를 하면 법원의 부담이 커지게 될 것으로 생각했기 때문이다.²⁰⁵⁾

2. 업무상 질병의 인정 절차

(1) 범위

근로자가 발병한 질병에 대해서는 일반적으로 다수의 원인 또는 조건이 경합하고 있으며 그 조건의 하나로서 업무가 개재하고 있는 점은 부정할 수 없다. 그러나 조건의 하나로서 업무가 개재하고 있는 것을 근거로 하여 즉시 업무와 질병 간에 인과관계가 있다고 하는 것은 타당하지 않고, 업무와 질병 간에 이른바 상당인과관계가 있는 경우에 비로소 업무상 질병으로 다루어지게 된다.

일본의 노재보험법에 의한 업무재해에 관한 보험급여는 노동기준법의 상당하는 각 규정에서 정하는 재해보상의 사유가 발생한 경우에 행하는 것으로 되어 있는데, 노동기준법에서의 재해보상책임은 사업주 과실의 유무를 불문하고 사업주에게 부과하는 것인 점, 산재보험급여의 원자는 사업주가 전액 부담한 보험료인 점을 고려하면, 근로자가 발병한 질병이 업무에 기인한 것인지의 여부의 판단은 적정하게 이루어져야 한다. 또한 근로자가 발병한 질병의 업무기인성은 명확하고 또한 타당한 것이어야 한다.

산재의 업무재해 중에서 특히 업무상 질병에 대해서는 노동기준법 제75조 제2항에서 업무상 질병을 후생노동성령에서 정하는 것으로 되어 있으며, 이 규정에 근거하여 노동기준법 시행규칙 별표 제1의 2의 규정 및 이에 근거한 고시에 규정하여 그 범위를 명확히 하고 있다.

이 별표 제1의 2에는 업무상 부상에 기인하는 질병 외에, 특정 유해인자를 포함한 업무에 종사하면 그 업무에 기인하여 발병한다고 인정되는 질병, 뇌·심장질환, 정신장애가 유형적으로 열거되어 있다.

205) 中嶋士元也, “労災補償の行政審査と司法審査”, 弘文堂, 2020, 12頁.

또한 장래에 이러한 열거질병을 추가 확충할 필요가 있는 점을 고려하여, 제10호에 “후생노동대신이 지정하는 질병”을 추가하고 제11호에 “기타 업무에 기인하는 것이 명확한 질병”을 규정하는 등, 개개의 사례에 입각하여 업무기인성의 판단을 하는 길도 남겨두는 방법으로, 업무상 질병의 범위를 규정하고 있다.

노동기준법 시행규칙 별표 제1의 2

별표 제1의 2 (제35조 관계)

① 업무상 부상에 기인하는 질병

② 물리적 인자로 인한 다음에 열거하는 질병

1. 자외선에 노출되는 업무로 인한 전안부 질환 또는 피부질환
2. 적외선에 노출되는 업무로 인한 망막 화상, 백내장 등의 안질환 또는 피부질환
3. 레이저 광선에 노출되는 업무로 인한 망막 화상 등의 안질환 또는 피부질환
4. 마이크로파에 노출되는 업무로 인한 백내장 등의 안질환
5. 전리방사선에 노출되는 업무로 인한 급성방사선증, 피부궤양 등의 방사선 피부장해, 백내장 등의 방사선 안질환, 방사선 폐렴, 재생불량성 빈혈 등의 조혈기장해, 뼈괴사 그 외 방사선장해
6. 고압실내작업 또는 잠수작업에 관련된 업무로 인한 잠함병 또는 잠수병
7. 기압이 낮은 곳에서의 업무로 인한 고산병 또는 항공감압증
8. 매우 더운 장소에서의 업무로 인한 열사병
9. 고열물체를 취급하는 업무로 인한 화상
10. 한랭한 장소에서의 업무 또는 저온물체를 취급하는 업무로 인한 동상
11. 현저한 소음이 발생하는 장소에서의 업무로 인한 난청 등 귀질환
12. 초음파에 노출되는 업무로 인한 손가락 등의 조직괴사
13. 1에서 12까지 열거한 것 외에, 이러한 질병에 부수하는 질병 그 외 물리적 인자에 노출되는 업무에 기인하는 것이 명확한 질병

③ 신체에 과도한 부담이 되는 작업양태에 기인하는 다음에 열거하는 질병

1. 격렬한 업무로 인한 근육, 힘줄, 뼈, 관절 질환 또는 내장탈
2. 중량물을 취급하는 업무, 요부에 과도한 부담을 주는 부자연스러운 작업 자세에서 수행하는 업무 그 외 요부에 과도한 부담을 주는 업무로 인한 요통
3. 착암기, 해머, 전기톱 등의 기계기구 사용으로 신체에 진동을 주는 업무로 인한 손가락, 전완부 등의 말초순환장해, 말초신경장해 또는 운동기장해
4. 전자계산기에 입력을 반복하여 수행하는 업무 그 외 상지(上肢)에 과도한 부담을 주는 업무로 인한 후두부, 경부, 견갑대, 상완, 전완 또는 손가락의 운동기장해
5. 1에서 4까지 열거한 것 외에, 이러한 질병에 부수하는 질병 그 외 신체에 과도한 부담을 주는 작업양태에 기인하는 것이 명확한 질병

④ 화학물질 등으로 인한 다음에 열거하는 질병

1. 후생노동대신이 지정하는 단일 화학물질 및 화합물(합금 포함)에 노출되는 업무로 인한 질병으로서 후생노동대신이 정하는 질병
 2. 불소수지, 염화비닐수지, 아크릴수지 등의 합성수지 열분해생성물에 노출되는 업무로 인한 눈점막의 염증 또는 기도점막의 염증 등의 호흡기 질환
 3. 그을음, 광물유, 옷, 테레빈유, 타르, 시멘트, 아민계수지경화제 등에 노출되는 업무로 인한 피부질환
 4. 단백질분해효소에 노출되는 업무로 인한 피부염, 결막염 또는 비염, 기관지 천식 등의 호흡기 질환
 5. 목재 분진, 동물의 털의 진애 등을 비산하는 장소에서의 업무 또는 항생물질 등에 노출되는 업무로 인한 알레르기성 비염, 기관지 천식 등의 호흡기 질환
 6. 낙면 등의 분진을 비산하는 장소에서의 업무로 인한 호흡기 질환
 7. 석면에 노출되는 업무로 인한 양성석면흉수 또는 비만성흉막비후
 8. 공기중의 산소 농도가 낮은 장소에서의 업무로 인한 산소결핍증
 9. 1에서 8까지 열거한 것 외에, 이러한 질병에 부수하는 질병 그 외 화학물질 등에 노출되는 업무에 기인하는 것이 명확한 질병
- ⑤ 분진을 비산하는 장소에서의 업무로 인한 진폐증 또는 진폐법(1960년 법률 제30호)에서 규정하는 진폐와 합병된 진폐법 시행규칙(1960년 노동성령 제6호) 제1조 각호에서 열거하는 질병
- ⑥ 세균, 바이러스 등의 병원체로 인한 다음에 열거하는 질병
1. 환자의 진료, 간호 업무, 개호 업무 또는 연구 그 외 목적으로 병원체를 취급하는 업무로 인한 전염성 질환
 2. 동물 또는 그 시체, 동물의 털, 가죽 그 외 동물성 것 또는 누더기 등의 고물을 취급하는 업무로 인한 브루셀라병, 탄저병 등의 감염성 질환
 3. 습윤지에서의 업무로 인한 웨일병 등의 렙토스피라증
 4. 야외에서의 업무로 인한 찌프가무시병
 5. 1에서 4까지 열거한 것 외에, 이러한 질병에 부수하는 질병 그 외 세균, 바이러스 등의 병원체에 노출되는 업무에 기인하는 것이 명확한 질병
- ⑦ 암원성 물질, 암원성 인자 또는 암원성 공정에서의 업무로 인한 다음에 열거하는 질병
1. 벤지딘에 노출되는 업무로 인한 요로계 종양
 2. 베타나프틸아민에 노출되는 업무로 인한 요로계 종양
 3. 4-아미노디페닐에 노출되는 업무로 인한 요로계 종양
 4. 4-니트로페닐에 노출되는 업무로 인한 요로계 종양
 5. 비스(클로로메틸)에테르에 노출되는 업무로 인한 폐암
 6. 베릴륨에 노출되는 업무로 인한 폐암

7. 벤조클로라이드에 노출되는 업무로 인한 폐암
8. 석면에 노출되는 업무로 인한 폐암이나 중피종
9. 벤젠에 노출되는 업무로 인한 백혈병
10. 염화비닐에 노출되는 업무로 인한 간혈관육종 또는 간세포암
11. 3·3-디클로로-4·4 디아미노디페닐메탄에 노출되는 업무에 의한 요로계 종양
12. 오르토 톨리딘에 노출되는 업무로 인한 방광암
13. 1·2-디클로로프로판에 노출되는 업무로 인한 담관암
14. 디클로로메탄에 노출되는 업무로 인한 담관암
15. 전리방사선에 노출되는 업무로 인한 백혈병, 폐암, 피부암, 골육종, 갑상선암, 다발성골수종 또는 비호지킨 림프종
16. 오라민을 제조하는 공정에서의 업무로 인한 요로계 종양
17. 마젠타를 제조하는 공정에서의 업무로 인한 요로계 종양
18. 코크스 또는 발생로가스를 제조하는 공정에서의 업무로 인한 폐암
19. 크롬산염 또는 중크롬산염을 제조하는 공정에서의 업무로 인한 폐암이나 상기도암
20. 니켈 제련 또는 정련하는 공정에서의 업무로 인한 폐암 또는 상기도암
21. 비소를 함유한 광석을 원료로 금속의 제련 또는 정련하는 공정, 무기비소화합물을 제조하는 공정에서의 업무로 인한 폐암이나 피부암
22. 그을음, 광물유, 타르, 피치, 아스팔트 또는 파라핀에 노출되는 업무로 인한 피부암
23. 1에서 22까지 열거한 것 외에, 이러한 질병에 부수하는 질병 그 외 암원성 물질, 암원성 인자에 노출되는 업무 또는 암원성 공정에서의 업무에 기인하는 것이 명확한 질병
- ⑧ 장기간에 걸친 장시간 업무 그 외 혈관병변 등을 현저히 악화시키는 업무로 인한 뇌출혈, 지주막하출혈, 뇌경색, 고혈압성뇌증, 심근경색, 협심증, 심정지(심장성돌연사 포함), 위독한 심부전 혹은 대동맥 해리 또는 이러한 질병에 부수하는 질병
- ⑨ 사람 생명에 관련된 사고와의 조우, 그 외 심리적으로 과도한 부담을 주는 사상(事象)을 수반하는 업무로 인한 정신 및 행동 장애 또는 이에 부수하는 질병
- ⑩ 전 각호에 열거한 것 외에, 후생노동대신이 지정하는 질병
- ⑪ 그 외 업무에 기인하는 것이 명확한 질병

(2) 업무수행성 및 업무기인성

각 업무상 질병에 관해서는 인정에 있어서 업무내용, 종사기간, 업무로 인한 부하,

증상 등에 대한 인정기준을 통달로 내림으로써 사안에 따라 인정요건을 충족시키는지의 여부를 조사하여 이루어지고 있다.²⁰⁶⁾

인정기준은 각 질병에 대한 현재의 의학적 지견을 집약하고 해당 질병과 업무와의 관계에 대한 유해인자와 그 노출기간 등 및 이로 인해 발생하는 질병 병상, 경과 등을 제시한 것이다. 인정기준이 제시되지 않은 질병도 있는데, 인정기준의 요건을 충족시킨 질병에 대해서는 원칙적으로 업무상 질병으로 취급된다.

1) 업무수행성

업무상 질병의 경우에도 업무수행성은 “근로자가 근로계약에 근거로 하여 사업주의 지배관리하에 있는 상태”를 말한다. 즉 업무상 질병은 근로자가 노동의 장에서 업무에 내재하는 다양한 유해인자에 노출되어 발생하는 것이기 때문에, 이러한 유해인자를 받는 위험에 노출되어 있는 상태를 업무수행성이라고 한다.

이 업무수행성은 근로자가 사업주의 지배관리하에 있는 상태에서 질병이 발병하는 것을 의미하는 것이 아니고, 사업주의 지배관리하에 있는 상태에서 유해인자에 노출되어 있는 것을 의미한다.

따라서 예를 들어 근로자가 사업주의 지배관리하에 뇌출혈을 발생했다고 해도, 그 발병원인에 충분한 업무상의 이유가 인정되지 않는 한, 해당 뇌출혈과 업무와의 사이에는 상당인과관계가 성립하지 않게 된다.

또한, 사업주의 지배관리를 벗어난 경우의 발병이라고 해도, 업무상의 유해인자에 대한 노출로 인한 것으로 인정되는 한, 해당 질병과 업무 사이에 상당인과관계가 인정되게 된다.

2) 업무기인성

근로자가 발병한 질병에 대해서 노동의 장에서의 유해인자의 존재, 유해인자에 대한 노출조건 및 발병 경과와 병태의 3요건이 충족되는 경우에는 원칙적으로 업무기인성이 인정된다.

(3) 업무상 질병 산재 인정 절차

206) 각 업무상 질병의 인정기준에 대한 통달 등은 다음의 후생노동성 사이트를 참조할 수 있다(労働基準情報：業務上疾病の認定等: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/gyomu.html)

1) 산업재해 보고

산업재해가 발생하면 먼저 사업주에게 보고한다. 신청서류를 작성할 때 다음의 사항을 기록해야 한다.

- 피해를 입은 근로자의 이름
- 산재가 발생한 일시(질병의 경우에는 진단을 받은 날)
- 산재가 발생한 상황을 확인한 사람의 이름
- 원인 및 발생상황
- 부상 및 질병의 부위 및 상태
- 수진한(했던) 병원명 등

원칙적으로 산재의 신청절차는 피해를 입은 근로자 또는 유족이 하는 것으로 되어 있는데, 신청방법을 모르거나 요양으로 인해 신청을 할 수 없는 경우 등은 사업주에게 상담하여 지원을 받거나, 사업자가 신청을 대행할 수 있다.

사업주는 근로자로부터 산재 보고를 받으면, 근로자의 부담을 줄이기 위해 적극적으로 협력해야 한다. 사업자가 신청서류를 작성하는 경우에는 근로자로부터 보고받은 내용에 맞춘 청구서를 작성하고 필요 서류와 함께 노동기준감독서에 제출한다.

그 외 사업주의 의무로서 산업재해 등의 원인으로 근로자가 사망 또는 휴업이 4일 이상이 될 전망이다, 지체없이 근로기준감독서에 "근로자사상병보고"를 제출해야 한다. 이 보고는 사업주가 반드시 작성해야 한다. 신청하는 급여 내용에 맞는 청구서를 노동기준감독서에 제출하고, 필요한 조사를 거친 후 산재로 인정되면 급여를 받을 수 있다.

2) 뇌·심장질환의 업무상 질병의 산재인정 절차

업무가 원인으로 발병한 뇌질환·심장질환은 산재로 인정되는데, 산재보험의 대상이 되는 질병은 ① 뇌질환과 ② 허혈성 심질환 등의 질병이 있다. 그리고 산재로 인정될지의 여부는 다음의 ① "이상(異常)한 사건", ② 단기간의 과중업무, ③ 장기간의 과중업무의 요소로 판단된다.

① "이상(異常)한 사건"은 발병직전부터 전날까지 동안에 이상한 사건에 조우한 적이 있으면 산재로 인정될 가능성이 있다. 이상한 사건은 정신적 부하, 신체적 부하, 작업환경의 변화 등을 들 수 있다.

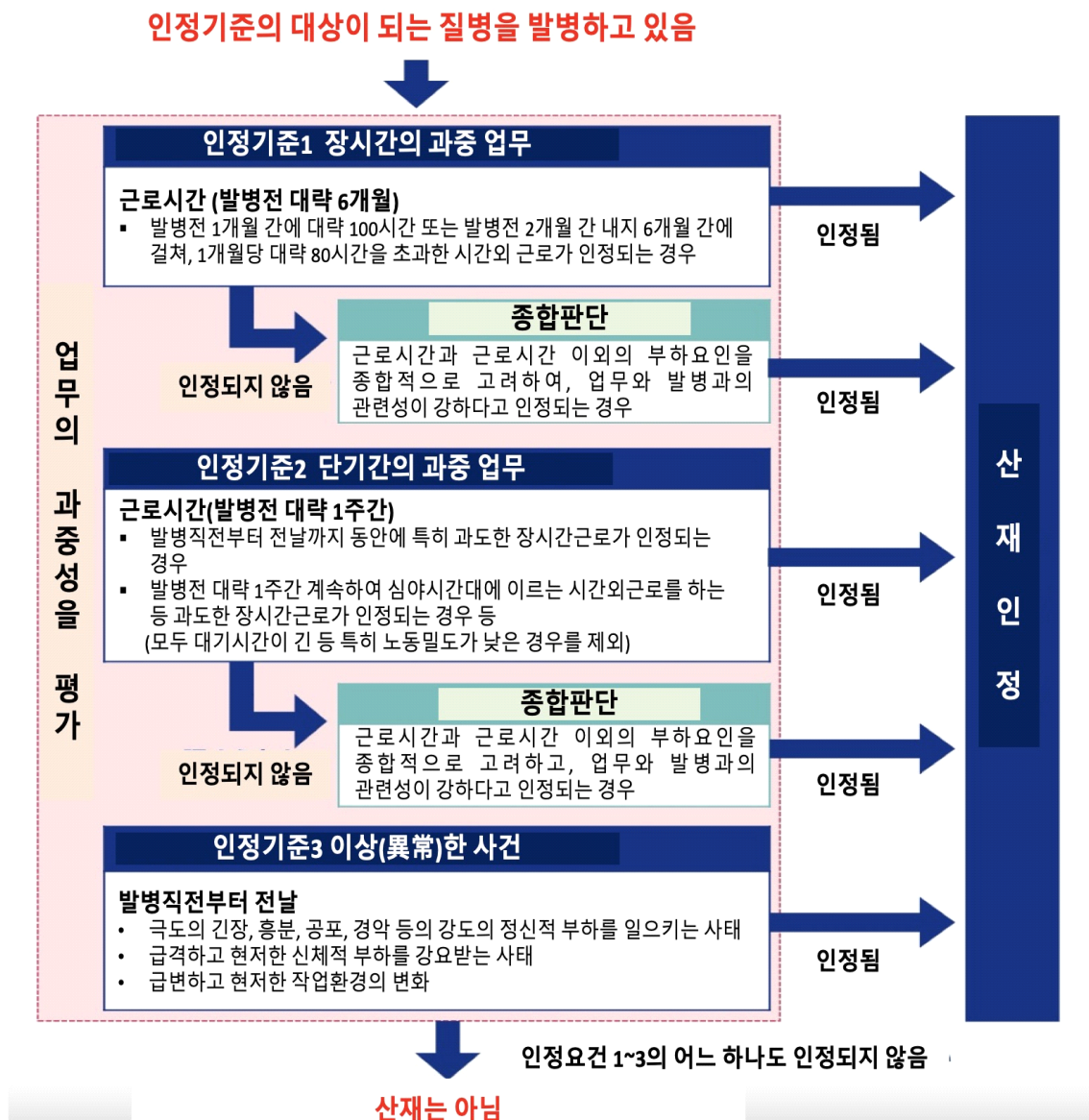
② 단기간의 과중업무가 있었는지에 대해서는 발병에 근접한 시기(발병전 대략 1

주간)에 특히 과중한 업무에 취업하고 있으면 산재로 인정될 가능성이 있다.

③ 장기간의 과중업무가 있었는지에 대해서는 발병전 장기간(발병전 대략 6개월)에 현저한 피로의 축적을 초래하는 특히 과중한 업무에 취업하고 있으면 산재로 인정될 가능성이 있다.

뇌질환 및 심장질환의 산재인정은 상당히 구체적인 판단기준이 마련되어 있기 때문에 그 판단기준에 따라 검토된다.

[그림 3-5] 뇌·심장질환의 산재인정 절차 (예)



출처: <https://www.mhlw.go.jp/content/001004355.pdf>

3. 업무상 질병 처리 절차

(1) 절차 규정

1) 개관

피재근로자의 산재보상보험 청구절차는 일본의 노재보험법 시행 이후 2016년 3월 31일까지는 노동기준감독서의 산재보험 부지급 결정(행정처분)에 불복이 있는 경우에는 “노동보험심사관”에 대한 “심사청구”를 하고, 여기에서의 결정에 여전히 불복이 있는 경우에는 “노동보험심사회”에 대한 “재심사청구”를 하여 기각의 재결이 나온 경우에 피해자는 비로소 노동기준감독서의 “원처분”의 취소를 요구하여 법원에 제소하는 것이 가능한 시스템이었다(이중 불복신청 전치주의, 구 노재보험법 제38조, 제40조). 그러나 그 후 노재보험법 개정으로 제40조에서 노동보험심사관의 “심사청구”를 거친 후, 재심사청구를 할지 소를 제기할지에 대하여 피해자에 선택권이 부여되는 방식으로 개정되었다(2016년 4월 1일 시행).

노재보험법은 제5장 “불복신청 및 소송”의 제38조에서 제41조에 산재보험급여 결정에 대한 불복신청과 소송에 대한 규정을 두고 있으며, 동법 제39조가 보험급여 결정에 대한 불복에 대해서는 행정불복심사법 제2장 및 제4장의 규정을 배제하는 것으로 되어 있다(단서 제22조를 제외). 그리고 심사관·심사회법 제1장 제2절이 심사청구에 대하여 동법 제2장 제2절이 재심사청구에 대하여 규정하고 있으며, 행정불복심사법 개정에도 있어 노재보험법 및 심사관·심사회법도 개정되어 행정불복심사법의 개정 내용이 반영되었다. 즉, 노재보험법 및 심사관·심사회법은 행정불복심사법을 원칙배제하면서, 동법에 거의 준거한 불복절차를 규정하고 있다고 할 수 있다.

(2) 행정불복심사법의 법개정 주요 내용

1) 불복신청 전치

행정불복심사법 개정을 계기로 불복신청 전치를 규정하는 각 개별법은 개정되었고, 심사청구 및 재심사청구를 거치지 않으면 취소소송을 제기할 수 없다고 하는 이중전치에 대해서는 모두 폐지되었다. 이에 노재보험법에서도 폐지되었기 때문에, 보험급여 결정에 대한 취소소송은 재심사청구를 하지 않아도 제기할 수 있다(노재

보험법 제40조 참조).

심사청구 전치에 대해서는 불복신청 전치를 규정하고 있던 95개의 개별법 중 46개의 법률이 불복신청 전치를 폐지하고 21개의 법률이 불복신청전치를 축소했지만, 노재보험법은 산재보험급여 결정에 대한 불복신청은 많기 때문에, 불복신청 전치로 하지 않으면 대량의 취소소송으로 법원의 부담이 과대하게 된다고 하여 개정 후에도 법 제40조에서 심사청구 전치주의를 규정하고 있다.

그러나 동법 제38조 제2항은 심사청구를 한 날로부터 3개월 경과해도 심사청구에 대한 결정이 없는 때에는 심사청구가 기각된 것으로 간주한다고 되어 있기 때문에, 3개월이 경과해도 심사청구에 대하여 결정이 없으면 소송제기를 할 수 있다.

2) 구두의견 내실화

행정불복심사법 개정에 따라, 심사관·심사회법이 개정되어 구두의견 진술시 원처분을 한 행정청에 대하여 질문할 수 있게 되었다(심사관·심사회법 제13조).

3) 심사청구기간의 연장, 표준심리기간 설정, 문서 등 열람 등

또한, 행정불복심사법 개정에 따라, 심사청구기간도 60일에서 3개월로 연장되어(심사관·심사회법 제8조), 심사관이 심사청구에 대한 결정을 하기까지 통상적으로 필요로 하는 표준적인 기간을 정하도록 노력하는 것도 규정되었다(동법 제7조의 2, 제50조). 또한 심사청구인 등은 제출된 문서, 기타 물건의 열람, 사본의 교부를 요구할 수 있게 되었다(동법 제16조의 3 제1항).

[표 3-14] 법개정에 따른 변경 사항

	개정전	개정후
불복신청기간	- 처분을 알게 된 날의 다음 날부터 60일 이내(심사청구) - 결정서 등본이 송부된 날의 다음날부터 60일 이내(재심사청구)	- 처분을 알게 된 날의 다음 날부터 3개월 이내(심사청구) - 결정서의 등본이 송부된 날의 다음날부터 2개월 이내(재심사청구)
표준심리기간의 설정	규정 없음	설정하도록 노력하는 것을 규정

심사청구절차의 계획적인 진행	규정 없음	재심사청구인 등의 심리에서 상호협력의무를 규정
구두의견진술	재심사청구인 등은 의견을 진 술할 수 있는 것을 규정	(개정전 내용에 추가하여) • 모든 당사자를 소집하여 행 하는 것 • 재심사청구인 등의 행정청 에 대한 질문권을 규정
물건의 제출	결정이 이루어지기까지는 언제 라도 증거가 되는 문서, 기타 물건을 제출할 수 있다(시행령)	• 재심사청구인 등은 증거가 되는 문서, 기타 물건을 제 출할 수 있는 것을 규정 • 심사회가 이러한 것을 제출 해야 하는 기간을 정한 때 에는 그 기간 내에 제출해 야 하는 것을 규정
특정심사청구절차의 계획적인진행	규정 없음	필요가 있는 경우에 당사자를 소집하고, 재심사청구의 절차 신청에 관한 의견을 청취하는 것을 규정
물건의 열람	규정 없음	재심사청구인 등은 제출된 문 서, 기타 물건의 등본을 요구할 수 있는 것을 규정
불복신청 전치	재심사청구 후가 아니면 법원 에 제소할 수 없다	심사청구 후가 아니면 법원에 제소할 수 없다(재심사 전에도 가능)

출처: 中嶋士元也, “労災補償の行政審査と司法審査”, 弘文堂, 2020, 14頁.

(3) 산재보험 심사청구제도의 특징

청구인이 산재보험급여를 청구한 경우, 노동기준감독서에서는 사안에 따라 통달, 인정기준 등에 따라 다양한 조사를 실시한다. 구체적으로는 청구인으로부터 이야기를 청취하고 사업장에 가서 이야기를 청취하고, 주치의 등에게 의견을 요구하고, 필요한 자료수집 등을 실시한다.

그리고 그 결과로서, 노동기준감독서장으로서 일정한 “보험급여의 지급결정”을 할지, 산재의 지급대상외로서 “부지급 결정”을 할지, 처분을 내리게 되는데, 처분을 받은 피재근로자 또는 유족이 받은 처분에 대해 납득이 가지 않거나 불복이 있는 때에는 노재보험법 제38조 이하의 규정에 따라 불복신청을 하게 된다.

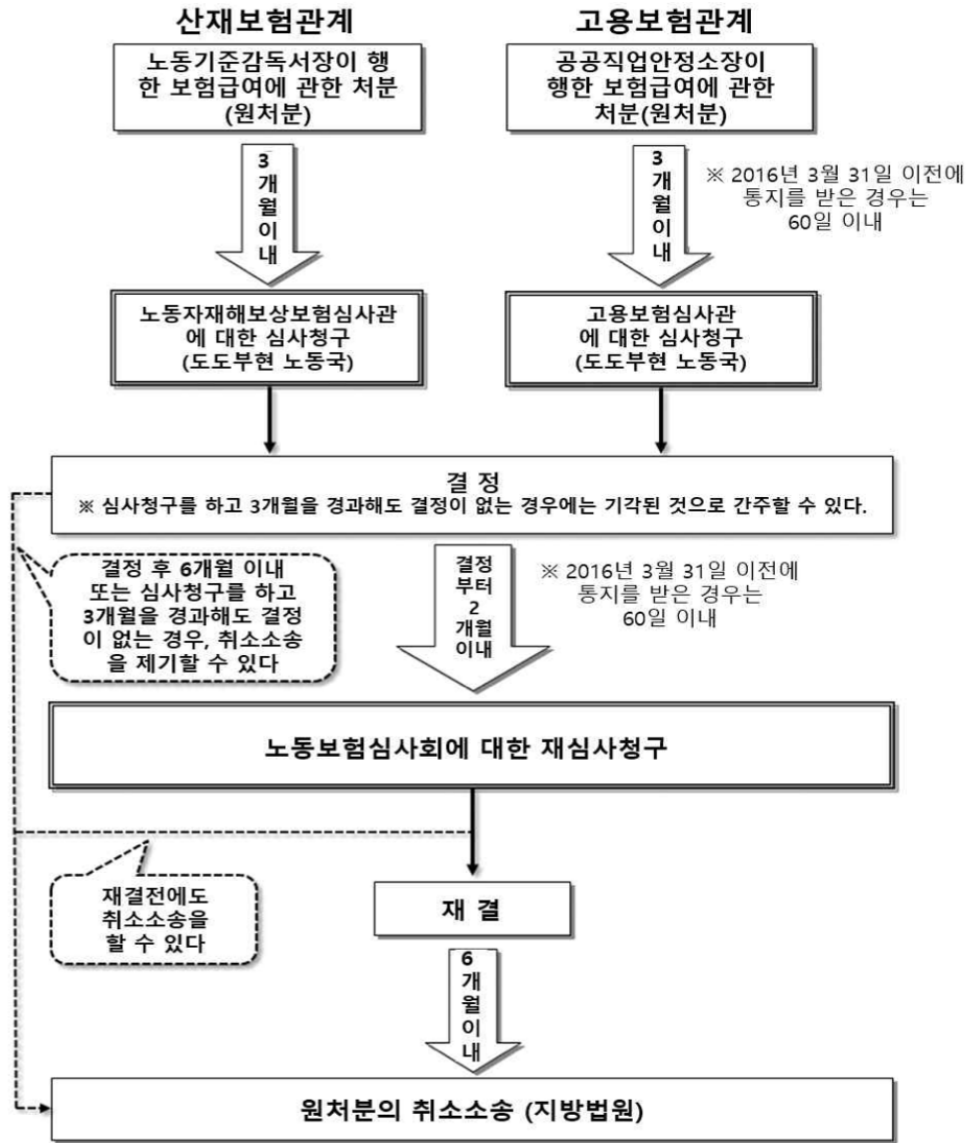
행정청이 내린 처분에 불복이 있는 경우, 행정불복심사법에 근거로 한 불복신청을 하거나, 행정사건소송법에 근거로 한 취소소송을 제기할 수 있다. 그러나 산재보험의 보험급여에 관한 처분은 대량으로 발생할 수 있는 전문적이고 신속한 문제해결이 필요한 처분에 대해서는 일반적으로 불복신청이나 소송에 익숙하지 않다.

그래서 노동기준감독서장이 행한 보험급여에 관한 처분에 대해 불만이 있고 그 처분(원처분)이 잘못되었다고 생각하는 경우에는 산재보험제도 독자적인 심사청구제도를 이용하여 불복신청을 할 수 있는 것으로 되어 있다. 이러한 심사청구제도는 행정기관에 의한 구제 제도로 2심제를 채택하고 있다.

1심의 심사기관은 노동도부현 노동국에 있는 노동자재해보상보험심사관(이하 심사관)이다. 심사관은 노동기준감독서장이 결정한 보험급여에 관한 처분에 불복이 있는 피재근로자 등으로부터 심사청구에 대해 심리를 하게 된다. 심사관은 이 심사청구를 받고 내용을 조사하고(심사청구 요건을 충족시키고 있지 않은 때에는 "각하"되는 경우도 있음), 심사청구인의 주장대로 원처분이 위법 또는 부당하다고 인정되는 때에는 원처분의 "취소" 결정을, 반대로 원처분이 위법하지도 부당하지도 않고 심사청구에 이유가 없다고 인정한 때에는 "기각" 결정을 한다.

심사청구가 기각되거나 원처분의 일부만이 취소되게 된 경우와 같이, 심사관의 결정에 대해서 여전히 불만이 있는 경우에는 더 나아가 2심의 심사기관인 노동보험심사회(이하 심사회)에 대해 재심사청구를 할 수 있다. 그리고 재심사청구에 대한 재결에 대해서도 여전히 불복하는 경우에는, 행정사건소송법에 근거로 한 가처분 취소소송을 제기할 수 있다.

[그림 3-6] 노동보험(산재보험+고용보험) 심사제도 구조



출처: <https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/02-01.html>

다만, 피해근로자의 신속한 보호를 도모하는 목적에서 예외 설정이 마련되었으며, 심사청구를 한 날로부터 3개월을 경과해도 심사관의 결정이 없는 경우에는 결정이 없는 채로 재심사 청구를 할 수 있고, 재심사 청구를 한 날로부터 3개월을 경과해도 재결이 없는 경우 또는 긴급한 필요가 있는 등 재결을 거치지 않는 것에 대하여 정당한 이유가 있는 경우에는 재결이 없는 채로 처분취소소송을 제기할 수 있는 것으로 되어 있다.

(4) 담당기관: 노동보험심사회²⁰⁷⁾

노동보험심사회는 산재보험과 고용보험의 급여 처분에 관하여 제2심으로서 행정 불복심사를 하는 국가 기관이다. 근거법률은 “노동보험심사관 및 노동보험심사회법” 제25조에 근거로 하고 있으며, 1956년 8월 1일 설치되었다.²⁰⁸⁾

소장사무는 (1) 노동자재해보상보험법 제38조 및 고용보험법 제69조의 규정에 따른 재심사 청구 사건을 취급하는 것, (2) 중소기업퇴직금공제법 제84조 제1항의 규정에 따른 심사의 사무를 취급하는 것이다.

이 심사회의 위원은 정수 9명으로, 인격이 고결하고 노동문제에 관한 식견을 가지고 또한 법률 또는 노동보험에 관한 학식경험을 가진 자로, 그 중 6명인 상근이다. 임기는 3년으로 한다.

4. 이의신청과 조정: 산재보험 심사청구 제기 방법(산재보험 불복신청)²⁰⁹⁾

(1) 심사청구 제기

심사청구에서 어떠한 주장을 전개해야 하는지를 검토하는지에 있어서 원처분의 결정이유를 아는 것이 중요한데, 원처분의 결정통지의 안내서(엽서)에는 짧게 이유가 부기되어 있을 뿐이므로, 심사청구에서 유효한 주장을 전개하기 위해서 충분하지 않다.

예를 들어 과로자살에서 산재인정의 요건은 (1) 인정기준의 대상이 되는 정신장애를 발병하고 있을 것, (2) 인정기준의 대상이 되는 정신장애의 발병전 및 대략 6개월 간에 업무에 의한 강한 심리적 부하가 인정될 것, (3) 업무이외의 심리적 부하나 개체측 요인으로 발병했다고는 인정되지 않을 것인데, 부지급 결정통지에는 “조사의 결과, 심리적 부하에 의한 정신장애의 인정기준의 대상이 되는 정신장애를 발병하고 있었다는 것이 인정되었지만, 심리적 부하가 “강”이 되는 업무에 의한 강한 심리적 부하가 있었다고는 인정되지 않았기 때문에, 부지급 결정을 하였습니다” 등으로만 기재되고, 상기 (1)(2)(3)의 어느 한 가지 요건이 결여되어 있다는 정도로 밖에 알 수 없다. 그렇기 때문에 (1) 요건이 부정된 것을 알게 되어도, (2) 요건의 부정된 것은 처분청이 피해자의 근로시간을 짧게 인정했기 때문인지, 피해자의 클레임 대

207) <https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/index.html>

208) https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/satei_01_04_03_11_10.pdf

209) 이하의 내용은 日本弁護士連合会行政訴訟センター編, “行政不服審査法の実務と書式[第2版]”, 民事法研究会, 2020, 322-337頁 참조하여 정리함.

응을 한 사실을 인정하지 않았기 때문인지 등에 대해서는 결정통지의 안내 기재의 이유에는 파악할 수 없다.

그래서 우선 심사청구를 하기 전에 조속히 개인정보개시청구를 해야 한다. 개인정보개시에 의한 등사서류가 심사청구 기간까지 여유가 있는 시기에 도착하면 심사청구서에 상세한 이유를 기재할 수 있지만, 개인정보개시청구의 개시에 시기가 맞지 않으면 우선은 심사청구를 신속하게 하고 개인정보가 개시된 후에 이유를 의견서에 상세하게 주장하게 도니다.

또한 의견서는 몇 차례나 제출해도 상관없다. 새롭게 정보를 입수하면 그 때마다 보충 의견서를 심사관에게 제출해야 한다.

1) 표준심리기간 및 심사청구 기간

일본의 후생노동대신은 심사청구가 된 때부터 해당 심사청구에 대한 결정을 할 때까지 통상 필요한 표준적인 기간을 정하도록 노력해야 하고, 동시에 이를 정한 때에는 도도부현 노동국에서의 비치 및 그 밖의 적당한 방법으로 공개해야 한다(심사관·심사회법 제7조의2).

그리고 심사청구 기간은 개정으로 연장되어, 심사청구인이 원처분이 있었던 것을 알게 된 날로부터 3개월이다. 다만, 정당한 이유로 이 기간 내에 심사청구를 할 수 없었던 것을 소명한 때에는 그러하지 않다(심사관·심사회법 제8조).

2) 청구하는 곳

심사청구는 노동자재해보상보험심사관 앞으로 한다(노재보험법 제38조 제1항). 노동자재해보상보험심사관은 심사관·심사회법에 근거로 하여 설치된 산재보험급여에 관한 결정에 대한 심사청구의 사건을 취급하는 것으로(동법 제2조 제1항), 각 도도부현 노동국에 설치되어 있다(동법 제2조의 2).

노동보험급여에 관한 불복은 원처분을 한 행정청의 소재지를 관할하는 도도부현 노동국에 설치된 심사관에게 하는 것이기 때문에(동법 제7조), 심사청구서를 제출하는 곳은 원처분을 한 노동기준감독서를 관할하는 도도부현 노동국이 된다. 또한 각 도도부현 노동국에서는 노동기준부 산재보상과가 설치되어 있는 것이 표준적이다.

3) 심사청구 방식

심사청구는 정령에서 정하는 바에 따라 문서 또는 구두로 할 수 있지만(심사관·심사회법 제9조), 당연히 특단의 사정이 없는 한 문서로 해야 한다.

4) 위임장

심사청구는 대리인에 의해서 할 수 있는 것으로 되어 있으며(심사관·심사회법 제9조의 2), 동조 제2항 단서에서 “단, 심사청구의 취하는 특별한 위임을 받은 경우에 한하여 할 수 있다”고 되어 있기 때문에, 위임장의 위임사항에 심사청구의 취하도 기재해두는 것이 바람직하다. 또한, 심사청구의 취하는 문서로 해야 한다(동법 제17조의 2 제2항).

(2) 심사청구 제기 후 절차

1) 보정과 각하 결정

심사청구가 부적법하여 그 결함을 보정할 수 없는 것인 때에는, 심사관은 결정을 가지고 이를 각하해야 하는 것으로 되어 있기 때문에(심사관·심사회법 제10조), 만일 심사청구가 부적법하다고 하여 보정이 명령된 경우에는 보정을 필요로 하다.

2) 심리절차

① 심사청구 후의 흐름

심사관은 심사청구가 이루어진 때에는 원처분을 한 행정청, 심사청구의 결과에 대하여 이해관계가 있는 행정청, 기타 제3자 등에게 통지해야 하고, 이 통지를 받은 자는 심사관에게 사건에 대해 의견을 말해야 하는 것으로 되어 있으며(심사관·심사회법 제13조 제1항 제2항), 심사청구 후에는 원처분청의 의견서가 심사청구인에게 송부된다.

이에 대하여 심사청구인으로서 반론하게 된다. 처분청의 의견서에 대한 해명을 요구하거나, 서면의 의견서 및 증거자료를 제출한다.

② 구두의견진술

심사청구인의 제기로 구두로 의견을 말할 기회를 부여받기 때문에(심사관·심사회법 제13조의 3), 구두의견을 진술하는 취지를 심사관에게 말해야 한다. 통상적으로는 심사관으로부터 구두의견을 진술할 의사가 있는지 확인하기 위한 서류가 도착하기 때문에, 그 때에 의사표명을 하면 된다. 그 후, 구두의견진술의 기일과 장소가 지정된다(동법 제13조의 3 제2항).

③ 질문권

구두의견을 진술할 때에, 제기인은 심사관의 허가를 얻어 심사청구에 관한 사건에 관하여 원처분을 한 행정청에 대하여 질문을 할 수 있는 것으로 되어 있다(심사관·심사회법 제13조의 3 제4항). 통상적으로 문서의 질문서에 대한 응답도 구두로 이루어지고, 문서로 회신이 이루어지는 경우는 없지만, 본래는 문서로 질문이 이루어지고 있는 경우에는 문서로 회신해야 한다.

④ 심리조서의 확인

구두의견진술에서의 의견이나 질문 및 회신에 대해서는 심리조서가 작성된다. 심리조서의 중요성에 비추어 보면, 심사청구인으로서 심리조서의 안이 완성되는 대로 안을 송부한 후에 확인할 기회를 주도록 적극적으로 제기를 해야 한다. 또한 심리가 녹음기기로 녹음되는 경우에는 그 녹음데이터 사본 교부를 요구하는 것도 생각할 수 있다.

⑤ 자료의 열람, 사본 교부

법 개정으로 심사청구인 등은 제출된 문서, 기타 물건의 열람, 사본의 교부를 요구할 수 있다고 하는 규정이 마련되고, 심사관은 제3자의 이익을 저해할 우려가 있다는 것을 인정할 때, 그 외 정당한 이유가 있는 때가 아니면 그 열람 또는 교부를 거부할 수 없다고 되어 있다(심사관·심사회법 제16조의 3 제1항). 그렇기 때문에 개인정보보호법에 근거로 한 개시청구를 한 시점에서는 제출되지 못했던 사업주 제출서류 등이 없는지를 심사관에게 확인하고 필요에 따라 동 조항에 근거로 한 열람 등을 요구할 수 있다.

(3) 재심사 청구

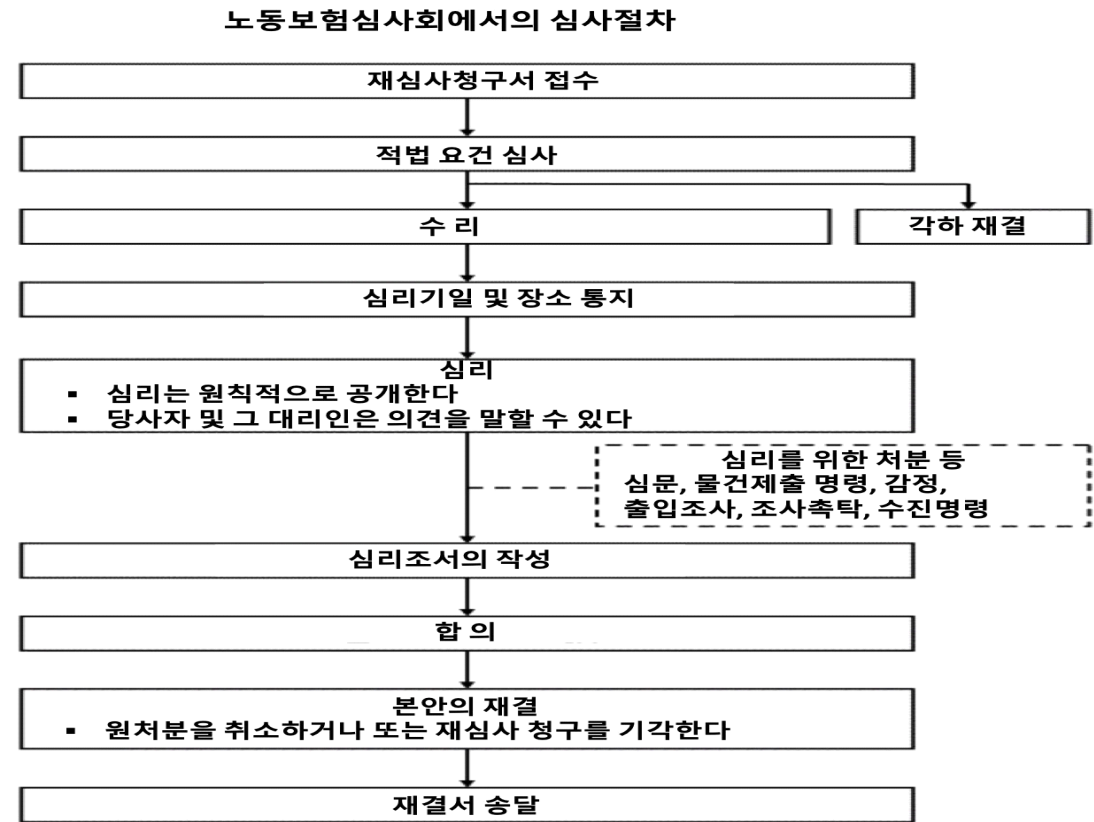
심사청구인이 심사청구를 기각당하거나 일부만 허용된 경우 등 심사관의 결정에 여전히 불복하는 경우에는 심사회에 대하여 재심사청구를 할 수 있다.

심사회는 후생노동대신의 소관 하에 마련된 2심의 심사기관으로, 9명의 위원회로 구성되어 그 합의제로 재심사 청구된 사건을 취급한다. 또한 심사관과는 달리, 후생노동성 통달에는 구속되지 않고 법령에만 근거로 하여 심리를 행한다.

1) 청구처, 불복신청기간, 신청방식

청구처는 노동보험심사회이고(노재보험법 제38조 제1항), 재심사청구 기간은 결정서 등본이 송부된 날의 다음날부터 기산하여 2개월 이내이다(심사법·심사회법 제38조 제1항). 신청은 서면으로 해야 한다(동법 제39조).

[그림 3-7] 노동보험심사회 심사 절차



출처: <https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/02-02.html>

2) 심리의 흐름

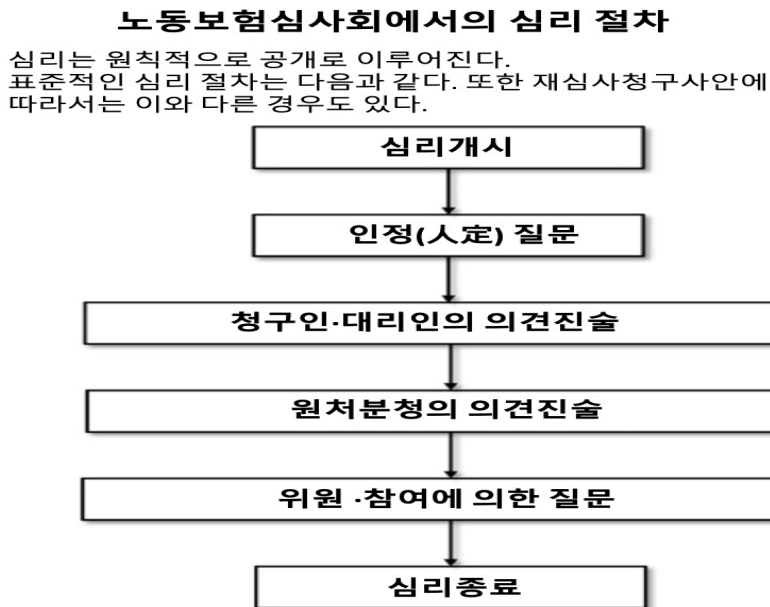
심사관·심사회법 제42조는 “심사회는 심사기일 및 장소를 정하고, 당사자 및 제36조의 규정에 따라 지명된 자에게 통지해야 한다”고 하고 있으며, 재심사 청구를 하

면 노동보험심사회가 일방적으로 심리일을 지정하는데, 당사자 및 그 대리인은 심리기일에 출두하여 의견을 진술할 수 있다(심사관·심사회법 제45조 제1항).

또한, 심사청구 후에 일건 기록이 송부되는데, 이를 잘 살펴 본 후, 의견서를 작성하고 심리기일에 출두하여 의견을 말하고 원처분청에 질문한다(심사관·심사회법 제45조 제5항). 심사청구시와 마찬가지로 노동보험심사회로부터 심리기일에 질문을 하는 경우에는 사전에 질문서를 제출하도록 요구받는데, 심문서의 사전제출 필요성이나 그 내용을 검토해야 하는 것도 심사청구시와 같다.

노동보험심사회의 지정으로 심리는 노동보험심사회 심리실에서 실시되는데(심사관·심사회법 제42조), 각지의 노동국 내의 회의실에서 TV회의 시스템에 의한 심리로 출석하는 것도 가능하다.

[그림 3-8] 노동보험심사회에서의 심리 절차



출처: <https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/02-05.html>

5. 현황 및 사례

(1) 현황²¹⁰⁾

210) 労働保険再審査取扱状況 :

<https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/index.html>

[표 3-15] 업무상 질병의 신규지급 결정 건수 (단위: 건)

	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
1. 업무상 부상에 기인하는 질병	4,221	4,263	4,460	4,491	4,474
2. 물리적 인자에 의한 질병(암 제외) (유해광선, 전리방사선, 이상기압, 이상 습도, 소음, 초음파 등)	756	1,264	1,019	1,071	756
3. 신체에 과도한 부담이 걸리는 작업 양태에 기인하는 질병 (요통, 진동장애, 상지장애 등)	1,322	1,391	1,519	1,441	1,388
4. 화학물질 등에 의한 질병(암 제외) (후생노동대신이 지정하는 화학물질 등 에 의한 질병을 포함)	213	210	210	213	235
5. 분진의 흡입에 의한 질병(진폐증 등)	333	277	272	222	197
6. 세균, 바이러스 등 병원체에 의한 질병(그 중 코로나19감염증)	115	133	122	4,716 (4,556)	19,700 (19,608)
7. 암원성 물질 혹은 암원성 인자 또는 암원성 공정에서의 업무에 의한 질병(직업암)	924	929	1,029	968	952
8. 장기간에 걸친 장시간 업무, 기타 혈관병변 등을 현저하게 증악시키는 업무에 의한 뇌혈관 질환 및 허혈성 심질환 등	253	238	216	194	172
9. 심리적 부하에 의한 정신장애	506	465	509	608	629
10. 전각호에서 열거하는 것 외에, 후생노동대신이 지정하는 질병	2	0	2	2	2
11. 기타 업무에 기인하는 것이 명확한 질병(그 중 코로나19 백신 접종에 관계되는 것(발열증상 등))	0	0	1	5	862 (858)
합 계	8,645	9,170	9,359	13,931	29,367

출처: 厚生労働省, “業務上疾病の労災補償状況調査結果”, 2023.04., 1 頁.

일본에서 업무상 질병으로 인한 산재보험 신규지급 건수를 보면, 2017년도부터 2021년도까지의 통계를 보면, 2017~2019년까지는 다소 증가하는 추세를 보였지만, 2020년에 “세균, 바이러스 등 병원체에 의한 질병”에 코로나19 감염증으로 인해 업무상 질병의 신규 지급 건수는 크게 늘어나 있음을 알 수 있다.

[표 3-16] 노동보험심사회 사건 처리 상황

	청구사건	재결사건	취하사건	남은 건수
2012년도	613	645	16	284
2013년도	659	560	5	378
2014년도	651	550	19	460
2015년도	694	607	9	538
2016년도	529	728	13	326
2017년도	482	408	13	387
2018년도	510	452	6	439
2019년도	547	467	13	506
2020년도	533	577	15	447
2021년도	579	580	12	434

[표 3-17] 이 중 산재보험 처리 건수

	청구건수	재결건수	취하건수	남은 건수
2012년도	568	607	12	267
2013년도	608	509	4	362
2014년도	623	519	18	448
2015년도	633	578	8	495
2016년도	507	673	13	316
2017년도	463	387	12	380
2018년도	483	441	6	416
2019년도	531	442	13	492
2020년도	511	556	14	433
2021년도	559	557	12	423

출처: 労働保険再審査取扱状況 : <https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/index.html>

한편, 노동보험심사회에 재심사청구를 하는 사건 처리 상황을 보면, 청구건수는 매년 다소의 증감은 있으며, 이 중 노동보험심사회의 사건 처리 건수 중 거의 대부분이 산재보험의 청구 및 재결 건수이다.

[표 3-18] 사건 종류별 청구 건수

	업무상 외	장애	치유 인정	재발 인정	근로자 자격	급여 기초	각하 결정	출퇴근 재해	석면구 제법	기타	합계
2012년도	326	94	14	26	11	15	8	14	4	56	568
2013년도	370	99	25	15	10	21	3	13	2	50	608
2014년도	394	101	22	22	8	20	11	12	2	31	623
2015년도	336	82	20	16	12	23	19	21	2	102	633
2016년도	258	87	24	16	11	21	15	20	2	53	507
2017년도	269	55	14	18	2	24	10	6	3	62	463
2018년도	270	46	14	12	9	28	4	10	4	86	483
2019년도	309	58	23	14	9	30	7	8	2	71	531
2020년도	286	72	21	12	7	28	10	14	4	57	511
2021년도	369	68	23	6	7	17	11	9	5	44	559

출처: 労働保険再審査取扱状況:

<https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/index.html>

[표 3-19] 사건 종류별 처리 건수

			업무 상외	장애	치유 인정	재발 인정	근로자 자격	급여 기초	각하 결정	출퇴근 재해	석면 구제법	기타	합계
2019	재결	취소	15	1	2	0	2	6	0	0	0	3	29
		기각	250	47	16	10	8	22	0	12	2	16	383
		각하	15	3	1	1	0	0	8	0	0	2	30
		소계	280	51	19	11	10	28	8	12	2	21	442
	취하		3	2	0	0	0	1	0	0	0	7	13
	합계		283	53	19	11	10	29	8	12	2	28	455
2020	재결	취소	13	1	0	0	1	6	0	2	0	3	26
		기각	322	63	25	14	9	20	0	8	3	33	497
		각하	11	6	1	2	1	2	6	0	0	4	33
		소계	346	70	26	16	11	28	6	10	3	40	556
	취하		2	1	0	0	0	1	0	0	0	10	14
	합계		348	71	26	16	11	29	6	10	3	50	570
2021	재결	취소	18	1	0	1	1	5	0	0	0	3	29
		기각	306	71	22	9	7	22	0	17	4	42	500
		각하	11	0	2	0	0	0	12	0	1	2	28

	소계	335	72	24	10	8	27	12	17	5	47	557
	취하	6	1	1	0	0	2	0	0	0	2	12
	합계	341	73	25	10	8	29	12	17	5	49	569

출처: 労働保険再審査取扱状況:

<https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/index.html>

그리고 이러한 산재보험 재심사 취급 사건의 대부분은 업무상 외와 관련된 것이 대다수를 차지하고 있으며, 대부분의 사건은 기각(원처분이 위법하지도 부당하지 않고 심사청구에 이유가 없다고 인정한 때에 “기각” 결정됨)으로 결정되는 경향을 보이고 있다.

(2) 사례

1) 노동자재해보상보험심사관 결정 사례²¹¹⁾

【개요】

심사청구인(이하 “청구인”이라고 함)에게 발병한 정신장애는 업무상 사유로 인한 것으로 인정된다고 하여, 보험급여를 지급하지 않는다고 한 원처분을 취소한 사례

【요지】

1. 사안의 개요 및 경과

청구인은 상사 및 동료로부터 괴롭힘 및 폭행 등을 당하고, 몸 상태가 좋지 못하게 되어 의료기관에 진료를 받아 정신장애로 진단받았다.

청구인은 정신장애는 업무상에 의한 것이라고 하여 보험급여를 청구하자, 노동기준감독서장(이하 “감독서장”이라고 함)은 업무상의 사유에 의한 것이라고는 인정되지 않는다고 하여 이를 지급하지 않는 취지의 처분을 하였다.

2. 심사청구의 이유

상사 및 동료에 의한 괴롭힘 등 업무에 기인하여 발병했음에도 불구하고, 감독서장이 “상사와의 트러블”이라고 평가한 것은 잘못이고, 업무상 재해로 인정되어야 한다.

3. 원처분청의 의견

(1) 정신장애의 인정기준의 대상이 되는 정신장애를 발병하고 있는 것 및 상사 및 동료

211) <https://www.mhlw.go.jp/content/11400000/000464376.pdf>

로부터의 괴롭힘 및 폭행 후에 발병하고 있는 것에 대하여 의학적인 견지에서 문제가 없다고 판단했다.

(2) 상사 및 동료가 물건을 던지거나 큰 소리로 혼내는 것을 사업장 관계자에게 목격되고 있는데, 청구인이 응수하는 모습도 목격되고 있으며, 청구인은 일방적으로 괴롭힘을 당하고 있었다고는 할 수 없고, 객관적으로 인식되는 트러블이 있었다고 인정하는 것이 상당하다

(3) 상기 (2)에 따라, 구체적인 사건 “상사와의 트러블이 있었다”를 적용하여, 그 평균적인 심리적 부하 강도는 “Ⅱ”로, “중”이 되는 사례 “업무를 둘러싼 방침 등에서 주위로부터도 객관적으로 인식되는 대립이 상사와의 관계에서 발생했다”고 해당되기 때문에, 심리적 부하의 강도는 “중”이라고 판단했다. 또한 정신장애의 인정기준에서의 항상적인 장시간 근로는 없었다고 판단했다.

(4) 업무이외의 심리적 부하에 대해서는 불명확했다.

(5) 이상의 점에서, 발병 전 대략 6개월 간에 청구인이 입은 업무에 의한 심리적 부하의 종합평가는 “중”이기 때문에, 청구인에게 발병한 정신장애는 업무상 사유에 의한 것이라고 인정되지 않는다고 판단하였다.

4. 심사관의 판단

(1) 청구인은 상사 및 동료로부터 인격을 부정하는 발언을 계속적 또한 빈번하게 듣고 있던 점, 던지는 물건에 맞은 경우가 종종 있었으며, 이것은 큰 부상으로 이어질 수 있는 행위로서, 해당 행위에 대해 청구인이 응수했던 것은 자기방어였다고 인정함이 상당하다고 판단했다.

(2) 상기 (1)에서, 구체적 사건 “(심한)괴롭힘, 따돌림, 또는 폭행을 당했다”가 적용되고, 그 평균적인 심리적 부하의 강도는 “Ⅲ”으로, “강”이 되는 사례 “부하에 대한 상사의 언동이, 업무 범위를 일탈하고 있으며 그 중에 인격 및 인간성을 부정하는 언동이 포함되고 또한 이것이 집요하게 행해졌다”에 해당되는 점에서, 심리적 부하의 강도는 “강”이라고 판단

(3) 이상의 사항에서, 발병 전 대략 6개월 간에 청구인이 받은 업무로 인한 심리적 부하의 종합평가는 “강”으로, 청구인에게 발병한 정신장애는 업무상 사유로 인한 것이라고 하는 것이 상당하다고 판단한다. 따라서 감독서장이 청구인에 대해 행한 보험급여를 지급하지 않는다는 취지의 처분은 이를 취소한다.

2) 노동보험심사회 재결 사례²¹²⁾

令和元年劳第380号

212) <https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/saiketu-youshi/dl/R01rou380.pdf>
<https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/saiketu-youshi/dl/R01rou225.pdf>

【주문】

본건 재심사청구를 기각한다.

【재심사청구의 취지】

제1 재심사청구의 취지

노동기준감독서장이 2019년 5월 23일자로 재심사청구인에게 한 노동자재해보상보험법에 의한 요양보상급여 및 휴업보상급여를 지급하지 않는다는 취지의 처분을 취소하는 것을 요구한다.

제2 사실의 개요

1. 재심사청구인(이하 “청구인”이라고 함)은 2003년 7월에 A소재의 B회사에 고용되어 택시 운전사로 업무에 종사하고 있었다.

2. 청구인은 2009년 1월 9일, C의료기관에서 “심신증”으로 진단받았다.

청구인에 의하면 2009년 1월 5일에 출근했을 때, 상사 등으로부터 서약서 등에 서명하지 않으면 자기퇴직 또는 징계해고의 어느 한 선택을 강요받음으로써 정신적인 충격을 받았다고 한다.

3. 청구인은 상기 정신장애를 발병했던 것은 업무상 사유에 의한 것이라고 하여, 2009년 1월 7일부터 2010년 10월 31일까지 동안의 휴업보상급여의 청구를 하자, 노동기준감독서장(이하 “감독서장”이라고 함)은 2011년 3월 30일자로 이를 지급하지 않는다는 취지의 처분(이하 “전회 처분”이라고 함)을 하였다.

청구인은 이 처분에 불복하여 심사청구를 거쳐 재심사청구를 하였는데, 당 심사회는 2012년 2월 29일자로 이를 기각하였다(平成23年労第429号. 이하 “전재결”라고 함).

그 후 청구인은 2013년 9월부터 장애후생연금을 수급하고 있었는데, 해당 연금의 장애인정일을 둘러싼 국가와의 소송 판결(이하 “고재(고등법원)판결”이라고 함)에서, 장애인정일인 2010년 7월 9일에 상병명 “우울상태”라고 인정받았다.

4. 본건은 청구인이 고재판결로 판명된 사실을 바탕으로 판단되었다고 하여, 재차 요양보상급여 및 2010년 11월 1일부터 2019년 3월 31일까지 동안에 휴업보상급여의 청구를 각각 하자, 감독서장은 이를 지급하지 않는다는 취지의 처분(이하 “본건 처분”이라고 함)을 했기 때문에, 이를 불복하여 본건 처분의 취소를 요구한 사안이다.

5. 청구인은 노동자재해보상보험심사관에게 심사청구를 하자, 동심사관이 2019년 9월 5일자로 이를 기각하는 취지의 결정을 했기 때문에, 이 결정을 불복하여 본건 재심사청구를 했다.

제3 당사자의 주장 요지

1. 청구인(생략)

2. 원처분청(생략)

제4 쟁점

청구인에게 발병한 정신장애가 업무상 사유에 의한 것이라고 인정되는가?

제5 심사자료(생략)

제6 이유

1. 당심사회의 사실 인정(생략)

2. 당심사회의 판단

(1) 본건 처분 가운데, 휴업보상급여는 전회처분에 관한 청구와 동일한 이유에 의한 후속청구라고 인정되는 바, 전재결에서 청구인에게 발병한 정신장애는 업무상 사유에 의한 것이라고는 인정되지 않는다고 판단하고 있다.

또한 본건 처분 가운데 요양보상급여는 전재결에서 업무상 사유에 의한 것이 아니라고 판단된 청구인에게 발병한 정신장애와 동일한 정신장애에 관한 것이다.

(2) 청구인은 고재판결의 사실인정에 근거로 하여 판단해야 한다는 취지를 주장하지만, 결정서에 실시하는 바와 같이, 노동자재해보상보험법과 후생연금보험법은 다른 제도이기 때문에, 청구인의 주장은 채택할 수 없다.

(3) 본건 재심사청구에 있어 재차 1건 기록을 정밀히 조사했는데, 새로운 사실 및 증거도 없고 전재결에서의 판단을 변경해야 하는 이유는 인정되지 않는다.

(4) 그런데 인정기준에 대하여 후생노동성 노동기준국장은 2020년 5월 29일자 기발 0529 제1호로서 인정기준 별표1을 개정했는데, 개정된 인정기준으로 검토를 해도 상기 판단을 좌우하지 않는다.

3. 결론

따라서 본건 처분은 타당하고, 이를 취소해야 하는 이유는 없기 때문에, 청구인의 본건 재심사 청구를 기각하기로 하고, 주문과 같이 재결한다.

2020년 7월 10일

III. 시사점

일본의 노재보험법상 산재보험 절차와 관련하여 요약하면 다음과 같다. 일본의 노재보험법상 재해보상급여에서 업무재해의 여부를 판단하는 것은 노동기준감독서장

이다(노재보험법 시행규칙 제1조 제3항). 노재보험법상 업무재해에 관한 보험급여는 피재근로자 또는 그 유족 등이 노동기준감독서장에게 그 급여 청구를 함으로써 이루어진다(노재보험법 제12조의 8 제2항). 이 피재근로자 또는 유족 등으로부터의 청구에 대한 노동기준감독서장의 결정에 불복이 있는 자는 각 도도부현 노동국 내의 노동자재해보상보험심사관에게 심사청구를 할 수 있고(노재보험법 제38조 제1항), 그 노동자재해보상보험심사관의 결정에도 불복이 있는 자는, 후생노동성 내의 노동보험심사회에 재심사청구를 할 수 있다(노재보험법 제38조 제1항). 그리고, 이 노동자재해보상보험심사관 및 노동보험심사회의 결정에 불복이 있는 자는 법원에 노동기준서장의 결정의 취소소송을 제기할 수 있다(노재보험법 제40조, 행정사건소송법 제3조 제3항).

이와 같이 일본의 산재보험급여에 관한 노동기준감독서장의 결정에 대해서는 산재신청을 한 근로자 측에게는 노동자재해보상보험심사관에 대한 심사청구, 노동보험심사회에 대한 재심사청구, 행정처분에 대한 취소소송(심사청구를 거친 후라면 제기 가능. 1심 내지 상고심까지 3심제) 등의 불복신청의 기회가 주어진다고 정리해볼 수 있다.

상기와 같이 살펴본 일본에서의 산재보험 절차와 관련하여, 다음의 시사점을 도출해볼 수 있다.

첫째, 일본에서도 산재보험의 보험급여의 결정에 대해 불복신청절차의 실질화를 위해 산재보험급여 결정에 대한 불복신청 절차가 개선된 것을 평가할 수 있다. 일본 정부는 행정불복심사법의 개정과 시행을 통해, 공정성의 향상, 이용편리함의 향상, 국민의 구제수단의 충실 및 확대를 목표로, 이중전치 제도를 해소하고, 법률에 따라서는 일부폐지·일부준치의 조치가 취해지게 되었다. 산재보험의 청구절차에 대해서는 종래의 이중전치가 재심사 단계에서 노동보험심사회의 필연적 전치는 폐지되고, 재심사 청구 또는 법원에 제소하는 것을 청구인의 선택에 맡기는 “일중전치화”가 되어, 산재보험의 재심사 청구에 있어 절차가 개선된 것을 평가할 수 있다.

둘째, 일본에서 업무상 질병의 산재인정의 원처분은 노동기준감독서에서의 조사 등으로 이루어지고 있는데, 필요에 따라 청구인, 사업장 관계자로부터의 청취 및 서류 제출 의뢰, 의사 등에 대한 의견서 의뢰 등을 한다. 그리고 업무가 원인인 부상 및 질병의 여부를 판단하는데 있어, 각각의 업무상 질병에 대한 구체적인 인정기준

을 엄격하게 갖추고 있고 이에 따라 산재의 인정여부를 판단하고 있다. 이러한 인정기준은 각 질병에 대한 현재의 의학적 지견을 집약하고 해당 질병과 업무와의 관계에 대한 유해인자와 그 노출기간 등 및 이로 인해 발생하는 질병 병상, 경과 등을 제시하고 있는 것으로 평가할 수 있다.

셋째, 산재보험의 심사청구와 관련하여 2014년 행정불복심사법과 관련법이 개정되어 심사청구제도를 사용하기 쉽도록 하기 위하여, (i) 심사청구기간으로 종래 60일에서 3개월로 연장하였고, 또한 (ii) 재결까지의 기간의 목표가 되는 “표준심리기간” 설정을 노력의무화하여 심리의 신속성 확보를 도모하고 있는 점에서 시사점을 도출할 수 있다. 특히 표준심리기간의 설정과 관련해서는 행정불복심사법 제16조에 따라, 심리의 지연을 막고, 심사청구인의 권리이익의 신속한 구제를 도모하는 관점에서, 심사청이 사전에 심리기간의 목표가 되는 것으로 표준심리기간을 정하도록 노력해야 하는 것이 규정되었다. 이전에는 산재보험 심사청구의 결정이 되기까지 반년부터 1년 정도 걸리는 경우가 적지 않았는데, 2016년 4월에 시행된 이 법 개정으로 심사청구절차에서의 표준심리기간을 마련하도록 노력하여, 가능한 한 3개월 이내에 처리를 하는 것으로 되어,²¹³⁾ 심리의 신속성이 도모되었다고 평가할 수 있다.

213) <https://fukushima-rousai.com/fufuku-saishinsa>

제4장 결 론 - 산재 절차 개선 입법정책적 개선방안 -

I. 산재보험 판정절차의 문제점과 개선 방향

1. 절차적 문제점

산업재해보상보험법의 규율 목적은 산업재해에 따른 제반 손해를 합리적으로 전보하고 건강과 노동능력을 회복하는 데 필요한 제반 사항을 제도화하는 데 있다.²¹⁴⁾ 충분한 보상도 중요하지만, 신속하게 보상이 이루어지는 것도 중요하다. 결국, 산재보상보험제도의 지향점은 충분한 보상과 신속한 보장 원칙과의 조화이다.

유감스럽게도 산재보상보험 절차에서 업무상 재해를 이유로 한 요양승인 등 산재 승인신청 이후 공단의 결정이 내려지기까지 상당한 시간이 소요되는 문제점이 있다. 그 주된 원인은 업무상 사고보다는 업무상 질병의 판정 처리의 장기화 현상이다.

특히 업무상 사고에 비해 업무상 질병은 그 발병원인이 다양해서 그것이 업무로 인한 것인지를 쉽게 판단하기 어렵다. 그만큼 질병은 업무상 재해로서 산재보상의 대상으로의 포섭 여부를 판단하는 데 상당한 기간이 소요될 개연성이 크다.

또한, 업무상 질병의 속성상 급성 중독이나 감염증 같은 것이 아닌 한, 그 발병의 시기도 근무기간 계속 중이 아니라 고용관계 종료 후 상당기간이 지난 후에도 발생할 수 있기 때문이다. 결국, 건강보험제도와 산업재해보상보험제도가 엄격히 구별되어 시행되고 있는 우리나라의 사정에서는 질병과 업무관련성의 판단에 신중을 기할 수밖에 없는 실정인 것은 맞다.

그럼에도 불구하고 업무상의 이유로 질병이 발병했다고 생각하는 피재근로자로서는 신속한 산재판단과 그에 따른 요양급여 등 보험급여의 조기 지급에 대한 요구나 요청이 더 강할 수밖에 없다. 이러한 피재근로자의 상황과 요청을 대변하여 노동계뿐만 아니라 정치권에서도 보험관장자인 고용노동부장관과 보험자인 근로복지공단

214) Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht-Ricke, 2009, § 1 SGB VII, Rn.1.

으로 하여금 산재보험 처분이 객관성을 잃지 않으면서도 신속하게 처리할 것을 강하게 주문하고 있는 실정이다.

결국, **산업재해보상보험 업무처리절차 개선의 핵심은 처리기간의 단축**이라고 할 것이다. 사후 산재승인이 이루어진다고 해도 산재처리기간이 지연된다면 적절하고 적시의 요양이 이루어지지 못해서 상병이 악화되거나 심한 경우에는 사망에 이를 위험성이 고조될 수도 있으며, 산재승인이 종국적으로 거절된 경우에는 보험당국이 피재근로자와 유족을 장기간 불안정한 위치에 방치했다가 승인조차 거부하고 말았다는 원망을 듣게 될 수도 있기 때문이다. 따라서 이하에서는 **산재판정의 공정성을 잃지 않으면서도 산재처리기간을 단축시키는 데에 기여하는 절차적 방안에 주목하여 입법정책적 개선방안을 제안한다.**

2. 절차개선의 방향

앞에서도 지적하였듯이 산재업무의 처리기간의 장기화를 불러일으키는 주된 원인은 업무상 사고로 인한 부상, 사망 보다는 업무상 질병 때문인 것으로 분석된다. 따라서 처리기간 단축도 업무상 질병의 처리기간 단축에 초점을 맞출 필요가 있다. 그러기 위해서는 산재처리업무에 종사하는 전문인력과 예산이 확충되는 것이 가장 바람직하겠으나 주어진 한계조건에서 기간 단축을 위한 효율적인 개선방안을 모색하는 것이 현실적이다. 이를 위해서는 **산재처리절차를 효율화하고 정형화된 업무상 질병의 처리 부하를 경감하는 한편 업무상 질병 처리에 관한 기간을 표준화해두어, 무분별하게 업무상 질병 처리가 지체되지 아니하도록 촉구함으로써, 산재판정의 신속성을 제도적으로 뒷받침하는 한편 중복적인 이의제기 절차를 실제적 판단에 지장이 없는 한도에서 단순화하는 것이 필요하다.**

이러한 개선원칙을 정리하면 다음과 같다.

<개선 방향>

첫째, 산재처리 프로세스의 효율화이다. 즉 산재신청사건의 업무처리 프로세스 중에서 가능한 범위에서 중복적인 판단 절차를 최소화하여 업무처리의 효율성을 높이는 것이다(예컨대 상병명의 조기확정). 또한, 예기치 않은 돌발변수의 발생

가능성을 절차적으로 분리하여 사전 차단함으로써 프로세스의 원활한 진행에 방해요소가 되지 않도록 관리한다.

둘째, 처리 부하의 경감과 선택적 집중이다. 업무관련성 인정률이 상대적으로 높은 질병에 관한 산재신청은 종래 패스트트랙 절차를 더욱 적극적이고 신속하게 진행시킴으로써 공단의 업무처리 부담을 줄이고, 이를 통해 여유가 생긴 가용인력과 자원을 다른 복잡하거나 난이도 있는 사건처리에 집중시킨다. 동시에 객관적 평가를 통해 패스트 트랙의 대상범위를 확대시키는 노력을 병행한다.

셋째, 표준처리기간 사전고지제 실시이다. 산재신청사건 중 업무상 질병에 관련해서는 처리에 소요되는 표준적인 기간을 정형화해 두고, 이를 신청인을 포함한 관련자에게 참고하도록 사전고지하는 등의 방식으로 표준기간을 가능한 한 준수하도록 권고한다. 다만 합리적 이유가 있는 경우에는 표준기간 상회 여부와 상관없으며, 다만 피해자 등에 대한 지체 이유 통지절차 등을 마련해 둘 필요가 있다. 나아가 표준기간 준수율을 기준으로 한 인센티브의 제공도 고려해 볼 만하다.

넷째, 산재판정에 관한 불복절차의 간소화이다. 물론 이를 위해서는 판정의 신뢰성 확보방안이 함께 모색되어야 할 것인바, 상기의 개선방안들이 긍정적인 시너지 효과를 낼 때 중장기적으로 달성가능하다고 본다.



이를 위한 세부실행과제는 다음과 같다.

<세부실행과제>

1. 산재처리 프로세스의 효율화

① 업무기인성 판단과 직접적인 관련은 없는 근로자성 등 피보험자격 판단은 고용노동부 지방노동청의 별도 부서(가칭 '산재피보험자격심사관')에서 진행하도록 함으로써 심사위나 재심사위 절차에서 이에 관한 판단 부담을 줄인다.

② 특별진찰이나 근로복지공단 산하 병원의 해당 분야 전문의의 상병명 판단은 추정의 원칙에 따라 특별한 반증이 없는 한 조기 확정함으로써 업무 관련성 판단에 집중할 수 있도록 한다(업무상질병자문위원회나 전문위원회의 재검토의뢰 및 산업재해보상보험재심사위원회에 의한 중복판단 최소화).

③ 종합병원급 이상과 근로복지공단 산하 병원의 의사는 산재에 대한 합리적인 의심이 있는 경우 보고할 의무를 부담시키는 한편 해당 주치의의 소견서는 상병명 판단에 신중을 기하도록 병원내부 의사결정 절차를 거쳐 병원명으로 작성하여 제출되도록 한다.

2. 처리부하의 경감을 통한 가용자원의 선택적 집중

① 포괄주의가 아닌 열거주의에 따라 산업재해보상보험법령과 근로기준법령의 별표에 명시된 질병목록 중에서 객관적으로 업무관련성이 인정될 수 있는 질병 목록들을 선별하여 패스트 트랙절차를 활용하여 판정기간을 단축한다. 즉, 패스트 트랙절차의 대상질병의 확대를 지속적으로 모색한다.

② 현재 인정된 특정 근골격계 질병의 패스트 트랙절차는 소속기관장의 재량으로 업무상 질병판정위원회의 절차를 생략할 수 있도록 한다(상병명 불확실 등 필요한 경우에만 질판위 심의의뢰).

3. 업무상 질병 처리에 대한 표준기간 준수권고제 도입

① 공단의 소속기관장은 산재신청사건의 특성을 고려하여 업무상 질병의 요양승인신청을 접수받은 후 일정기간(예컨대 7일 내지 10일) 안에 신청서류를 검토한 후에 적절한 판정처리에 필요한 표준심의기간(심사위나 재심사 기간은 제외/근로자성 등 피보험자격 판단에 소요되는 기간은 제외) 범위 내에서 처리되도록 권고하는 절차를 마련해 둘 필요가 있다.

② 표준기간을 도과하는 경우에는 그 사유와 진행상황 등을 신청인 등에게 확인

할 수 있도록 할 필요가 있다.

4. 불복절차의 간소화

① 업무상 질병 판단과 관련해서 업무상 질병판정위 심의를 거쳤거나 혹은 질판위 절차가 생략되었기에 소속기관장이 내린 원처분에 불복하는 경우에는 동일 기구 내에 설치됨으로써 질판위와 중복적인 성격이 강한 산업재해보상보험심사위 절차는 생략하고 곧바로 고용노동부의 산업재해보상보험재심사위로의 심사청구를 가능하게 한다.

② (가칭)산재피보험자격심사관으로부터 근로자가 아니라거나 노무제공자가 아니라는 판단회신을 받은 경우에는 소속기관장이 요양승인신청을 거절하도록 하고 이 결정(처분)에 대해서는 산업재해보상보험재심사위로의 재심사청구를 하지 못하도록 하고 그 원처분에 대하여 곧바로 행정소송을 제기할 수 있도록 한다.



재해 판정에 대한 신뢰성 확보와 수용성 제고

이러한 절차 개선을 통해 궁극적으로 업무상 재해 판정에 대한 신뢰확보 및 당사자의 수용성을 제고할 수 있을 것이다. 이상의 내용을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

II. 역할 분담을 통한 판정처리 절차의 효율성 제고

1. 피보험자격 확인을 전담하는 (가칭)산재보험심사관제 도입

(1) 문제점

재해를 당한 자가 산재보험급여를 받기 위해서는 업무상 재해에 해당되는 점이

인정되는 것 외에도 먼저 근로자 자격이 있는지가 별도로 확인되어야 한다. 나아가 최근 전속성 요건이 삭제된 노무제공자의 산재보험 확대에 인하여 재해를 당한 자가 과연 피보험자격이 있는지를 판단하는 것은 좀 더 복잡한 판단대상이 되었다.

이 문제를 업무상 질병판정위원회나 심사나 재심사단계에서 판단하는 것은 절차를 복잡하게 하는 것일 뿐만 아니라 판단의 전문성도 담보되지 않을 수 있다. 이에 대한 개선안을 강구할 필요가 있다.

(2) 개선안

① 근로자성, 노무제공자 여부 등을 포함한 피보험자격 확인은, 고용노동부 지방 고용노동청에 (가칭)산재보험심사관을 두어 이를 전담시킴으로써 역할 분담을 하는 것이 바람직하다. 근로복지공단 소속기관의 장이 신청접수 또는 재해조사 단계에서 피보험자격이 문제된다고 판단한 경우에는 이를 전담하는 (가칭)산재보험심사관에게 심의를 의뢰한다.

산재보험심사관에 대한 심사의뢰가 있더라도 소속기관의 장은 업무상 질병 판정을 위한 재해 조사나 업무 관련성 여부를 동시에 조사할 수는 있지만, 어느 경우이든 질판위나 소속기관의 산재여부 결정은 산재보험심사관에 의한 심사결과가 통보된 이후에만 가능하도록 설계할 수 있다.

② 한편 불복절차와 관련해서는 (가칭)산재보험심사관이 근로자나 노무제공자가 아니라는 이유로 피보험자 자격을 부인하면 이에 불복하는 신청인은 이를 처분으로 보아 법원에 곧바로 그 취소를 구하는 행정소송을 제기하도록 한다.

구체적으로 그 과정을 설계하면 피보험자격에 관한 산재보험심사관의 부정적 판단을 회신받은 소속기관장은, 신청인의 피보험자격 없음을 이유로 요양 승인이나 산재 인정 신청을 거부하는 결정을 내리고 이를 신청인에게 통보하는 것이다(업무상 질병과 마찬가지로 업무상 사고의 경우도 소속기관장이 산재보험심사관의 회신에 따라 곧바로 불승인 결정 통보). 이에 불복하는 신청인은 소속기관장의 결정을 처분으로 보아 행정법원에 취소소송을 제기하여 법원의 판단을 받도록 한다. 즉 이에 대해서는 산업재해보상보험 심사위원회나 재심사위원회에 심사나 재심사를 제기하지 못하도록 하여 처리절차를 효율화한다.

2. 피재근로자 상병명에 대한 주치의 소견서 작성 개선

(1) 산재판단 절차상 「주치의 의견」의 문제점

직업병이나 사고를 당하여 재해가 발생한 피재 근로자는 의료기관에서 치료를 받게 된다. 이때 치료는 신속하면서도, 충분하게 이루어져야 한다. 피재근로자에 대한 치료비용의 부담은 업무상 재해 여부에 따라 달라지게 된다.

피재근로자에게 있어 “‘업무상 재해’ 여부에 대한 판단은, (i) 1차적으로는 피재근로자 개인에 의해 행해진다. 다만 (ii) 재해를 입은 근로자의 치료 과정 또는 치료 후에 그 치료를 담당하는 의사 등은 해당 피재 근로자에게 업무상 재해 여부에 대한 “주치의 의견”을 제공하게 되는데, 이 또한 현재 산재판단절차에서는 피재근로자에 의해 산재접수가 이루어질 때 함께 제출된다.

그런데 주치의의 업무상 재해 여부에 대한 의견은, 피재근로자의 산재 절차의 접수 여부는 물론이고, 산재 여부에 대한 행정 및 사법 판단 절차 이행 여부에 대한 결정에 상당한 영향을 미친다고 볼 수 있다. 피재근로자의 불만은, 업무상 재해 여부에 대한 근로복지공단 또는 산업재해재심사위원회의 심사절차과정에서 주로 “왜 자신의 주치의 의견과 공단 또는 재심사위원회의 판단이 상이한가?”에 집중되는 경향이 있다.

물론 전문성이나 자료의 정밀성 등의 차이가 있어 업무상 재해에 대한 판단이 달라질 수는 있겠지만, 피재근로자로서는 자신에게 유리하다고 판단되는 주치의 등 전문가의 의견을 - 과도하다고 볼 수 있을 만큼 - 신뢰하면서, 산재인정 절차를 개시 및 지속하게 된다. 이와 달리 산재인정 절차과정에서의 근로복지공단이나 재심사위원회는 주치의 의견에 대해 과소평가하는 경향도 보인다. 그 결과 근로복지공단측의 자문이나 특별진찰에서 피재근로자의 상병코드가 주치의와 달라지는 경우도 흔하다.

결국 주치의 의견에 대한 피재근로자와 산재 판단 주체 간에는 상당한 인식의 괴리가 나타나며, 이러한 괴리는 양측 사이에서 불필요한 갈등과 소모적인 분쟁의 발생 및 지속을 초래하게 된다. 이는 결국 해당 피재근로자는 물론 공단이나 국가행정력의 낭비로 이어지게 되고 된다. 따라서 주치의 의견의 공식성을 보강할 필요가 있다. 다시 말해 주치의 의견에 대한 객관성과 신중성을 높이는 것은, 불필요한 산재인정 절차의 남발을 막을 수 있으며, 나아가 산재 인정 여부를 판단하는 공단이

나 행정기관의 심사결과를 존중하게 만드는 데 기여할 수 있을 것으로 보인다.

(2) 개선방안 : 종합병원급 이상 및 근로복지공단 병원은 병원차원의 작성

① 종합병원 주치의의 업무상 질병 신고의무와 의견견서 작성의 공적 절차화를 법령에 명시해둘 필요가 있다. 구체적으로 보면 종합병원 이상의 의료기관과 근로복지공단 병원(현재 전국 10개 병원과 3개 의원)에 근무하는 주치의가 업무상 재해 특히 업무상 질병 여부에 대한 의견서 작성을 피재근로자로부터 요청받는 경우에도 그 의견서는 해당 주치의 명의 하에서 재량적으로 작성되도록 할 것이 아니라, 해당 주치의의 의견을 받아 병원의 명의로 작성하여 제출되도록 하는 제도개선을 고려할 필요가 있다.

② 종합병원급 이상의 의료기관에서는 담당 주치의가 의견서를 작성하면 병원 측은 적어도 해당 분야 및 관련 분야 2인 이상의 전문의의 검토를 거쳐 의견서 발급을 추진해서 병원 명의의 의견서를 내도록 하는 절차를 둔다면 업무상 재해 판단 절차에의 참여가 남발되는 일은 다소나마 줄일 수 있을 것으로 보인다. 물론 이런 과정을 통해 제시된 상병명과 상병코드가 종국적으로 확정된 것으로 보지는 않더라도 추정의 원칙에 따라 자문위나 질판위나 특별진찰에 따라 다른 상병명으로 확인되기까지는 잠정적인 위치를 인정받아야 할 것이다. 특히 근로복지공단 산하 병원(병원 10개, 3개 의원은 제외) 그리고 직업병 안심센터가 개소된 거점 종합병원과 협력병원의 경우²¹⁵⁾에는 그 병원명의로 상병명 및 상병코드는 신청인측이나 다른 특별한 반증이 없는 한 추정의 원칙에 따라 잠정적인 지위를 부여할 필요가 있다.

<보론> 병원급 이하의 주치의 소견서 문제

종합병원급이 아닌 병원급 이하의 소규모 의료기관에 대해서는 병원 명의의 소견서 발급이나 산재의심 신고의무까지 부담시키기에는 행정인력이나 자원이 부족한 것이 현실이다. 따라서 현재와 같이 주치의의 소견서 발급방식을 유지할 수밖에 없을 것이다.

다만 이 경우에도 주치의의 상병코드는 가능한 한 상단분류로 간소화(예 : F43 심한 스트레스에 대한 반응 및 적응장애)해서 분류하도록 안내하고, 그 이후에

215) 현재 10개 권역에 10개의 거점 종합병원에 직업병 안심센터가 개소되어 있고, 총 104개의 협력병원과 업무협약이 체결되어 있다.

근로복지공단이 의뢰하는 자문위원회나 특별진찰 혹은 질병판정위 단계에서 비로소 상병명과 상병코드가 확정되도록 할 필요가 있다.

3. 종합병원급 의사의 업무상 질병 의심사례 신고의무 및 점진적 확대

(1) 문제점

① 해당 재해 치료를 담당하는 의사 등은 가장 먼저 업무상 재해 여부를 객관적이고 전문적으로 판단할 수 있는 주체이다. 그럼에도 불구하고 현실적으로는 피재근로자의 주장이나 의견을 충분한 분석평가 없이 그대로 수용하여 주치의 의견서가 작성되는 경우가 발생할 수 있다. 독일의 경우에는 직업병 신고는 의사의 의무사항이다. 따라서 의사가 재해근로자를 치료하는 과정에서 직업병인지 의심되는 경우 산재보험조합에 신고해야 한다(사회법전 제7권 제202조). 물론 이때 직업병 여부에 대한 의심은 의심일 뿐 적극적인 산재 판단이 아니지만 의사는 업무상 질병이라는 ‘합리적 의심’이 있는 경우에 신고를 해야 하는 법적인 의무를 가지고 있다.²¹⁶⁾

② 이처럼 우리의 경우에도 질병 내원환자를 처음 진료하는 의사의 업무상 질병 의심 사례를 신고하도록 제도화를 촉진해 나갈 필요가 있다. 또한 2022년부터 급성중독과 같은 업무상 질병에 대한 즉각 대응과 모니터링을 위해 대학병원과 권역응급의료센터, 지역응급의료기관, 종합병원의 직업환경의학과 또는 응급의학과를 중심으로 구성된 직업병 안심센터가 개소하여 협력병원과 함께 운영되고 있다. 이를 활용할 수 있다고 본다.

<보론> 직업병 안심센터

2022년 시작된 직업병 안심센터란 지역별 거점 종합병원을 중심으로 관할 지역의 여러 의료기관과 협력을 통해 근로자들의 직업성 질병을 찾아내는 모니터링 체계를 말하는 것으로 질병이 발생한 근로자가 먼저 병원 또는 응급실에 방문하게 되었을 때, 초기 진단 단계에서 의사들이 질병과 직업의 관련성이 있다고 의심하게 되면 직업환경전문의에게 연계하고 이를 연계받은 전문의는 환자의 상태

216) 김인아 외, 「업무상 재해 인정기준 및 구체적 판정절차에 대한 해외사례 연구」(고용노동부 정책연구보고서), 2015, 74면

와 직업과의 관련성을 파악, 유사한 질병이 확산될 가능성이 있다고 판단되면 관할 고용노동청 근로감독관 등과 협업하여 조사·지원에 나서는 등 후속조치를 수행해 직업성 질병을 조기에 인지하고 추가적인 환자 발생을 예방하는 기능을 담당한다.²¹⁷⁾ 직업병 안심센터 사업은 특히 급성 중독과 같이 갑자기 발생하는 질병에 관한 대응에 효과적일 것으로 기대된다.

<센터 현황>²¹⁸⁾ 2023년 6월 현재 “서울, 인천, 강원, 경기남부, 경기북부, 대구, 부산·울산, 경남, 광주, 대전·충청”의 10개 직업병 안심센터가 있으며 센터당 구성인원은 평균 11.5명이다. 직업환경의학 전문의는 센터당 2~5명, 전공의는 평균 3.1명, 간호사는 1~3명, 산업위생기사는 평균 2.3명이다. 모든 직업병 안심센터에서 전체 임상과 협진의뢰가 가능하도록 구성하고, 공통적으로 호흡기내과, 응급의학과, 피부과를 포함하였다(급성중독증이나 폐암 등에 대응차원). 직업병 안심센터의 협력병원은 의원급과 병원급은 거의 없고 주로 상급종합병원(현재 30개)과 종합병원(현재 62개)이 주를 이룬다.

(2) 개선안

① 업무상 질병에 대한 산재신청을 신속히 하기 위해서 산재보험 의료기관인 종합병원 이상의 의료기관과 근로복지공단 병원(현재 전국 10개 병원과 3개 의원), 그리고 직업병 안심센터가 설치된 의료기관과 그 협력병원에 근무하는 주치의는 업무상 질병이라는 ‘합리적 의심’이 드는 경우에는 병원 내부의 의사결정 과정을 거쳐 병원의 명의로 상병명과 상병코드를 정하고 이를 의무적으로 근로복지공단이나 건강보험공단에 제출되도록 할 필요가 있다. 이 같은 업무상 질병 신고제도가 정착된다면 피해근로자의 절차적 부담을 완화시킬 수 있다.²¹⁹⁾

② 신고의무는 의료기관의 성격을 고려하여 단계별 확대가 현실적이다. 우선 1차적으로는 근로복지공단 병원과 직업병 안심센터가 설치된 의료기관을 대상으로 업무상 질병이 의심되는 사례에 대한 의사의 신고의무를 부여하고 다음으로 2차적으

217) 김정연, “직업병 안심센터를 운영하며”, 『OSHRI:View』(2023년 제2호), 산업안전보건연구원, 2023.6., 9면

218) 하제철, “직업병 안심센터 현황 및 자료수집 체계”, 『OSHRI:View』(2023년 제2호), 산업안전보건연구원, 2023.6., 16-17면에서 발췌

219) 김경하, 「직업성 암 요양결정 사례 및 판례분석 연구」, 근로복지공단 근로복지연구원, 2019, 88면

로 특진의료기관을 포함한 종합병원급 이상의 의료기관 소속 의사의 신고의무를 부여하는 식으로 확대해 나가는 방안을 고려할 필요가 있다.

후자와 관련해서 이미 산재보험법 시행령 제118조(특진의료기관) 제5항에서는 “특진의료기관은 제117조제1항제3호에 따른 진찰결과 업무상 질병에 해당된다고 판단되는 경우에는 진찰받은 사람과 같은 장소에서 동일 또는 유사한 유해요인에 노출된 근로자에게 법 제41조에 따른 요양급여 신청에 관한 상담, 안내, 그 밖에 필요한 지원을 할 수 있다.”라고 정하고 있어서 업무상 질병에 대한 신고의무를 부여하는 것이 크게 어렵지는 않을 것으로 본다. 유의할 점은 이상에서 제안한 종합병원급 이상 의료기관 소속 진료의사의 산재의심 신고의무는, 앞의 2에서 언급한 종합병원 명의의 소견서 작성원칙과 셋트로 운용해야 신뢰성과 공정성을 확보할 수 있다는 점이다. 그렇지 않고 종합병원 명의의 소견서 작성만을 시행한다면 산재신청을 어렵게 만든다는 비판을 받을 수 있기 때문이다.

4. 상병명 판단에 관한 소위원회 역할의 명확화

(1) 소위원회 제도 현황

현행 산업재해보상보험법상 보험급여결정과 관련하여 소위원회 제도는 업무상질병판정위원회 심의단계, 그리고 산업재해보상보험 심사단계와 재심사단계 등 모든 단계에서 운영되고 있다. 산업재해보상보험재심사위원회에서 전문분야별 소위원회(5명 이내 구성)와 업무상질병판정위원회의 소위원회(3명 구성), 그리고 산업재해보상보험심사위원회에 두는 전문분야별 소위원회(5명 이내 구성)가 그것이다. 소위원회라는 용어가 명시적으로 사용된 법령(법률, 대통령령, 시행령)을 살펴보면 산업재해보상보험재심사위원회의 소위원회는 시행령 제111조²²⁰⁾이며, 업무상질병판정위원회의 소위원회는 시행규칙 제9조의²²¹⁾이다. 나머지 산업재해보상보험심사위원회의 소위원회의 근거는 실상 공단의 내규인 「산업재해보상보험 심사업무처리규정」 제23조에 불과하다.

220) 시행령 해당 조문의 근거는 산업재해보상보험법 제107조 제10항 “재심사위원회의 조직·운영 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다”는 규정이다.

221) 시행규칙 해당 조문의 근거는 산업재해보상보험법 제38조 제3항 “판정위원회의 구성과 운영에 필요한 사항은 고용노동부령으로 정한다”는 규정이다.

(2) 문제점

업무상 질병과 관련한 요양승인 판정과 불복절차에서 문제되는 것 중의 하나는 상병명의 확인 문제이다. 산업재해보상보험재심사위원회에서 특정위원인 1명 의사의 의학적 소견에 의해 처분청 자문의사나 질병판정위원회 의사(위원), 산재보험심사위원회 의사(위원)의 의학적 소견이 모두 무시된 채 재결되는 사례가 있어 업무상 질병의 상병명 진단과 이에 관한 판정의 일관성을 해치는 경우가 종종 발생한다. 물론 산업재해보상보험재심사위원회는 법률이 부여한 행정심판에 준하는 권한에 따라 공단의 업무상 질병 여부에 관한 보험급여에 관한 결정에 대한 원처분을 둘러싼 재심사청구에 대해 인용과 기각, 각하 등의 결정을 내릴 권한이 있다.

문제는 업무상 질병의 인정의 출발점은 업무관련성 이전에 상병명의 확인이라고 할 것임에도 불구하고 상병명과 관련하여 직접진찰도 해 보지 않은 재심사위원 의사가 제출받은 자료만으로 그 이전까지의 전문의 의사의 진찰과 소견을 쉽게 부인할 수 있는 재심사 시스템의 취약성에 있다. 따라서 상병명 진단과 확인에 관한 의외성을 줄이고 신중을 기하는 방향으로 보완이 필요하다. 그래야만 불복절차가 장기화되는 것을 방지하고 판정의 일관성과 안정성을 확보할 수 있다. 이를 위해서는 업무상 질병판정위원회와 산업재해보상보험재심사위원회의 소위원회의 역할과 임무를 명확히 하여 업무상 질병의 상병명이나 업무관련성 판단과 관련해서 신중을 기하도록 할 필요가 있다.

(3) 개선안

① 법 제119조(진찰 요구)는 공단은 보험급여에 관하여 필요하다고 인정하면 대통령령으로 정하는 바에 따라 보험급여를 받은 사람 또는 이를 받으려는 사람에게 산재보험 의료기관²²²⁾에서 진찰을 받을 것을 요구할 수 있도록 정하고 이에 따라 법 시행령 제117조(진찰 요구 대상 등) 제1항은 공단이 진찰을 요구할 수 있는 경우의 하나로서 “업무상의 재해인지 판단하기 위한 진찰”을 규정하고 있다. 따라서 특별진찰의 결과 상병명이, 신청인 주치의 소견서 내지 공단의 자문의사의 자문에 표출된 상병명과 부합한다면 이를 업무상질병판정위원회(소위원회)나 재심사위원회에서 명백한 의학적 입증도 없이 부인할 수 있도록 허용하는 것은 법령의 취지에 반한다고 볼 수 있다. 그 진단 상병명의 일관성을 확보하는 것이 바람직하다.

222) 법시행령 제118조 제1항에 특진의료기관이 열거되어 있다.

문제가 되는 것은 특진의료기관에서 진찰한 결과가 주치의 및 자문의사의 소견과 각각 다른 경우인데 이는 실제로는 특진 결과가 신청인에게 불리하게 나온 것이라고 볼 수 있다. 이렇듯 진찰소견 불일치의 경우에 대비하여 법 시행령 제118조 제4항은 공단은 다시 진찰하여 판정하거나 판단할 수 있도록 함으로써 불확실성을 가난한 배제하고자 하는 것이다.²²³⁾

② 따라서 이런 절차를 거쳐 진단된 상병명에 대해서는 적어도 재심사위원회에 참석하는 의사 신분의 개별 위원의 소견만으로는 상병명이 변경되지 못하도록 할 필요가 있다. 오로지 개별 위원(의사)이 상병명에 대해 동의하지 못하는 경우에는 재심사위원회 위원장에게 해당 전문분야 “(가칭)의학판정 소위원회”의 개최를 요청하도록 하고 위원장은 이를 받아들여 위원을 지정하여 소위원회를 개최토록 하여 상병명 기타 의학적 판단을 요청하도록 할 필요가 있다. 이렇듯 재심사위원회 해당 분야 의학판정소위원회에서 상병명 등이 결정될 경우에는 재심사위원회에 보고되면 그 내용대로 재심사위원회에서 심의된 것으로 보고 다음 단계로서 업무관련성 판단에 집중하도록 법정화할 필요가 있다.

③ 이 문제에 대한 법규정화는 산업재해보상보험법에 정하는 방법이 가장 바람직하겠으나 재심사위원회 소위원회의 구성·운영에 대해서는 현행법상 법률이 아닌 시행령(제111조)에서 정하고 있다는 점을 고려하여 위 내용도 시행령에서 규정화하는 것이 현실적이라고 본다. 그 구체적인 내용은 업무상질병판정위원회 소위원회에 관한 법시행규칙의 조문(제9조의 2 제5항)을 참고할 수 있을 것이다. 산재보험법 시행규칙 제9조의 2에 따르면 업무상질병판정위원회 소위원회는 질병명 등 판정위원회가 정하는 경미한 사항에 대하여 심의하도록 하고 있지만(제2항), 판정위원회에 보고되는 소위원회 심의된 사항은 판정위원회에서 심의된 것으로 본다고 정하고 있다(제5항). 이를 참조하여 산재보험재심사위원회의 전문분야별 (가칭)의학판정 소위원회의 권한(상병명 진단 관련) 등에 관한 시행령 조항을 추가할 필요가 있다.

<보론> 업무상질병판정위원회 전문위원회

업무상질병판정위원회 운영규정 제26조의 2에 의하면 소위원회 외에 업무상질병판정위원회의 업무를 효율적으로 수행하기 위해 둘 수 있도록 한 전문위원회

223) 그럼에도 불구하고 그 진찰의 결과로는 여전히 진찰 요구의 목적에 따른 판정 또는 판단이 곤란하다면 부득이 자문의사회의의 심의를 거쳐 이를 판정하거나 판단할 수 있도록 규정하고 있다(시행령 제118조 제4항 단서).

제도(2021년2월26일 신설)가 있다. 질판위 운영규정에 따르면 전문위원회는 주로 사전검토 전문위원회로, 소위원회는 질판위 심의 후 사후 소위원회로 진행하는 것으로 보이나 23년 1월 현황자료에 의하면 2021년도 전문위원회 개최 건수가 확인되지 않을 정도로 전문위원회 제도는 업무상 질병 판정의 소요기간 단축에의 기여에 의문이 제기되는 상황이다. 나아가 전문위원회(사전검토 전문위원회)와 소위원회의 기능분담에 대한 기준도 명확하지 않다.

앞의 (가칭)산재보험심사관이 도입되어 고용노동부에서의 판단으로 일원화시킨다면 적어도 산재판단의 전제로서 근로자성 판단을 위한 전문위원회를 별도로 운영할 필요성은 없어 보인다. 자칫하면 옥상옥에 그칠 수 있다.

III. 산재 원처분 결정의 신속성 확보 - 소속기관장의 표준심의기간 설정과 기간준수 인센티브의 제도화

(1) 문제점

산재보험법 시행규칙 제21조(요양급여의 결정 등) 제1항에 따르면 “공단은 법 제41조에 따른 요양급여의 신청을 받으면 그 신청을 받은 날부터 7일 이내에 요양급여를 지급할지를 결정하여 신청인 및 보험가입자에게 알려야 한다”고 규정하고 있다. 그러나 이 7일의 심의의뢰 기간에는 시행규칙 제21조 제2항 제2호부터 제6호까지에 해당하는 기간(예컨대 현장조사, 특별진찰, 산재보험의료기관 조사 등의 기간)은 포함하지 아니한다. 그 결과 업무상 사고에 비해 업무상 질병, 예컨대 직업성 암, 정신질병, 뇌심혈관, 근골격계를 포함한 기타질병의 처리 소요일수는 매우 긴 편이다. 이처럼 비현실적인 법규정은 예측가능성과 법적 안정성을 떨어뜨려 신청인 피해근로자의 불신과 불만을 야기하는 원인이 된다. 따라서 무엇보다 이 기간을 단축할 방안을 마련할 필요가 있다.

(2) 개선안

① 현행 법문과 현실의 괴리를 줄이기 위해서는 표준기간에 대한 준수권고제도를 도입하여 담당자들의 인식을 제고할 필요가 있다. 즉 업무상 질병 사건에 한해 요양급여 신청접수를 받은 소속기관장은 접수를 받은 지 일정기간(7일 내지 10일) 안

에 신청에 관한 기본적인 사항의 확인을 거쳐, 혹은 필요한 경우에는 질병자문위원회의 자문을 거쳐 소속기관의 장이나 질판위의 결정까지 예상되는 총 소요기간을 표준으로 하여 표준심의기간²²⁴⁾ 내지 표준처리기간을 설정하도록 할 필요가 있다. 이것이 신속보상의 원칙에도 부합하고, 또한 피해근로자나 그 유가족의 예측가능성을 높일 수 있다.

② 표준심의기간 사전고지 제도가 시행된다면 현행 산업재해보상보험법 시행규칙 제21조(요양급여의 결정 등) 제2항에서 처리기간 7일에서 제외되는 기간에 대한 대대적인 개편과 재조정이 필요할 것이다. 다만 표준시간제를 실시하더라도 근로자성이나 노무제공자성이 문제가 있어서 산재보험심사관의 판단을 받게 되는 경우 또는 특별진찰을 의뢰하였으나 신청근로자측 사정으로 지연되는 경우 등은 그 처리기간이나 지연기간은 표준심의기간에서 제외하는 기간으로 보아야 할 것이다.

③ 한편 사전고지된 표준심의기간을 도과한 경우에는 신청근로자에게 처리상황과 지연이유에 대해 서면으로 안내하도록 할 필요가 있다. 중장기적으로는 접수사건의 처리단계에 대해 온라인 확인이 가능하도록 시스템을 구축하는 방안도 필요할 것이다.

<보론>

표준기간권고제가 향후 안착되면 중장기적으로는 일부의 “심각한 질병항목”에 대해서는 신청인에게 사전고지된 업무상 질병 신청사건의 소요기간(표준심의기간)이 도과한 때로부터 질병의 요양과정에서 발생하는 국민건강보험법상 본인 일부 부담금에 대해서 근로복지공단이 산재보상기금에서 부담하는 제도를 마련할 필요도 있다고 본다. 예측가능성과 함께 공단이 일정 책임을 부담함으로써 신뢰구축에 기여할 수 있다.

- 현행 본인 일부 부담금 대부사업²²⁵⁾을 응용하여 요양급여의 신청을 한 질병과 업무 간에 상당인과관계가 있을 것으로 추정된다는 의학적 소견이 있는 질병일 것을 전제로 하되, 그 중에서 치명률도 높고 생활상 침해도가 높아 신속한 요양

224) 일본은 「労働保険審査官及び労働保険審査会法」 제7조의2(표준심리기간)에서 “후생노동 대신은 심사청구가 된 때부터 해당 심사청구에 대한 결정을 할 때까지 통상 필요한 표준적인 기간을 정하도록 노력하는 동시에, 이를 정한 때에는 도도부현 노동국에서의 비치 및 그 밖의 적당한 방법으로 공개하여야 한다.”고 정하고 있다. 본문에서 제안한 표준심의기간은 이를 심사청구절차가 아니라 원처분 결정절차에 응용한 개념이다.

225) 현행 산업재해보상보험법 제93조 및 동법 시행령 제84조에서 요양급여의 신청을 한 질

이 필요한 중한 질병(직업병 중 업무상 질병 사망자비율이 높은 직업성 암 중 일부와 석면폐증, 진폐 등 호흡기질환, 그리고 세균바이러스에 의한 감염병 등) 중에서 의학적인 연구검토를 통해 신속한 요양지원이 필요한, 일부 부담금 지원 대상 질병목록을 선정할 수 있을 것이다.

IV. 업무부하의 경감과 가용자원의 효율적 활용

1. 업무상 질병 판단에 관한 패스트트랙제도 적용범위 확대

(1) 문제점

직업병에 대한 데이터를 업종 및 직무별로 세부화하여 업무상 재해 판단 절차를 간이화하는 제도, 즉 패스트 트랙의 대상을 가능한 한 확대할 필요가 있다. 영국에서 산업재해장해급여는 업무상 질병 B에 해당하는 모든 석면 관련 질병 및 업무상 질병 D3, D8, D9, D10 및 D11 등을 포함하여 말기 암을 포함하는 청구에 대해서 패스트 트랙 사례로 처리함은 앞서 설명한 바와 같다. 물론 영국에서의 관련 법률이나 가이드라인에서 패스트 트랙에 해당하는 질병의 범위가 확정되어 있는 것은 아니지만, 신청자의 질병이 심각한 직업병에 해당하거나, 앞으로 생존기간이 길지 않은 경우에 적용하고 있어 패스트 트랙이 적용되었던 대상 질병의 범위가 실무상으로 점차 확대되는 것으로 볼 수 있다.

우리나라의 패스트 트랙 대상질병은 영국과 비교해서는 많이 부족한 것이 현실이다. 업무상 질병 판단에 관한 패스트 트랙 제도가 업무상 질병 여부에 대한 판단을 기다리는 신청자는 물론 공단에 대해서도 그 절차이행의 유무형적 부담을 덜어주기 위한 것임은 물론이다. 따라서 이에 대한 개선도 필요하다고 본다.

(2) 개선안

① 현행 패스트 트랙제도는 근골격계 질병에 대해서만 적용되나, 향후 이를 뇌심

병과 업무 간에 상당인과관계가 있을 것으로 추정된다는 의학적 소견이 있는 경우로서 요양급여를 신청한 날부터 30일이 지날 때까지 공단이 요양급여에 관한 결정을 하지 아니하였을 때는 국민건강보험법상 요양급여 비용의 본인 일부 부담금에 대해 대부할 수 있도록 하고 있다. 그러나 말그대로 대부사업의 한계 때문에 실제 이용현황은 거의 없는 실정이다.

혈관, 정신질환, 직업성 암, 기타질환 등으로 확대 적용하되, 신속한 치료가 필요한 심각한 질병을 우선 고려하는 한편, 그 실효성을 높이기 위해서는 해당 산업의 직종 및 직무별 세부 기준을 마련하는 등 체계 구축을 도모할 필요가 있어 보인다. 패스트 트랙의 확대적용 대상은 우선적인 치료가 필요한 심각한 질병이거나 아니면 상병명과 업무와의 관련성이 상대적으로 쉽게 추정됨으로써 신속한 처리를 하더라도 판정의 객관성이나 공정성에 특별히 문제를 일으키지 않는 질병²²⁶⁾을 우선할 필요가 있다. 특히 후자의 경우에는 신속한 처리를 통해 소속기관에서의 업무처리 부담을 덜어줌으로써 다른 업무상 질병의 판정에 좀 더 집중할 수 있다는 데에 기여할 수 있다.

② 다만 패스트 트랙의 대상질병에 포함시키기 위해서는 의학적 검토와 함께 노사정의 지속적인 협의가 필요할 것이다.

2. 근골격계 질환에 대한 패스트 트랙의 신속한 운용

(1) 문제점

2022. 4. 산재보험법 제37조 제1항제2호 및 같은 법 시행령 제34조제3항에 따라 뇌혈관 질병 또는 심장 질병 및 근골격계 질병의 업무상 질병 인정 여부 결정에 필요한 사항을 개정하여 고시하였는데²²⁷⁾ 주요 내용은, 근골격계 질병의 업무상 질병 인정 절차를 간이화하는 데 있었다. 즉, 근골격계 질병에 대한 업무 관련성 인정 기준을 제시하고, 이에 해당하면, 업무관련성을 인정하도록 하였다.²²⁸⁾ 이때 업무 관련성 인정과 관련하여 고려되는 기준이란 근골격계 질병의 상병, 직종, 근무기간, 유효기간 등이다. 이처럼 근골격계 질병의 상병명만 정확한 인정된다면 수월하게 업무 관련성을 인정하도록 도입했음에도 불구하고 여전히 업무상 질병판정위의 판정을 받도록 하는 것은 그만큼 처리기간을 지연시킬 수 있다. 나아가 이는 업무관련성이 객관적으로 확인되는 신청사건에 대해서는 사건처리의 업무부담을 줄임으로써 다른

226) 예컨대 조선소 근로자들에게서 흔한 근골격계질환은 근막통증후군, 추간판탈출증, 염좌, 외상과염, 무릎의 연골연화증 등으로 관찰되었으며 신체부위 중 경추에서 가장 많았고 요추, 어깨, 팔, 무릎, 손 순이었다. 이 경우에는 정확한 상병명 진단이 내려지면 직종, 근무기간, 유효기간을 검토함으로써 빠른 판단을 내릴 수 있다. 고용노동부고시(제2022 - 40 호) 중에서 [별표 1] 라목 3) 관련 상병, 직종, 근무기간, 유효기간 기준 참고

227) 고용노동부 2022. 4. 28. 고시 「뇌혈관 질병 또는 심장 질병 및 근골격계 질병의 업무상 질병 인정 여부 결정에 필요한 사항」 일부개정 고시

228) 이를 업무상재해 추정제도라고도 하나 그 실질은 패스트트랙(Fast-track)제도로 보아야 한다.

사건처리에 인력과 시간을 집중시키려는 것에 지장을 줄 수도 있다.

따라서 현재 패스트 트랙을 활용할 수 있는 질병만이라도 신속한 처리를 함으로써 업무상 질병에 관한 전체 요양신청 처리와 판단의 공단측 부담을 줄이는 것이 산재 요양결정의 신속한 처리에 기여한다고 본다.

(2) 개선안

① 현행 산업재해보상보험법 시행규칙 제7조는 제1호 내지 제6호까지 업무상 질병판정위원회의 심의에서 제외되는 질병을 정하고 있는 바, 그 중 6호는 “그 밖에 업무와 질병사이에 상당인과관계가 있는지를 명백히 알 수 있는 경우로서 공단이 정하는 질병”²²⁹⁾이라고 정하고 있다. 따라서 신속한 판정과 보상을 위한 패스트 트랙의 취지를 고려하여 현재의 산재보상제도에 따른 업무상 질병판정위원회 심의 면제대상(법 시행규칙 제7조)에 패스트 트랙 근골격계 질병을 포함시킬 필요가 있다. 따라서 근골격계질환의 상병, 직종, 근무기간, 유효기간을 충족할 경우에는 업무관련성이 강하다고 평가하도록 된 고용노동부고시(제2022 - 40호) 별표 1에 열거된 근골격계 상병명에 대해서는 질판위의 심의대상으로 삼지 않고 소속기관장이 바로 해당 상병분야의 진료과목 전문의 자격을 가진 자문의사에게 의학 자문을 받아서 상병명이 확인된다면 업무상 질병으로 인정하고 요양승인을 하는 것이 바람직하다.

② 다만 위와 같이 자문의사의 의학 자문을 받았더라도 상병명 불확실 등의 사유가 있다면 소속기관장은 예외적으로 업무상 질병판정위의 심의대상으로 올릴 수 있도록 허용한다면 판정의 객관성을 확보할 수 있으리라 본다.

3. 업무상 질병판정위원회 절차 제외대상 확대

(1) 문제점

현행법상 피재근로자 등 산재보험 수급권자가 근로복지공단에 보험급여의 지급을 신청 또는 청구하면, 근로복지공단은 법령의 규정에 따라 지급 여부를 결정하게 된

229) 이 중에서 ①산업재해보상보험법 제49조에 따른 추가상병 요양급여를 신청한 질병과 ② 석면폐증, ③산업재해보상보험법 시행령 제34조 제3항 별표 3 제6호 피부질병 중에서 (바·사목), 제9호 감염성 질병 중에서 (가·다목), 제12호 물리적 요인에 의한 질병 중에서 (바·사목)은 현 법령상 별도의 자문도 조건으로 하고 있지 않다.

다. 물론 업무상 질병에 관해서는 원칙적으로 업무상 질병판정위원회를 거쳐야 한다. 업무상 질병판정위원회 제도는 판정의 객관성과 전문성, 공정성을 기하기 위해 도입된 것이다. 그러나 업무관련성이 어느 정도 검증된 질병, 즉 진폐, 이황화탄소 중독증, 유해·위험요인에 일시적으로 다량 노출되어 나타나는 급성 중독 증상 또는 소견 등의 질병 등에 대해서는 업무상질병판정위원회 절차를 거칠 필요가 없다. 특히 영 제117조제1항 제3호에 따른 진찰을 한 결과 업무와의 관련성이 매우 높다는 소견이 있는 질병과 법 제22조 각 호의 기관에 자문한 결과 업무와의 관련성이 높다고 인정된 질병의 경우도 그러하다.

그러나 현행 법령에 따르면 여전히 산업재해보상보험법 시행령 별표3 「업무상 질병에 대한 구체적인 인정 기준」에 적시된 업무상 질병 중 극히 소수만이 업무상 질병판정위원회 판정절차 제외 대상으로 되어 있다. 즉 상당수의 업무상 질병 리스트는 질판위 절차 제외대상이 아니다. 따라서 공단의 업무부하의 경감과 이를 통해 절감된 인력과 시간을 다른 사건, 즉 신중하게 상병명과 업무관련성을 판단해야 하는 사건에 효율적으로 집중시켜 전반적인 사건처리기간을 단축하기 위한 방안을 강구할 필요가 있다.

(2) 개선안

① 현행 산업재해보상보험법 시행령 별표3의 「업무상 질병에 대한 구체적인 인정 기준」은 열거주의와 포괄주의를 포섭한 혼합주의 방식을 채택하고 있다. 따라서 이들 열거된 질병 항목 중에서 일부를 선정하여 업무상 질병판정위원회 심의대상에서 제외되는 질병으로 확대해 포섭할 필요가 있다. 물론 상병명을 확정하기 곤란한 것이 원인이라면 요양급여 신청 전후 절차에서 상병명 진단의 객관성과 권위를 높이는 방법을 모색하면 될 것이다.

② 요컨대 업무상 질병판정위원회 심의대상에서 제외되는 질병목록으로서 “그 밖에 업무와 질병사이에 상당인과관계가 있는지를 명백히 알 수 있는 경우로서 공단이 정하는 질병”(산재보험법 시행규칙 제7조 제6호)과 이에 근거한 「업무상 질병판정위원회 운영규정」 제5조(판정위원회의 심의 제외 질병)에 시행령 별표3의 질병목록 중에서 일부를 선정하여 추가하는 것이 바람직하다.

V. 업무상 재해판정에 대한 불복절차의 일원화

(1) 문제점

현재의 업무상 재해 판단에 관한 원처분에 대한 불복은 일반 행정심판기관과는 다른 별도의 특수한 행정심판기관인 근로복지공단의 산업재해보상보험심사위원회와 고용노동부의 산업재해보상보험재심사위원회 등에 의한 심사제도를 채택하고 있다.²³⁰⁾ 즉 현행 제도체계는 제1심의 심사기관으로 산업재해보상보험심사위원회가 있고, 제2심의 심사기관으로 산업재해보상보험재심사위원회를 두고 있다.²³¹⁾

그런데 현재 산업재해보상보험법은 업무상 질병판정위원회의 심의를 거쳐 업무상 질병의 인정 여부가 결정된 경우에는 심사절차를 거치지 않을 수 있도록 하고 있다(산재보험법 제105조 제2항 및 동법 시행령 제102조 제1항). 그러나 업무상 질병판정위 결정에 대한 심사청구 자체를 막지는 않고 있으며, 나아가 이 경우에도 공단이 심사위원회의 심의를 거쳐 결정할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 심사위원회의 심의를 거쳐 결정할 수 있도록 하고 있다(시행령 제102조 제2항). 그리하여 실제로 「산업재해보상보험 심사업무처리규정」 제17조(업무상질병판정위원회 경유 사건)에 1호에 따르면 “업무상질병판정위원회와 제44조에 따른 관계 전문가 간 의학적 소견(이사장의 의뢰에 의한 자문)이 상이한 경우”에는 심사위원회 심의회의에 상정할 수 있도록 하고 있다. 그러나 이는 자칫 신청처리기간을 지연하고 원활한 절차 진행에 혼란을 일으킬 수 있기 때문에 문제라고 본다.

그 이유를 살펴보면 첫째 심의절차의 중복 가능성이다. 산업재해보상보험법 제105조 제4항에 따르면 산업재해보상보험심사위원회로 하여금 심사 청구의 심리를 위하여 ① 청구인 또는 관계인을 지정 장소에 출석하게 하여 질문하거나 의견을 진술하게 하고, ② 청구인 또는 관계인에게 증거가 될 수 있는 문서나 그 밖의 물건을 제출하게 하고, ③ 전문적인 지식이나 경험을 가진 제3자에게 감정하게 하거나, ④ 소속 직원에게 사건에 관계가 있는 사업장이나 그 밖의 장소에 출입하여 사업주·근로자, 그 밖의 관계인에게 질문하게 하거나, 문서나 그 밖의 물건을 검사하게 하고 또는 ⑤ 심사 청구와 관계가 있는 근로자에게 공단이 지정하는 의사·치과의사 또는 한의사의 진단을 받게 할 수 있도록 명시하고 있는데, 그러나 이러한 것들

230) 김수복, 「산업재해보상보험법」, (주)중앙경제, 2008, 644-645면 참고.

231) 김수복, 「산업재해보상보험법」, (주)중앙경제, 2008, 645면.

은 결과적으로 업무상질병판정위의 판정(인정, 불인정, 일부인정 등)이나 (질판위 절차제외 대상인 경우) 소속기관의 장이 업무상 재해 여부에 관한 결정을 내리기 위해 시행한 것²³²⁾을 다시금 반복하는 것과 크게 다르지 않다. 물론 판정의 객관성과 공정성 및 전문성을 위해서는 이러한 부분에 대한 재검토 내지 재점검 절차 자체가 불필요한 것은 아니지만 문제는 같은 공단 내부에서 이루어지는 절차이기 때문에 그 검증절차의 엄격성이 아무래도 약할 것이라는 인식을 신청인에게 줌으로써 신청인의 심사위결정의 수용성을 약화시킬 우려가 있다.

둘째, 업무상 질병 불인정에 대한 심사청구의 취소율이 유의미하게 낮다는 점이다. 실제로 이는 통계적으로도 확인된다. 2022년도 심의현황 자료²³³⁾를 보자면 업무상 질병 판정사건(총 17,222건) 중 불인정(일부인정 포함)건(총 8,946건)에 대한 이의제기율(심사청구와 재심사청구 및 심사후 재심사청구건을 불인정건 8,946건으로 나눈 비율)은 21.7%이었다. 이 중에서 심사위에의 심사청구 접수는 670건이고 이 중에서 결정된 건수 586건 중 취소/일부취소 건은 32건으로서 심사청구 결정건수 대비 취소/일부취소율은 5%이다. 이에 반해 재심사위에의 재심사청구 접수는 1075건이며 이 중에서 결정된 건수 270건 중 취소/일부취소 건은 27건으로서 재심사청구 결정건수 대비 취소/일부취소율은 10%이다. 또한 심사청구와 재심사청구, 그리고 심사후 재심사청구를 모두 합친 전체 건수(1,939건) 중 결정건수(863건) 대비 취소/일부취소율은 전국평균은 6.8%인 바, 이와 비교할 때 전체 심사청구의 취소율이 특히 낮다는 것을 알 수 있다. 업무상 질병과 관련하여 재심사청구가, 아무래도 업무상 질병판정위를 거친 경우에 이루어지는 불복절차일 가능성이 크고 이에 반해 심사청구는 업무상 질병판정위를 거치지 않은 소속기관 불승인사건에 대한 불복절차일 가능성이 크다고 추정해 보면 업무상 질병위 결정에 대해 재심사 청구가 아니라 심사위에의 심사청구를 허용하는 것은 재심사위원회로 재심사가 몰림으로써 증가할 판정부담을 줄여주는 장점이 있다는 것을 논외로 한다면(그러나 엄격히 말해서 이는 공단의 관심사항일 뿐이다) 불복하는 피재근로자 입장에서는 처리시간만 더 소요될 뿐 그리 큰 장점이 되지 못한다. 심사청구 인정률이 전반적으로 낮기 때

232) 예컨대 업무상질병판정위원회 운영규정 제13조(심의안건 검토회의) 제2항에 따르면 위원장은 심의회의를 개최하기 이전에 검토회의를 개최한 결과 심의를 위해 필요하다고 인정하면 ① 소속기관장에게 추가 조사나 자료의 보완을 요청하거나 ② 제26조의2에 따른 전문위원회에 심의안건을 회부하여 검토하거나 ③ 제34조에 따른 전문가에게 자문을 받게 하고, ④ 시행규칙 제22조에 따라 자문을 의뢰하게 하거나 또는 ⑤ 시행령 제118조에 따른 특진 의료기관에서 진찰을 받게 할 수 있도록 정하고 있다.

233) 근로복지공단 산재보상국 업무상질병부, 「업무상질병판정위원회 2022년도 4분기 심의현황 분석」, 2023.1. 20면 참고

문이다.

업무상 질병을 포함한 업무상 재해 결정의 전문성을 잃지 않으면서도 결정의 신속성을 담보하기 위하여는 과거 산업재해보상보험심사관의 역할을 대체하는 역할을 담당하는 업무상 질병판정위원회의 결정에 대해서는 심사청구를 거치지 않을 수 있도록 한 현행법의 취지를 명확히 하여 그 절차나 불복방식의 간소화 조치를 고려할 필요가 있다.

(2) 개선안

① 제1안 : 현행 심사위원회와 재심사위원회를 일원화하여 하나의 심사위원회만을 두어 별도의 재심사위원회를 거치지 않도록 하는 방안을 강구할 수 있다. 통합 심사위원회 심사 및 판정에 대한 불복은 행정소송으로 가도록 하면 된다. 이 경우에 업무상 질병판정위원회뿐만 아니라 업무상 사고로 인한 부상과 사망의 산재의 불승인이나 혹은 업무상 질병판정위의 결정대상이 아닌 업무상 질병에 대한 소속기관장의 불승인결정에 대해 통합 심사위원회로 심사청구가 이루어진다면 큰 부담이 생길 수 있다. 따라서 이 경우에는 반드시 심사위원회의 증설과 인력의 증원이 병행되어야 할 것이다.

② 제2안 : 현재의 심사위원회와 재심사위원회를 그대로 두고 업무상 질병에 관한 업무상 질병판정위원회의 결정(기각이나 각하결정)에 대해서만 재심사위원회로 재심사청구를 하도록 하는 방안이 있다. 이는 현재 운용되는 시스템의 변경을 최소화하는 방안으로서 단지 업무상 질병판정위의 결정에 불복하는 신청인의 입장에서 심사위에의 심사청구 취소율이 낮아 심사청구가 크게 실익이 크지 않은 이의제기 절차의 중복판단을 선제적으로 줄이는 방안이 된다.

③ 제3안 : 현재의 심사위원회와 재심사위원회를 그대로 두는 것은 2안과 같되, 업무상 질병의 경우에 국한하여 그 산재 인정 여부와 관련한 이의제기는 그것이 소속기관장의 불승인 결정이든 업무상 질병판정위원회를 거친 기각결정이든, 그 불복은 재심사위원회에 청구를 하도록 하는 방안이다. 이 방안은 업무상 질병을 주장하는 신청인을 불복절차의 장기화에 빠뜨리지 않으면서도 접수사건에 대한 재심사위원회의 처리 부담은 적어도 제①안 보다는 줄어들 수 있다는 장점이 있다.

VI. 소결 : 업무상 재해 판정에 대한 신뢰확보 및 수용성 제고

이상에서는 관련 기관의 역할분담 명확화를 통한 산재판정의 프로세스 효율화 방안으로서 (가칭)산재피보험자격심사관제를 실시하는 한편 패스트트랙의 운용효율화 및 표준심의기간 설정과 그 준수를 촉구하고, 그 준수율에 따라 인센티브를 제공하는 제도의 도입으로 처리기간 단축 유도 등을 검토하고 제안하였다. 이러한 절차적 개선안들이 적절하게 운영되어 지속된다면 업무상 재해 인정 및 보험급여 결정에 대한 신청당사자의 신뢰를 구축하고 중장기적으로 수용성을 제고하는 데에 기여할 수 있으리라 본다.

나아가 앞에서는 별도로 언급하지 않았지만 산업재해보상보험 심사절차에서 직업 법관이나 공익위원이 위원으로 참여하여 산재판단을 하도록 유도한다면 해당 심사 결과에 대한 사회적 신뢰를 높이는 데에 도움이 될 것으로 생각된다. 따라서 (재)심사위원회 구성에서 공익위원으로서 일정비율 이상 참여를 적극적으로 모색할 필요가 있다.

참고문헌

- 고용노동부/근로복지공단 근로복지연구원, 「유럽 7개국 산재보험제도」, 2021.
- 김명길, 「기본행정법」, 탐북스, 2014.
- 김수복, 「산업재해보상보험법」, (주)중앙경제, 2008.
- 김형배, 노동법, 2010.
- 류지태·박종수, 「행정법신론」, 박영사.
- 오종은, 「노동 환경 유연성 확대에 따른 산재보험 적용 변화 연구」, 근로복지공단 근로복지연구원, 2020.
- 이상국, 「산재보험법(I)」, 대명출판사, 2017.
- 이상국, 「산재보험법(II)」, 대명출판사, 2017.
- 이현주·정홍주·이홍무·오창수·정호열·석승훈, 「외국의 산재보험제도 연구-선보장·후정 산제도를 중심으로」, 한국노동연구원, 2004.
- 전광석, 한국사회보장법론, 2007.
- 정하중·김광수, 「행정법개론」, 법문사, 2022.
- 한국노총, 「산재보험 선보상 후정산 제도 - 요양급여, 휴업급여 선지급 방안 -」
- 김근주, 영국 산업재해보상제도의 보호범위, 한양법학 제27권 제2호, 한양법학회, 2016.
- 김기태·이승윤, 한국 공적 상병수당 도입을 위한 제도 비교연구 및 정책제언, 사회복지정책 제45권 제1호, 한국사회복지정책학회, 2018.
- 김종수, 상병급여제도에 관한 소고, 사회보장법 연구 제5권 제1호, 서울대학교 사회보장법연구회, 2016.
- 김광수, "행정심판제도의 현황과 발전방향", 「행정법연구」(제43호), 2015.
- 김남철, "우리나라 행정심판의 위상과 발전방향", 「행정법학」(제14호), 2018.
- 김수근, "새로운 업무상 질병 인정기준의 의의와 과제", 「월간 산업보건」(제300호), 대한산업보건학회, 2013.
- 김용욱, "행정절차구조의 유형화 시론 -준사법절차적 대심구조의 구현을 중심으로-", 「법조」(제71권 제3호), 2022.
- 박지순 · 이주원, "산재보험급여소송에서 업무상 재해의 증명책임", 고려법학 제63호, 고려대학교 법학연구원
- 박찬임, 복지체제와 취업자 소득지원 정책, 한국노동연구원, 2021.
- 서보국, "행정심판제도의 기능과 책임성 강화에 대한 고찰" 「법학연구」(제28권 제3

- 호), 2020.
- 선정원, "행정심판과 고충처리제도의 조직적 통합의 의의와 법정책적 개선과제", 「법과 정책 연구」(제11집 제4호), 2011.
- 성중탁, "행정심판에서의 재판청구제도 도입에 관한 논의", 「법학논총」(제29집 제1호), 2022.
- 이윤정, "행정심판에서 부당성 심사의 실용성과 확대 방안", 「강원법학」(제68권), 2022.
- 이정원, "독일의 산업재해 발생현황", 국제노동브리프, 한국노동연구원 2006.
- 정남철, "행정심판의 확대 및 기능 강화를 위한 개선방안", 「행정법학」(제14호), 2018.
- 정사언, "행정심판의 절차상 한계와 효율성확보방안", 「국가법연구」(제8권 제2호), 2012.
- 정슬기, 영국의 산재보상제도와 합리성 판단기준, 사회법연구 제48호, 한국사회법학회, 2022.
- 최선웅, "행정심판의 헌법상 근거 -헌법 제107조 제3항의 해석을 중심으로-", 「행정법연구」(제44호), 2016.
- 최영규, "행정심판의 기능과 심판기관의 구성 -행정심판의 사법화에 대한 이의-", 「행정법연구」(제42호), 2015.
- 최지현, "헌법상 재판청구권의 보장을 위한 행정구제 법제의 설계", 「법조」(제69권 제6호), 2020.
- 최진수, "행정심판 제도의 구조에 관한 고찰" 「공법연구」(제43집 제2호), 2014.
- 황창근, "행정심판과 재결취소소송의 관계", 「연세법학」(제35호), 2020.
- 고용노동부 2022. 4. 28. 고시 「뇌혈관 질병 또는 심장 질병 및 근골격계 질병의 업무상 질병 인정 여부 결정에 필요한 사항」 일부개정 고시
- 근로복지공단, "근골격계질환 특별진찰을 통한 업무관련성 평가 계획(안)", 2017. 10.
- 근로복지공단 2023. 3. 20. 보도자료, "2022년 산재노동자 1,493명 소송없이 권리구제 받아 -산재심사위원회 심사청구 통해 비용 부담 없이 60일 이내 결정-"
- 발생빈도가 높은 근골격계 상병 업무상질병 조사 및 판정 지침(제정 및 시행일자 2022.7.1. 근로복지공단 제2022-25호)
- 산업재해보상보험 의학 자문 운영 지침
- 공공데이터포털 홈페이지, <https://www.data.go.kr/data/15105030/fileData.do>(2023.

7. 20. 확인)

근로복지공단 홈페이지, <https://www.comwel.or.kr/comwel/comp/eval/psyc.jsp>(2023.

7. 20. 확인)

산업재해보상보험 재심사위원회 홈페이지, <https://www.iaciac.go.kr/committee/history/main.do>(2023. 9. 17. 확인)

산업재해보상보험재심사위원회 홈페이지, <https://www.iaciac.go.kr/info/statistics/main.do>(2023. 7. 20. 확인)

안전보건공단 산업안전보건연구원 홈페이지, <https://oshri.kosha.or.kr/oshri/professionalBusiness/occupationalDisease.do>(2023. 7. 21. 확인)

직업환경연구원 홈페이지, <https://www.comwel.or.kr/lab-lung/busi/work/genl.jsp>(2023. 7. 21. 확인)

<독일>

Durchführung der Heilbehandlung, die Vergütung der Ärzte sowie die Art und Weise der Abrechnung der ärztlichen Leistungen(SGB VII § 34 Abs. 3).

Heinrich Braun, Industrialisierung und Sozialpolitik in Deutschland, Köln/Berlin, 1956, S.76.

Schulin(Hrsg.)/Breuer, Handbuch des Sozialversicherungsrechts, Bd. 2, Unfallversicherungsrecht, 1996, § 1 Rn. 86.

Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht-Ricke, 2009, § 1 SGB VII, Rn.1.

독일 재해보험의 특징에 관하여 <https://mm.inje.ac.kr/app/board/attach/viewer.do?boardNo=178&articleNo=9987&attachNo=7861>

독일 법정재해보험기구(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. <https://www.dguv.de/de/index.jsp>, 2023. 9. 14. 최종확인)

https://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/125_jahre/index.jsp (2023. 9. 14. 최종확인).

https://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/125_jahre/struktur/index.jsp (2023. 9. 14. 최종확인).

https://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/125_jahre/weimar/index.jsp (2023. 9. 14. 최종확인).

https://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/125_jahre/nachkriegszeit/index.js

p (2023. 9. 14. 최종확인).

https://www.dguv.de/de/mediencenter/hintergrund/125_jahre/einheit/index.jsp (2023. 9. 14. 최종확인).

https://www.dguv.de/medien/landesverbaende/de/med_reha/documents/d_arzt3.pdf (2023. 9. 14. 최종확인).

<https://www.oftersheim.de/service-bw/verfahren/Feststellung%20einer%20Berufskrankheit;file:///C:/Users/User/Downloads/30-Ablauf-Verfahren-Berufskrankheit.pdf> (2023. 9. 14. 최종확인) 참조.

<영국>

영국 정부의 산업재해장해급여 가이드라인(Industrial Injuries Disablement Benefits: technical guidance, 2023.7.11.)

Department for Work & Pensions, NI260 - A guide to Revision, Supersession and Appeal-Decision makers, April 2009.

Department for Work and Pensions(2023), Diseases: Industrial Injuries Disablement Benefit interactive claim form, Last updated : 30 June 2023

DWP(2003), A guide to Industrial Injuries Benefits,

House of Commons Library(2023), Industrial Injuries Benefit Constituency casework, Published Thursday, 25 May, 2023

The Social Security (Industrial Injuries Benefit and Personal Independence Payment: Equality Impact Assessment-Results, 2021.2.23.(legislation.gov.uk)

영국 정부 홈페이지(www.gov.uk), Industrial Injuries Disablement Benefit: quarterly statistics(www.gov.uk)

<일본>

日本弁護士連合会行政訴訟センター編, "行政不服審査法の実務と書式[第2版]", 民事法研究会, 2020.

中嶋士元也, "労災補償の行政審査と司法審査", 弘文堂, 2020.

労働基準情報：業務上疾病の認定等: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/gyomu.html

<https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/index.html>

https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/satei_01_04_03_11_10.pdf

<https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/index.html>

<https://www.mhlw.go.jp/content/11400000/000464376.pdf>

<https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/saiket-u-youshi/dl/R01rou380.pdf>

<https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/saiket-u-youshi/dl/R01rou225.pdf>